



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN NOVEMBER
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang	2
2.1 Visi	2
2.2 Misi	2
2.3 Motto	2
2.4 7 Nilai Budi Utama	2
2.5 Struktur Organisasi	3
Bab III Laporan Kinerja Pelayanan	4
3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI).....	4
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut	4
3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan	6
3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada	7
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan	20
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik.....	20
3.3.2 Rawat Inap.....	23
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)	32
3.3.4 High Care Unit (HCU)	33
3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD).....	34
3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO).....	35
3.4 Kinerja Bidang Penunjang	36
3.4.1 Instalasi Farmasi	36
3.4.2 Laboratorium.....	57
3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran	59
3.4.4 Radiologi	65
3.4.5 Gizi	70
3.4.6 CSSD - Laundry	84
3.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan.....	89
3.5.1 SDM	89
3.5.2 IPSRS.....	98
3.5.3 Security.....	106
3.5.4 Parkir	109
3.5.5 Humas Marketing	110
3.5.6 Penjaminan	118
3.5.7 PIPP – MOD – MPP	119
3.5.8 <i>Cleaning Service</i>	127
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum	128
3.5.10 IT - SIMRS	129
3.5.11 Driver	130
3.6 Komite dan Tim	131
3.6.1 Komite Mutu.....	131
3.6.2 Komite PPI.....	199
3.6.3 Tim PKRS	213
3.6.4 Tim Prognas.....	215
3.6.5 Tim PPRA	254
3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT	261
3.7 Permasalahan Rumah Sakit	263
3.8 Profil SDM	267
Bab IV Kesimpulan dan Saran	270
Bab V Penutup	271
Lampiran	272

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan November Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

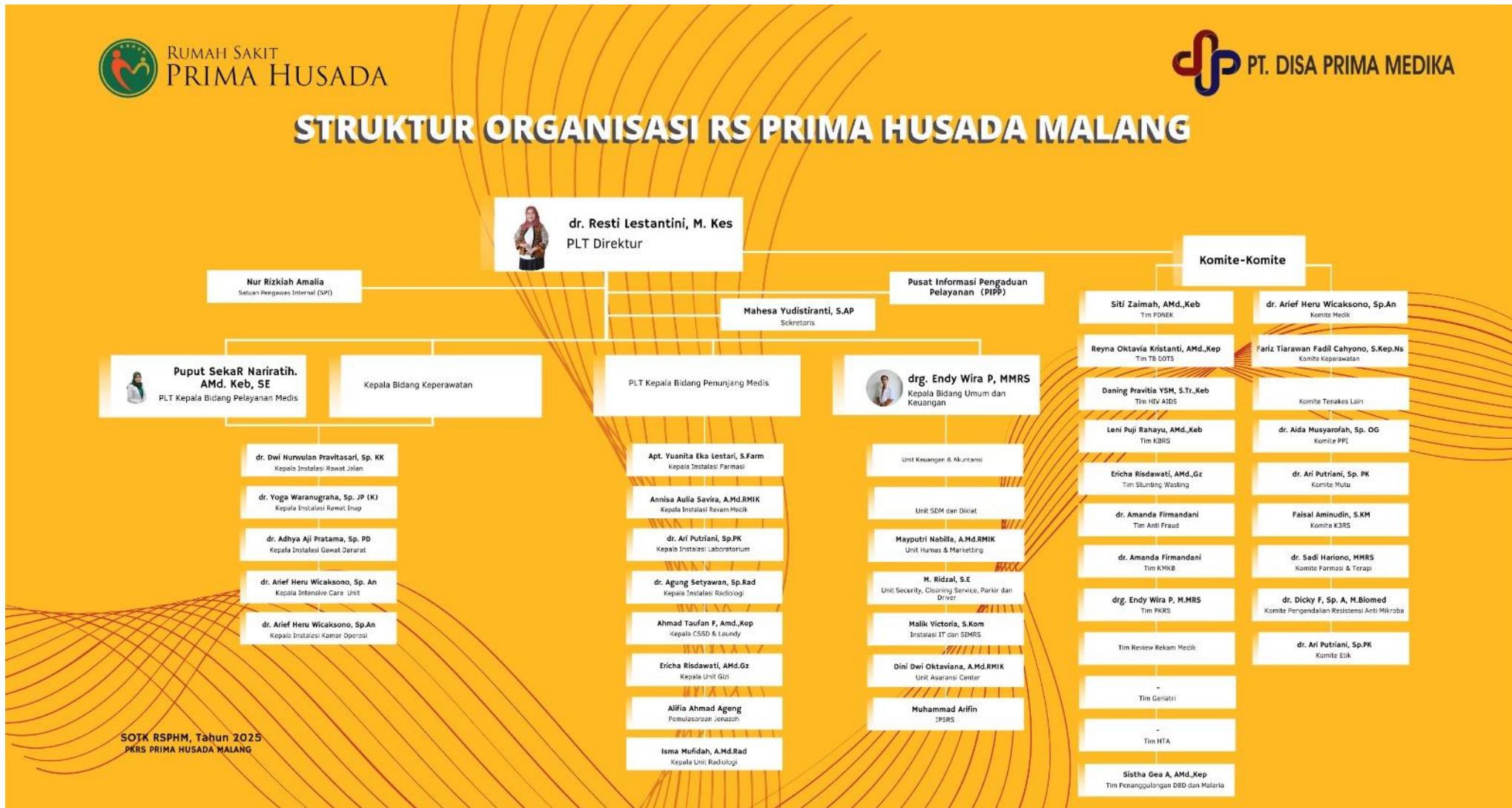
Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



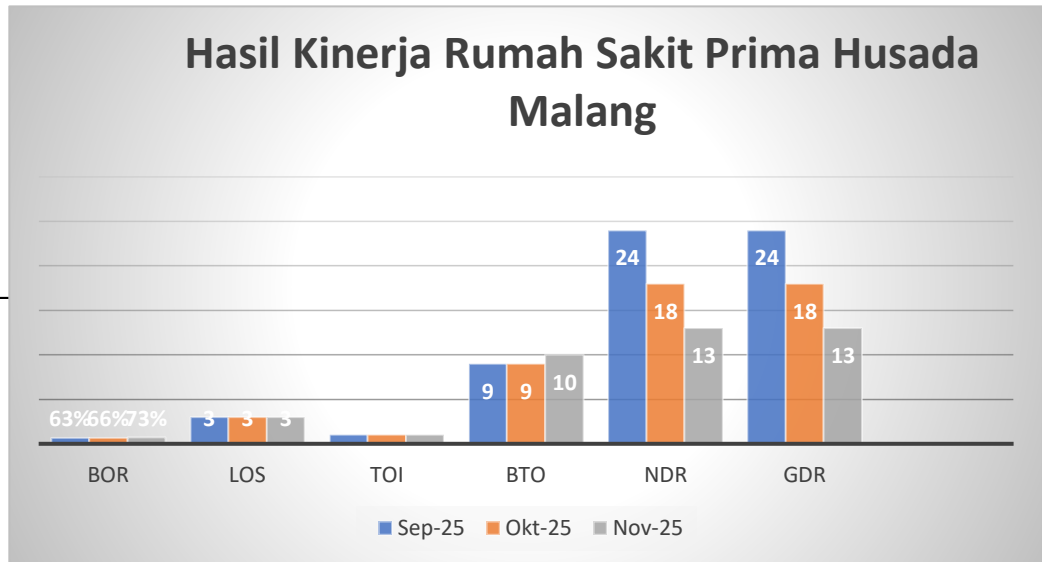
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
BOR	63%	66%	73%
LOS	3 hari	3 hari	3 hari
TOI	1 hari	1 hari	1 hari
BTO	9 kali	9 kali	10 kali

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Masalah :

- LOS sesuai standar** → indikasi pasien dirawat relatif singkat, bisa karena:
 - Kasus yang ditangani sebagian besar ringan.
 - Tekanan efisiensi rawat inap (lebih banyak diarahkan rawat jalan).
 - Atau kemungkinan pasien pulang cepat namun berpotensi readmisi.
- BTO tinggi** → mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.
- BOR fluktuatif** walaupun masih dalam batas ideal → perlu perhatian agar tetap stabil dan tidak menurun di bawah standar.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Untuk BOR:

Lakukan monitoring tren kunjungan pasien dan optimalkan pemasaran layanan unggulan agar BOR tetap stabil.

2. Untuk LOS:

- a) Evaluasi clinical pathway: apakah perawatan sudah sesuai standar atau pasien pulang terlalu cepat.
- b) Lakukan monitoring readmisi untuk mendeteksi apakah pasien yang pulang cepat sering kembali ke RS.

3. Untuk TOI:

Sudah sesuai standar, tetap dipertahankan dengan manajemen bed yang baik.

4. Untuk BTO:

- a) Pastikan mutu pelayanan tetap terjaga meski perputaran pasien tinggi.
- b) Perkuat manajemen SDM (tenaga medis dan paramedis) agar tidak terjadi kelelahan kerja (burnout).
- c) Evaluasi ketersediaan fasilitas dan sarana agar tetap seimbang dengan volume pasien.

Analisa

1. BOR (Bed Occupancy Rate)

- a) 63% → 66 % → 73%
- b) Utilisasi (BOR) naik yang cukup signifikan pada November, yakni naik sekitar **7 poin persentase** dibandingkan bulan sebelumnya

2. LOS (Length of Stay)

- a) Karena LOS dan TOI tetap konstan, penurunan BOR & BTO sangat mungkin disebabkan oleh **penurunan jumlah pasien yang masuk / rawat inap**, bukan karena inefisiensi internal
- b) Hal ini menunjukkan bahwa lama perawatan rata-rata pasien stabil dan tidak ada gangguan signifikan dalam alur pelayanan.

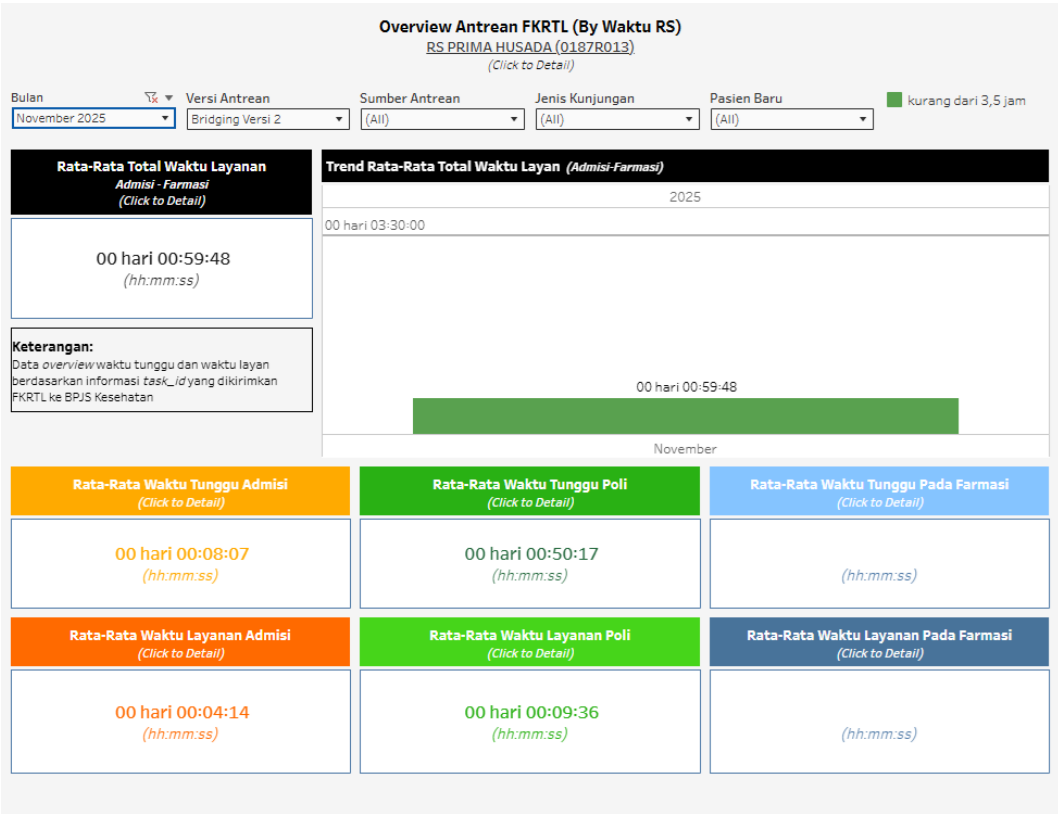
3. TOI (Turn Over Interval)

- a) Tetap 1 hari
- b) TOI yang tetap menunjukkan bahwa waktu tunggu tempat tidur sebelum dipakai kembali berada pada kondisi stabil.
- c) Kapasitas tempat tidur yang tersedia dapat langsung digunakan kembali tanpa jeda yang terlalu panjang.

4. BTO (Bed Turn Over)

- a) 9 kali → 9 kali → 10 kali
- b) Terjadi kenaikan BTO, yang menunjukkan peningkatan frekuensi penggunaan tempat tidur pada November.
- c) Efisiensi internal relatif stabil (LOS dan TOI) — artinya sistem operasional internal tidak memburuk secara mendadak

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	Jenis	Target	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	46,43%	47.64%	49.61%	50.19%	48.42%	48.20%	
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	95.11%	94.28%	92.04%	94.61%	94.20%	94.36%	

Analisis :
 Pemanfaatan antrian online data juli 2025 belum mendapat dari BPJS

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabid

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.1 Bidang Pelayanan dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Perubahan input diagnosis di pengkajian awal dan indikasi medis di surat kontrol	1. Pada Pengkajian Awal Medis Rawat Jalan dan CPPT Rawat Jalan: Pada Bagian Diagnosis ditambahkan input Jenis Penyakit (Akut/Kronis), semi otomatis cek dari inputan diagnosis DPJP. 2. Pada Input Surat Kontrol: Ditambahkan inputan Indikasi Medis 3. Pada Input Surat Kontrol:	1. Pengguna wajib memverifikasi hasil dari pengecekan sistem karena sistem akan mengecek kemiripan inputan diagnosis dengan database penyakit kronis 2. Pengguna harus menginput indikasi medis setiap membuat surat kontrol 3. Pengguna wajib memilih sesuai kondisi pelayanan

			Perubahan isi pilihan Jenis Kontrol 4. Pada Input Surat Kontrol: Tanggal Kontrol diberikan nilai default sesuai jenis penyakit 5. Pada Input Surat Kontrol: Pemberian peringatan potensi fragmentasi jika input tanggal tidak sesuai aturan yang berlaku	4. Dengan kasus normal Pengguna tidak perlu mengisi tanggal kontrol karena sudah di-default oleh sistem, tapi pengguna wajib memverifikasi kebenaran tanggal kontrol 5. Pengguna akan diberikan peringatan jika penginputan tanggal kontrol tidak sesuai aturan yang berlaku
2	IRJA	Pemeriksaan calon Jamaa Haji	1. Pemeriksaan CJH dilaksanakan secara kolektif tanggal 13 dan 14 November 2025 di ruang lantai 2A 2. Dihadiri oleh CJH dari PKM jabung, pakis, dan singosari	1. Ada beberapa CJH susulan yang tidak bisa datang di tanggal 13 dan 14 Nov, ikut dalam antrian susulan yang di handel oleh Ricky dan Sherly. Untuk DPJP dengan dr Aji, SpPD dan dr Ardhi, SpPD.
3	IRJA	Skrining mata di acara HKN yang dihadiri oleh pasien prolanis dan geriatri	1. Terdapat acara pemeriksaan skrining mata oleh dr. Diah, SPM dan dr Titok, SpM dalam acara memperingati HKN di Hall Sakura lantai 5 2. Acara yang diikuti termasuk senam DM, hipnoterapi dan penyuluhan kesehatan 3. Terdapat pemeriksaan Tensi dan GDA untuk pasien yang terdaftar BPJS Kesehatan	1. Pasien pasien yang berpotensi cataract, belum bisa ke RS, karena FKTP masih observasi dan tidak bisa langsung mengeluarkan rujukan 2. Pasien mempunyai rujukan yang masih aktif sehingga tidak bisa dikeluarkan rujukan ke mata 3. Beberapa pasien yang sudah di skrining dan dihubungi, tidak segera periksa kembali ke klinik
		Re- Upload dan sharing Poli Sunday Clinic	1. Karena poli Sunday clinic jarang diupload, dan hanya di share di	Untuk poli sunday clinic khusus pasien bpjs tetap mengikuti

			WA channel, beberapa orang tidak tahu kalau poli minggu ready termasuk melayani pasien dengan BPJS kesehatan 2. Pelayanan Sunday clinic meliputi poli anak, saraf, dan peny dalam	prosedur, karena masin-masing dokter mempunyai kuota masing-masing sesuai HFIS
		ODC pasien Umum dan Asuransi Non BPJS Kesehatan	1. Buat SPO Alur ODC pasien Umum dan Asuransi Non BPJS Kesehatan 2. Sosialisasi pada unit terkait untuk pelaksanaan dan monitoring di lapangan 3. Kriteria pasien ODC ini diluar tindakan phaco dan curettage karena tarif nya berbeda	1. Untuk ringkasan pulang tidak bisa diakses menggunakan billing rawat jalan 2. Solusi untuk kelengkapan klaim (khusus pasien asuransi) bisa ditarik melalui simrs fitur resume medis rawat jalan
4	IGD	Bimtek dan sosialisasi terkait pneumonia	Bimtek dan sosialisasi terkait pneumonia dilaksanakan selama 1 minggu yang dihadiri oleh perawat dan dokter IGD	Bimtek dilaksanakan saat jam operan, sehingga perawat maupun dokter yang dinas pagi dan sore bisa mengikuti bimtek tersebut. Tidak ada kendala selama proses bimbingan dari PT.
5	IKO	Pengajuan alat bor craniotomy di IKO	Ada demo dari vendor untuk pemakaian alat bor craniotomy di IKO	Dari hasil demo, apabila dengan harga yang ditawarkan, saran tidak diambil, dan dicari merk yang lebih bagus. Karena penggunaan nya tidak maksimal dan pertimbangan cari merk yang sesuai dan terjangkau. Merk esculap tidak direkomendasikan karena alat mahal tetapi ringkih. Sehingga ada pertimbangan merk NSK dan Medtronic. Untuk nomor medtrep sudah diberikan ke pengadaan PT

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Penulisan KPO (Kartu Pengambilan Obat) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. b. Pengajuan form penambahan fitur E-KPO ke programmer yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. c. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. d. Jumlah KPO tertinggal : 155 e. Belum tersedia printer thermal untuk cetak e-KPO.	Dalam antrian progamer
		2. Perbaikan sistem ROP Depo Farmasi dan Gudang Farmasi	a. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan barang dari depo ke Gudang Farmasi melalui rumus ROP. b. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan pembelian Gudang Farmasi melalui rumus ROP. c. Fitur sisa stok depo pada sistem ROP sudah tersedia.	Monitoring dan evaluasi rumus ROP yang sudah ada
		3. Renovasi ruang Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart	a. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl dan monitoring tekanan ruangan dengan magnehelic dan dicatat pada spreadsheet. b. Form pengajuan penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. Pass	Follow up form pengajuan LAF dan pass-box air lock

			box ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril. Form sudah masuk ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika.	
		4. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam <i>vaccine refrigerator</i> disertai Log tag. b. Perluasan ruang buffer stok 6 Maret 2025, sudah tersedia cctv dan smart door lock.	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan <i>vaccine refrigerator</i> .
		5. Pendaftaran pengantaran obat primantara di Farmasi	a. Fitur “antar obat” di SIMRS sudah tersedia dan ada laporan penjualan obat diantar. Namun kekurangannya tidak ada kolom asal poli, jam pemesanan, obat selesai, biaya, cara bayar, jarak pengiriman dan serah terima farmasi dan kurir primantara sehingga pendataan pasien menggunakan google spreadsheet primantara. b. Belum ada penanda resep obat siap dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap di SIMRS. c. Perubahan alur pendaftaran primantara oleh farmasi. a. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet.
		6. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit).	Pengajuan fitur ke progamer.

			b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	
		7. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		8. Pelayanan retriaksi obat kronis: penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Penunjang Lab dan Hasil Pemeriksaan Lab dimunculkan saat DPJP input e-resep; Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		9. Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu : a. Format laporan berkas obat kronis, berisi : nomor, tanggal registrasi, no. registrasi, no. rm, nama pasien, unit asal, nama dokter, no. sep, nama obat, hasil pemeriksaan penunjang. Tujuan untuk memudahkan farmasi melihat kelengkapan berkas klaim obat kronis yaitu Resep, SEP, Hasil Pemeriksaan Penunjang	Pengajuan fitur ke progamer.

			b. Format laporan resep iter, berisi : nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/ belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		10. Penambahan fitur warning di SIMRS DPJP “Pasien tidak ambil obat”	Pengajuan form penambahan fitur warning di SIMRS DPJP “Pasien tidak ambil obat” untuk mengurangi retur obat tertinggal.	Pengajuan fitur ke progamer.
		11. Ruang handrub	a. Penambahan ruang handrub pada tanggal 28 mei 2025 untuk pengisian botol cairan handrub yang habis di ruangan agar meminimalkan mikroorganisme. b. Pengisian handrub dilakukan oleh apoteker. c. Sudah dilakukan sosialisasi pengisian botol handrub oleh komite PPI.	Monitoring dan Evaluasi.
		12. Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik	Alur pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik : a. Melakukan edukasi ke pasien terkait harga vaksin dan biaya jasa dokter kemudian	Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik

			dibuatkan copy resep manual (yang berisi identitas pasien, nama vaksin, jumlah dan no telfon pasien) b. Pasien diarahkan ke kasir untuk pembayaran. c. Order vaksin ke gudang farmasi. d. Ketika vaksin datang akan dihubungi oleh marketing. e. Farmasi melakukan cetak nota pasien dan follow up kepada kasir untuk pelunasan berdasarkan kwitansi manual sebelumnya. d. Pasien melakukan suntik di poli vaksin.	
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024. c. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer. d. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024. e. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer.	Rencana trial menunggu Programmer PT
		2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. b. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Sudah berjalan. Follow up pengadaan katrol.
3.	Floorstok IKO	Perbaikan sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : a. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu :	Monitoring dan Evaluasi.

			- Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang dimasukkan dalam list floorstok. - Perbaikan alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP. - Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO. - Koordinasi dengan karu IKO penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing. - Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. b. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu : - Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis	
--	--	--	--	--

			resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai. - Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi oleh perawat di SIMRS. c. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. d. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan selisih stok → Petugas IKO diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstok ke depo farmasi). - Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan sesuai tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstok iko.	
--	--	--	--	--

			- Jumlah stok di sistem Floorstok IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan operasi sehingga tidak perawat tidak input ke pasien. e. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan dan atau kurang → Melakukan stok opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan atau kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 : a. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan.	
--	--	--	--	--

			b. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. c. Sistem stok IKO sudah dikunci. d. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. e. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans “farmasi” bukan fitur “floor stok unit” sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan. Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan permintaan FS ketika malam hari karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan random stok dan ditemukan selisih stok lebih di sistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok	
--	--	--	--	--

			simrs 0 maka farmasi mengecek stok yang ada didepo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada diinputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke perawat untuk diinputkan kembali. Resep akan dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat. f. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok opname. Data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programmer langsung merubah dan sistem di lock. - Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi	
--	--	--	---	--

			→ perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. g. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar Operasi Kepada Instalasi Farmasi. h. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. i. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. j. Ada petugas farmasi di IKO	
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA). 3. Kirim ke Satu Sehat untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	Poli gizi dan kia belum menjalankan ERM Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap.	1. Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan ERM. 2. Beberapa kendala teknis dan keterbatasan SDM dalam penggunaan sistem. Monitoring dan Evaluasi.

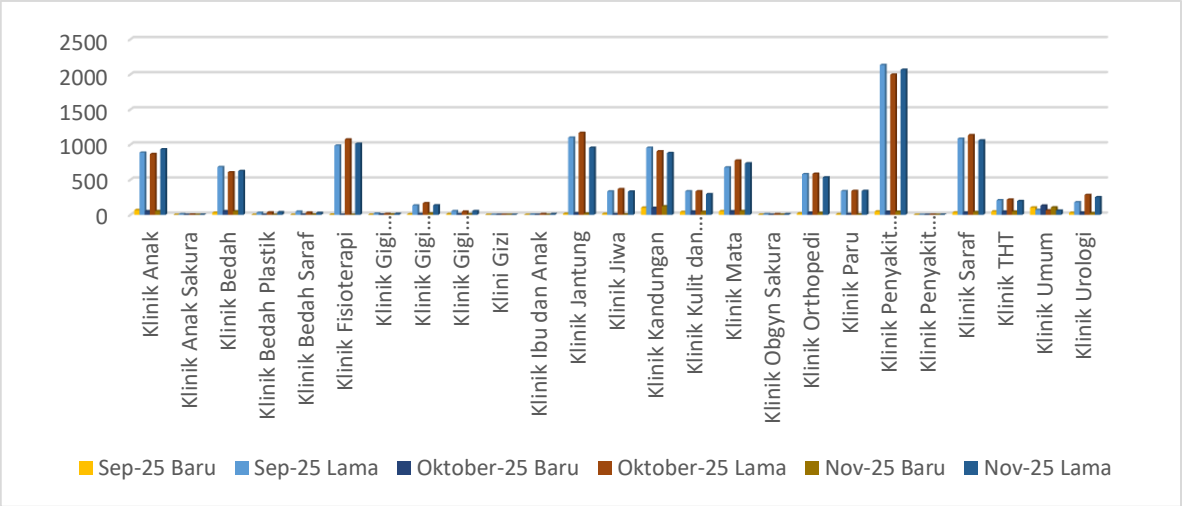
			TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	
		4. Formulir rekapitulasi kegiatan pelayanan laboratorium pada SIMRS	Rekapitulasi jumlah pemeriksaan lab dengan kriteria jenis kelamin dan hasil nilai rata-rata pemeriksaan lab	Keterlambatan pengisian pada web SIRS online → Follow up ke Programmer untuk update fitur di SIMRS

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

No	Nama Unit	September			Oktober			November		
		Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total
1	Klinik Anak	68	886	954	52	866	918	54	934	988
2	Klinik Anak Sakura	1	8	9	1	4	5	0	2	2
3	Klinik Bedah	31	681	712	51	606	657	50	624	674
4	Klinik Bedah Plastik	1	30	31	1	35	36	1	38	39
5	Klinik Bedah Saraf	1	46	47	2	33	35	3	28	31
6	Klinik Fisioterapi	3	987	990	1	1074	1075	0	1012	1012
7	Klinik Gigi Ortodonti	2	17	19	3	13	16	5	14	19
8	Klinik Gigi Pedodontis	9	134	143	11	166	177	19	135	154
9	Klinik Gigi Periodonti	10	54	64	8	46	54	8	53	61
10	Klini Gizi	0	0	0	0	1	1	0	0	0
11	Klinik Ibu dan Anak	0	3	3	0	11	11	0	10	10
12	Klinik Jantung	15	1099	1114	23	1167	1190	17	955	972
13	Klinik Jiwa	14	333	347	8	366	374	5	331	336
14	Klinik Kandungan	102	956	1058	99	905	1004	122	880	1002
15	Klinik Kulit dan Kelamin	42	336	378	46	335	381	43	294	337
16	Klinik Mata	52	675	727	49	773	822	54	733	787
17	Klinik Obgyn Sakura	2	9	11	1	8	9	2	8	10
18	Klinik Orthopedi	20	580	600	31	584	615	27	533	560
19	Klinik Paru	8	337	345	10	340	350	5	340	345
20	Klinik Penyakit Dalam	48	2134	2182	44	1996	2040	44	2066	2110
21	Klinik Penyakit Dalam Sakura	0	1	1	1	2	3	0	2	2
22	Klinik Saraf	35	1084	1119	33	1135	1168	40	1059	1099
23	Klinik THT	48	208	256	46	217	263	46	196	242
24	Klinik Umum	104	70	174	132	64	196	107	60	167
25	Klinik Urologi	29	180	209	33	283	316	25	252	277



Analisis :

- 1. Kunjungan pasien rawat jalan Oktober ke November 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 4%
- 2. Kunjungan tertinggi : Poli Penyakit Dalam dengan kunjungan 2110 pasien
- 3. Kenaikan tertinggi : Poli Gigi Ortodonti dengan peningkatan sebesar 19%
- 4. Penurunan tertinggi : Poli Anak sakura dengan penurunan signifikan sebesar 60%

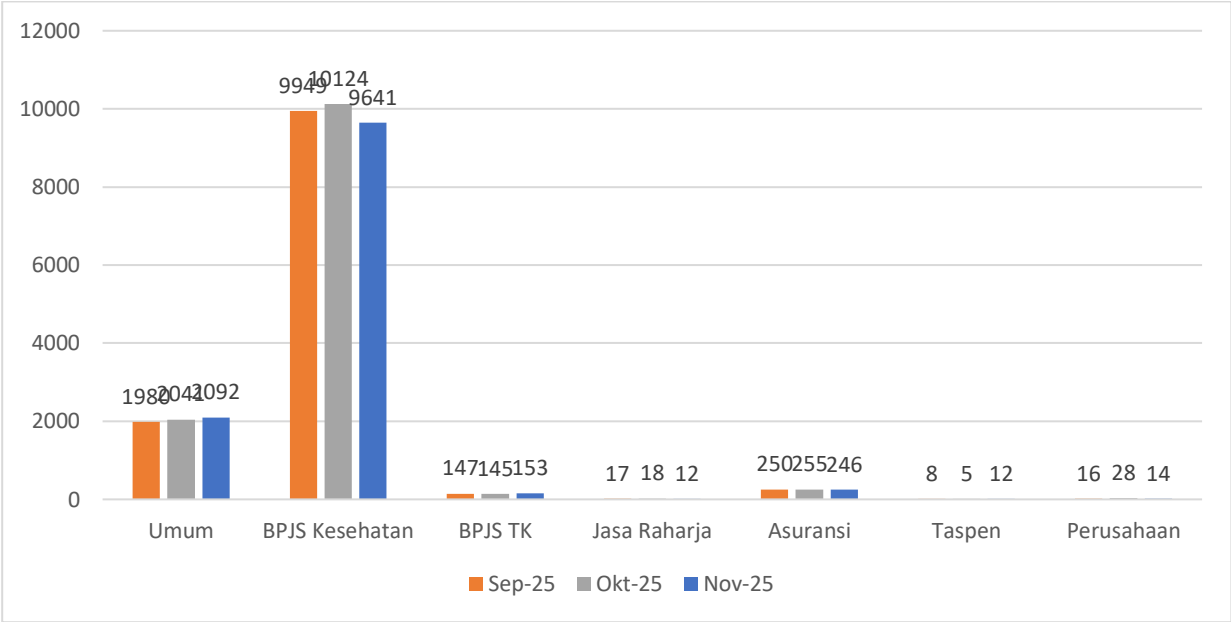
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
- 2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum, asuransi tentang pelayanan poli Sakura
- 3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
- 4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
- 5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- 7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	SEP-25	%	OKT-25	%	NOV-25	%
1	Umum	1964	15,87%	1980	16,01%	2041	16,18%
2	BPJS Kesehatan	9965	80,51%	9949	80,45%	10124	80,25%
3	JKK	154	1,24%	147	1,19%	145	1,15%
4	Jasa raharja	10	0,08%	17	0,14%	18	0,14%
5	Asuransi swasta	261	2,11%	250	2,02%	255	2,02%
6	Perusahaan	3	0,02%	8	0,06%	5	0,04%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	20	0,16%	16	0,13%	28	0,22%
	Total	12377	100%	12367	100%	12616	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
Kunjungan poli dengan cara bayar tertinggi yaitu BPJS Kesehatan sejumlah 9641 pasien, mengalami penurunan dari Bulan Oktober ke November

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

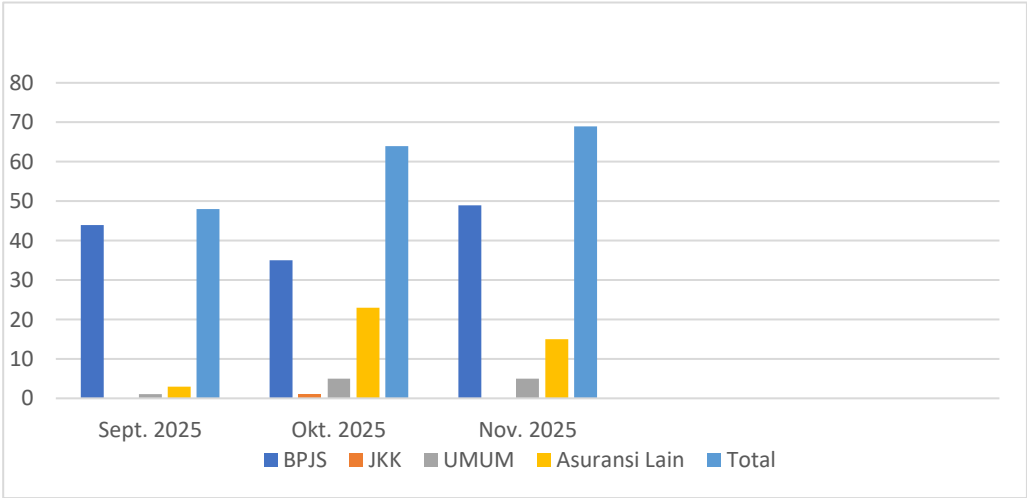
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September – November 2025)

NO	HAL	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	44	35	49	40%
2	JKK	0	1	0	100%
3	Umum	1	5	5	100%
4	Asuransi Lain	3	23	15	34,78%
Total Pasien		48	64	69	7,81%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (September – November 2025)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Sept.2025	44	1	0	3	48
	Analisa	Bulan september pasien BPJS bertahan di angka 44	Bulan september pasien umum turun menjadi 1	Pasien JKK tdk ada yg naik kelas	Untuk pasien asuransi menurun drastic dari 20 menjadi 3 dikarenakan banyak pasien yg menggunakan BPJS dan COB dengan asuransi	Total bulan September jumlah pasien emnurun drastic dari 71 menjadi 48 dikarenakan banyak yg sesuai kelas dan memilih dikelas 3 atau 2
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
2	Okt.2025	35	5	1	23	64
	Analisa	Bulan September pasien BPJS mengalami penurunan dari 44 menjadi 35	Bulan September pasien Umum naik dari 1 menjadi 5	Pasien JKK bulan September ada 1 karena pasien naik VIP	Untuk pasien asuransi di bulan September naik drastic dari 3 menjasi 23	Total bulan September jumlah pasien mengalami kenaikan lagi dari 48 menjadi 64
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
3	NOVEMBER 2025	49	5	0	15	69
	Analisa	Bulan November pasien BPJS mengalami kenaikan dari	Bulan November pasien umum stabil diangka 5	Pasien JKK bulan November kosong. Karena	Pasien asuransi di bulan November mengalami penurunan	Bulan November total pasien mengalami kenaikan yg

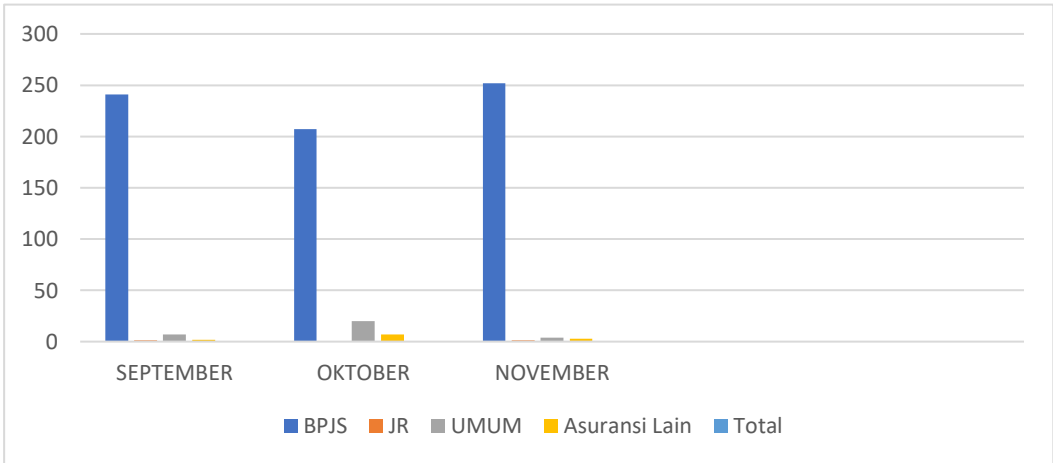
		35 menjadi 49		tidak ada pasien JKK yg naik kelas	karena pasien banyak yg memakai BPJS dan COB dengan asuransi	segnifkan daro 64 menjadi 69
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (September - November 2025)

NO	HAL	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	241	207	252	↑17,8
2	JR	1	0	1	↑100%
3	Umum	7	20	4	↓40%
4	Asuransi Lain	2	7	3	↓13
Total Pasien		251	234	260	↑10%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS ada peningkatan selama 3 bulan terakhir pada bulan November 2025 Sebesar 17,8%	Pasien Umum mengalami peningkatan n di bulan Oktober sebanyak 65% dan mengalami penurunan di bulan november sebesar	Pasien JR dari 3 bulan terakhir tetap Dikarenaka KLL kebanyakan tunggal dan jatuh sendiri	Pasien Asuransi mengalami kenaikan 71,4% di bulan Oktober dan mengalami penurunan di bulan november sebesar 13% Karena rata-rata pasien	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak terjadi di bulan juli peningkatan di setiap bulannya yaitu 291 dan mengalami penurunan di bulan agustus

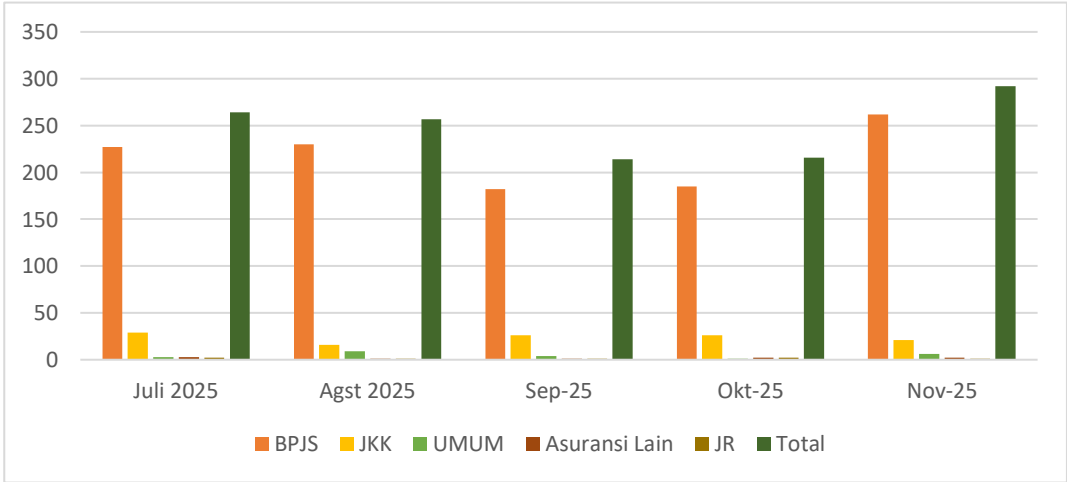
			40% Dikarenaka n pasien sudah memiliki BPJS semua		menggunakan penjamin BPJS	sebanyak 15% yaitu 254 Serta mengalami seddikit penurunan lagi di bulan September sebanyak 1,2% Dan mengalami penurunan di bulan oktober sebanyak 7,2% Serta mengalami peningkatan di bulan November sebesar 10%
	RTL	a) Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya b) Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2025)

NO	HAL	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	182	185	262	↑ 41,62 %
2	JKK	26	26	21	↓ 19,23% %
3	Umum	4	1	6	100%
4	Asuransi Lain	1	2	2	100 %
5	JR	1	2	1	↓ 50 %
Total Pasien		214	216	292	↑ 35,18 %

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2025)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	

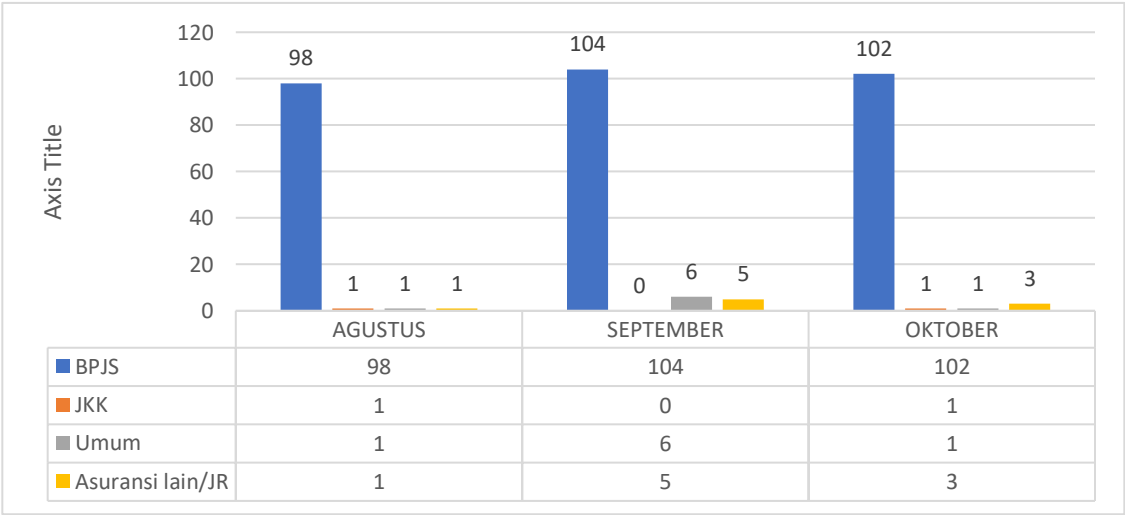
1	Analisis capaian November 2025	Pasien BPJS mengalami peningkatan pada bulan November 2025 sebesar 41,62%	Pasien Umum pada bulan November 2025 mengalami penurunan yaitu sebanyak 92,23%	Jumlah Pasien JKK pada bulan November mengalami penurunan yaitu sebanyak 19,23%	Jumlah Pasien JR pada bulan November mengalami penurunan 50% dan asuransi lain naik 100%	Peningkatan jumlah pasien di bulan November 2025 dengan jumlah pasien sebanyak 35,18 %
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Untuk Irna 3A sementara tutup dan dialihkan ke Irna 2A sehingga pasien menurun				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(September - November 2025)

NO	HAL	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	98	104	102	↓1,96
2	JKK	1	0	1	↑100%
3	Umum	1	6	1	↓83,33%
4	Asuransi Lain	1	5	3	↓40%
Total Pasien		101	115	107	↓7,47%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(September - November 2025)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	

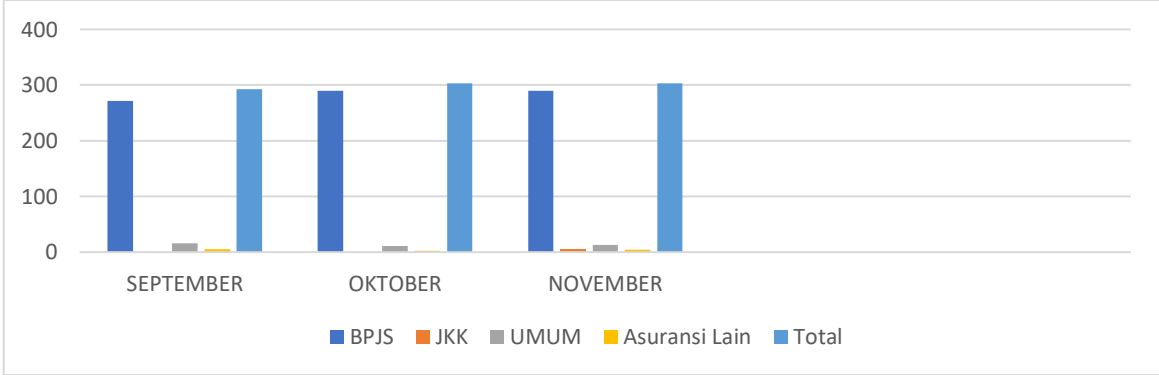
1	Analisis capaian September 2025	Total Pasien BPJS mengalami penurunan sebanyak ↓9% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum sama dengan kunjungan bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan ↓67% dari bulan sebelumnya	Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak ↓21% dari bulan sebelumnya	Pada bulan September untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↓27%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
2	Analisis capaian Oktober 2025	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑6% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak ↑83% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan ↓100% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak ↑80% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Oktober untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑12%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
3	Analisis capaian November 2025	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↓1,96% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak ↑100% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan ↓83,33% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak ↓40% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Oktober untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↓7,47%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - Npvember 2025)

NO	PENJAMIN	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	272	290	290	Sama dengan bulan sebelumnya
2	JKK	0	0	4	↑ 100%
3	Umum	16	11	13	↑ 18,18%
4	Asuransi Lain	5	2	4	↑ 50%
Total Pasien		293	303	311	↑ 0,96%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - Npvenber 2025)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

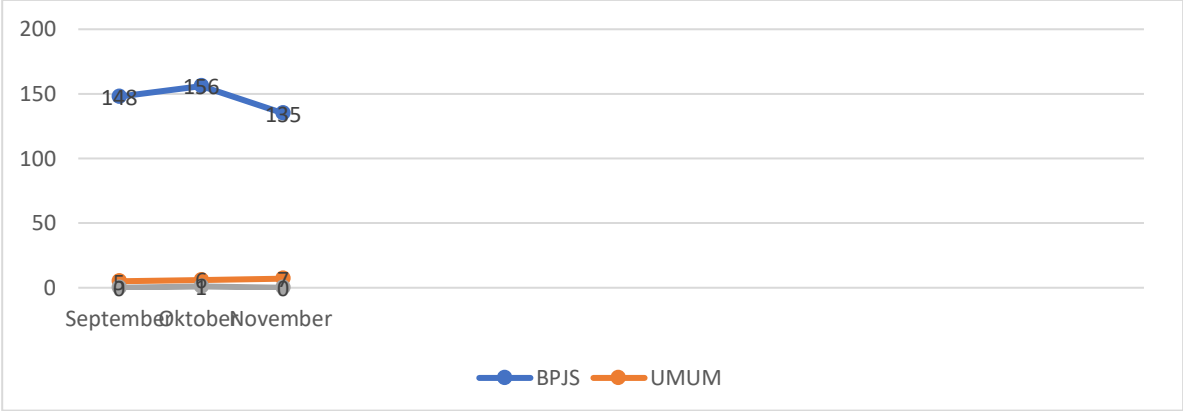
NO	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	Umum	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami terjadi penurunan pada bulan September 2025 yaitu sebanyak 272 pasien	Pasien Umum mengalami penurnan pada bulan September 2025 yaitu sebanyak 16 pasien	Pasien JKK mengalami peningkatan pada bulan November 2025 Oktober 2025	Jumlah pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan pada bulan September 2025	Penurunan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak pada bulan September dengan jumlah pasien sebanyak 293 pasien.
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - Npvenber 2025)

NO	HAL	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	148	156	135	↓ 13,46%
2	Umum	5	6	7	↑ 100%
3	Asuransi	0	1	0	↓ 0%
Total Pasien		153	163	143	↓ 12,26%

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - Npvmber 2025)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

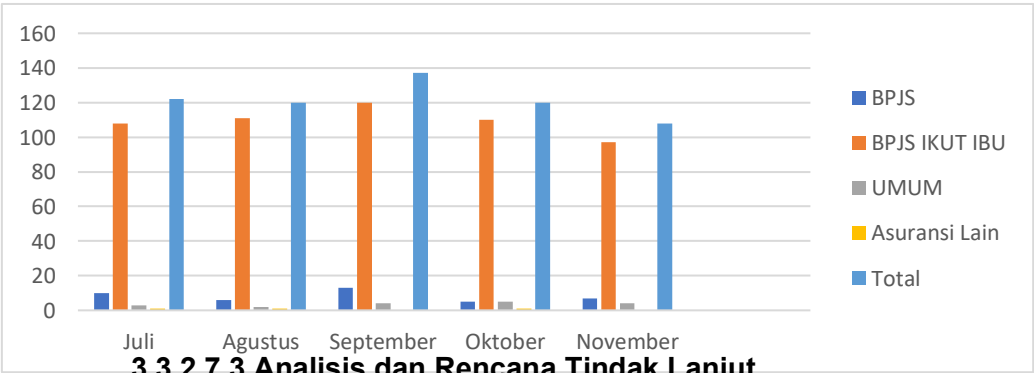
NO	BULAN	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Bulan Septemver-November	Pasien BPJS pada bulan November mengalami penurunan 13,5%	Pasien umum pada bulan November Mengalami kenaikan 100%	Tidak ada Pasien Asuransi pada bulan November	Kunjungan naik dengan bulan sebelumnya. Selalu melakukan Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2025)

NO	HAL	TARGET/BULAN	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	13	5	7	↑6,5%
2	Umum	2	4	5	4	↓3,7%
3	Asuransi Lain	1	0	1	0	0
4	BPJS IKUT IBU	100	120	109	97	↓11%
Total Pasien		110	137	120	108	↓10%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar September - November 2025)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT	

					IBU	
1	September	13	4	0	120	137
		Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 9,5%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,9%	Tidakada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 87,6%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
2	Oktober	5	5	1	109	120
		Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 6,8%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,3%	Ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 14,16%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
3	November 2025	7	4	0	97	108
		Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 6,5%	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,7%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 11%	
		Meningkatkan	Meningkatkan	Bekerjasama	Meningkatkan	

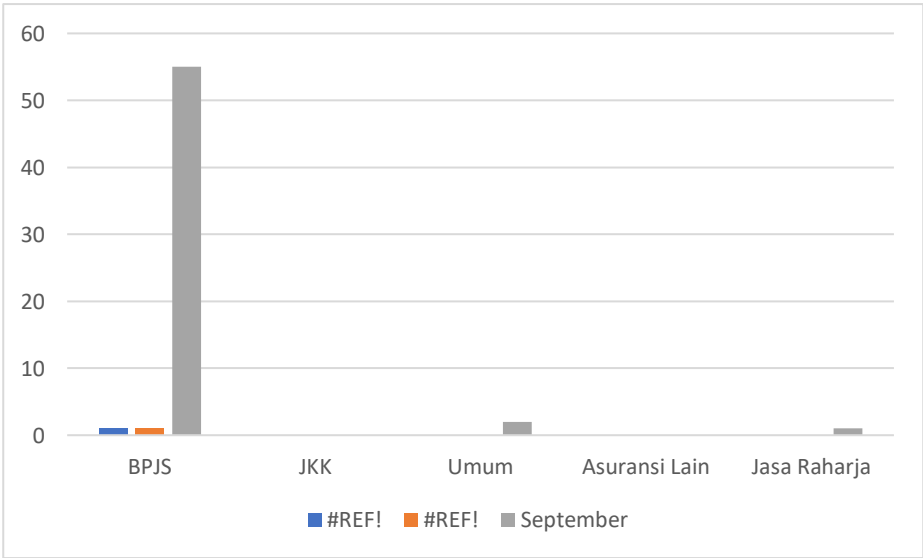
		pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	dengan IGD untuk promosi kesehatan	pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
--	--	---	---	------------------------------------	--	--

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2025)

NO	PENJAMIN	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	55	34	49	↑0,44%
2	JKK	0	0	1	↑100%
3	Umum	2	2	0	↓100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	1	0	1	↑100%
Total Pasien		58	36	51	↑0,42 %

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2025)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Oktober 2025 mengalami	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan bulan Oktober	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan November 2025 tidak ada kunjungan,	Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada mengalami kenaikan sebesar

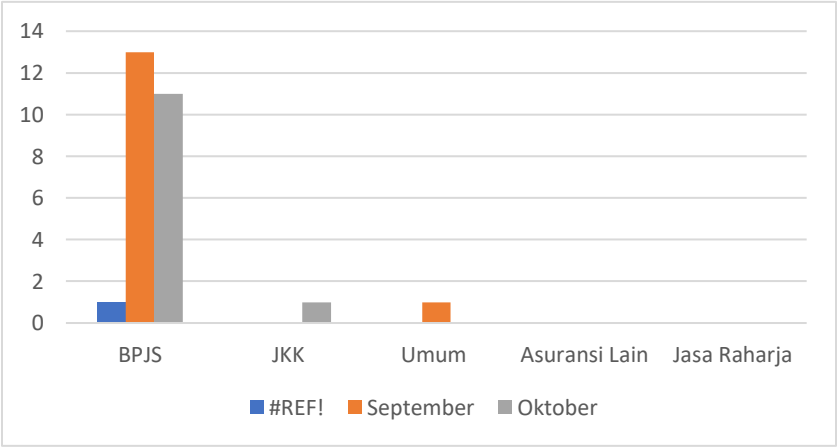
		penurunan 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya	dibandingkan bulan dengan bulan sebelumnya			0,05% dibandingkan dari bulan sebelumnya karena pasien yang perawatan di ruang ICU adalah sebagian pasien jantung
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2025)

NO	HAL	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	13	11	27	↑1,45%
2	JKK	0	1	0	↓100%
3	Umum	1	0	1	↑100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	0	0	0	Tetap
Total Pasien		14	12	28	↑1,33%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN AGUSTUS	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan November 2025 mengalami kenaikan di bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan November 2025 mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi bulan Npember 2025 tidak ada pasien	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada tetap dari bulan sebelumnya

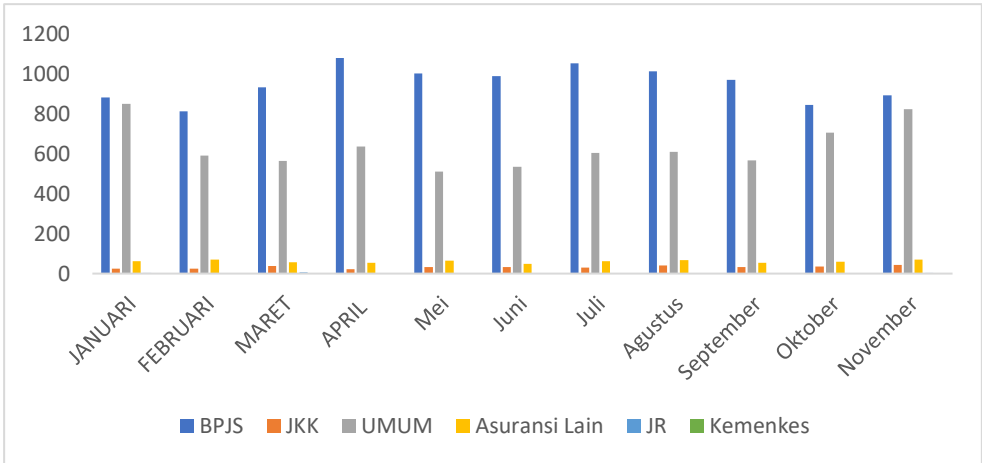
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat	
---	-----	--	--

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2025)

NO	HAL	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	967	844	890	↑ 5,1%
2	JKK	565	705	822	↑ 14,2 %
3	Umum	34	36	44	↑18,1 %
4	Asuransi Lain	54	60	70	↑ 14,2%
5	JR	0	0	3	↑300%
Total Pasien		1602	1645	1805	↑ 8,8 %

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Tahun 2025



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	BULAN	INSTALASI GAWAT DARURAT					
1	Septembe r	BPJS	UMUM	JKK	ASURANSI	JR	TOTAL PASIEN
	Analisis	Kunjungan pasien BPJS di IGD kenaikan dibandingkan bulan November 2025 banyaknya rujukan dari luar yang di tolak terkait fasilitas dan untuk kunjungan menurun,pen urunan ini	Kunjungan pasien UMUM di IGD mengalami kenaikan pada bulan November 2025	JKK mencatat kenaikan 14,2 % dibandingkan bulan sebelumnya	Asuransi Lain mencatat kenaikan 14,2 % dibandingkan bulan sebelumnya.	Terdapat 3 pasien pada bulan November.	Terjadi kenaikan total kunjungan pasien sebesar 8,8 % % dari Oktober ke November

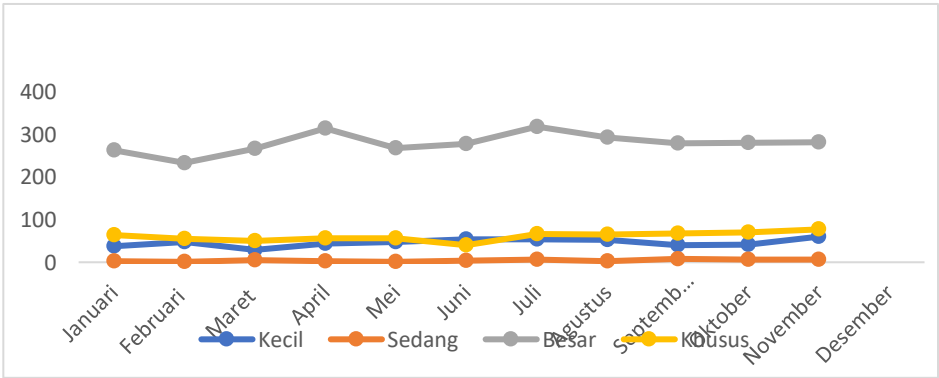
		juga di sebabkan banyaknya pendingan pasien TF sehingga membatasi pasien terkait TF					
	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (September - November 2025)

NO	HAL	SEPTEMBER 2025				OKTOBER 2025				NOVEMBER 2025			
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh
1	BPJS	40	8	269	31	39	3	264	43	57	4	264	37
2	JR	0	0	1	3	0	0	3	6	0	0	0	1
3	Umum	0	0	5	9	1	2	11	16	3	2	11	12
4	Asuransi Lain	0	0	2	2	1	1	3	4	0	0	4	5
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BPJS TK	0	0	2	23	0	0	0	22	0	0	4	5
	Total Pasien	395				397				424			

3.1.4.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin 2025



3.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	INSTALASI KAMAR OPERASI			
1	NOVEMBER	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
	Analisis	Jumlah pasien mata dibagi setiap bulannya jadi jika tidak ada kendala jumlah pasien operasi kecil relative tetap namun di bulan September DPJP sempat sakit sehingga pasien operasi kecil ditunda	Pasien Iridectomy meningkat	Pasien cito dari IGD tidak sebanyak bulan sebelumnya, jumlah pasien loadingan dari poli juga menurun	Jumlah pasien urologi dan jkk meningkat.
	RTL	Tingkatkan capaian dengan mengawal pasien-pasien yang menunda dilakukan tindakan	Meningkatkan capaian dengan sosiali ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Memilah pasien-pasien di IGD yang benar-benar bisa dilakukan tindakan di sini agar dikerjakan di sini dan tidak dirujuk	Pertahankan capaian dengan memberikan pelayanan kepada pasien agar pasien-pasien kecelakaan kerja tetap dibawa ke RSPHM.

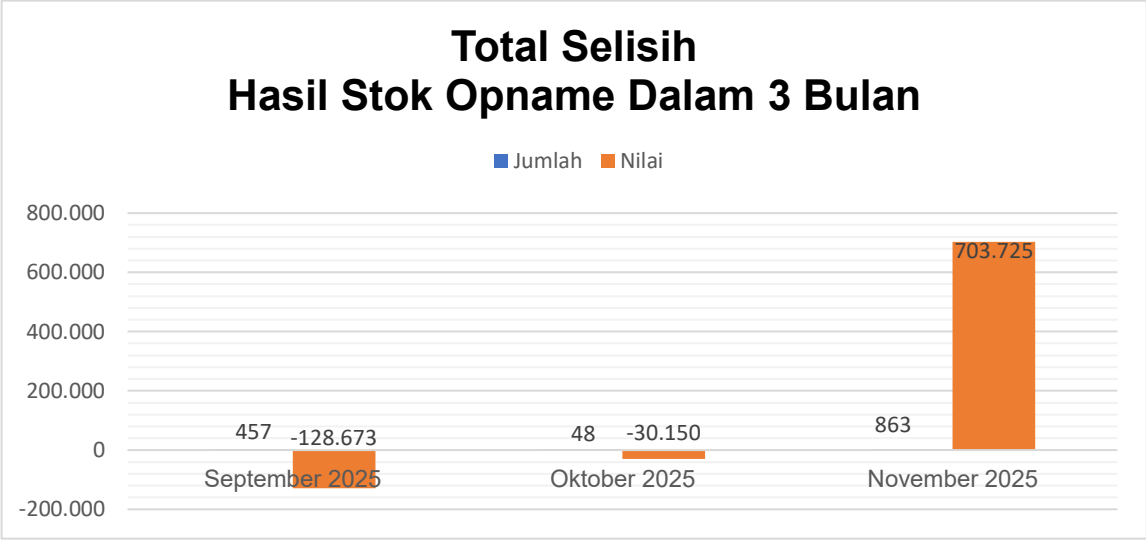
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi September - November 2025

Unit	Stok	September 2025		Oktober 2025		November 2025	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
GUDAN G	Fisik	752.721	1.527.749.098	843.653	1.625.961.714	837.290	1.658.488.290
	Sistem	752.621	1.527.722.972	843.553	1.625.961.714	837.289	1.658.452.110
	Selisih	+100	+26.126	+100	0	+1	+36.180
DEPO FARMASI	Fisik	288.883	680.780.122	252.706	603.601.797	242.459	632.482.479
	Sistem	288.526	680.934.921	252.758	603.631.947	241.597	631.814.934
	Selisih	+357	-154.799	-52	-30.150	+862	+667.545
IKO	Fisik	2.548	93.388.930	2.427	89.711.385	2.640	89.254.399
	Sistem	2.548	93.388.930	2.427	89.711.385	2.640	89.254.399
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		+457	-128.673	+48	-30.150	+863	+703.725

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi September - November 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

NO	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
Gudang Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih jauh dari target (0) yaitu sebesar Rp +36.180 , hal ini disebabkan karena :		
1	Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan	Supervisi secara berkala
2	F04637 Imunkid syrup – novell selisih lebih 1 flash karena kesalahan jumlah barang disiapkan.	1. Penggunaan scan barcode atau RFID dalam proses serah terima barang → follow up ke programmer terkait dengan program scan. 2. Pelaksanaan double check oleh petugas gudang dan unit. 3. Dilakukan retur barang unit jika tidak diambil oleh unit.
3	F00366 Human Albumin 20% tidak terinput stok opname, karena pengadaan mengaktifkan master F00366 namun belum menambahkan rak kulkas pada sistem yang seharusnya bisa menggunakan master barang F00112 Cairan Inf Human Albumin 20% - Kimia Farma sehingga terjadi double master.	Pengadaan koordinasi ke kains untuk melakukan double check master barang ketika diaktifkan.
Depo Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih jauh dari target (0) yaitu sebesar Rp +667.545 , hal ini disebabkan karena :		
1	Ketidaksesuaian dalam proses INPUT dan SIAP menyebabkan kesalahan dalam jumlah obat yang di input dan disiapkan, yang seharusnya dapat dihindari dengan melakukan double check.	1. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan. 2. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala. 3. Monitoring dan evaluasi oleh Kabid terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. Jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki.
2	Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD menggunakan resep manual dengan inputan resep di SIMRS, seperti : F01986 Sput 10 cc - gidcare = -31 F01984 Sput 1 cc – onemed = +11 F01992 Sput 5 cc - gidcare = +6	1. Penegasan kembali kepada perawat IGD terkait kewajiban penulisan resep yang sesuai → kolaborasi dengan Karu IGD. 2. Petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan dan supervisi oleh kains farmasi. 3. Perbaikan alur resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double

		crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan.
3	Selisih lebih terjadi karena proses retur ODD harian yang tidak optimal dari rawat inap (Resep ODD harian tidak diinput retur di SIMRS oleh perawat IRNA sementara pasien sudah KRS).	1. Dilakukan pemahaman kembali proses return sesuai alur dan dilakukan supervisi berkala oleh Karu IRNA dan PJ Shift ruangan untuk mengontrol terkait proses return ke farmasi sesuai dengan alur yang sudah di sepakati 2. Melakukan double crosscheck oleh petugas farmasi saat akan melakukan return di supervisi setiap hari oleh kains farmasi 3. Melakukan audit dan evaluasi berkala oleh Kabid keperawatan dan Kabid penunjang terkait obat-obatan yang belum tereturn sesuai dengan alur
4	Kesalahan dalam perhitungan buffer stok tidak sesuai: F00631 Pregabalin 75 mg - hexpharm jaya = +196 F00676 Risperidone tab 2 mg - nulab = +196 F00716 Spironolactone tab 100 mg - ogb dexta = +184	1. Perbaikan penataan ulang buffer stok sesuai rak di ruang buffer stok (sesuai alfabetis dan penggolongan obat). 2. Penambahan lemari buffer stok di ruang buffer agar buffer tidak di tumpuk di dalam kardus.
5	F00798 Vaksin Menivax Meningitis - Biofarma secara fisik tidak ada pada depo farmasi, tetapi pada sistem terdapat stok 9 vial saat hari H SO. Hal ini disebabkan rencana trial input resep melalui simrs pada tgl 12/11/2025 ternyata ERM rawat jalan tidak support untuk input resep karena harus input diagnosa dll namun gudang dan kains lupa tidak retur secara sistem ke gudang sehingga stok simrs nandon di depo.	1. Membuat berita acara penyesuaian SO.
6	F01395 Foley Cath Silicon No 12 - Rusch ditemukan pada kertas kerja 8 pcs namun stok di SIMRS 13 pcs, dilakukan verifikasi ulang fisik 8 pcs (farmasi tidak teliiti mencari barang selisish). Kemudian kains melakukan telusur ditemukan tiap bulan Foley Cath Silicon No 12 – Rusch tidak pernah ada selisih dan pengeluaran barang karena termasuk barang slow moving dan di cek rak alkes ditemukan 5 pcs yang tercampur dengan ukuran lain sehingga tidak terhitung saat proses verifikasi.	1. Meningkatkan ketelitian petugas dalam perhitungan SO. 2. Membuat berita acara penyesuaian SO.
IKO : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :		
1	Perawat patuh melakukan input resep; retur penjualan barang yang tidak terpakai sudah rutin dilakukan; tidak ada anomali data di SIMRS	Supervisi secara berkala

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan November 2025 - Mei 2026)

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Laporan Penjualan Mar 24 - Nov 25
							Sept	Okt	Nov		
1.	F01390	Foley cath no 20 - rusch	Pcs	20.570	30/11/2025	P20L04	22	20	17	308.550	21
2.	F01395	Foley cath silicon no 12 - rusch	Pcs	77.000	30/01/2026	KME21B1823	19	19	19	1.078.000	3
3.	F00558	Obat suntik kb 1 - harsen (hibah)	Vial	0	30/01/2026	3A020100	28	48	34	0	187
4.	F04628	Ethambutol tab 250 mg (hibah) -	Tab	-	28/02/2026	T24605	44	186	228	-	887
5.	F00395	Isoniazid tab 300 mg (hibah) - kimia farma	Tab	-	28/02/2026	P40360N	1.347	1.305	1.214	-	575
6.	F00514	Nebacetin powder 5 g - pharos	Btl	23.000	28/02/2026	Y3B054A	4	4	3	92.000	4
7.	F02878	Ts. Silicone. l/a str (tip ia silicone lurus) - sp212 -alcon	PCS	990.000	28/02/2026	15N4RO	2	2	2	1.980.000	0 (BMHP)
8.	F00968	Benang t-vio 2-0 v9 - triton	Pcs	83.000	30/03/2026	23030460	12	11	10	830.000	65
9.	F00115	Cairan inf kaen mg3 500 ml - otsuka	Flash	13.656	30/03/2026	G87C54A	27	27	25	355.056	55
10.	F01382	Foley cath 3 way no 20 - rusch	Pcs	83.625	30/03/2026	183430	10	10	10	836.250	31
11.	F00517	Neostigmine inj 0.5 mg/ml - ethica	Amp	10.901	30/03/2026	E23C0063A	10	10	6	65.406	12 (Depo Farmasi)
12.	F00450	Lixiana tab 30 mg - kalbe	Tab	25.000	30/03/2026	353698	75	75	75	1.875.000	0
13.	F04488	Norepinephrine inj 1 mg/ml - bernofarm	Amp	14.680	30/03/2026	26B114	5	5	5	73.400	2.652
14.	F00517	Neostigmine inj 05 mg/ml - ethica	Amp	10.901	30/04/2026	E24D0116A	10	10	10	109.010	Gudang Farmasi
15.	F00944	Benang t-mono 6-0 m54 - triton	Pcs	144.000	30/04/2026	230405CF	23	21	28	4.032.000	30
16.	F00542	Ntg inj 1 mg/ml - ferron	VIAL	58.500	30/04/2026	BN4340550B	2	2	1	58.500	57
17.	F00701	Sequest susp 40 g - novell	Sach	19.250	30/04/2026	256269	31	27	27	519.750	42
18.	F00807	Vaksin synflorix 0.5 ml - gsk	VIAL	616.801	30/04/2026	ASPNB362AF	2	2	2	1.233.602	8
TOTAL										10.936.991	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan November 2025 - Mei 2026)

NO	ANALISIS	TINDAK LANJUT
1	Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan November 2025 - Mei 2026 karena obat dan alkes slow moving: 1. Foley cath no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 24/09/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 2. Foley cath silicon no 12 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/02/2023 dari distributor sejumlah 20 pcs. 3. Obat suntik kb 1 - harsen (hibah) sebagai obat KB. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari BKKBN dengan ed < 1 tahun pada tanggal 22/08/2025 sejumlah 40 vial. 4. Ethambutol tab 250 mg (hibah) untuk terapi tuberculosis. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 24/05/2025 sejumlah 224 tablet. 5. Isoniazid tab 300 mg (hibah) - kimia farma untuk terapi tuberculosis. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 24/05/2025 sejumlah 300 tablet. 6. Nebacetin powder 5 g – pharos digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi kulit superfisial (permukaan) yang disebabkan oleh bakteri. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 16/06/2023 dari distributor sejumlah 5 botol. 7. Ts. Silicone. I/a str (tip ia silicone lurus) - sp212 –alcon untuk sparepart instrumen phaco. Faktur pembelian terakhir tanggal 06/11/2025 dari distributor sejumlah 2 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 8. Benang t-vio 2-0 v9 – triton digunakan untuk operasi. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/03/2023 dari distributor sejumlah 48 pcs. 9. Cairan inf kaen mg3 500 ml – otsuka digunakan untuk membantu pengobatan ketidakseimbangan karbohidrat dan elektrolit pada keadaan insufisiensi asupan makanan per oral, prosedur pembedahan, neonatologi, dan asidosis diabetikum. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 13/01/2025 dari distributor sejumlah 20 flash. 10. Foley cath 3 way no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/06/2024 dari distributor sejumlah 20 pcs. 11. Neostigmine inj 0.5 mg/ml – ethica meringankan gejala myasthenia gravis, ileus paralitik, atau retensi urine pascaoperasi, serta menghilangkan efek obat bius pascaoperasi. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 28/11/2024 dari distributor sejumlah 10 amp.	1. Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 4. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 5. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS. 6. Floorstok IKO yang slow moving di tukar dengan ED jauh.

12. Lixiana tab 30 mg – kalbe untuk gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah, penyumbatan pada paru-paru, serta mencegah stroke. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/09/2021 dari distributor sejumlah 84 tablet. 13. Norepinephrine inj 1 mg/ml – bernofarm untuk mengatasi hipotensi yang mengancam nyawa dan menangani kondisi henti jantung dan syok septik. Terdapat obat slow moving di IKO. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/02/2025 dari distributor sejumlah 300 amp. 14. Benang t-mono 6-0 m54 – triton digunakan untuk operasi. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 07/08/2025 dari distributor sejumlah 12 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 15. Ntg inj 1 mg/ml – ferron untuk gagal jantung kongestif yang tidak responsif karena infark miokard akut, angina tidak stabil yang sulit disembuhkan dengan beta blocker dan nitrat sublingual. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari RSPH Sukorejo pada tanggal 21/08/2025. 16. Sequest susp 40 g – novell untuk terapi tambahan untuk menurunkan kadar kolesterol serum pada pasien dengan hiperkolesterolemia primer yang tidak menunjukkan respon terhadap kontrol makanan, menurunkan kadar kolesterol pada pasien dengan hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia, mengurangi pruritus pada obstruksi parsial pada saluran empedu, terapi tambahan dengan terapi rehidrasi pada diare karena malabsorpsi asam empedu, reseksi usus, penyakit Chron, vagotomi, dan neuropati vagal diabetikum. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/06/2024 dari distributor sejumlah 40 sachet. 17. Vaksin synflorix 0.5 ml – gsk mencegah infeksi pneumokokal. Vaksin sudah di bayar lunas oleh pasien namun belum disuntikkan. Faktur pembelian terakhir tanggal 03/07/2025 dari distributor sejumlah 1 vial.	
---	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter
2	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah Tenaga Vokasi Farmasi/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
3	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
4	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi

															petugas
5	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
6	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
7	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
8	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
9	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas

10	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
----	------	--	--------	--------	------------------------------------	--------------------------	---	---------	----------------------	-------	--------------------------	----------------------	---	--	---

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan November 2025

NO	INSTALASI	UMUM	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	ASURANSI SWASTA	JASA RAHARJA	TOTAL
1	Instalasi Rawat Inap						
	Jumlah Resep Obat Racikan	15	298	0	0	0	313
	Jumlah Resep Obat Jadi	376	7502	0	444	45	8367
	Jumlah Resep Obat	391	7800	0	444	45	8680
2	IGD						
	Jumlah Resep Obat Racikan	96	66	0	0	0	162
	Jumlah Resep Obat Jadi	1036	2130	0	213	20	3399
	Jumlah Resep Obat	1132	2196	0	213	20	3561
3	Instalasi Rawat Jalan						
	Jumlah Resep Obat Racikan	352	1477	0	0	0	1829
	Jumlah Resep Obat Jadi	1022	6349	0	292	5	7668
	Jumlah Resep Obat	1374	7826	0	292	5	9497
4	IKO						
	Jumlah Resep Obat Racikan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Resep Obat Jadi	45	926	0	90	21	1082
	Jumlah Resep Obat	45	926	0	90	21	1082
TOTAL		2942	18.748	0	1039	91	22.820

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Oktober – November 2025



Analisis :

1. Kunjungan pasien Umum pada bulan November 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2025, dengan total resep yaitu : bulan Oktober 2025 sebanyak 2.803 resep umum dan bulan November 2025 sebanyak 2.942 resep umum.

- Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada bulan November 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2025, dengan total resep yaitu : bulan Oktober 2025 sebanyak 18.059 resep BPJS Kesehatan dan bulan November 2025 sebanyak 18.748 resep BPJS Kesehatan.
- Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasa Raharja pada bulan November 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2025 dengan total resep yaitu : bulan Oktober 2025 sebanyak 1.195 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja, sedangkan bulan November 2025 sebanyak 1.130 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja
- Secara keseluruhan total resep pada bulan November 2025 mengalami peningkatan :
 - Adanya pembatasan kunjungan pasien per poli untuk pasien rawat jalan,
 - Adanya target PRB dimana pasien rujuk balik ke FKTP jika pasien sudah stabil di poli,
 - Retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien di poli,
 - Kurangnya promo tarif vaksin di poli,
 - Kurangnya promo tarif poli sakura untuk poli lain,
 - DPJP tidak praktek karena libur,
 - Adanya batasan diagnosa yang tidak bisa di layani di FKRTL untuk pasien IGD,
 - Adanya batasan plafon BPJS Kesehatan sehingga tidak semua obat dapat di cover sesuai kebutuhan pasien dengan pertimbangan biaya obat untuk pasien rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut :

- Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
- Kolaborasi dengan Petugas Pendaftaran untuk menjaring pasien-pasien yang mempunyai jaminan kesehatan lebih dari 1 untuk menggunakan asuransi swasta terlebih dulu.
- Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
- Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
- Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
- Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan September - November 2025

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Sept 25	Okt 25	Nov 25	
1	Pengkajian resep	100%	99,29%	99,53%	99,18%	Jumlah pengkajian resep yaitu September 2025 = 21.197 Oktober 2025 = 22.057 November 2025 = 22.820 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep yaitu September 2025 = 151 Oktober 2025 = 103 November 2025 = 188
2	Dispensing Sediaan Steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.
3	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan

						dalam RM.
4	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	0	Tidak ada kejadian pelaporan efek samping obat
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat
6	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
9	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM.
10	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape
11	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	15	14	16	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur

3.2.1.10 Tabel Analisa dan Tindaklanjut Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan Juli - September 2025

KINERJA	ANALISA	TINDAKLANJUT
Pengkajian Resep	Penulisan resep yang lengkap bulan November 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2025, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Oktober 2025 sebanyak 99,53% dan bulan November 2025 sebanyak 99,18%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : 1. Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS. 2. Dari segi telaah farmasetik : ditemukan 103 resep dimana dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. 3. Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker	1. Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke Depo Farmasi. 2. Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). 3. Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

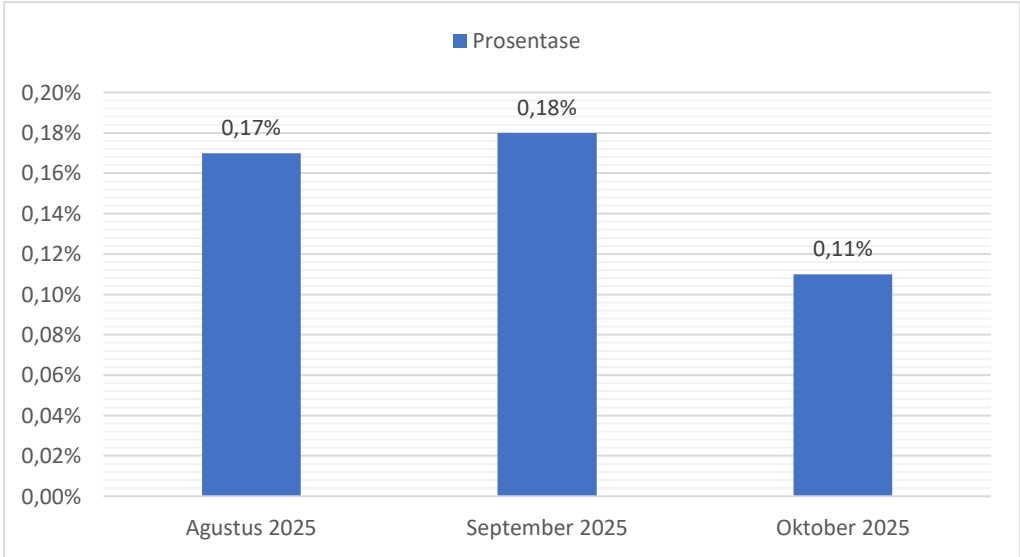
Kejadian Efek Samping Obat	- Hasil monitoring pelaporan MESO bulan November 2025 tidak ditemukan terjadinya efek samping obat. - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien. - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO). - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. - Menganalisa laporan ESO. - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga	- Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi. - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO)	PPA dapat megakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli, dan e-book yang tersedia di SIMRS.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape sudah tersedia di unit pelayanan, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien	Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien November 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Oktober 2025 sebanyak 14 dan bulan November 2025 sebanyak 16. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam, keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama, dan pasien tidak rutin minum obat sehingga obat kunjungan sebelumnya masih ada.	- Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

1.2.1.11 Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada September - November 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/9/2025-30/9/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/9/2025-30/9/2025	Methylegometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase September 2025 = 0.18%					

1	1/10/2025-31/10/2025	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Tanpa saran substitusi
2	1/10/2025-31/10/2025	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Oktober 2025 = 0.11%					
1	1/11/2025-30/11/2025	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	1/11/2025-30/11/2025	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
Total prosentase November 2025 = 0.17%					

1.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Agustus - Oktober 2025



Analisis :

- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Borraginol-N Suppositoria dan Borraginol-S Suppositoria (produk paten originator) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan November 2025

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1	Pemusnahan Obat	-	-	-	Tidak ada pemusnahan
2	BMHP/ Alat Kesehatan	Sput 3 CC	Stera medical(No.	Ruang Irna 2 3 4 A : Jika di buat ngoplos obat	Form keluhan alat kesehatan substandard dari

	Rusak (Substandar)		batch : 01092588)	tarikannya berat. Gampang lepas jika dibuat injeksi Ruang Ina 6 7 8 A : 1. Tarikan dan dorongan spuit berat 2. Jarum kurang tajam 3. Jarum mudah tersumbat Ruang Ina 5C : 1. Susah di dorong di Tarik. 2. Saat nyedot obat tarikan sulit ICU : 1. Jarum kurang tajam/ terasa tumpul 2. Jarum gampang mleyot 3. Beberapa spuit bocor saat dibuat mengambil obat	ruangan rawat inap dilaporkan tanggal 31/10/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT dan tindak lanjut untuk mengganti dengan spuit – gidcare.
		Spuit 10 CC	Stera medical (No. batch : 10102588)		
		Ezelin insulin	Kalbe No. Batch : MVEZLC240 23	Insulin macet karena cairan tidak keluar dan sudah dicoba diganti bd micro 3 kali cairan tetap tidak keluar sehingga tidak bisa digunakan. Produk yang rusak total 1 pen.	Form keluhan alat kesehatan substandard dari Ina 6A dilaporkan tanggal 09/11/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT dan tindak lanjut untuk mengganti sediaan farmasi yang rusak ke distributor agar tidak terjadi selisih stok
		Polyflex IV Cannula no. 20	Polymed No. Batch : 3094023D	IGD : IV cannula darah merembes pangkal infus Ruang Ina 4 A : 1. Jarum kurang singset/ tumpul. 2. Jika mau di pasangkan ke pasien kurang sret dan kencang sehingga pasien kesakitan	Form keluhan alat kesehatan substandard dari IGD dan Ina 4A dilaporkan tanggal 19/11/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT dan tindak lanjut untuk mengganti dengan iv cannula - hospitech.
		Spinocain No. 27G	B-Braun No. Batch : 24K23H8B05	Spinocain yang produk lama lebih bagus dan tutupnya bisa dipakai buat ujung suction dan tidak pernah bocor. Sedangkan Spinocain yang saat ini tersedia (kemasan baru) tutupnya lurus tidak bisa di buat ujung suction jadi IKO kesulitan mencari pengganti buat ujung suction dan bocor di bagian pangkal. Produk yang rusak total 5 pcs.	Form keluhan alat kesehatan substandard dari IKO dilaporkan tanggal 25/11/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT dan tindak lanjut untuk dikomunikasikan dengan distributor dan pengadaan PT untuk evaluasi lebih lanjut.
3	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan November 2025

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2024 dan belum mencapai	P	Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname
		D	Berdasarkan Surat Edaran dari RS Nomor 218/I-SE/DIR/III/2025 tentang Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Farmasi disampaikan beberapa kebijakan

	target selisih 0.	S	Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0
		A	- Penyesuaian / Adjustment stock (akibat dari adanya selisih hasil stock opname) dengan acuan selisih wajar sebesar 1% dari total persediaan TIDAK LAGI DIBERLAKUKAN per 1 Januari 2025. - Acuan selisih hasil SO sesuai dengan BA (Berita Acara) hasil SO. - Selisih Kurang (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO < jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu dan menentukan unit yang terlibat kemudian hitung beban 60% kepada Manajemen Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit, Kabid Penunjang, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Umum & keuangan, Kains. Farmasi). Penanggung jawab rak dan unit terlibat sebesar 40% dari jumlah selisih SO. Pembebanan langsung pada periode berjalan. - Selisih Lebih (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO > jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu, jika selisih lebih masih dalam selisih wajar tidak dibebankan, jika terdapat selisih lebih yang mengalami peningkatan ekstrim, maka diberlakukan pembebanan selisih lebih hasil SO berupa teguran tertulis dari direktur rumah sakit kepada unit penyebab selisih SO dan penanggung jawab rak. - Hasil dari perhitungan selisih akan disesuaikan dalam penggajian setiap bulan
2.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. September 2025 = -128.673 Oktober 2025 = -30.150 November 2025 = +703.725	P	Perencanaan scan barcode.
		D	1. Sudah dilakukan pengajuan proposal scan barcode dan pengadaan alat yang menunjang pelayanan. 2. Sudah dilakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya.
		S	Selisih stok opname di gudang farmasi dan depo farmasi
		A	1. Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien. 2. Scan barcode menunggu antrian di progamer PT.
3.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan % dan waktu tunggu obat racikan %	P	Perencanaan elektronik KPO dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur elektronik KPO di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	1. Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. 2. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1. Elektronik KPO menunggu antrian di progamer PT. 2. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 136 KPO.
4.	Obat tertinggal 2x24 jam	P	Perbaikan kebijakan obat tertinggal.
		D	Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
		S	1. Obat tertinggal bulan September mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Farmasi sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	1. Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.

			2. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. 3. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
5.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi death moving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
6.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan VVM (Vaksin Vial Monitor) untuk vaksin pemerintah warna segiempat lebih gelap dari warna lingkaran sehingga tidak layak digunakan. (Data vaksin pada Tabel 9.10)	P	Pengadaaan VR (Vaccine Refrigerator) di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	1. Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. 2. Mengedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli. 3. Koordinasi dengan PJ Vaksin Pemerintah untuk permintaan vaksin baru ke Puskesmas.
7.	Ditemukan resep IU (Ketidaksesuaian surat kontrol poli dengan jadwal ambil obat apotek online BPJS Kesehatan 30 hari). September 2025 = 36 resep Oktober 2025 = 21 resep November 2025 = 10 resep	P	Koordinasi dengan Karu poli
		D	1. Sosialisasi fitur edit no apol. 2. Koordinasi dengan Karu poli untuk edukasi ke perawat perhitungan obat 30 hari agar surat kontrol sesuai.
		S	1. Perawat salah perhitungan obat 30 hari sehingga surat kontrol tidak sesuai 30 hari. 2. Farmasi banyak pendingan resep di SIMRS karena belum bisa input no apol. 3. Farmasi utang input obat di apol. 4. Jika sudah waktunya input apol farmasi telpon verifikator bahwa resep sudah dikerjakan.
		A	1. Alur fitur "Edit No APOL" : a. Input resep IU di apol b. Copy no apol c. Klik kanan sesuai resep yang telah dikerjakan di apol d. Klik "Edit No APOL" e. Paste no apol f. Klik OK 2. Alur perubahan surat kontrol ; a. Farmasi menemukan IU di apol b. Farmasi konfirmasi ke perawat poli untuk hapus surkon di SIMRS. c. Farmasi konfirmasi ke CSO untuk hapus di V-Claim pada grup whatsapp Pelayanan BPJS Kes jika merubah surat kontrol pakai HP IFRS dengan format: Ganti Surat Kontrol Nama pasien :

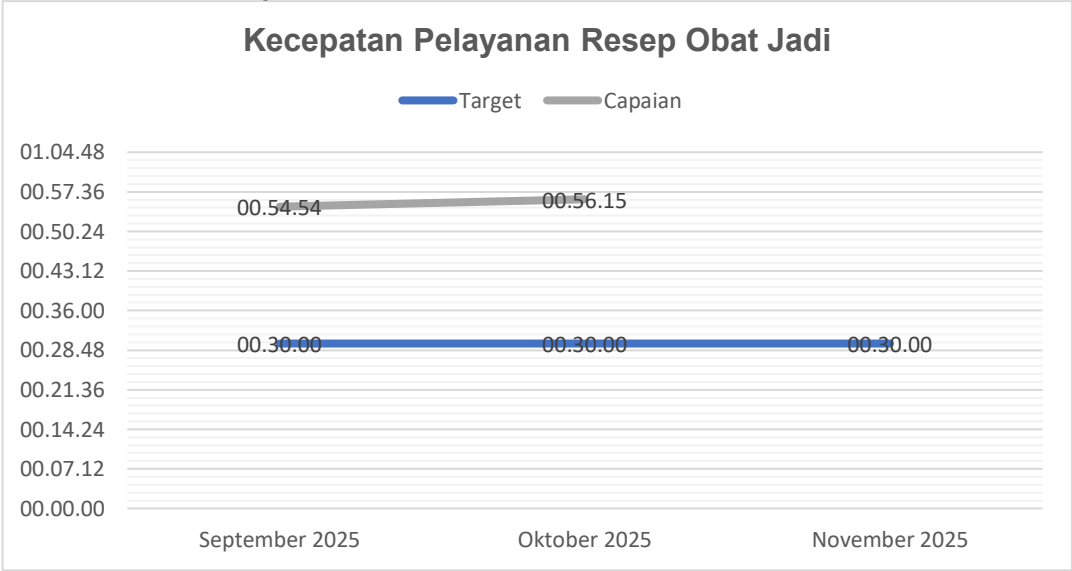
			No. RM : DPJP : Tanggal perubahan : Alasan perubahan : IU/TK tanggal berapa d. Perawat input ulang surkon terbaru di SIMRS dan mengirimkan di grup WA. e. Pendaftaran mengubah di V-Claim f. Apoteker KIE pasien menuju CSO untuk mengambil surat kontrol, jika obat di primantara maka farmasi mencetak surat kontrol dan di steples ke obatnya. g. Pasien mengambil obat ke farmasi jika sudah ke CSO.
8.	Obat Rawat Inap di tandon di Nurse Station	P	Pengecekan obat tandonan di nurse station setelah dilakukan serah terima obat ODD
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi terkait pengecekan obat tandonan di nurse station
		S	Memaksimalkan jobdesk distribusi obat rawat inap oleh Tenaga Vokasi Farmasi dan Apoteker untuk mengecek obat yang ada di nurse station
		A	Pada saat distribusi obat rawat inap Tenaga Vokasi Farmasi wajib mengecek obat-obat yang ada di nurse station. Jika ada tandonan obat, Tenaga Vokasi Farmasi wajib menanyakan ke perawat jam pemberian obatnya. Jika sudah terlewat jam pemberiannya maka Tenaga Vokasi Farmasi wajib cek DPO obat yang ada di nurse station jika sudah lewat waktu pemberian harus di retur saat itu juga, serah terima obat dengan perawat dan perawat juga langsung input retur di simrs. Apoteker rawat inap saat visite pasien juga wajib double check obat yang ada di nurse station. Jika obat signa PRN / kp berkoordinasi dengan apoteker, apakah pasien masih membutuhkan terapi tersebut.
9.	Kesalahan input nama obat di apotek online BPJS Kesehatan sehingga terjadi pendingan obat kronis.	P	Pengajuan bridging simrs dan apotek online BPJS Kesehatan
		D	1. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada apoteker dan tenaga vokasi farmasi terkait pendingan yang sering terjadi untuk memperbaiki ketelitian inputan obat di apotek online BPJS Kesehatan. 2. Pengecekan inputan obat kronis di apotek online BPJS dan e-resep oleh admin farmasi setiap hari
		S	1. Kesalahan input nama obat di apotek online BPJS Kesehatan dan muncul di pendingan obat kronis yaitu velpraz tab 250 mg/ valproat 250 SK tab salut 250 mg (salah input valproat 250 SK tab lepas lambat 250 mg), berotec / fenoterol hbr 100 sk inh 100 mcg/puff (salah input fenoterol hbr 0,1 SK btl 50 ml), adalat oros 10 mg / aripriprazol 10 SK tab dispersible 10 mg (salah input aripriprazol 15 SK tab discmelt 15 mg). 2. Kesalahan centangan obat paket dan non paket di SIMRS.
		A	1. Jobdesk admin farmasi yaitu staff non tenaga vokasi farmasi. 2. Jadwal admin farmasi yaitu NS (jam 08.00-16.00). 3. Target admin : tidak ada masalah inputan apotek online dan pendingan.
10.	Rekonstitusi sediaan steril bentuk serbuk injeksi wajib dilakukan di LAF	P	Pelaksanaan rekonstitusi serbuk injeksi semuanya dilakukan di LAF
		D	Pengajuan proposal pelatihan penyiapan obat intravena dan teknik aseptik
		S	Perlu adanya pelaksanaan pengoplosan obat injeksi bentuk serbuk untuk setiap obat yang akan digunakan, sehingga perlunya farmasi untuk mengoplos obat setiap shiftnya di LAF namun terkendala

			dengan jumlah tenaga yang melakukan pengoplosan injeksi selama ini adalah apoteker.
		A	1. Tenaga vokasi farmasi sesuai regulasi PMK terbaru bisa diberikan kewenangan melakukan rekonstitusi sediaan steril dengan syarat sudah terlatih. 2. Dilakukan pelatihan dispensing sediaan steril. 3. Dilakukan trial dispensing sediaan steril setiap shift. 4. Dilakukan penjadwalan per shift untuk TVF dan Apoteker yang akan mengoplos.
12.	Input permintaan barang dari depo farmasi ke gudang farmasi	P	Pelaksanaan permintaan barang dari depo farmasi ke gudang farmasi dengan ROP (Re Order Point)
		D	Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada apoteker dan tenaga vokasi farmasi terkait ROP (Re Order Point)
		S	1. Permintaan ke gudang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu (tidak merata). 2. Fitur permintaan barang ROP tidak pernah dipakai lagi.
		A	1. Semua petugas harus bisa melakukan pengecekan barang menipis, harus bisa dan mau melakukan permintaan barang ke gudang. 2. Melakukan evaluasi dan melakukan permintaan dengan fitur ROP lagi. 3. Melakukan perbandingan permintaan ROP dan non ROP.
13.	Tandonan retur infus di ruang RR IKO	P	Tenaga vokasi farmasi IKO mengecek tandonan infus di ruang RR IKO
		D	Koordinasi dengan kepala ruang IKO dan sosialisasi kepada apoteker dan tenaga vokasi farmasi
		S	Temuan retur infus yang menumpuk di ruang RR IKO
		A	Tenaga vokasi farmasi IKO wajib melihat dan mengecek lagi tandonan ns 1000 ml atau steril water dan follow up ke ruangan untuk retur sesuai pasien sehingga tidak ada tandonan.
14.	Terdapat pendingan obat yang tidak tercover oleh asuransi	P	Farmasi menghubungi admin asuransi untuk pengesahan obat
		D	sosialisasi kepada apoteker dan tenaga vokasi farmasi
		S	Pendingan obat karena tidak tercover oleh asuransi yang diketahui setelah pasien ambil obat, dimana alur sebelumnya yang menghubungi admin asuransi adakah kasir dan asuransi tersebut tidak memiliki formularium obat.
		A	Tersedia website Live Chat Admedika untuk konsultasi terkait apakah obat tercover atau tidak, seperti sediaan kosmetik, obat hormon, vitamin yang mengandung ekstrak herbal, dll. https://livechat.admedika.co.id/login User : farmasiphm Password : F@rmasiphm165 Lippo general insurance (Meditap) https://provider.meditap.id/billing/approval user : primahusadamalang01 pass : Prima123 Untuk no. kartu/ polis farmasi menghubungi kasir.
15.	Pasien loadingan operasi utang input resep	P	
		D	Koordinasi dengan kbid penunjang dan kbid pelayanan medis untuk memperbaiki alur peresepan pasien loadingan
		S	Pasien loadingan selama ini ada kendala di pendaftaran. Alasan perawat belum input resep set loadingan karena pasien belum di daftarkan

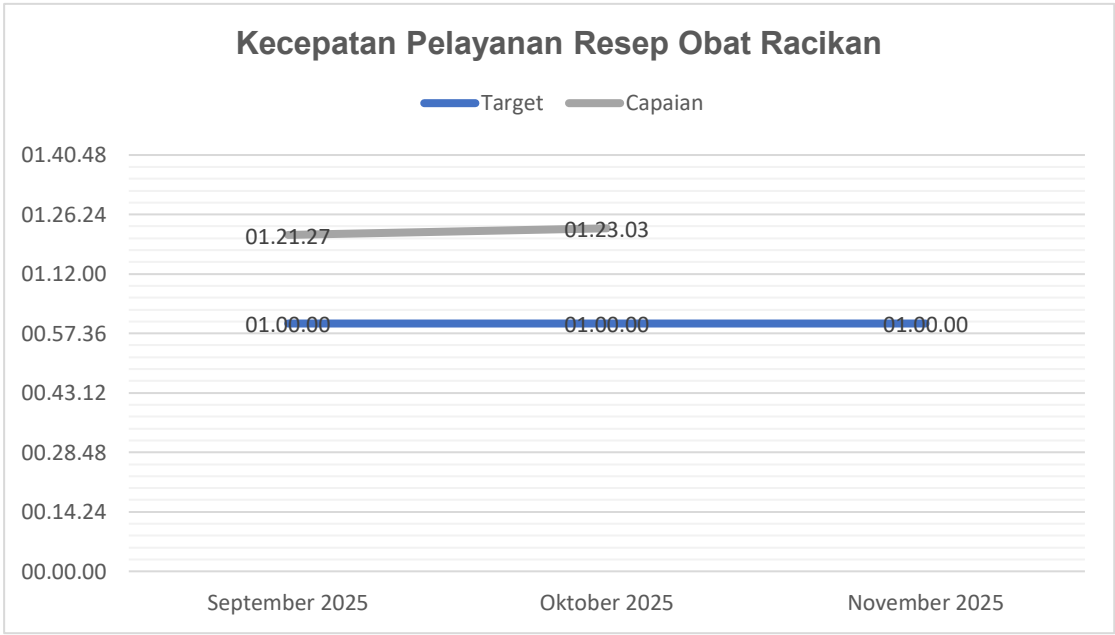
			akhirnya pasien di jemput dulu dan ambil bmhp set lodingan oleh perawat ke farmasi (utang input).
		A	Perbaiki alur pasien loadingan : 1. Pasien di daftarkan oleh pendaftaran 2. Perawat irna input resep 3. Perawat jemput pasien ke pendaftaran dan ambil set loadingan di farmasi.

1.2.1.16 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Rawat Jalan Bulan September - November 2025

Grafik Pelayanan Resep Obat Jadi Bulan September - November 2025



1.2.1.17 Grafik Pelayanan Resep Obat Racikan September - November 2025



Analisis :

- Kecepatan pelayanan resep obat jadi belum mencapai 100% dengan realisasi 00:56:15 dari target yang di tetapkan sebesar ≤ 30 menit.
- Kecepatan pelayanan resep obat racikan belum mencapai 100% dengan realisasi 01:23:03 dari target yang di tetapkan sebesar ≤ 60 menit.

-
3. Waktu tunggu obat rawat jalan pada bulan November 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan September 2025 dan belum mencapai target 100% dikarenakan:
 - DPJP tidak praktek karena cuti sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari berikutnya ketika DPJP praktek,
 - Jadwal praktek DPJP yang bersamaan,
 - Komposisi farmasi tidak lengkap dengan 4 apoteker rawat jalan (1 orang cuti melahirkan), 25 Tenaga Vokasi Farmasi, dan 2 Admin Farmasi.
 - Masih terdapat petugas tidak real time klik ambil obat di SIMRS sehingga data tidak akurat.
 - Terdapat data waktu tunggu di SIMRS berubah ketika ada revisi resep (pending resep) jadi yang terbaca adalah setelah pending resep.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Evaluasi kebijakan alur penyiapan sampai penyerahan obat ke pasien dan mengulang sosialisasi kebijakan alur penyiapan sampai penyerahan obat ke pasien.
2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
4. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
5. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh Tenaga Vokasi Farmasi, resep iter dan PRB oleh apoteker.

1.2.1 Laboratorium

1.2.1.11Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium

	Target	Sep'25	%	Okt'25	%	Nov'25	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
HEMATOLOG I	1950	1628	<10,4 %	1752	>7,0 7%	1836	>4,57%
FAAL HEMOSTASI S	716	741	<4,8%	759	>2,3 %	758	<0,13%
HEMATOLOG I LAIN	1	0	0%	0	0%	0	0%
URINALISIS	418	267	<5,6%	291	>8,2 %	316	>7,9%
ANALISA FEACES	30	9	<18,1 %	11	>18, 1%	13	>15,3%
FUNGSI HATI	611	306	<2,8%	315	>2,8 %	318	>0,94%
LEMAK DARAH	806	787	<2,5%	676	<14, 1%	696	>20%
GINJAL HIPERTENSI	1394	1402	>0,07 %	1342	<4,2 %	1374	>2,3%
GULA DARAH	1187	1876	<11,3	1963	>4,4 3%	2016	>2,6%
JANTUNG	583	497	<8,8%	550	>9,6 %	603	>8,7%
ELEKTROLIT DAN BGA	334	208	>21,1 %	215	>3,2 %	190	>13,1%
IMUNO SEROLOGI	481	266	>37,4 %	300	>11, 2%	313	>4,15%
REMATIK	6	3	>40%	7	>57 %	4	<42,5%
ENDOKRINO LOGI	60	69	<4,1%	63	<9,5 %	58	<7,9%
REPRODUKS I	44	86	<6,5%	88	>2,2 %	63	<28,4%
MIKROBIOLO GI	32	54	>14,8 %	58	>6,8 %	37	<36,2%
Jumlah	8654	8199	<7,6%	8390	>3,2 2%	8595	>2,3%

Analisis :

Jumlah Pemeriksaan Pada bulan November 2025 mengalami Kenaikan sebanyak 2,3% dari Bulan September, dengan 8595 pemeriksaan Laboratorium Akan tetapi masih dibawah target yang di tetapkan yaitu 8654

Rencana Tindak Lanjut :

Tetap memberikan pelayanan yang terbaik ke pada pasien khususnya pasien Laboratorium

1.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan November 2025

NO	NAMA PASIEN	NO RM	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPEL	UNIT ASAL	SAMPEL YANG DITERIMA
1	Rafassya	239523	02/11/2025	IGD	DL Cloting
2	Priyo Nurbaya	213196	09/11/2025	IGD	DL Cloting
3	Juma'iya	138695	23/11/2025	7A	DI Cloting
4	Retno	240806	24/11/2025	IGD	DL Cloting

5	Suparlan	240723	26/11/2025	IGD	FH Cloting
6	Uman	240739	26/11/2025	IGD	DL Cloting

Analisis :
 Di temukan 6 pasien yang sampel darahnya rusak

Rencana Tindak Lanjut :
 Konfirmasi ke Unit pengirim sampel untuk minta sampel ulang

1.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS April – November 2025

Bulan	Permintaan Labu Darah				Total	Return Labu Darah				Total
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
April 2025	13	10	25	20	68	2	7	5	4	18
Mei 2025	20	27	42	9	98	4	-	-	-	4
Juni 2025	15	29	27	8	79	2	1	-	-	3
Juli 2025	18	14	29	6	67	1	4	-	3	8
Agustus 2025	15	32	30	6	83	6	2	0	2	10
September 2025	21	22	33	3	79	3	4	0	6	13
Oktober 2025	30	24	27	9	90	14	3	4	5	26
November 2025	29	35	34	7	105	5	1	0	3	9

1.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Maret - Mei 2025

NO	NAMA PASIEN	JUMLAH PASIEN DAN PERMINTAAN LABU DARAH INCOMPATIBLE				TOTAL PERMINTAAN LABU DARAH
		A	AB	O	B	
Bulan April 2025						
Tidak ada						
Bulan Mei 2025						
Tidak ada						
Bulan Juni 2025						
1.	Siti Rahajuningsih				√	2 Labu
Bulan Juli 2025						
Tidak ada						
Bulan Agustus 2025						
Tidak ada						
Bulan September 2025						
Tidak ada						
Bulan Oktober 2025						
Tidak ada						
Bulan November 2025						
Tidak ada						

Analisis :
 Tidak dtemukan pasien Incompatible

Rencana Tindak Lanjut :
 Pertahankan Tetap telili dan berhati hati dalam melakukan crossmatch

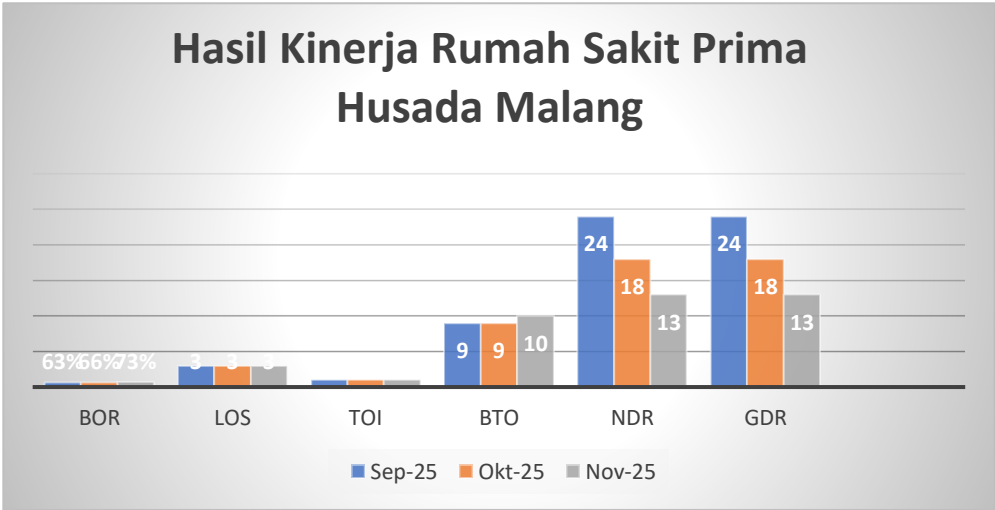
1.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Novemberr 2025

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang													
						LT 2C	LT 2A	LT 3A	LT 3 C	LT 4ab	LT 5C	LT 6	LT 7	LT 8	MTS	NICU	HCU	ICU	TOTAL
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60 - 80 %	September 25	47	30	11	65	79	43	67	66	70	74	30	25	31	63
					Oktober 25	65	49	0	61	84	60	72	67	78	74	3	19	18	66
					November 25	73	40	34	72	92	59	84	71	71	74	38	47	26	73
ALOS (Average Length of Stay)	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6 - 9 hari	September 25	4	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4	2	2	3
					Oktober 25	4	3	0	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3
					November 25	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	5	2	2	3
TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	September 25	3	5	9	1	1	3	1	1	1	1	6	3	3	1
					Oktober 25	1	2	0	1	0	2	1	1	1	1	45	5	6	1
					November 25	1	3	3	1	0	2	1	1	1	1	6	1	4	1
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	jumlah pasien. Jumlah TT	4 - 5 kali	September 25	6	4	3	9	11	5	9	8	8	12	3	7	6	9
				(dalam hitungan bulan)	Oktober 25	8	7	0	8	13	8	9	8	9	12	1	6	4	9
					November 25	9	7	7	9	13	8	10	8	9	11	3	15	6	10

NDR (Net Death Rate)	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ Mati} >48\text{jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25%	September 25	0	0	0	0	0	0	19	32	0	0	100	71	351	24
					Oktober 25	0	0	0	4	7	0	19	0	19	0	0	182	361	18
					November 25	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	34	260	13
GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45%	September 25	0	0	0	0	0	0	19	32	0	0	100	71	351	24
					Oktober 25	0	0	0	4	7	0	19	0	19	0	0	182	361	18
					November 25	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	34	260	13

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan November 2025



Analisis :

Indikator	Nilai November 2025	Standar Ideal	Evaluasi Singkat
BOR	73%	60%-85%	Masih dalam standar ideal
LOS	3 hari	BPJS : 3 hari UMUM : 6-12 hari	Dibawah standar BPJS, perlu dicermati
TOI	1 hari	1-3 hari	Sesuai standar, efisien
BTO	10 kali	4-5 kali	Konsisten tinggi, perlu evaluasi

Update Tren Tahun 2025

Indikator	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Catatan
BOR	81%	75%	72%	68%	69%	73%	72%	63%	66%	73%	Penurunan signifikan sejak Bulan September
LOS	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Penurunan LOS, dibawah standar SE PT DPM
TOI	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Stabil, efisien
BTO	9 kali	10 kali	10 kali	9 kali	9 kali	10 kali	10 kali	9 kali	9 kali	10 kali	Konsisten tinggi, diluar standar ideal

Masalah :

1. BOR (Bed Occupancy Rate)

Walaupun masih dalam batas ideal → Perlu perhatian agar BOR tetap stabil dan tidak turun di bawah standar.

2. LOS (Length of Stay)

Indikasi pasien dirawat relatif singkat, bisa karena:

- a) Kasus yang ditangani sebagian besar ringan.
- b) Tekanan efisiensi rawat inap (lebih banyak diarahkan rawat jalan).
- c) Atau kemungkinan pasien pulang cepat namun berpotensi readmisi.

3. TOI (Turn Over Interval)

Mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.

- 4. BTO (Bed Turn Over)**
 Mengindikasikan perputaran pasien yang cepat. Namun, apabila tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan, kondisi ini berpotensi meningkatkan beban kerja tenaga medis

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Untuk BOR:**
 Lakukan monitoring tren kunjungan pasien dan optimalkan pemasaran layanan unggulan agar BOR tetap stabil.
- 2. Untuk LOS:**
 - a) Evaluasi clinical pathway: apakah perawatan sudah sesuai standar atau pasien pulang terlalu cepat.
 - b) Lakukan monitoring readmisi untuk mendeteksi apakah pasien yang pulang cepat sering kembali ke RS.
- 3. Untuk TOI:**
 Sudah sesuai standar, tetap dipertahankan dengan manajemen bed yang baik.
- 4. Untuk BTO:**
 - a) Pastikan mutu pelayanan tetap terjaga meski perputaran pasien tinggi.
 - b) Perkuat manajemen SDM (tenaga medis dan paramedis) agar tidak terjadi kelelahan kerja (burnout).
 - c) Evaluasi ketersediaan fasilitas dan sarana agar tetap seimbang dengan volume pasien.

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan November 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	400
2.	E11.4	With neurological complications	359
3.	J47	Bronchiectasis	304
4.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	298
5.	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	261
6.	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	227
7.	R50.9	Fever, unspecified	217
8.	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	196
9.	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	173
10.	K80.8	Other cholelithiasis	170

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan November 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	Typhoid Fever	154
2.	J18.9	Pneumonia	72
3.	E11.9	Dm Type 2	67
4.	I63.9	Cerebro Vaskuler Accident	49
5.	J18.0	Bronchopneumonia	19
6.	A09.9	Gastroenteritis Akut	18
7.	A90	Dengue Fever	16
8.	N20.0	Batu Ureter	17
9.	I20.0	Unstable Angina Pectoris	15
10.	I50.9	Acute Decompensated Heart Failure	14

Analisis :
 Diagnosa terbanyak pasien rawat inap bulan November 2025 adalah typhoid fever sejumlah 154 Pasien. Diagnosa tersebut diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap November 2025

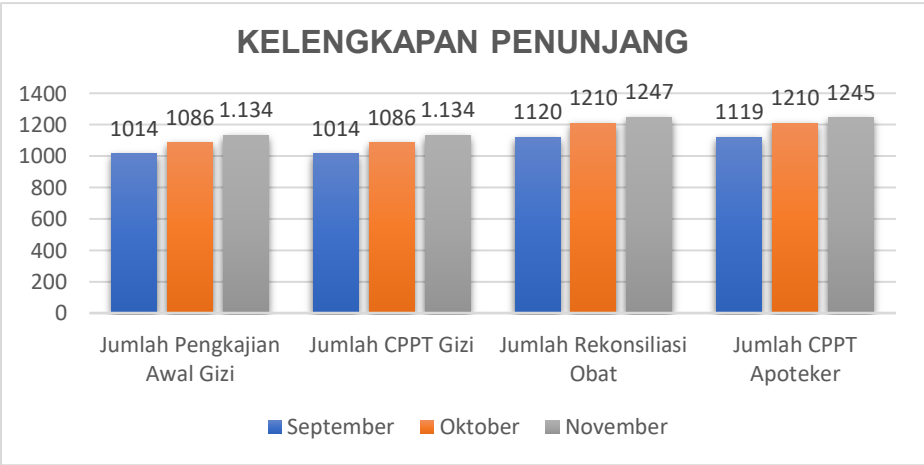
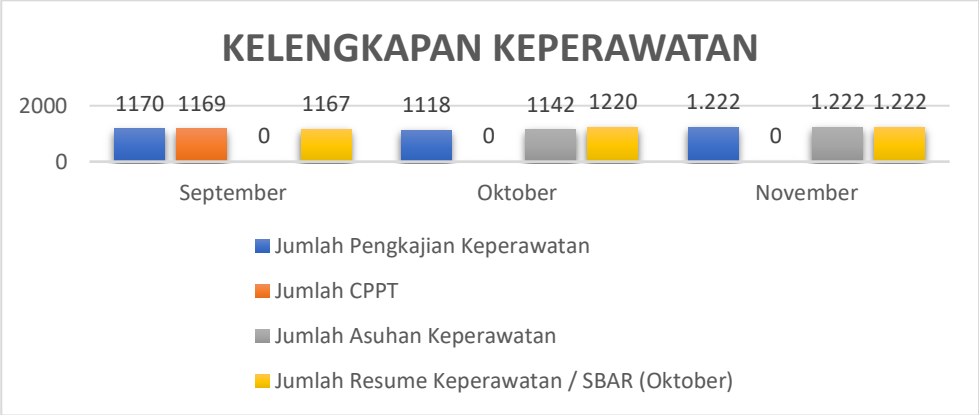
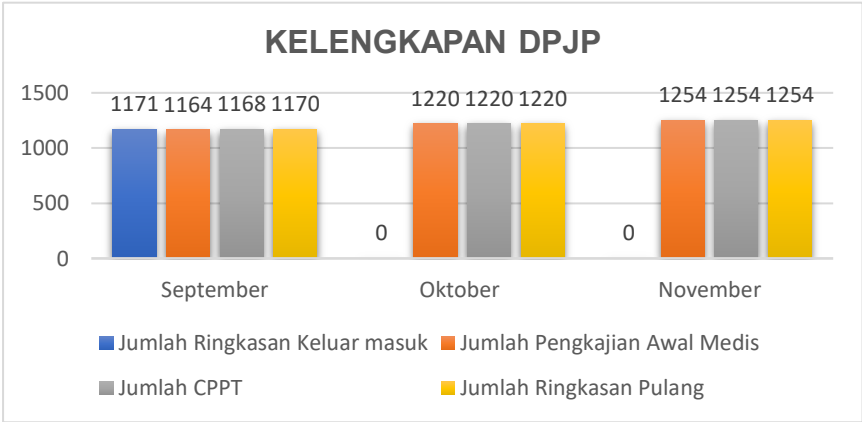
KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28
Juli	1281	99,89	3	0,10	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11
Agustus	1247	97	4	3	1241	99	10	1	1250	100	1	0	1250	100	1	0
September	1171	100	0	0	1164	98,14	7	1,86	1168	99,73	4	0,33	1170	99,84	1	0,16
Oktober	-	-	-	-	1219	99,91	1	0,09	1220	100	0	0	1220	100	0	0
November	-	-	-	-	1241	98,96	13	1,04	1229	98,01	25	1,99	1253	99,92	1	0,08

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR (Oktober)			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20
Juli	1289	100	0	0	1289	100	0	0	-	-	-	-	1289	100	0	0
Agustus	1289	100	0	0	1287	100	0	0	-	-	-	-	1287	100	0	0
September	1170	99,52	1	0,48	1169	99,33	2	0,67	-	-	-	-	1170	99,52	1	0,48
Oktober	1118	92	112	8	-	-	-	-	1142	94	78	6	1220	100	0	0
November	1201	98,28	21	1,72	-	-	-	-	1210	99,02	12	0,98	1222	100	0	0

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11

Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2
Juli	666	58	563	48	1124	99,65	5	0,35	1269	96,67	1	3,33	1272	96,67	1	3,33
Agustus	1150	100	0	0	1150	100	0	0	1277	100	0	0	1274	100	0	0
September	1014	100	0	0	1014	100	0	0	1120	100	0	0	1119	99,96	1	0,4
Oktober	975	90	111	10	1076	99	10	1	1210	100	0	0	1100	91	110	9
November	918	81	216	19	1132	99,82	2	0,18	1246	99,92	1	0,08	1208	96,87	37	2,97

3.1.1.6 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan November 2025



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi 19% , sebanyak 216 dokumen
- 2. Kelengkapan pengkajian keperawatan 98,28% pada Bulan November 2025.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan November 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

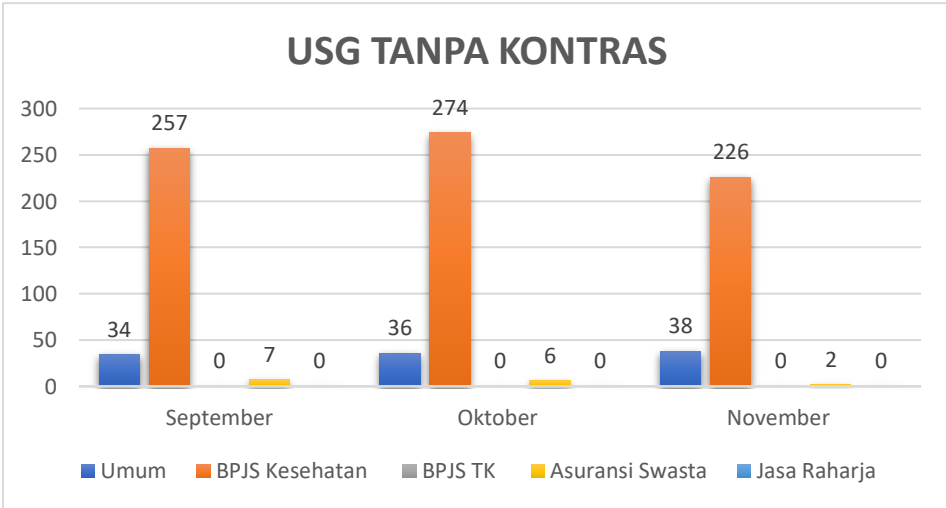
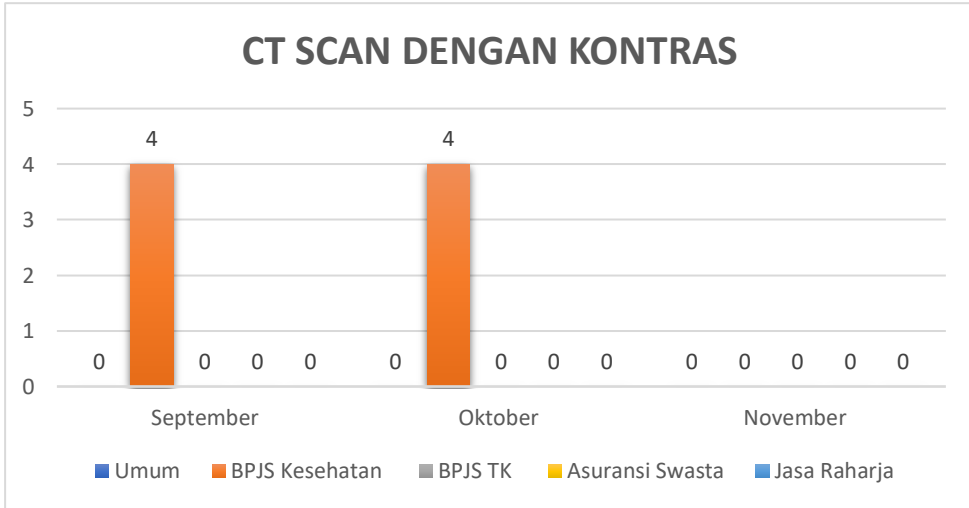
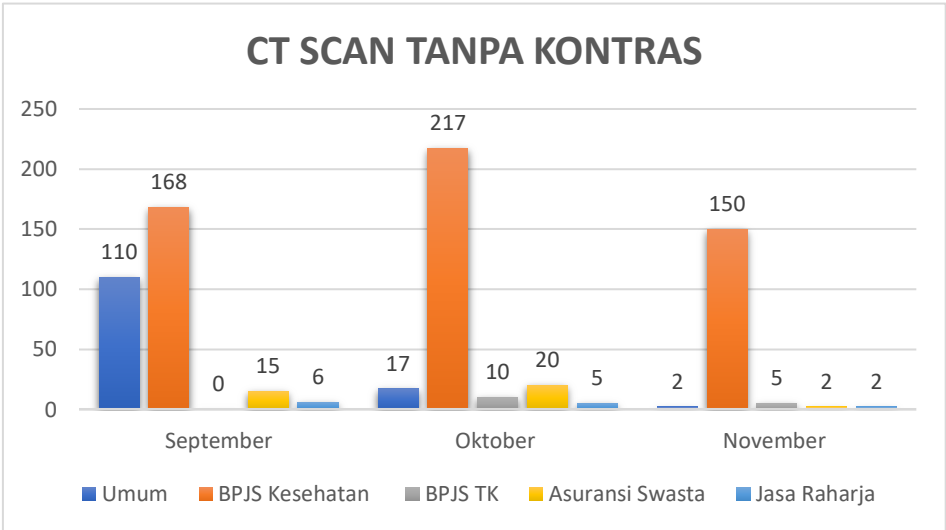
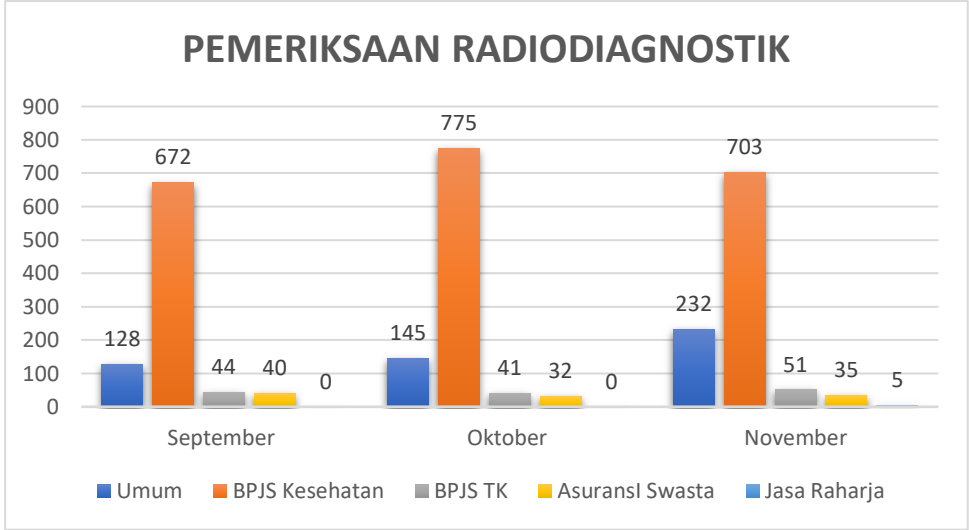
- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan.

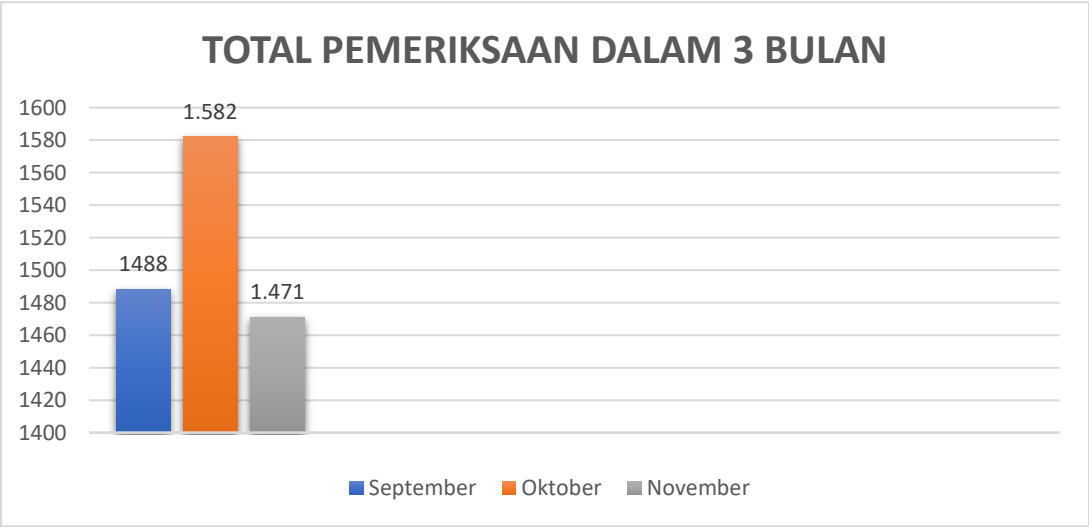
6.2.4 Radiologi

6.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi September - November 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1.	RADIOLOGI	UMUM	128	145	232
		BPJS KESEHATAN	672	775	703
		BPJS TK	44	41	51
		ASURANSI SWASTA	40	32	35
		JASARAHARJA	0	0	5
	TOTAL		884	993	1026
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	110	17	12
		BPJS KESEHATAN	168	217	150
		BPJS TK	0	10	5
		ASURANSI SWASTA	15	20	2
		JASARAHARJA	6	5	2
	TOTAL		294	269	171
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	0	0
		BPJS KESEHATAN	4	4	0
		BPJS TK	306	0	0
		ASURANSI SWASTA	306	0	0
		JASARAHARJA		0	0
	TOTAL		666	4	0
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	34	36	38
		BPJS KESEHATAN	257	274	226
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	7	6	20
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		306	316	274
TOTAL KESELURUHAN			896		

6.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi September - November 2025





Analisis :

- Pelayanan pemeriksaan selama Bulan November 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada Bulan November 2025 pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - Radiodiagnostik : 1026
 - USG Tanpa Kontras : 274
 - CT Scan Tanpa Kontras : 171
- Jumlah total pemeriksaan selama Bulan November 2025 adalah sebanyak 1471 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

- Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
- Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
- Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

6.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Maret 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	By Ny Zaimatus (227984)	Normal	Pneumonia	2
2.		Kasti (073280)	Normal	Infark Akut	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Agus Wahyu (114824)	Spondylosis	Compresi Fractura	1
Bulan April 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Ny Sri Asnanik (224631)	CVA Infark	CVA Infark	2
2.		Dian Nihayatul (212732)	Normal	Normal	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Mei 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Sumroti (231733)	Cardiomegali	Cardiomegaly dan Pneumonia	2
2.		Roeskandar	Lung Tumor	Lung Tumor dan Pneumonia	
1.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Rizka Anada	Normal	Fracture Scapulla	1
Bulan Juni 2025					

1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Kiki Nur Ika Sari (232011)	Normal	Tetap Normal	1
Bulan Juli 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	- Eko sutaji (189842) - Sabar (195701)	-Normal -Normal	- Pulmonary hipertension - Pneumonia	2
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	0	0	0	0
Bulan Agustus 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Sabar / 195701	Normal	Pneumonia	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.Rad	Andrianto / 234437	Normal	Ada garis fraktur	1
Bulan September 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	-	-	-	-
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.Rad	ry wahyu /177112	Normal	Fraktur linear costae	1
Bulan Oktober 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	1.Kunaini/239044	Lung edema	Lung edema+pneumonia	2
		2. Tri tungga/ 118125	Normal	Fraktur costae 4	
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	-	-	-	-
Bulan November 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	1. Kodrat/240207	Cardiomegali	Cardiomegali+Pneumonia	3
		2. Kusen/162784	Lung emphysema	Pneumonia	
		3. Vivi/240408	Pneumonia	TB Paru	
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	-	-	-	-

Analisis :
 Pada Bulan November Tahun 2025 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak ditulis secara lengkap pada surat permintaan radiologi.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
 2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

6.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr. Agung, Sp.Rad (K)		dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	00:03:20	00:25:00 (waktu efektif) 00:180:00 (diatas jam 12 malam)	00:03:04	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
2.	Ro Vertebrae	-	-	00:04:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
3.	Ro Abdomen	-	-	00:10:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
4.	Ro Extremitas	-	-	00:02.00	0:10:00 (pada saat jam praktek)

					24:00:00 (diluar jam praktek)
5.	Ro Skull	-	-	00:02:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
6.	USG Abdomen	00:08:00	00:05:00	00:15:00	00:10:00
7.	CT Scan Non Kontras	00:05:00	00:30:00 (waktu efektif) 24:00:00 (diatas jam 12 malam)	-	-
8.	CT Scan Dengan Kontras	00:15:00	00:25:00 (waktu efektif) 24:00:00 (diatas jam 12 malam)	-	-
9.	Radiologi CITO	00:10:00	00:04:00 (waktu elektif) 00:25:00 (diatas jam 12 malam)	00:10:00	0:10:00

Analisa :

1. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Thorax 3 menit 4 detik dan rata- rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
2. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Vertabrae 4 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
3. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Ekstremitas 2 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
4. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Abdomen 10 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
5. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Skull 2 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
6. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi USG 15 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 10 menit. Hal ini disebabkan karna hasil usg langsung dibaca oleh radiolog. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
7. Semua pemerikaan CT Scan di alihkan ke dokter Agung Setyawan, Sp.Rad berdasarkan kesepakatan antar radiolog.
8. Terdapat pembacaan CITO selama bulan Agustus 2025 dan hasil *ekspertise* sesuai target yakni kurang dari 30 menit

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

6.2.4.5 Tabel PMI dan PME di Radiologi

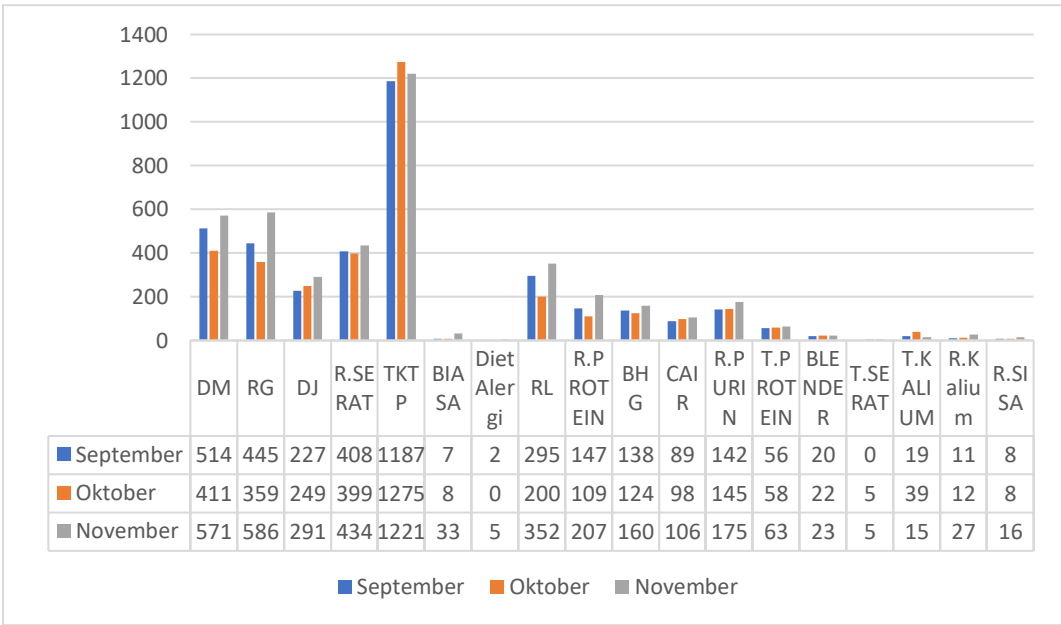
No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit November 2025

No.	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan September	Bulan Oktober	Bulan November	
1.	Diabetes Mellitus	411	492	571	16
2.	Rendah Garam	359	564	586	3,9
3.	Jantung	249	287	291	1,39
4.	Rendah Serat	399	358	434	21,2
5.	TKTP	1275	1240	1221	-1,5
6.	Makanan Biasa	8	23	33	43,4
7.	Diet Alergi	0	8	5	-37,5
8.	Rendah Lemak	200	284	352	23,9
9.	Rendah Protein	109	173	207	19,6
10.	Bubur Halus	124	153	160	4,5
11.	Cair	98	107	106	-0,9
12.	Rendah Purin	145	175	175	0
13.	Tinggi Protein	58	43	63	46,5
14.	Blender	22	25	23	-8
15.	Tinggi Serat	5	0	5	0
16.	Tinggi Kalium	39	42	15	-64
17.	Rendah Kalium	12	31	27	-14
18.	Rendah Sisa	8	12	16	33
Jumlah		3616	4017	4290	4,7

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit November 2025



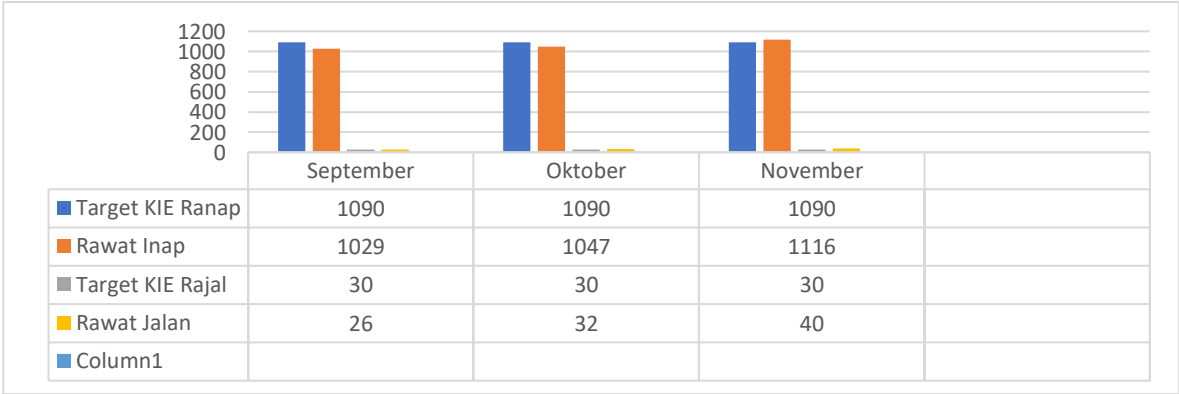
Analisis :
Jumlah pesanan diet pasien rawat inap meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pasien di rawat inap. Pemberian diet rendah serat meningkat karena banyaknya pasien rawat inap dengan diagnosa TF dan dalam kondisi diare. Diet makanan biasa juga mengalami kenaikan karena banyaknya pasien rawat inap dengan usia 6 bulan kebawah sehingga makanan yang disediakan diberikan kepada ibu pasien yang masih menyusui pasien. Diet yang mengalami penurunan adalah diet alergi, tinggi kalium dan rendah kalium.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan dan mengajukan perubahan siklus menu. Melakukan konseling kepada karyawan perusahaan yang memiliki MOU dengan RSPHM.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi September - November 2025

No.	Indikasi	Jumlah Pasien September	Jumlah Pasien Oktober	Jumlah Pasien November
1.	Konsultasi Rawat Inap	1029	1047	1116
2.	Konsultasi Rawat Jalan	26	32	40

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada Bulan September - November 2025



Analisis :
Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada bulan November meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan bulan November mengalami peningkatan

dikarenakan DPJP sudah mulai aktif melakukan rujukan konseling gizi rawat jalan. Poli Spesialis yang sering merujuk pasien untuk konseling gizi adalah poli jantung (dokter Mira Sp.JP) dan poli penyakit dalam (dr. Ardhany Sp.PD, dokter Ardhi Bustami, Sp.PD dan dr.Heriyatmo, Sp.PD).

Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan dokter DPJP dan asisten poli spesialis agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi, selain itu koordinasi dengan tim pendaftaran dalam mempromosikan poli gizi.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Agustus 2025

NO	JENIS KOMPLAIN	NAMA PASIEN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT	TOTAL
Bulan Februari 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	An Yuan (B3C-4 IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Menu yang didapat tidak bervariasi dibandingkan dengan terakhir kali pasien rawat inap (siklus menu berulang)	1. Siklus menu yang berlaku di RS Prima Husada Malang adalah siklus menu 10 hari+1 hari 2. Pasien MRS pada hari dimana siklus menu yang sama dengan hari MRS sebelumnya.	Melakukan analisis asupan makan pasien selama rawat inap untuk melihat daya terima pasien tersebut terhadap menu yang disajikan	1
Bulan Maret 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan April 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan Mei 2025					
1.	Keluhan pasien dan OB yang belum mendapatkan makanan	An Abimanyu Putra Herlambang (C3C-8, IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Ayah pasien menyampaikan bahwa jika pasien belum selesai makan maka jangan mengambil makanan pasien terlebih dahulu.	1. Jam pengambilan makan adalah 1 jam setelah pembagian makan. 2. Pasien mengalami penurunan nafsu makan sehingga mengkonsumsi makanan dalam waktu lebih lama.	1. Koordinasi dengan tim penyaji untuk memberikan edukasi terkait jam pengambilan alat makan yaitu 1 jam setelah pembagian makan. 2. Koordinasi dengan CS pantry untuk cara edukasi yang benar sebelum mengambil alat makan pasien.	1
Bulan Juni 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	Ny Nadiyah Firliani Komplain melalui google review “makanannya kurang enak”	a. Pasien sakit mengalami penurunan nafsu makan dan penurunan citarasa	Koordinasi dengan seluruh petugas pengolahan dalam pembuatan standar resep masakan agar masakan yang	1

			b. Antara satu petugas pengolahan dan pengolahan lain memiliki selera rasa yang berbeda sehingga ketika memberi rasa pada makanan disesuaikan dengan selera petugas masing-masing	dihasilkan sama antara satu petugas dengan petugas lain	
Bulan Juli 2025					
1	Keluhan adanya benda asing dalam makanan pasien	- Ani Puji Lestari (C3a-6) komplain ada benang wol saat makan siang menu mie bihun, benang dikunyah saat makan oleh pasien. Pasien tidak langsung lapor, tapi mengisi kuesioner saat KRS. - Hana Rizki Anjani (3c anak) komplain sebaiknya pasien sering diberi menu sayur dan buah.	- Ahli gizi kurang teliti dalam melakukan QC makanan pasien - Petugas pengolahan tidak teliti dalam mengolah bihun. Tidak menggunting benang bihun dengan teliti sehingga ada benang yang tertinggal - Pasien anak dengan diagnosa TF diberikan advice DPJP diet rendah serat (tidak boleh mengkonsumsi sayur dan buah). Ahli gizi sudah menjelaskan diet kepada keluarga pasien. Keluarga pasien yang dijelaskan tidak mengoperkan kepada anggota keluarga yang lain. Ahli gizi tidak konfirmasi	- Koordinasi dengan seluruh petugas pengolahan, pemorsia, dan ahli gizi dalam menjaga kebersihan makanan dari benda asing - Sosialisasi kepada seluruh ahli gizi jika setelah memberikan penjelasan melakukan konfirmasi terkait informasi yang diberikan.	2

			terkait informasi yang diberikan.		
Bulan Agustus 2025					
1	Keluhan tentang variasi makanan	- Etik Hariani (2c) komplain jika masakannya tolong bervariasi, - Komplain dari kuisisioner (3 Agustus) Untuk menu makanan bisa bervariasi lagi - Komplain kuisisioner (30 Agustus) Masukan untuk bagian gizi supaya lebih fariatif menu, untuk rasa kurang asin.	Menu makan pasien pada siklus yang berjalan ada yang diulang dalam waktu berdekatan, sehingga jika pasien dirawat dalam waktu 3 hari berisiko masih menemukan menu yang sama dengan hari sebelumnya	- Koordinasi dengan Instalasi gizi RSPHS terkait komplain variasi menu yang muncul - Mengajukan perubahan siklus kepada PT DPM untuk menghindari pengulangan menu dalam waktu dekat (proses pengajuan)	3
Bulan September 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan Oktober 2025					
1	Keluhan tentang mutu makanan pasien	- Pasien a/n Ny Sudarti'in dan Ny. Nuktah (25 Oktober 2025) komplain bahwa nasi tim pasien berair seperti sudah basi - Pasien a/n (26 Oktober 2025) Supratiknyo komplain di makanan pasien ada cacing masih hidup	- Nasi tim pasien berair dikarenakan oleh petugas pengolahan (Tyas) nasi tim yang dimasak pagi dicampur dengan nasi tim pana yang baru matang. Sehingga nasi tim mudah berair dan basi. - Ahli gizi (Veni) Saat QC tidak mengetahui jika di makanan pasien ada cacing yang masih hidup	- Sosialisasi kepada pengolahan agar tidak mencampur nasi tim yang sudah dingin dengan nasi tim yang masih panas - Edukasi kepada tim pengolahan agar lebih bersih dalam membersihkan sayuran, penyaji lebih teliti saat memorsi makanan dan ahli gizi lebih teliti saat melakukan QC makanan pasien.	2
Bulan November 2025					
Tidak ada komplain					

2.4.5.6 Tabel Rekap *Food Waste* (Sisa Makanan) 2025

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025	
1.	Karbohidrat	Nasi	134,5	135,5	105,3	75% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat.
		Nasi Tim	204,5	198,2	145	
	Total		339	333,7	250,3	
2.	Snack	Roti Kukus	0,3	0	0,3	Snack yang memiliki sisa paling banyak adalah bubur sagu
		Setup Pisang	0,8	0,4	0	
		Kacang Hijau	0,4	1,4	0,4	
		Kue Hongkong	0,2	0	0	
		Terang Bulan	1,4	0	0	
	Total		8,8	4,3	2,2	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 12,3 Kg
	Bulan		Okt 2025			
	Pagi	Rolade ayam masak kecap dengan tahu goreng + buncis	5,2			
		Bakwan Jagung				
	Tambahan VIP	Telur mata sapi rebus				
	Siang	Semur daging+wortel+de daunan	5,8			
		Tahu goreng				
	Tambahan VIP	Abon				
	Sore	Semur (ayam fillet, buncis,dedaunan,t omat)	4,4			
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Telur dadar tebal				
	Total		11,9			
2.	Menu 2					
	Bulan		Okt 2025			
	Pagi	Cah sawi putih+wortel, dedaunan, ayam suwir	6,3			
		Rolade ayam				
	Tambahan VIP	Tempe goreng				
	Siang	Bening bayam, oyong	4,8			
		Bakwan jagung				
	Tambahan VIP	Telur Mata Sapi				
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	3,2			
		Tempe Goreng				
	Tambahan VIP	Bakso Goreng				

		Mekar			
	Total		7,2		
3.	Menu 3				
	Bulan		Okt 2025		
	Pagi	Semur (ayam fillet, buncis, daunan, tomat)	4,9		
		Perkedel kentang ayam			
	Tambahan VIP	Telur Dadar tebal			
	Siang	Sup (sawi daging, ayam dadu, wortel)	6		
		Bakwan jagung			
	Tambahan VIP	Lapis daging			
	Sore	Oseng (Jamur Kuping, Wortel, Bakso, Kacang Polong)	4,4		
		Ayam Bombay			
		Tempe Orek			
	Tambahan VIP	Telur Dadar			
	Total		10,9		
4.	Menu 4				
	Bulan		Okt 2025		
	Pagi	Manisa, buncis, bakso masak kuning	7		
		Telur pindang			
	Tambahan VIP	Jamur Goreng			
	Siang	Sup (wortel, polong, bakso, jamur es)	6,1		
		Fillet ayam panggang tabur wijen			
	Tambahan VIP	Perkedel kentang ayam			
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	4,6		
		Telur Rebus			
		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Keripik Kentang			
	Total		14,1		
5.	Menu 5				
	Bulan		Okt 2025		
	Pagi	Tahu +telur+wortel	5,7		

		masak kuning				
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Abon				
	Siang	Bening jagung sisir, bayam, manisah	5,9			
		Ayam wijen				
	Tambahan VIP	Telur ceplok/rebus	2,7	5,2	2,6	
	Sore	Sup Merah (Bakso, Ayam Dadu, Polong, Wortel)				
		Tempe Goreng				
		Telur Dadar				
	Total		9,5	12,6	8	
Total Sisa Menu tanpa KH		109,7	110,6	82,4		
Total Keseluruhan dengan KH		448,7	444,3	362,4		

2.4.5.7 Siklus Menu Baru pada bulan Oktober

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	
1.	Karbohidrat	Nasi	107	105,3	93,6	23% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH pada bulan November menurun 3,5% dari bulan Oktober
		Nasi Tim	173	145	147,6	
	Total		280	250,3	241,2	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0,3	0	Snack yang memiliki sisa paling banyak adalah bubur kacang hijau
		Setup Pisang	0,4	0	1	
		Kacang Hijau	1,4	0,4	1,8	
		Kue Hongkong	0	0	0	
		Terang Bulan	0	0	0	
		Bubur Sagu	1,0	0,7	1,4	
		Kue Lumpur	0	0	0	
		Puding	0,6	0,5	0	
		Donat	0,5	0,2	0	
		Tahu Fantasi	0,4	0,4	0	
		Sagu Mutiara	0	0	0	
	Total		4,3	2,2	2,1	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 13,9 Kg
	Bulan		Okt 2025	Nov 2025		
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	3,4	4,6		
		Rolade Ayam				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng				
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	4,1	5,7		
		Ayam Kecap				
		Tahu Bumbu				

		Tomat			
	Tambahan VIP	Telur Ceplok			
	Sore	Sup (Suun, wortel, polong, bakso)	5,5	5,1	
		Perkedel kentang ayam			
	Tambahan VIP	Ayam fillet panggang teflon			
	Total		13	15,4	
2.	Menu 2				
	Bulan		Okt 2025	Nov 2025	
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	3,5	4,4	
		Tahu Rempah (Remet)			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Rebus			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	3	5,5	
		Ayam Wijen			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Telur Gulung			
	Sore	Capjae (wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)	5,2	4,9	
		Telur dadar tebal			
	Tambahan VIP	Tempe goreng			
	Total		11,7	14,8	
3.	Menu 3				
	Bulan		Okt 2025	Nov 2025	
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,3	4,8	
		Tahu Krispy			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Ceplok			
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	3,8	5,7	
		Rolade Ayam			
		Tahu Goreng			
	Tambahan VIP	Tempe Bacem			
	Sore	Sapo (tahu goreng, wortel, bakso,dedaunan, saos tiram)	5,7	6,2	
		Telur rebus			
	Tambahan VIP	Tempe goreng			

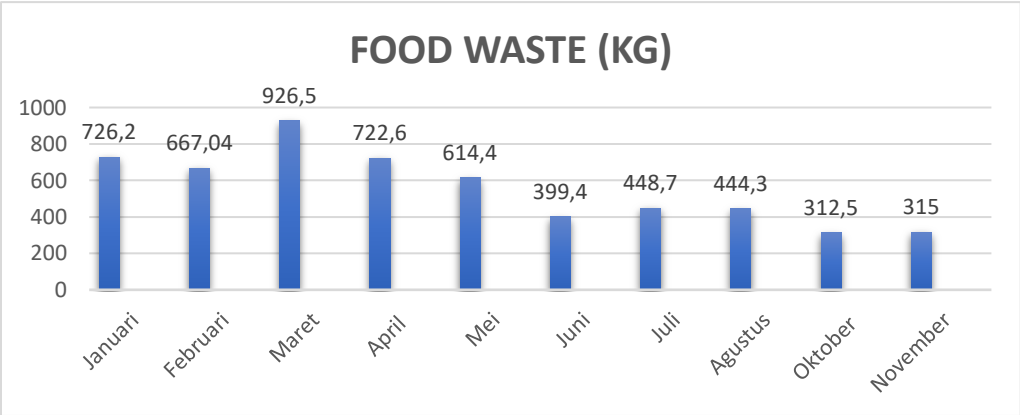
	Total		12,8	16,7	
4.	Menu 4				
	Bulan		Okt 2025	Nov 2025	
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	3,6	6,1	
		Tahu Nugget			
		Abon			
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar			
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	4,1	4,6	
		Ayam Kecap			
		Jamur Krispy			
	Tambahan VIP	Tahu Bacem			
	Sore	Fuyunghai (telur, wortel,daunan)sas u polong orang	6,2	1,3	
		Jamur goreng			
	Tambahan VIP	abon			
	Total		13,9	12	
5.	Menu 5				
	Bulan		Okt 2025	Nov 2025	
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	3,4	6,1	
		Opor Tahu			
		Oper Telur			
	Tambahan VIP	Tempe Goreng			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	3,4	4,8	
		Ayam Bombay			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Tahu Krispy			
	Sore	Soto ayam	4,6	4	
		Telur rebus			
		VIP= Perkedel ayam			
	Total		11,4	14,9	
	Total Sisa Menu tanpa KH		62,8	73,8	
	Total Keseluruhan dengan KH		312,5	315	

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2025

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)	Rata-Rata/Hari
1.	Januari 2025	726.2	23,42
2.	Februari 2025	667.04	23,82
3.	Maret 2025	926.5	29,88
4.	April 2025	722.6	24,08

5.	Mei 2025	614,4	19,81
6.	Juni 2025	399,4	13,3
7.	Juli 2025	448,7	14
8.	Agustus 2025	444,3	14
9.	Oktober 2025	312,5	10,9
10	November 2025	315	10,5

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Tahun 2025



Analisis :

1. Terdapat perubahan perhitungan sisa makanan pada Bulan Maret 2025, dimana perhitungan dipisahkan per menu dengan tujuan mengetahui menu makanan yang kurang diminati.
2. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa ada penurunan sisa makanan pada Bulan November 2025, yaitu sebanyak 312,5 kg, setelah dilakukan tindaklanjut mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian dan memperbaiki dalam segi rasa dan penampilan.
3. Masih ditemukan sisa makanan selain karbohidrat, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
 - a. Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - b. Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - c. Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.
4. Tidak ada keterlambatan pengiriman makanan, jadwal makan sesuai.
5. Menu snack yang tidak diminati adalah setup pisang, bubur kacang hijau, bubur sagu dan tahu fantasi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien terkait pemberian diit dan pembatasan makanan dari luar.
2. Melakukan plating secara menarik.
3. Mengadakan cooking class.
4. Memperbaiki dari segi rasa, tampilan dan menu.
5. Mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian.
6. Mengganti menu snack yang tidak diminati.
7. Menimbang sisa makanan tanpa kuah.

2.4.5.7 Lampiran Pemantauan Air Panas di Pencucian Alat Makan



RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
Monitoring Suhu (Suhu Normal = 19° - 25° Celcius)

BULAN :
TEMPAT : PENCUCIAN CENTRAL

Ruang	TANGGAL																																																					
	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18		
	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M									
Batas suhu min (°C)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15						
Batas suhu maks (°C)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25						
Nilai Suhu (°C)	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6						
Inisial Staff	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm			
Supervisi Karu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V						



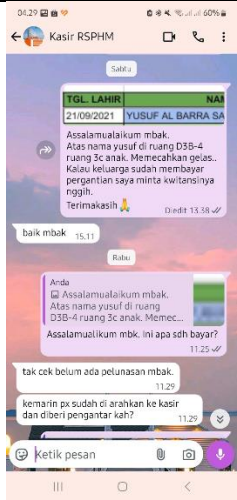
19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31		
P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M			
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
26.4	26.5	26.3	26.5	27.3	25.6	26.4	26.5	26.3	26.5	27.3	25.6	26.4	26.5	26.3	26.5	27.3	25.6	26.4	26.5	26.3	26.5	27.3	25.6	26.4	26.5	26.3	26.5	27.3	25.6	26.4	26.5	26.3	26.5	27.3	25.6			
an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an			
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

(--) Suhu ruang tidak lebih dari 25°C (---) Suhu ruang tidak kurang dari 15°C

2.4.5.8 Lampiran Rekap Data Kehilangan Alat Makan

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	RUANGAN	NAMA ALAT	BUKTI KUITANSI	DOKUMENTASI	KETERANGAN
Januari 2025							
1.	19/01/2025	Suratman	D7A-9	Sendok			Kasir salah nama
2.	21/01/2025	Anissa Octaviafitri Widodo	B5C-2	Sendok			Pasien sudah KRS
3.	26/01/2025	Aqilla Rassi Susanto	B2	Mangkuk Kecil			Sudah kembali
4.	31/01/2025	Ilma Ayuningsi	T4C-3	Gelas			Sudah pembayaran
Februari 2025							
1.	01/02/2025	Abid Fadhul Abyan	B3C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	01/02/2025	Cholifah	B5C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang

3.	04/02/2025	Widya Dwi Anandita	D6A-11	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
4.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Makan			Sendok terbawa pulang
5.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Snack			Sendok terbawa pulang
6.	06/02/2025	Chabibatul Aziizah	B3C-1	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
7.	06/02/2025	Mimi Eka	D4C-7	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
8.	19/02/2025	Ni'matul Udhma Himza	D3B-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Maret 2025							
1.	11/03/2025	Muhammad Syifa	V3 (VIP)				Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	24/03/2025	Pranata Dimas Ariansyah	C3C-10				Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	25/03/2025	Mistianingsih	C3A-4				Sendok hilang pasien sudah pulang
April 2025							
1.	17/04/2025	Achmad Yogie Septiansyah	B2-5C	Gelas			Sudah pembayaran
Mei 2025							
1.	05/05/2025	Kasiati	D8A-12	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	12/05/2025	Adhibah Mahirah Azizah	C3C-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	28/05/2025	Ika Rodyana	D6A-8	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Juni 2025							
Juli 2025							
1	04/07/2025	Ahmad Subandi	D7A-1	Sendok Makan			Sendok Hilang Px Pulang
2	06/07/2025	Lili Anita	B3C-6	Gelas			Memecahkan Gelas
3	11/07/2025	Eka Maulidia Sari	V3 (VVIP)	Sendok Snack			Sendok Snack Hilang Px Sudah Pulang
4	11/07/2025	Arnemelia Ayunda Lestari	A2 (VIP)	Sendok Snack			Sendok Snack Hilang Px Sudah Pulang
5	11/07/2025	Arnemelia Ayunda	A2 (VIP)	Garpu			Garpu Hilang Px Sudah

		Lestari					Pulang
6	11/07/2025	Sophia Alya Khairani	B3C-4	Sendok Makan			Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
7	20/07/2025	Arya Raka Pratama	C3C-7	Sendok Makan			Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
Agustus 2025							
1	04/08/2025	Aisyah Bulan Jewel Gandhi	D3C-7	Sendok Makan	-	-	Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
2	12/08/2025	Farieza Dayn Za-Zahra	D3B-2	Sendok Makan	-	-	Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
3	02/08/2025	Yusuf Al Barra Saputra	D3B-4	Gelas Pasien			Memecahkan Gelas, Pasien Pulang Tanpa Membayar
September 2025							
1	23/09/2025	D7A-2	DENI IRAWAN		-	GELAS PASIEN	Pasien memecahkan gelas dan sudah membayar penggantian ke kasir
Oktober 2025							
1	30/10/2025	C2A-1	ARYTA WULANDARI		-	GELAS PASIEN	Pasien memecahkan gelas dan sudah membayar penggantian ke kasir
November 2025							
1	28/11/2025	D6A-8	UMI KULSUM	-	-	SENDOK PASIEN	Pasien menghilangkan sendok, akan tetapi pasien komplain saat diminta mengembalikan dan mengganti sendok

- Analisis :
- Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 kehilangan alat makan pada Bulan November 2025.
 - Ada perubahan alur dan dilakukan supervisi oleh Koordinator CS.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
- 2. Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangan , CS Pantry dan Ruangan, dan Kasir.

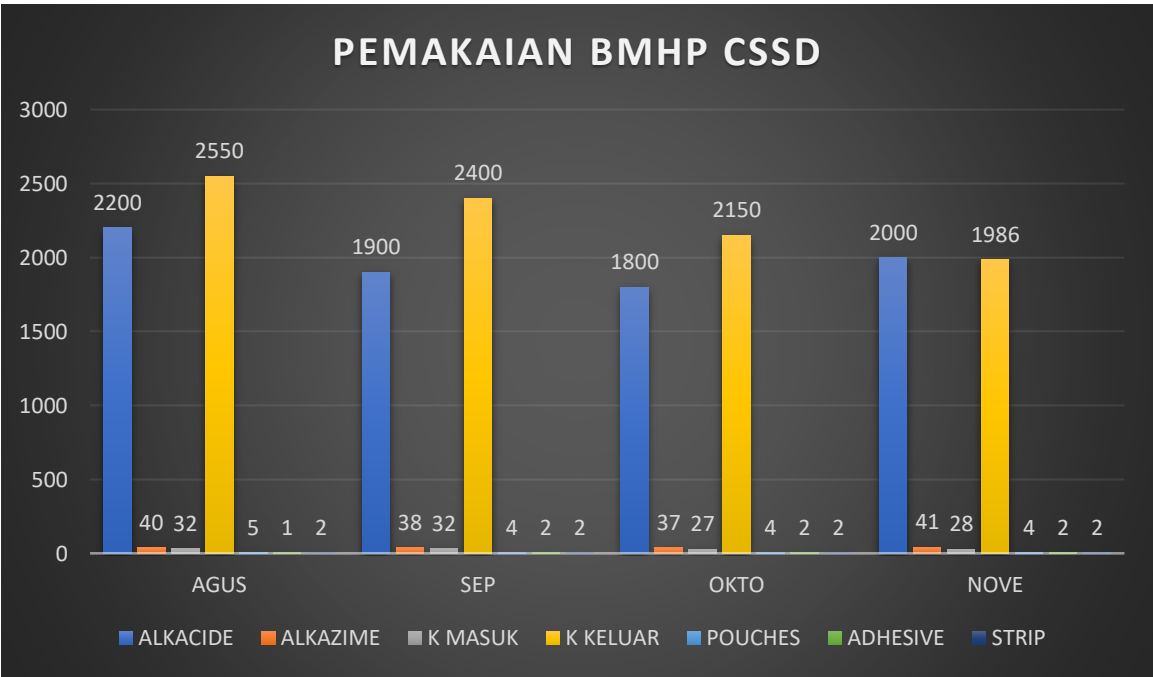
4.4.7 CSSD – Laundry

4.4.7.1 CSSD

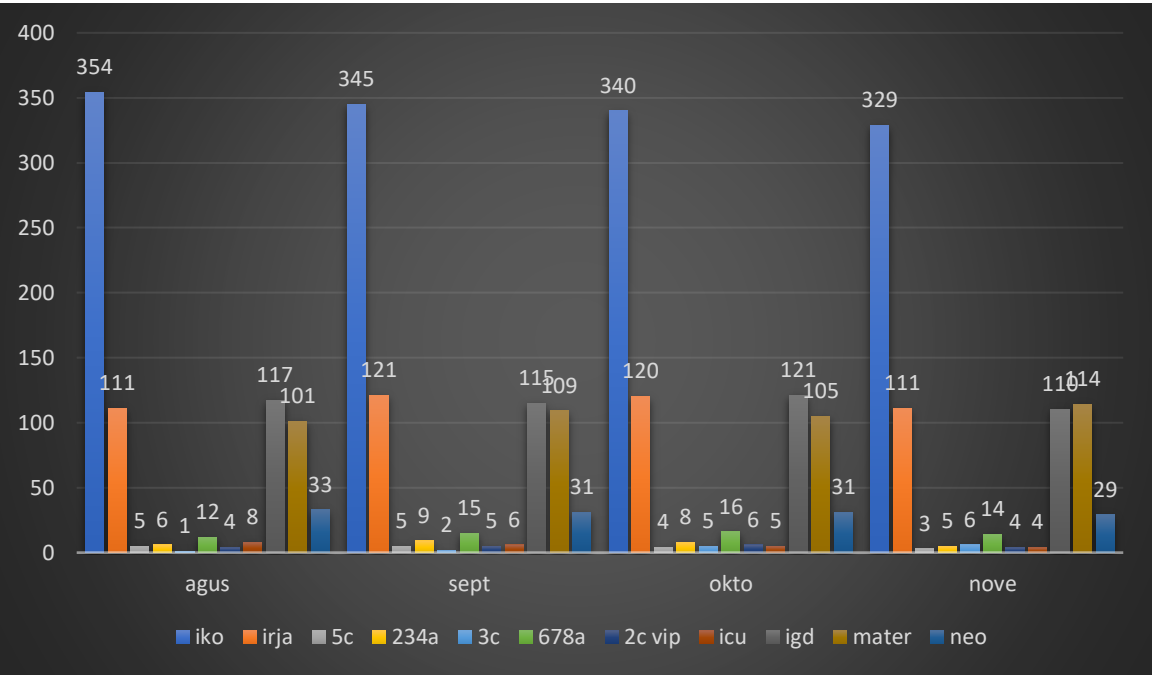
4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD September - November 2025

NO	HAL	BULAN TAHUN 2025		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1.	Chemical Alcacide (ml)	1900	1800	2000
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	38	37	41
3.	Kassa Masuk (roll)	32	27	28
4.	Kassa Keluar (pouches)	2400	2150	1986
5.	BHP Pouces (roll)	4	4	4
6.	Indikator Adhesive (roll)	2	2	2
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	2
8.	IKO	345	340	329
9.	IRJA	121	120	111
10.	IRNA 5C	5	4	3
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	9	8	5
12.	IRNA 3C ANAK	2	5	6
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	15	16	14
14.	IRNA 2C VIP	5	6	4
15.	IRNA ICU	6	5	4
16.	IGD	115	121	110
17.	MATERNITAS	109	105	114
18.	NEONATOLOGI	31	31	29
Jumlah		763	761	729

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan Agustus - November 2025



Analisis :
Pada bulan November penggunaan alkazime dan alkacide meningkat. Permintaan kasa roll juga meningkat



- Analisis :**
1. Pada bulan november jumlah alat yang disetor di CSSD yang mengalami peningkatan yaitu: 3c Anak dan Maternitas
 2. Sementara Pada bulan Oktober alat yang disetor di CSSD yang mengalami penurunan yaitu IKO, 234A, 678A, 5C, IGD, 2C, IRJA, ICU DAN PERINA

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
 2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
 3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
 4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.7.4 Tabel Penggunaan Reuse Pada Bulan NovemberTahun 2025

Nama Alat	Reuse ke1
Junctionrees	-
Breating circuit	-

Analisis :
Tidak ada permintaan alat reuse pada Bulan November2025.

4.4.7.4 Tabel Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD

UNIT	BULAN								TOTAL
	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	AGT 2025	SEP 2025	OKT 2025	NOV 2025	
	Kejadian Instrument Kurang								
IKO	1	4	1	2	-	-	0	0	8
IGD	0	0	0	0	-	-	0	0	0
IRNA	0	0	0	0	-	-	0	0	0
IRJA	0	1	0	0	-	-	0	0	1
	Kejadian Instrumen Hilang								
IKO	0	0	0	0	-	-	0	0	0
IGD	2	0	0	0	-	-	0	0	2

IRNA	0	0	0	0	-	-	0	0	0
IRJA	0	0	1	0	-	-	0	0	1

Analisis :

-

Rencana Tindak Lanjut :

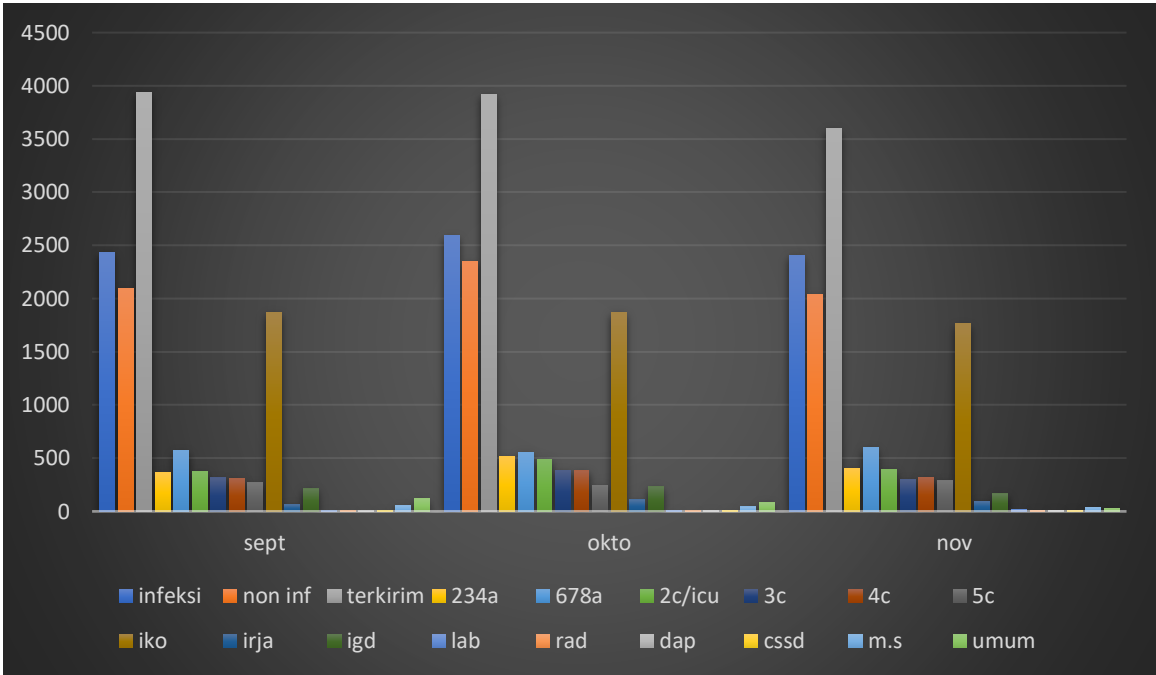
-

1.4.7.2 Laundry

1.4.7.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry pada Bulan September – November Tahun 2025

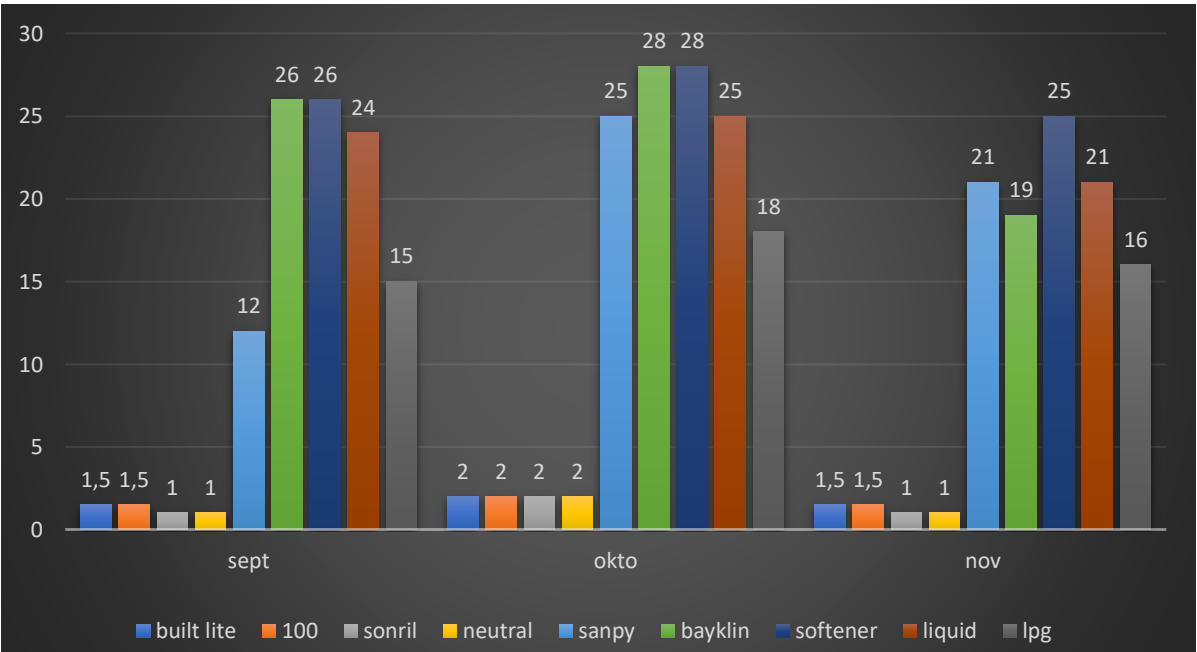
NO	HAL	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	1,5	2	1,5
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	1,5	2	1,5
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	1	2	1
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	2	1
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	12	25	21
6.	Pemutih Bayclean (liter)	26	28	19
7.	Softener (liter)	26	28	25
8.	Liquid matic (liter)	24	25	21
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	15	18	16
TOTAL		108	132	88
1.	Linen Infeksious	2437	2591	2409
2.	Linen Non Infeksious	2097	2347	2037
3.	IRNA 2,3,4 A	361	513	405
4.	IRNA 6,7,8 A	571	553	602
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	375	491	394
6.	IRNA 3C	315	388	299
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	311	382	322
8.	IRNA 5C	267	248	286
9.	IKO	1865	1867	1762
10.	IRJA	67	111	97
11.	IGD	211	231	165
12.	LABORATORIUM	5	8	15
13.	RADIOLOGI	3	6	10
14.	DAPUR/GIZI	5	8	10
15.	CSSD	7	9	10
16.	Linen MS	55	42	39
17.	Umum	117	81	30
Total		9069	9876	8892

1.4.7.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan September - November 2025



- Analisis :**
- 1. Linen IKO mengalami penurunan dari 1867 ke 1762
 - 2. Linen irja, igd juga menurun
 - 3. Linen irna juga mengalami penurunan

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
 - 2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
 - 3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
 - 4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
 - 5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
 - 6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.



Analisis :

Pada bulan november semua BMHP mengalami penurunan pemakaian yaitu karena cucian di laundry juga menurun, terutama cucian IKO

4.4.7.2.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan September - November 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1.	Sprei	122	115	286
2.	Sarung bantal	241	134	343
3.	Selimut	158	151	326
4.	Baju tim IKO	105	105	105
5.	Baju ganti pasien	28	28	28
6.	Skort	145	145	145
7.	Perlak	15	15	13
8.	Baju ganti laundry	14	14	14
9.	Duk lubang besar	20	20	20
10.	Duk pembungkus	50	50	50
11.	Duk kecil 1 meter	41	41	40
12.	Duk ortho	12	12	12
13.	Duk lubang kecil	16	16	16
14.	Duk kaki	11	11	11
15.	Meja mayo	18	18	18
16.	Skort IKO	58	58	58
17.	Waslap	51	51	48
18.	Handuk CSSD	10	10	10
19.	Bantal	121	121	121
20.	Baju Pasien	21	21	21

1.4.7.2.3 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan September - November 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1.	Sprei	11	11	7
2.	Sarung bantal	12	12	7
3.	Selimut	6	6	7
4.	Duk Pembungkus	3	3	0
5.	Duk Lubang Kecil	1	1	0
6.	Celana Tim IKO	5	5	0
7.	Baju Tim IKO	5	5	0
8.	Baju Pasien	5	5	0
9.	Skort	1	1	0
10.	Perlak	3	3	2
11.	Baju Ganti Laundry	0	0	0
12.	Duk Kecil	2	2	1
13.	Waslap	4	4	3
14.	Handuk CSSD	0	0	0
15.	Bantal	2	2	0
16.	Kerudung	0	0	0
17.	Kantong L	0	0	0
18.	Meja Mayo	1	1	0

Analisis :

1. Untuk linen rusak bulan oktober sprei sarban dan selimut, sementara untuk linen lain belum terhitung

2. Sprei, sarban dan selimut rusak karena terdapat noda yang membandel dan sudah dilakukan spoting berulang

Rencana Tindak Lanjut :
Follow up Pengadaan PT

1.4.7.2.4 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Juni Tahun 2025

NO	NAMA BENDA	JUMLAH		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1.	Masker IKO	2	2	2
2.	Tissue	2	2	2
3.	Jarum	0	0	0
4.	Bumbu Dapur	0	0	0
5.	Uang	0	0	0
6.	Alat Tulis	0	0	0
7.	Benda lainnya (Underpad)	2	0	0

- Analisis :**
- Benda asing yang sering tercampur di bulan November yaitu tissue dari IKO, Masker dari IKO dan instrument IKO
 - Ketidakdisiplinan paling banyak dari Unit IKO.
 - Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- Melakukan sosialisasi kepada unit.
 - Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4 Kinerja Bidang Umum
4.4.7 SDM

3.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	40	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analisis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0

		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	11	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	22	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		7	6	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	8	8	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	28	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	13	2	0
		D4 Keperawatan Gigi		2	1	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	7	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	17	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		10	6	4	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	13	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	11	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		3	3	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0

		D3 Keperawatan		4	4	0	1
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	7	1	1
30	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	15	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	1	1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	40	14	8	6	0
		SMA		21	17	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0

51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			429	429	284	145	2

Keterangan :
Pada bulan November terdapat 2 staf resign (Staf Neonatologi dan Laboratorium).

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	drg. Khadijah fauzi Basalamah, Sp. KG	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	19 November 2025	SIP Baru
2	Kendita Putri Mahadini, S. ST	Perawat Gigi	21 November 2025	SIP Baru

Keterangan :
Pada bulan November terdapat 2 SIP baru yang terbit.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Sudah mendapat kandidat dengan drg. Khadijah, Sp. KG. SIP sudah terbit, menunggu Hfis aktif.
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
7	Dokter Umum IGD	2	1	1	On proses rekrutmen	On proses rekrutmen

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	21 Oktober 2025	Khusus	Kendita Putri Mahadini	S1	Perawat Gigi	21 Oktober 2025	Penempatan IRJA Poli Gigi

Keterangan : Pada bulan November 2025 ada 1 staf dengan orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK

Keterangan:

Pada bulan November 2025 belum terdapat pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum & Keuangan	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Satuan Pengawas Internal	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	40	0	11	27	2	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	5	5	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	0	5	0	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	16	0	9	7	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	0	2	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	11	0	8	3	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	22	0	11	11	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	12	0	9	3	0	0	Unit IKO secara keseluruhan

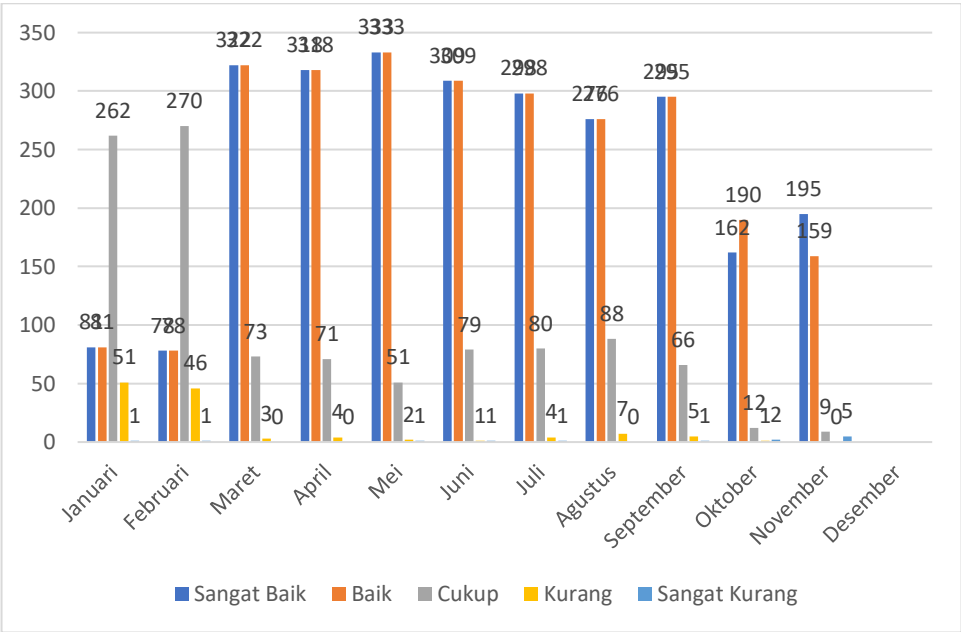
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCN secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRs	Umum	6	0	4	2	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	28	0	22	5		1	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	7	0	4	2	0	1	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	17	0	11	6	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	13	0	9	3	0	1	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	8	0	5	3	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	21	0	9	12	4	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	11	0	6	4	0	1	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	9	0	3	6	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	9	0	0	3	6	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	9	0	4	5	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	2	3	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	7	0	4	3	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	15	0	3	12	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	4	0	4	0	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									umum.
33	SDM	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	0	3	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	40	0	24	15	0	1	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	8	4	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	6	0	4	2	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode November 2025.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78	322	318	333	309	298	276	295	161	195	
Baik	262	270	73	71	51	79	81	88	66	192	159	
Cukup	51	46	30	40	21	11	41	70	51	12	9	

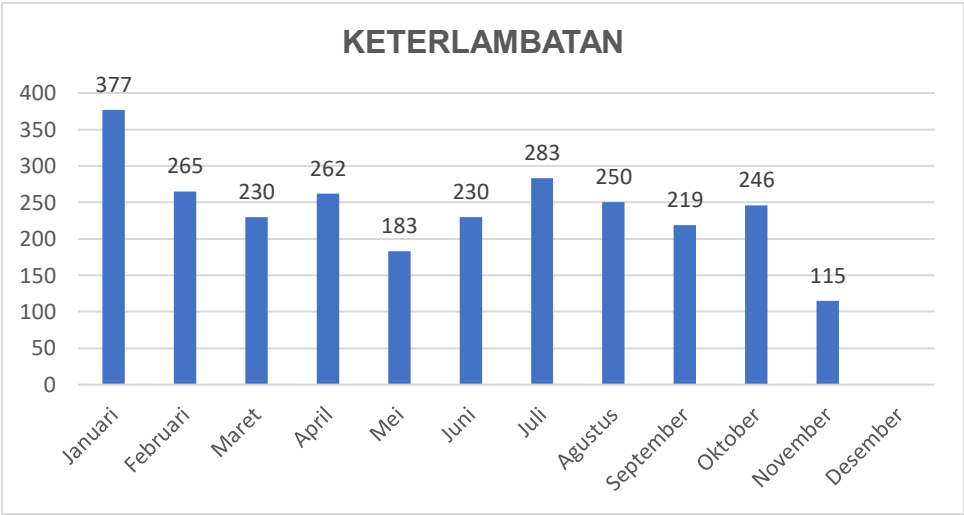
Kurang	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	
Sangat Kurang	4	4	2	5	4	1	1	2	2	2	5	
TOTAL	399	399	400	398	391	391	385	373	369	368	368	

Analisa :
 Secara umum terdapat penurunan kategori sangat baik ke baik akibat tidak adanya diklat seluruh staf di bulan November 2025 dan adanya peningkatan keterlambatan karyawan.

Rencana Tindakanlanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.
4. Membuat diklat dengan konsep baru sesuai arahan PT

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265	230	262	183	230	283	250	219	246	115	



Analisa :
 Secara umum terdapat peningkatan keterlambatan karyawan dari bulan sebelumnya dan paling rendah selama 11 bulan terakhir

Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAK PATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	0

4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	1
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	1
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	1
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	0
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	1
12	ICU	0	0	0	0	0	0	0
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	0
16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	1
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	0
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	0
21	CSSD	0	0	0	0	0	0	1
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	1
23	Keuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	1
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	0
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	0
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	0
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	0
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	8

Analisis :
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.6.1 Supervisi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	100%	50%	100%	100%	100%	0%	100%	50%	50%	50%	

Analisis:
 Dilakukan tanggal 22 November 2025
 Dilakukan mandiri ke tiap unit.
 Masih ditemukan staf yang tidak menggunakan nametag karena terlupa

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
1	Saudah, S. Kep., Ns	IRNA 3C Anak	Neonatologi
2	Neneng Aprilia Pangestuti, Amd. Kep	IRNA 234A	IRNA 2C
3	Safitri Retno kurniawati, Amd. Kep	CSSD	IRNA 3C Anak3
4	Elok Oktaviana, Amd. Keb	IGD	Maternitas

Analisis : pada bulan Oktober 2025 terdapat 3 staf rotasi

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintanance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	90%	84.61	66.6	92.3	76,92	89,74	69.2%	82.05%	64.10%	53,8%	84,61%	74,35%	

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%
Februari	270	135	50.00%
Maret	276	153	55.43%
April	276	150	54.34%
Mei	275	142	51.64%
Juni	276	165	59.78%
Juli	276	166	60.14%
Agustus	276	194	70%
September	276	77	27,8%
Oktober	276	136	49.27%
November	276	131	47,46%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21
Februari	22
Maret	21
April	17
Mei	26
Juni	15
Juli	25
Agustus	29
September	17
Oktober	17
November	16

Analisa :
Pada bulan ini capaian adalah 74,35% untuk ruangan dan 47,46% untuk alat kesehatan

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk rekrutmen ATEM sesuai ABK (tidak ada pemenuhan rekrutmen)

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL
TARGET/BULAN	42	30	23	95
JANUARI	11	6	16	33
FEBRUARI	23	17	11	51
MARET	14	41	6	61
APRIL	7	30	6	43
MEI	19	18	18	45
JUNI	7	16	2	25
JULI	15	21	12	48
AGUSTUS	3	4	16	23
SEPTEMBER	9	21	20	50
OKTOBER	6	13	10	29
NOVEMBER	1	21	16	38
DESEMBER				

Analisa :
Pemeliharaan AC bulan November naik dibandingkan sebelumnya

Link terlampir : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
10	Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
11	November	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala
Melalui link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/110WG4QS8bLSVMEPsinZvqSZrNmPuELgYBKbs_oUd89Eo/edit?gid=2003963143#gid=2003963143

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
10.	Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
11	November	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3AmeFpNj9z9LRM1HECH586kvHODUBC2dxtMaMTx1WQ/edit?gid=1843933243#gid=1843933243>
2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWCMAg6OMZK7k/edit?gid=1243237048#gid=1243237048>
3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg3I7 SLF6JsafyAZHxZKoPBLPgAbgEV92qYIFZj4M/edit?gid=183386497#gid=183386497>
4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj662P7GKprEiZdfb8deF4N2QJmVQGokfuJtxTLk8DQ/edit?gid=462403140#gid=462403140>
5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pBsP-cAEM1iC5zDKXn4KuGJAyz1vEbGXE73obF9jQ80/edit?gid=0#gid=0>
6. Link Pemeliharaan Panel LVMDP
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH5ImQzu3mwTuMa1Qj72tGD5eDJHUXIzD63VM4gWdNQ/edit?gid=0#gid=0>

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

November 2025							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/11/2025	2852	2629	223	MMHG			MMHG
02/11/2025	2629	2400	229	MMHG			MMHG
03/11/2025	2400	2181	219	MMHG			MMHG
04/11/2025	2181	1945	236	MMHG			MMHG
05/11/2025	1945	1699	246	MMHG			MMHG
06/11/2025	1699	1456	243	MMHG			MMHG
07/11/2025	1306	3169	0	MMHG		1863	MMHG
07/11/2025	3169	3077	92	MMHG			MMHG
08/11/2025	3077	2792	285	MMHG			MMHG
09/11/2025	2792	2531	261	MMHG			MMHG
10/11/2025	2531	2287	244	MMHG			MMHG
11/11/2025	2287	2023	264	MMHG			MMHG
12/11/2025	2023	1772	251	MMHG			MMHG
13/11/2025	1772	1357	415	MMHG			MMHG
14/11/2025	1357	3125	0	MMHG		1768	MMHG
14/11/2025	3125	3010	115	MMHG			MMHG
15/11/2025	3010	2740	270	MMHG			MMHG
16/11/2025	2740	2459	281	MMHG			MMHG
17/11/2025	2459	2150	309	MMHG			MMHG
18/11/2025	2150	1659	491	MMHG			MMHG
19/11/2025	1659	1377	282	MMHG			MMHG
20/11/2025	1377	1038	339	MMHG			MMHG
21/11/2025	1038	3209	0	MMHG	sesudah pengisian	2171	MMHG
21/11/2025	3209	3107	102	MMHG			MMHG
22/11/2025	3107	2806	301	MMHG			MMHG
23/11/2025	2806	2474	332	MMHG			MMHG
24/11/2025	2474	2122	352	MMHG			MMHG
25/11/2025	2122	1765	357	MMHG			MMHG
26/11/2025	1765	1430	335	MMHG			MMHG
27/11/2025	1430	957	473	MMHG			MMHG
28/11/2025	957	3115	0	MMHG	sesudah pengisian	2158	MMHG
28/11/2025	3115	3050	65	MMHG			MMHG
29/11/2025	3050	2756	294	MMHG			MMHG
30/11/2025	2756	2487	269	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			8175	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						7960	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			506.5666667	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3184	MMHG

Analisis :

Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi melalui link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuzd_v1pO6Q2IDQr5clmEvCF-S-0EF2VI8LY_e93IQE/edit?gid=342425059#gid=342425059

1.5.2.2.7 Filter Air

3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi melalui
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcauU1Xi-rY4On3PymLDuNIIV0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 List Lokasi Lift

NO	LOKASI	KONDISI
1	Lift Gedung A Pasien	Baik
2	Lift Gedung A Pengunjung	Baik
3	Lift Gedung B	Baik
4	Lift Gedung C Umum	Baik
5	Lift Gedung C Karyawan	Baik
6	Lift Gedung D (Garansi)	Baik

1.5.2.2.8.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qMBqK_KT7GLwypkDMOm-X2vb5cPJtVV/edit?gid=730491017#gid=730491017

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOK6Lufn7skng/edit?usp=sharing

1.5.2.2.10 Air Minum

NAMA	LOKASI	KONDISI
Instalasi Air Minum 1	Lantai 1 Gedung C	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah

				mencapai target
April	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
 RTL :
 monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.11 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

NAMA	LOKASI	KONDISI
Filter Air Bersih Poli Gigi 1	Lantai 2D	Baik
Filter Air Bersih Poli Gigi 2	Lantai 2D	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai

				target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.12 Rekapn Kegiatan External

BULAN	JUMLAH KEGIATAN (HARI)
Januari	4
Februari	4
Maret	4
April	15
Mei	12
Juni	15
Juli	6
Agustus	12
September	13
Oktober	12
November	16

Keterangan :
Perbantuan eksternal ke instansi lain pada bulan ini adalah 12 Hari ke klinik Mutiara Sehat. 5 Kali ke RSDH.

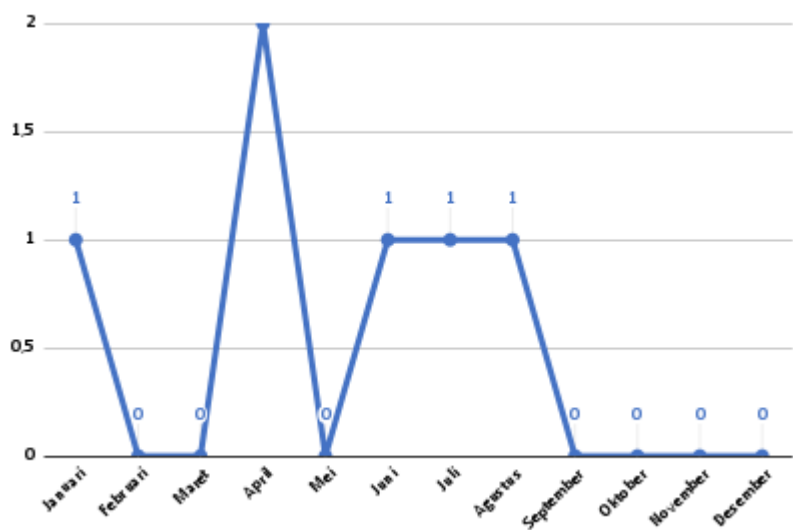
Rekapn link : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



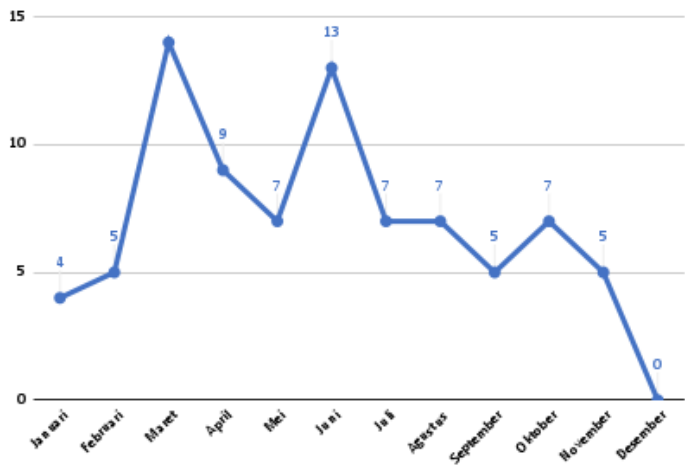
Analisa :
Tidak ada kehilangan barang bulan ini

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	5	14	9	7	13	7	7	5	7	5

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



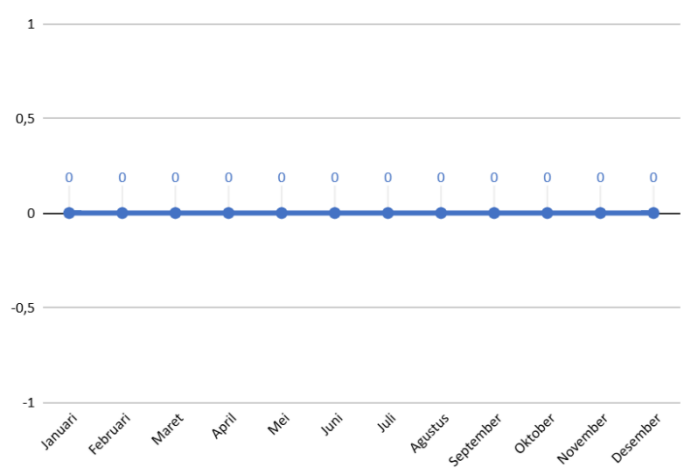
Analisis :
Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

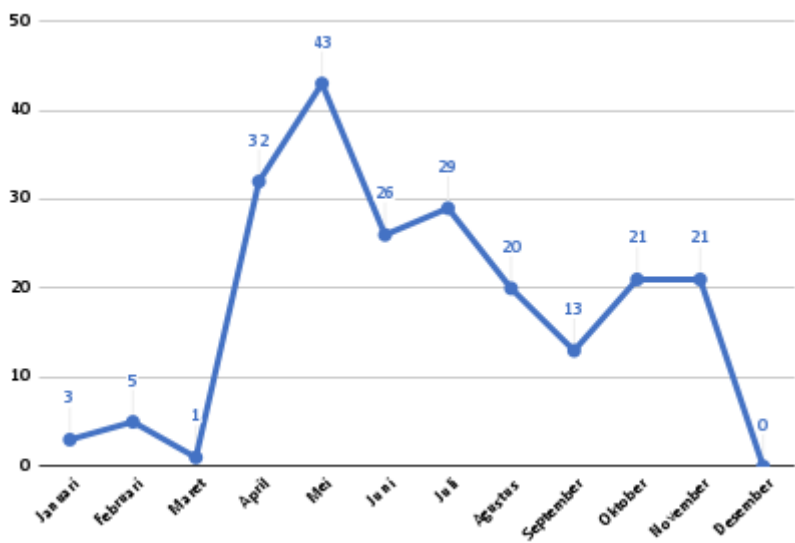


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusuhan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5	1	32	45	26	29	20	13	21	21	

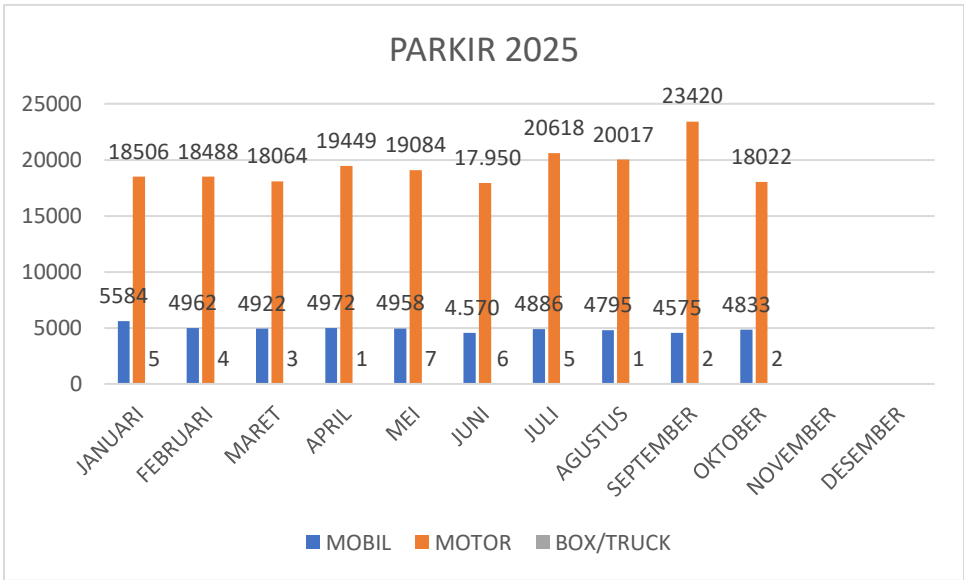


Analisis :
 Angka 21 ini terindikasi masih belum terekap semua, hal ini ditunjukkan dari rata-rata per hari yang telah diedukasi karena merokok bisa lebih dari 1x. Dengan temuan yang lebih banyak dari bulan lalu mengindikasikan pencatatan dan pelaporan lebih baik.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :
 Progres parkir fluktuatif sesuai dengan kunjungan pasien dan jumlah hari libur

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

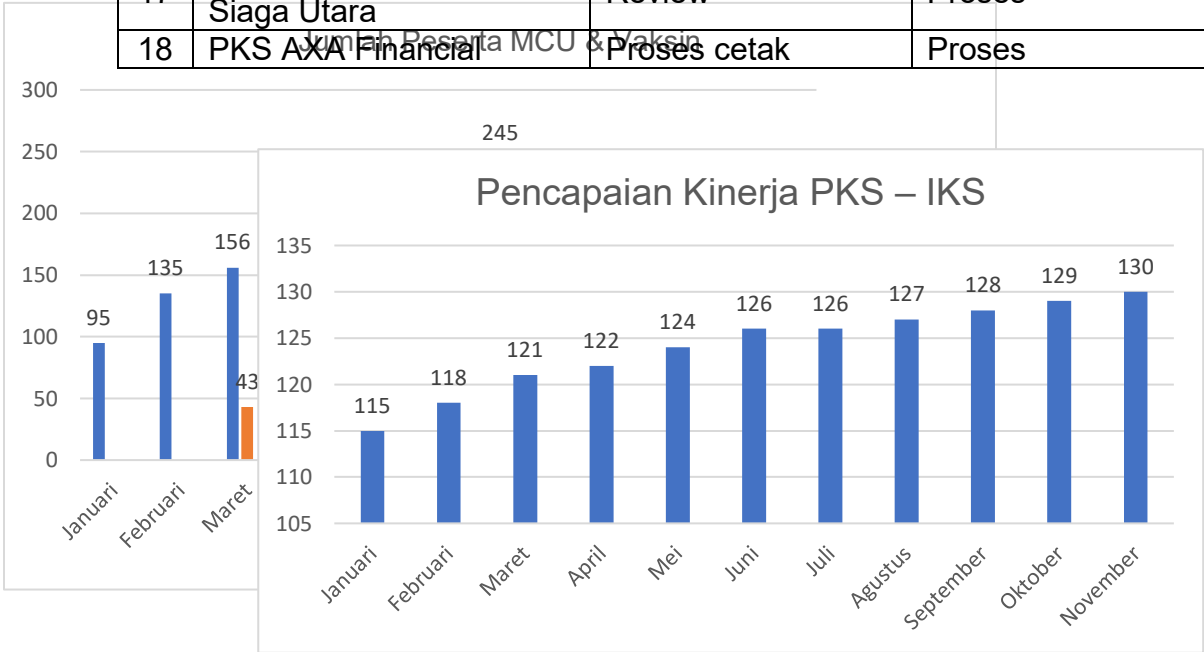
3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Juni 2025

No	Bulan	Target	Jumlah					Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	(review pihak kedua) 1 (110lastic110 evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3
3	Maret 2025	1 IKS baru	121	1	1	0	1 (Proses review)	1
4	April 2025	1 IKS baru	122	1	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
5	Mei 2025	1 IKS baru	124	0	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
6	Juni 2025	2 IKS Baru	126	0	1	1	(2 Proses Review Pihak ke 2)	2
7	Juli 2025	1 IKS Baru	126	1	0	0	1 (Proses Review)	1
8	Agustus 2025	1 IKS	127	1	0	1	1 (Klinik Utama Kedungdoro)	1
9	September 2025	1 IKS	128	1	1	0	1 (Proses Review)	1
10	Oktober	1 IKS	129	0	1	0	1 (Proses Review)	1
11	November	1 IKS	130	1	0	1	1 (Proses Review)	1
Analisis ; 1. Pada bulan November 2025, PKS baru dengan CV. Karunia Edi Peni (Aumireta Group) dalam tahap Pengisian oleh Pihak kedua 2. Draft yang dikirim ke Pihak kedua dalam tahap Review Rencana Tindak Lanjut : 3. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru 2025

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Selesai
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Selesai
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Selesai
4	PT. Kasoem Hearing	Proses TTD	Selesai
5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan
7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Selesai
8	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	Review (konfirmasi terakhir bulan April	Proses pihak Dispenduk

		masih menunggu pihak sekda)	
9	PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex)	Review	Proses Perpanjangan
10	Kirim Proposal Nestle Event Lacto Club	Proses Event	Kirim Dokumen Tambahan
11	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
12	PT Pindad (Persero)	Review	Proses Pihak Kedua
13	RS Panti Nirmala	Review	Proses Review
14	BRI Life	Review	Proses
15	Klinik Utama Kedungdoro	Review	Proses
16	TPA Halodoc	Review	Proses Review
17	Ambulance Relawan Siaga Utara	Review	Proses
18	PKS AXA Financial	Proses cetak	Proses



3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Tahun 2025

NO	BULAN	TARGET	JUMLAH PASIEN GOSHOW	ON SITE
1	Januari	25	95	-
2	Februari	25	135	-
3	MARET	150	156	43
4	APRIL	150	56	53
5	MEI	150	115	-
6	JUNI	150	210	-
7	JULI	150	254	
8	AGUSTUS	150	168	
9	SEPTEMBER	150	174	
10	OKTOBER	150	202	39
11	NOVEMBER	150	165	21 (MCU Haji)
			68 (MCU Haji)	
12	DESEMBER	150		

Analisis ;

Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Oktober meningkat sebesar 5,39% dibandingkan bulan sebelumnya.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan Promosi rutin melalui Social Media dengan update berkala
2. Kunjungan ke SMA dan SMK untuk menawarkan program MCU

3.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2025

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Berca Kawan Sejati Cab. Malang Official	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
2	Februari	PT Pesta Pora	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Peserta 106 orang
3	Maret	Meteor Cell Singosari	Sudah terlaksana
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Perubahan Peserta menjadi 53 orang dan pengajuan dengan Bus MCU
4	April	PT Green Mountains Natural Food	Sudah terlaksana
5	Mei	PT Kencana Tiara Gemilang	Sudah terlaksana 10 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 11 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
6	Juni	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 7 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 1 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
7	Juli	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Indonesian Marine	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
8	Agustus	PT Arjaya Mukti Santosa	Sudah terlaksana 4 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
9	September	Sjava Travel Indonesia	Sudah terlaksana Vaksin dengan 32 Jamaah di Rumah Sakit
10	Oktober	PT Exel Mandiri Inovasi	Sudah terlaksana 39 Orang Pelaksanaan On Site Perusahaan
		PT Aneka Tuna Indonesia	Sudah terlaksana 2 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Sukanda Djaya	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
11	November	Shanaya Resort	Sudah terlaksana 3 Orang di Rumah Sakit, Deal untuk Setiap Karyawan Baru akan melakukan MCU di RS
		MCU Haji	Sudah terlaksana MCU Haji On Site PKM Ardimulyo 21 Orang

Target	No	Tgl	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
MCU dan Vaksin	1	22/03/2025	Meteor Cell Singosari	Program MCU On Site dengan Meteor Cell Cabang Singosari	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan kuota untuk pemeriksaan Gula Darah (Stick) = 40, Cholesterol (Stick) = 22, dan Uric Acid = 26.	Hasil Pemeriksaan diberikan langsung On The Spot dengan pembuatan Kitir oleh Tim RS PHM
MCU dan Vaksin	2	22/04/2025	PT Green Mountains Natural	Program MCU On Site dengan PT Green Mountains	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran	Hasil Pemeriksaan MCU diberikan

			Foods	Natural Foods	dengan kuota untuk pemeriksaan Gula Darah (Stick) = 40, Cholesterol (Stick) = 22, dan Uric Acid = 26.	setelah H+7 Pemeriksaan
MCU dan Vaksin	3	29/04/2025	PT Green Mountains Natural Foods	Program MCU On Site dengan PT Green Mountains Natural Foods	Menyerahkan Hasil Pemeriksaan MCU	Hasil Pemeriksaan telah diberikan
MCU dan Vaksin	4	21/06/2025	PT Puninar Jaya	Program MCU di RS dengan PT Puninar Jaya	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 7 Orang	Hasil Pemeriksaan telah diberikan
MCU dan Vaksin	5	12/07/2025	PT Puninar Jaya	Program MCU di RS dengan PT Puninar Jaya	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 5 Orang	Hasil Pemeriksaan telah diberikan
MCU dan Vaksin	6	30/07/2025	PT Indonesian Marine	Program MCU di RS dengan PT Indonesian Marine	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 5 Orang	Hasil Pemeriksaan masih dikonsultasikan dengan dokter nimim
MCU dan Vaksin	7	05/08/2025	PT Indonesian Marine	Program MCU di RS dengan PT Indonesian Marine	Mengantarkan hasil MCU PT Indonesian Marine	Hasil Pemeriksaan telah diberikan
MCU dan Vaksin	8	05/08/2025	Bu Erna (PKM Ardimulyo)	Program Vaksin 33 orang untuk Rekanan pengajian beliau	Penawaran dan deal untuk 33 orang di tanggal 13 September 2025	Menunggu Konfirmasi Data Pasien
MCU dan Vaksin	9	12/09/2025	Sjava Travel Indonesia (Bu Erna)	Program Vaksin 33 orang untuk Rekanan pengajian beliau	Sudah dilaksanakan untuk vaksin sesuai ketentuan penawaran dengan 6 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	10	13/09/2025	Sjava Travel Indonesia (Bu Erna)	Program Vaksin 33 orang untuk Rekanan pengajian beliau	Sudah dilaksanakan untuk vaksin sesuai ketentuan penawaran dengan 26 Orang karena 1 pasien meninggal dunia 3 hari sebelum jadwal vaksin	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	11	06/10/2025	PT Exel Mandiri Inovasi	Pelaksanaan MCU Karyawan PT Exel Inovasi bersama dengan Klinik MS Lawang	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 39 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	12	29/10/2025	PT Sukanda Djaya Malang	Program MCU di RS dengan PT Sukanda Djaya Malang	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 5 Orang	Hasil Pemeriksaan telah diberikan
MCU dan Vaksin	13	Nove mber	Shanaya Resort	Program MCU Continue Karyawan Baru Shanya Resort di RS PHM	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 3 Orang	Hasil Pemeriksaan telah diberikan

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5	10	2	2	2	17	6	6	10	11	6

Analisa :

Kunjungan eksternal disesuaikan dengan permasalahan yang ada, komunikasi sekarang juga dilakukan dengan online pada beberapa target klinik dan mitra. Untuk kegiatan umum seperti pengenalan RS dll sudah dilakukan di event HKN

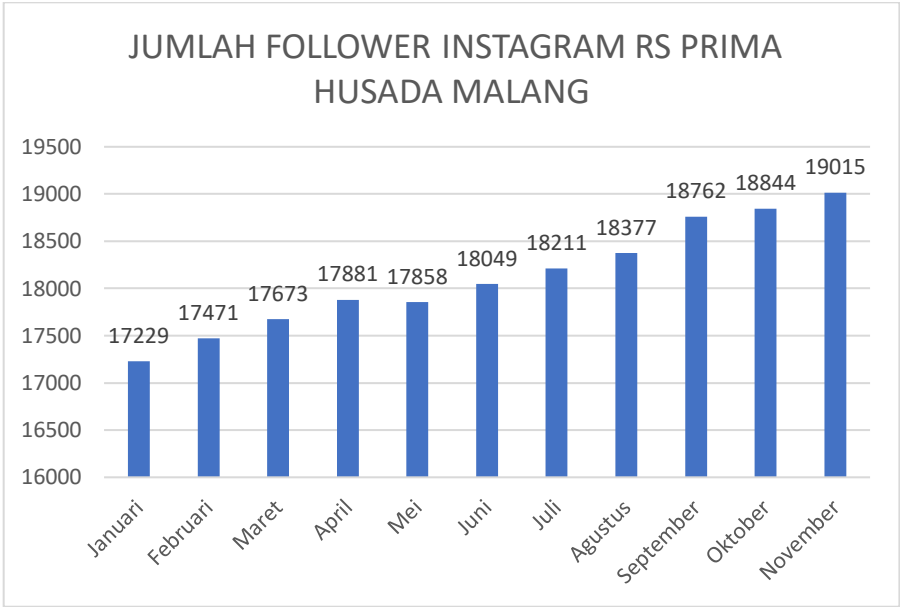
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala.

1.5.5.2.4 Digital Marketing

1.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

Platform Instagram

JUMLAH KONTEN BARU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	3	7	9	10	10	9	10	8	6	19	11	
REELS	5	5	11	5	1	1	6	7	3	4	4	
STORY	6	10	14	8	12	10	18	11	17	37	18	
TOTAL	14	22	34	28	23	19	34	26	26	60	33	0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	6	11	16	19	10	12	14	8	10	24	14	
FEED VIDEO	0	0	0	0	1	1	6	7	3	4	4	
REELS	3	4	5	7	1	1	6	7	3	4	4	
STORY	29	33	28	38	12	29	74	24	51	87	40	
TOTAL	38	48	49	64	24	20	100	46	67	119	62	0
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	17,229	17,471	17.673	17.881	17850	18049	18.211	18.377	18.762	18.84	19015	
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	496	242	202	208	374	286	346	283	385	82	171	0
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

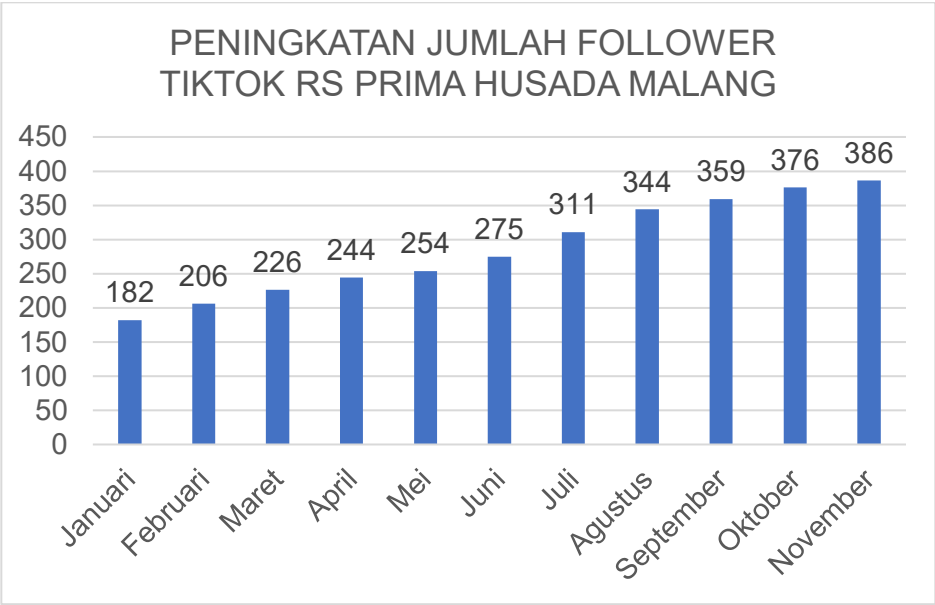


Analisa :
Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 0.91% dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	2	3	4	0	2	1	3	3	3	2	1	
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	182	206	226	244	254	275	331	344	359	376	386	
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	16	24	20	18	10	21	36	33	15	17	10	0
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH LIKE	45	72	1023	1085	1187	1222	1336	1476	1585	1652	1709	



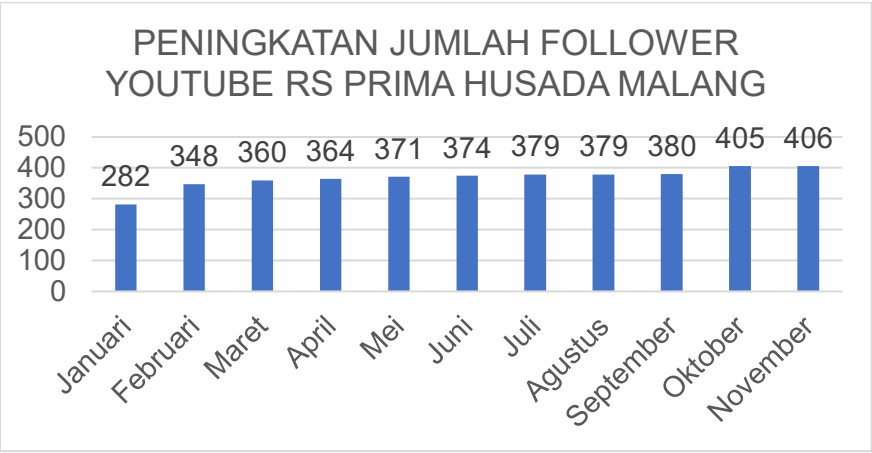
Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 4,74% dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH SUBS	282	348	360	364	371	374	379	379	380	405	406	
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	4	66	12	4	7	3	5	0	1	25	1	0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

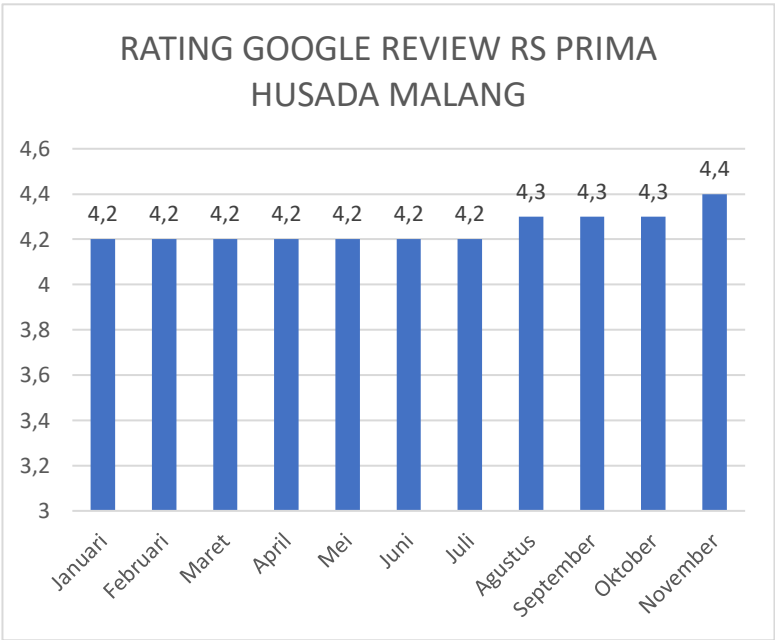


Analisa :
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan Sebesar 0,25% dari bulan Sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	AP	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	



NO	BULAN	KOMENTAR POSITIF	KOMENTAR NEGATIF
1	Jan-25	18	6
2	Feb-25	13	6
3	Mar-25	7	5
4	Apr-25	25	10
5	May-25	15	7
6	Jun-25	19	3
7	Jul-25	60	3

8	Aug-25	44	10
9	Sep-25	104	5
10	Oct-25	173	0
11	Nov-25	0	0
12	Dec-25	0	0

Analisa :
 Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan September. Namun Komentar positif meningkat.

Rencana Tindal Lanjut :
 Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG											
PERIODE 2025											
		Y	Z	AA	AB	AC					
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PEMBAYARAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARA N (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG
		a	b	c	(a-b-c=d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h	
PERIODE NOVEMBER 2025 :											
1	Acurasi	284.832.974	155.816.681	3.525.887	125.490.406	263.256.843	21648.374	333.757	241.214.711	366.705.117	0-30 HARI
2	Pencatatan	637.580.661	336.323.020	5.800	301.251.841	348.720.502	21632.721	-	327.087.781	628.339.622	31-60 HARI
3	Masdin Inskalkh	79.180.530	17.571.347	804.903	60.804.440	106.380.360	-	-	106.380.360	167.785.401	61-90 HARI
4	Jura Rahrja	146.345.832	11.653.653	0	134.686.178	126.159.419	-	-	126.159.419	244.845.537	91-120 HARI
5	BPJS Ketanggakerjaan	702.424.349	647.291.050	1743.378	53.389.921	519.859.307	-	-	519.859.307	573.249.227	>120 HARI
Total Saldo										1.996.924.965	Jumlah Piutang

Keterangan : Cut off 30 November 2025 sebesar Rp 1.996.924.965

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT INAP			
1.	Tidak sesuai kaidah pengkodean klinis, moderat fatty liver (K76.0) tidak perlu dikoding	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Readmisi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Diagnosa hf tidak melampirkan hasil echo max 1 tahun, dengan penurunan ef/diastolik dan terdapat gejala hf serta treatment hf	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Indikasi rawat inap	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Diagnosa thypoid tidak perlu di input, jika salmonella +4	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Tidak sesuai standar pelayanan : IgM salomnella positif 4, tidak indikasi MRS, klaim ajukan rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Kode 56.0 (urs) riw terdapat tindakan pemecahan batu/blood clot/foreign body reseleksi kode URS	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
8	Pasien Pro Rujuk, tagihan RAJAL	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
RAWAT JALAN			

1	Fragmentasi, kunjungan 7 hari asal rujukan sama	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Pasien kronis mendapat obat sama 3 bulan berturut-turut, harusnya untuk kunjungan ke 4 di prb/iterasi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Pasien bukan stroke, irm 6 bulan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Pasien post op katarak, pasien sudah post 4x kontrol, indikasi kontrol lagi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Pasien kunjungan di 5 poli, konsul internal satu tagihan dengan poli utama	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Indikasi fragmentasi, usg berulang	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Rujukan transit, hanya minta rujukan ke RS yang lebih tinggi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
8	Waktu rujukan vs sep terbit anomali, hanya 8 menit	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
9	Poli jantung irm mata 1 RS, indikasi pasien belanja pelayanan dan sel referral	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

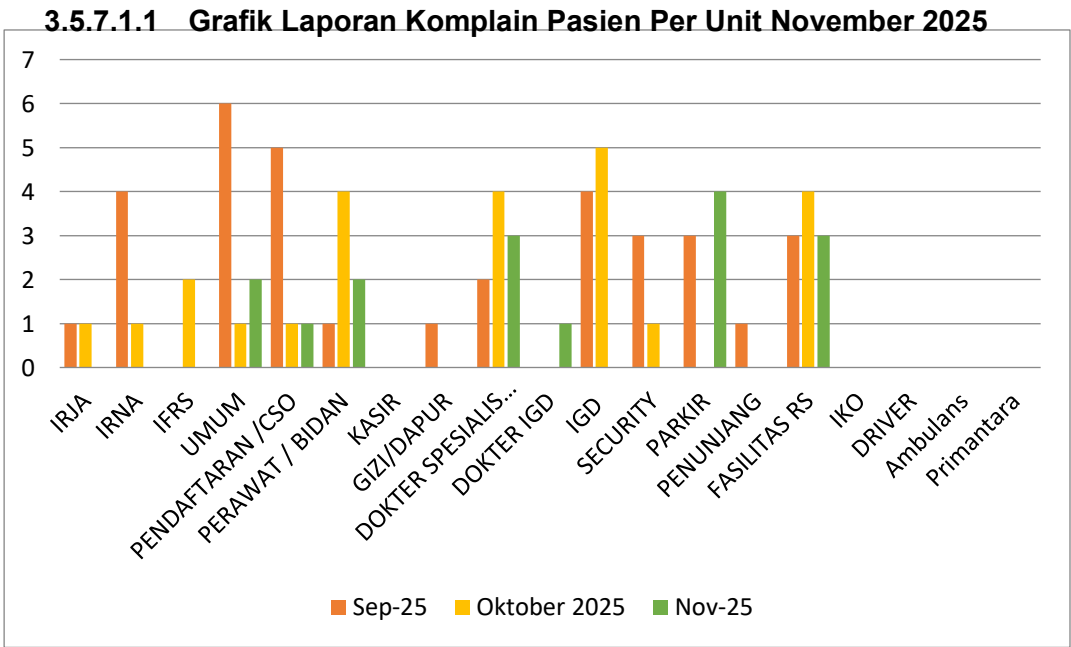
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan November 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1.	IRJA	1	1	0
2.	IRNA	4	1	0
3.	IFRS	0	2	0
4.	UMUM	6	1	2
5.	PENDAFTARAN /CSO	5	1	1
6.	PERAWAT / BIDAN	1	4	2
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	1	0	1
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	2	4	3
10.	DOKTER IGD	0	0	1
11.	IGD	4	5	0
12.	SECURITY	3	1	0
13.	PARKIR	3	0	4
14.	PENUNJANG	1	0	0
15.	FASILITAS RS	3	4	3
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0

19	Primantara	0	0	0
Total		34	24	17



- Analisis :**
- Jumlah pasien komplain selama Bulan November 2025 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.
1. Jumlah complain Pada bulan November 2025 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan September 2025 sebanyak 34 pasien. pada bulan oktober 2025 sebanyak 24 pasien. Sedangkan pada ulan November sebanyak 16 pasien
 2. Komplain terbanyak pada bulan November 2025 yaitu dari bagian Parkir sebanyak 4 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
 3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 1 kasus complain dengan rincian :
 1. Fasilitas RS sebanyak 1 kasus yaitu perbaruan matras penunggu pasien sudah kaku dan keras

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

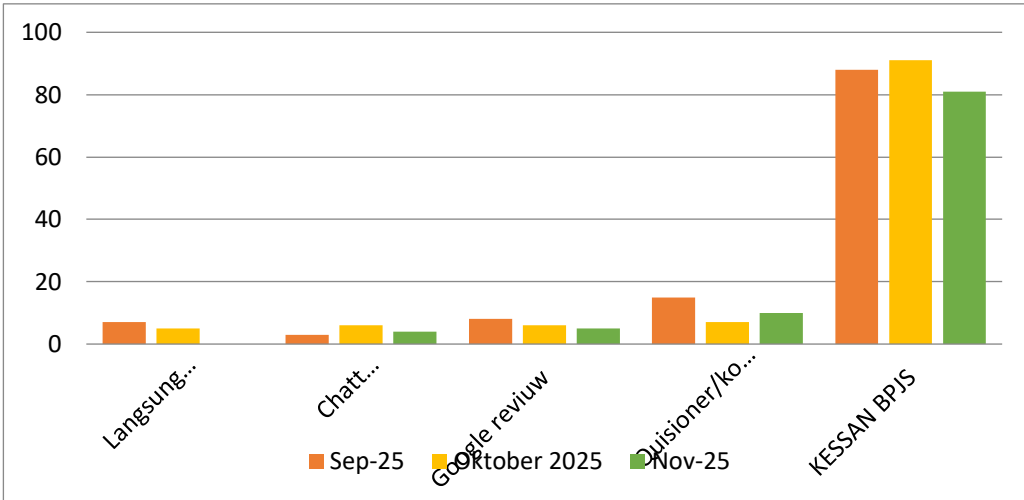
3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan November 2025

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1.	Langsung tatap muka	7	5	0
2.	Tidak Langsung :			
a	Chatt (Whatsapp)	3	6	4
b	Google reviuw	8	6	5
3.	Quisioner/kolom kritik saran	15	7	10
4	KESSAN	88	91	81

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan November 2025



Analisis :

Pada bulan November 2025 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 10 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari Google viuw sebanyak 5 dan WA sebanyak 4 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan November 2025

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 ‘	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 ‘	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	100%	0	0
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	90%	0	100%
					9		1
5.	KESSAN	100%	100%	100%	100%	0	0

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan November 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 90% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

- 1. Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 1 kasus complain dengan rincian :
 - 1) Fasilitas RS sebanyak 1 kasus yaitu perbaruan matras penunggu pasien sudah kaku dan keras

Rencana Tindak Lanjut :

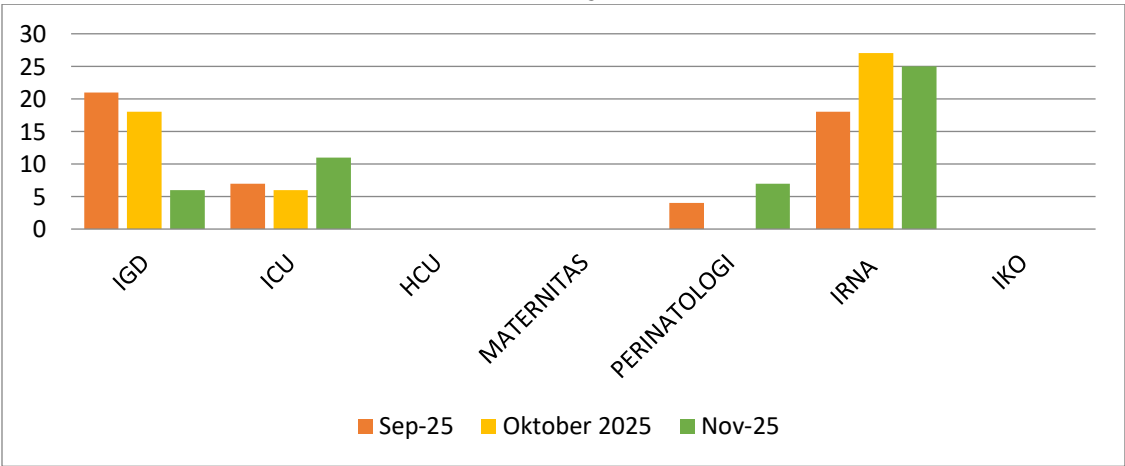
Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk

3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan November 2025

NO	UNIT PERUJUK	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1.	IGD	21	18	6
2.	ICU	7	6	11
3.	HCU	0	0	0
4.	MATERNITAS	0	0	0
5.	NEONATOLOGI	4	0	7
6	IRNA	18	27	25
7	IKO	0	0	0
Total		50	51	49

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan November 2025



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk November 2025

NO	Nama Pasien	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	TN SURIADI	ICU	ARDS	dr. elvi sp p	RSSA	Pro Bronkoskopi ec gagal weaning ventilator	17hari	Tidak
2	sdr. Wulan Saraswati	IRNA	Grand mal seizure	dr. Farid sp.s	RSJ Lawang	Pro EEG	2	Tidak
3	Tn Fadilah	ICU	DOC ec CVA	dr. Farid sp.s	RS Lavallette	Pro Unit Stroke	1	Tidak

4	Tn.Mu'alim	IRNA	CVA Infark+DM Type 2	dr Farid, Sp	RSSA	Pro Unit Stroke	6	Tarif rs : 6.799.285 Plavon : 6.389.000 Minus : 410. 285
5	BY. JEREEL GABRIEAL BARA	NEO	BBLASR+Apnea of Bronchopulmonary dysplasia+Neonatal Difficulty feeding at breast+Congenital Pneumonia	dr. Ratih, Sp.A	RS Lavalette Malang	Pro subSpesialis Neonatologi	3	Tidak
6	Tn. Nursalam	IRNA	Hematocezia profus+Anemia perdarahan aktif+Hemoroid grade III	dr. Anton Sp. B	RSSA	Penanganan lanjutan oleh bedah digestif dengan comorbid CAD dan HHD. Sdh 3 kolf tranfusi, anti coagulasi stop perdarahan msh berlanjut dan hb tetap di 6	3	Tarif rs : 3.459.797 Plavon : 2.404.900 Minus : 1.054.897
7	BY. NY. YANASTRI DWI SHALMITA	NEO	RDS+BBLSR+NEC+Neonatal Bronchopneumonia	dr. Fiona, Sp.A	RS Lavalette Malang	Pro subSpesialis Neonatologi	2	Tidak
8	Ny.Yunita Hana	IRNA	Susp Gastritis Erosiv + Myoma Uteri	dr. Ardhany.SP.JP	RS Saiful Anwar	*pro pertimbangan Endoscopy + perawatan Sp.PD- KGEH*	5	Tidak
9	BY. JEREEL GABRIAN BARA	NEO	BBLASR+Apnea of Bronchopulmonary dysplasia+Neonatal Difficulty feeding at breast+Congenital Pneumonia+Neonatal Difficulty feeding at breast+Congenital Pneumonia+NEC	dr. Ratih, Sp.A	RS Panti Nirmala	Pro subSpesialis Neonatologi	4	Tidak
10	Ny. ISTI RAHAYU	IRNA	Neoplasma Cerebri	dr.Farid Sp.N konsul dr. Andy Sp.P konsul dr.Nurhadi Sp.M	RS Saiful Anwar	Pro MRI kepala dengan kontras	2	Tidak
11	Ny. Henny Indrawati	IRNA	CVA Emboli	dr.Farid Sp.N konsul dr. Virginia, Sp.KFR konsul dr. Zora, Sp.PD	RS Lavallette	Pro stroke unit + perawatan lebih lanjut	5	Tidak
12	by. INTAN AMRINA ROSYADA	IRNA	suspect epidermolisis bulosa	dr. dicky Sp.A co dr. vita Sp. KK	RS UB	Pro Nicu dan Sp. KK anak	2	Tidak
13	NY. RUMANI	IRNA	HF Reduced ejection fraction	dr. Yoga, Sp.JP konsul dr. Ardhi, Sp.PD	RSSA fast track CVCU	Pro ICU/ CVCU/ ICCU	6	Tidak
14	NGATIPAH	IGD	Nstemi	dr. Miryanti, Sp. JP	RS UMM	pro immediate invasive strategy	1	Tidak
15	Tn Munawir	ICU	ICH	dr. Farid sp.s	RSSA	Pro Unit Stroke	3	Tidak
16	Tn Saturi	IRNA	MR+CAD post PCI+HF reduced EF+Cholelitis akut+Hiponatremi	dr. Yoga Sp.JP	RSSA	PRO ICCU+IABP utk syok kardiogeniknya+dr SpJP konsultan intensivist	8	Tidak
17	Ny. Yuli Musricha	IRNA	Dengue expanded syndrome + bacterial infection + efusi pleura	dr. Aji Sp. PD	RSSA	Pro plasmapheresis perawatan KPTI dan Pemberian Transfusi Albumin	4	Tidak
18	Ny. Suparmi	ICU	CKD, ADHF dt DM Cardiomyopathy, AF SVR, PAD, DM	dr Ardhany Sp PD	RSI Aisyiah Malang	Pro HD	2	Tidak
19	SITI NGAISAH	IRNA	ESRD dengan uremic gastropathy dan Trombositopenia	dr. Ardhi, Sp. PD	RSSA	Pro HD	4	Tidak
20	RODIYAH	IGD	DOC dt Intrakranial susp CVA + Hemiparese D++ Ekstrakranial susp Thyroid Storm dt Struma Uninodusa Toxica (Burch Wartofsky Score 65) + Susp Pneumonia CURB 3	dr. Farid SP.S	KARSA HUSADA	Pro Unit Stroke	2	Tidak
21	NY. HERLANDYN SETYOWATI	IRNA	cf colum femus s+edeme genu s	dr. Oka SP.OT	RS SOEPRAON	pro orif femur	2	Tidak
22	NY. SIYATI	ICU	cva ich+ht emergency	dr. Syahrir Sp.S	RS Lavalette	Pro Unit Stroke	2	Tidak
23	Ny. Endang Dwi Astutik	IRNA	CKD st 5 + CVA infark + Anemia	dr. Farid Sp.S raber dr. Ardhany, Sp. PD	RS Lavalette	Pro HD	3	Tidak
24	Tn. EKO PRIYANTO	IGD	STEMI INFERIOR	dr. Mira Sp. JP	RSI AISIYAH	pro PCI	1	Tidak
25	Tn. Saeni	ICU	CKD	dr. Ardhany Sp.Pd. KGH	RSI Aisyiah Malang	Pro HD	2	Tidak
26	Ny. DASIATUN	IGD	STEMI INFERIOR	dr Mira Sp JP	RST Soepraoen	Pro PCI	1	Tidak

27	Ny. SUPARMI	IGD	CKD ON HD+ ALO+ HHD	dr Ardhany Sp PD	RS Karsa Husada	Pro HD	2	Tidak
28	Ny. RIZKI KURNIA PURWATANTI	ICU	Syok kardiogenik, POST VF (ROSC), Gagal Nafas Perbaikan	dr Mira Sp JP	RSI Aisyiah Malang	Pro HD	7	Tidak
29	Tn. NUR ALI	IGD	NSTEMI, HF, Post VT	dr Yoga Sp JP	RSSA	Pro PCI	1	Tidak
30	Tn. Kodrat Pribadi	ICU	CVA Trombosis, AF RVR, HF	dr Fahima Sp N, raber dr Ira Sp JP, co dr Aji Sp PD	Rs Lavalette	Pro stroke unit	7	Tidak
31	MUKHAMMAD NIZAR ARROFI	IRNA	Brain Stem Tumor	dr Fachriy Sp BS	RSSA	Pro MRI + Radioterapi	3	Tidak
32	Tn. Kustiono	IRNA	Grandmall Seizure	Dr. Farid Sp.S	RSJ DR Radjiman wediodiningrat Lawang	PRO EEG	2	Tidak
33	Tn. Sarman	IRNA	SOP Cerebri Supratentorial	Dr. Fahimma, S.S	RS Lavalette	PRO tatalaksana SOP Cerebr	6	Tidak
34	Tn. Ramun	IRNA	CKD St V dd ACKD + Oliguria	Dr. Aji, Sp.PD	RS LAvalette	PRO HD	4	Tidak
35	TN Ichsan	ICU	cva ich	dr. Farid Sp.S	RS Lavalette	pro unit stroke	5	Tidak
36	NY. SAWITAH	IRNA	CVA INFARK	dr. Farid Sp.S	RS Lavalette	Pro Stroke Unit	5	Tarif rs : 8.844.518 Plavon : 6.389.000 Minus : 2.455.518
37	Sdr. Ajib Kholili Maulana	IRNA	COR 456+FR MAXILLA+FR FRONTAL	dr. Fachry Sp.BS	RSSA	Pro craniotomy elevasi fr sinus frontal dan Join Op dengan Sp.BP Pro Platting Achbar	2	Tidak
38	BY. Firda Ayu	NEO	BBLSR+Neonatal sizure+Pneumonia+NEC	dr. Ratih, Sp.A	RS Lavalette	Pro subSpesialis Neonatologi	8	Tidak
39	Ny.Nita Yatin	ICU	NSTEMI+Syock Cardiogenic+Post SVT Hemodinamika tidak stabil +AKI St. II-III+Sepsis MODS+Dilated Cardiomyopathy	dr.miryanti.,Sp.JP+ dr.Ardhi.,Sp.PD	RSI Aisyiah Malang	Pro PCI	2	Tidak
40	Sdri. Ika Nur Indah Sari	IRNA	CKR 456+Fraktur Frontalis+Fraktur Maxillaris	dr. Fachriy, Sp.BS+ dr. Sigit, Sp.BP.	RSSA	Pro Craniotomy Elevasi Fraktur	1	Tidak
41	Ny. Nur Hidayati	IRNA	Neglected Fr Radius Ulna D	dr. Kuntadi Sp. OT	RSSA	Pro tatalaksana lanjutan	1	Tidak
42	Tn. Agus Suwandi	IRNA	Moderate Cholangitis	dr. Zaki Sp.B	RSSA	Pro CBD Explore	2	Tidak
43	Tn. Slamet	ICU	CVA Emboli	dr. Fahimma Sp.N Konsul dr. Yoga Sp.Jp	RSSA (IGD IPIT)	Pro stroke unit	5	Tidak
44	Ny. Siti Sukarna	IRNA	CKD state V	dr. ardhani sp.pd	RS Lavalet	Pro HD	3	Tidak
45	By. Ny. Khusnu Wahyuningsih	NEO	Neonatal pneumonia	dr. Ratih, Sp.A	RS Panti Nirmala	Pro subSpesialis Neonatologi	2	Tidak
46	Ny. Syaropah	IRNA	CVA emboli, AF RVR, Hemiplegia Flaccid	dr. dewi Sp.S	RS Lavalette	Pro Unit Stroke	2	Tidak
47	By. Ny.Farida	NEO	RDS	dr Dicky, Ap.a	RS Lavalette Malang	Pro subSpesialis Neonatologi	2	Tidak
48	Ny. Endang Hariastuti R. R.	IRNA	UAP, Syok cardiogenik	dr. Miryanti, Sp. Jp	RSI Aisyiah	pro immediate invasve strategy dan back up HD (et causa refractory chest pain on optimal medical treatment)	3	Tidak
49	By. Ny. Ira Susilowati	NEO	RDS, Neonatal bronchopneumonia	dr. Dicky, Sp.A	RSSA	Pro subSpesialis Neonatologi	3	Tidak

Analisis :

- Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan November 2025.
 Pada bulan September sebanyak 50 pasien, pada bulan Oktober 2025 sebanyak 51 pasien
 Sedangkan pada bulan November sebanyak 49 pasien
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro PCI
 - Pro CVCU
 - Pro stroke unit
 - Pro HD
 - MRI
 - Pro bedah saraf lanjutan

- g) Membutuhkan alat khusus
 - h) Membutuhkan pengobatan ARV
3. Alasan rujuk karena plavon habis meningkat dari bulan sebelumnya.
Pada bulan Oktober sebanyak : Rp 6.231.130 Sedangkan pada bulan November 2025 sebanyak : Rp.3.920.700

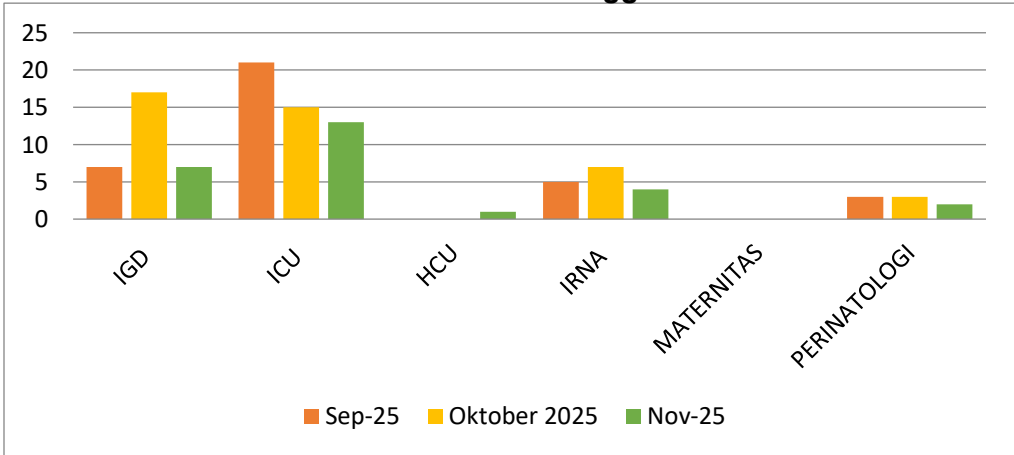
Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- 2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan November 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	September 2025	Oktober 2025	NOVEMBER 2025
1.	IGD	7	17	7
2.	ICU	21	15	13
3	HCU	0	0	1
4.	IRNA	5	7	4
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	3	3	2
Total		36	42	27

Grafik Jumlah Pasien Meninggal November 2025



Tabel Rincian Pasien Meninggal November 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	PENYEBAB KEMATIAN	DPJP	EWS
1	Akhmad Zaenal Fanani	IRNA	DOC + ARDS dt Pneumonia dd TB Paru + Retensi Sputum + CVA Trombosis	ARDS	dr Heri Sp PD	√
2	G Mada Hadi	ICU	CVA INFARK+HIPONATREMIA+RETENSI SPUTUM+ULKUS DICUBITUS+SEPSIS+DM	SEPSIS	dr. farid Sp.N raber dr. Heru Sp.An konsul dr. elvi Sp.P	√
3	Supi'i	IGD	DOA	DOA	dr.KEZIA	√
4	Enny Zuhriah	IRNA	KOMA HIPOGLIKEMIA + CKD + ARDS + Riwayat CVA	CKD	dr. Ardhi, Sp.PD	√
5	Ny.Tuminah	ICU	CVA INFARK + Pneumonia + AF + Susp.TB	CARDIAC ARREST	dr.Farid.,Sp.N	√
6	Tn. Abd Djakfar	ICU	Post op craniotomy+decompresi tulang	CARDIAC ARREST	dr.Fachry Sp.BS	√
7	Ny. Supiya	ICU	Post op craniotomy+ICH	CARDIAC ARREST	dr.Fachry Sp.BS	√

8	Ahmad Riadi	IGD	DOA	DOA	dr Isrotul	√
9	By Ny Yulia Devi	NEO	IUFD	IUFD	dr. Humaira, Sp.OG	√
10	Sai'i	IGD	DOC+ syok cardiogenik	syok cardiogenik	dr. Ira, Sp.JP	√
11	Kasiyati	ICU	POST OP VP SHUNT, HT, DM, CVA ICH	CARDIAC ARREST	dr. Fachri Sp.BS	√
12	Wadji	ICU	ARDS+Syock Condition+DM+Pneumonia+Susp TB	Syock Condition	dr Aji, Sp.PD+dr Andy, Sp.P	√
13	By Ny Afinda Dwi	NEO	IUFD	IUFD	dr AIDA, Sp.OG	√
14	Agus Sudarmawan	IGD	alo adhf + nsteacs + post rosc		dr Yoga Sp JP	√
15	Agus Salim	IGD	DOA	DOA	dr Rino	√
16	Munawaroh	ICU	cardiac arrest	cardiac arrest	dr Heri Sp PD	√
17	Alfan Zahidin	HCU	CVA ICH, HT	cardiac arrest	dr. Farid Sp. N	√
18	Ernawati	IRNA	DM hiperglikemia, kolik abdomen, susp. serosis susp.abses hati	serosis	dr. Heri, Sp.PD	√
19	Arie Wahyudi Virgian Nanta	ICU	ADHF, CAD, MR	ADHF	dr Yoga Sp JP	√
20	Much Abdul Azis	ICU	PERITONITIS + POST OP LAPARATOMY	CARDIAC ARREST	dr. Anton Sp.B raber dr. Heru Sp.An	√
21	Agus Irwanto	ICU	DSS+S.CVA ICH	CARDIAC ARREST	dr. Ardhany Sp.PD raber dr. farid Sp.N raber dr. Heru Sp.An	√
22	Misti Rahayu	ICU	CVA infark, AF	CARDIAC ARREST	dr. Farid Sp S, K/ dr Ira Sp Jp, K/ dr Heru Sp An	√
23	Ignatius Loyola Rahardjo	ICU	Pneumonia+ARDS+sepsis+susp acute limb iskemia+susp efusi pleura	CARDIAC ARREST	dr. elvi Sp P, K/ dr Ira Sp Jp, K/ dr Heru Sp An	√
24	Solikah	IRNA	CHOLELITIASIS ,JAUNDICE, ACITES	Cardiact arest. DM	dr. Aji Sp.PD	√
25	Agus Dani	IGD	DOA	Cardiact arestt	dr Endra	√
26	Pudjo Ismanto	IGD	ARDS	Cardiact arestt	dr Fachriy, Sp.BS	√
27	Darmadji	ICU	uremic encephalophthy	Cardiact arestt	dr. Ardhi Sp PD	√

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan November 2025 sebanyak 27 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD : 17 pasien, ICU : 15 pasien IRNA : 7 pasien Neo : 3 pasien
3. Pada bulan Oktober 2025 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 4 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	Habis PKS	12	19	16
2	BPJS status Denda	36	41	63
3	BPJS status Premi	0	0	3
4	BPJS status Denda dan Premi	2	1	0
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	1	2	2
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	3	2	2
7	BPJS status penanguhan pembayaran	5	3	5
8	Rencana pengurusan BPJS	91	85	68
9	BPJS status tidak ditanggung	4	5	2

10	BPJS tidak aktif akhir bulan	0	1	1
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	0	0	0

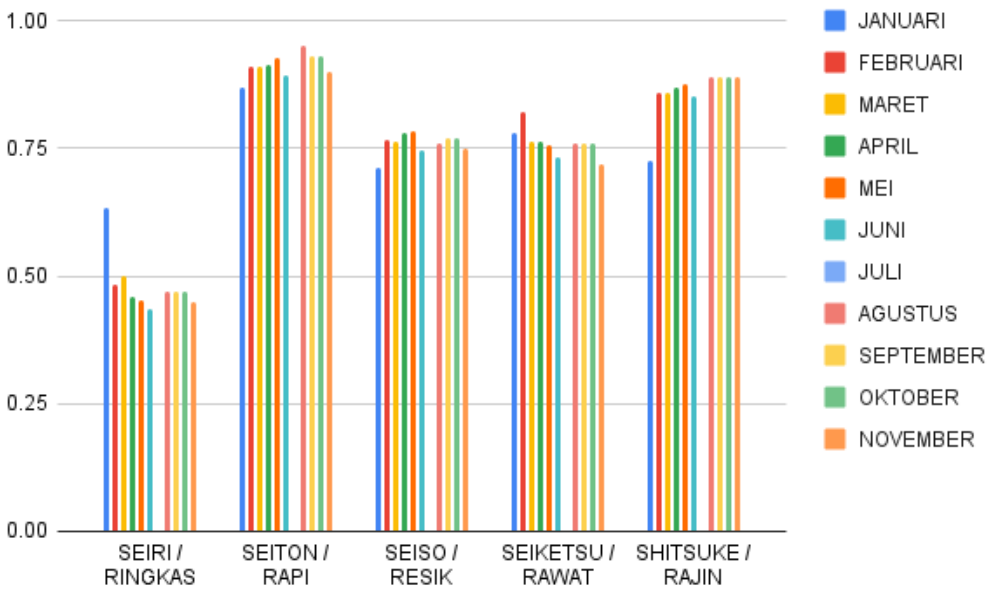
3.5.8 **Cleaning Service**

3.5.8.1 **Indikator Kerja Cleaning Service**

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 **Tabel Produktifitas Cleaning Service**

NO	JENIS SPV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%	50%	50%	45%	44%		47%	47%	47%	45%
2	SEITON / RAPI	87%	91%	91%	91%	93%	89%		95%	93%	93%	90%
3	SEISO / RESIK	71%	77%	76%	76%	78%	75%		76%	77%	77%	75%
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%	76%	76%	76%	73%		76%	76%	76%	72%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%	86%	86%	88%	85%		89%	89%	89%	89%



Analisa :
 Terdapat progress pada semua factor penilaian bulan ini. Peningkatan perlu dipertahankan.

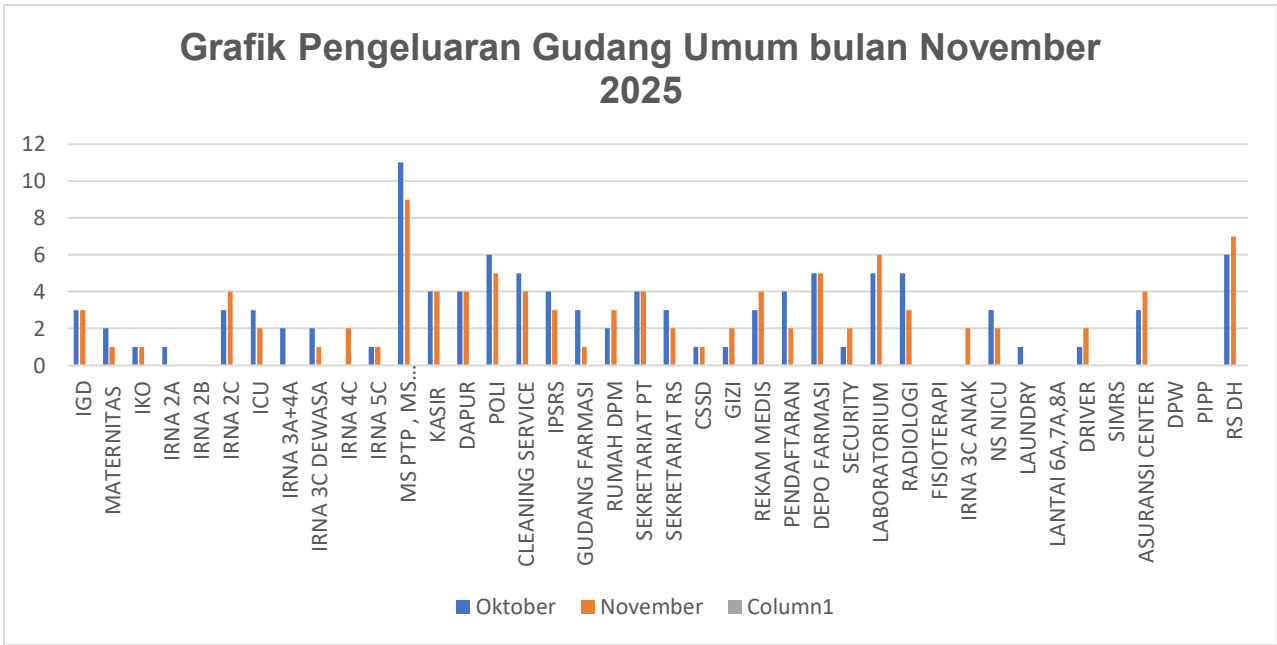
Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		OKTOBER	NOVEMBER	
1	IGD	3	3	↑0%
2	MATERNITAS	2	1	↓-100%
3	IKO	1	1	↓0%
4	IRNA 2A	1	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	3	4	↑25%
7	ICU	3	2	↓-50%
8	IRNA 3A+4A	2	0	↓0%
9	IRNA 3C DEWASA	2	1	↓-100%
10	IRNA 4C	0	2	↑100%
11	IRNA 5C	1	1	↓0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	11	10	↓-10%
13	KASIR	4	4	↑0%
14	DAPUR	4	4	↓ 0%
15	POLI	6	6	↑0%
16	CLEANING SERVICE	5	4	↓-25%
17	IPSRS	4	4	↓0%
18	GUDANG FARMASI	3	1	↓-100%
19	RUMAH DPM	2	3	↑33,33%
20	SEKRETARIAT PT	4	4	↑0%
21	SEKRETARIAT RS	3	3	↓0%
22	CSSD	1	1	↓0%
23	GIZI	1	2	↑50%
24	REKAM MEDIS	3	4	↑25%
25	PENDAFTARAN	4	2	↓-100%
26	DEPO FARMASI	5	5	↓0%
27	SECURITY	1	2	50%
28	LABORATORIUM	5	6	↑16,66%
29	RADIOLOGI	5	3	↓-66,66%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	0	2	↑100%
32	NS NICU	3	2	↓-50%%
33	LAUNDRY	1	0	↓0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	0	↓0%
35	DRIVER	1	2	↑50%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	3	4	↑25%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	6	7	↑14,28%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat dan RSDH

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
- 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
- 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT SIMRS

3.7.8 Capaian Tata Laksana Keluhan

NO	JENIS KELUHAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
1	Keluhan terkait software	4	4	100%
2	Keluhan terkait hardware	93	93	100%

Analisis : Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT
Rencana Tindak Lanjut : Monitoring dan Evaluasi

3.7.9 Rekapitulasi Kejadian Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Analisis : Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT

3.5.11 Driver

Tabel Rekapitulasi Pengantaran Berdasarkan Keperluan

KEPERLUAN	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
RUJUK PASIEN KE RS LAIN	60	46	47	57	35	48	51	36	50	49	49	
RUJUK PASIEN KE RSPHS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	
JEMPUT RUMAH PASIEN	17	13	18	16	11	14	21	15	14	15	18	
ANTAR RUMAH PASIEN	19	14	11	16	20	13	18	23	9	11	5	
SAMPEL LAB	19	19	12	14	15	30	30	27	26	18	21	
SAMPEL SHK	4	2	3	3	3	5	3	5	4	4	3	
KEPERLUAN NONKLINIS STAF RSPHM	5	6	2	7	5	5	2	3	7	6	11	
KEPERLUAN NON KLINIS STAF PT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENGANTARAN JENAZAH	25	29	16	23	44	35	31	36	26	33	24	
RUJUK CT SCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	
ANTAR MCU RSPHM	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
LAIN-LAIN	7	11	13	6	12	11	6	10	9	11	10	
TOTAL	158	140	122	142	145	162	162	156	147	183	141	0

Analisa :
Kondisi Pengantaran Kembali pada rata-rata utama setelah alat CT Scan Kembali normal dan berfungsi

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

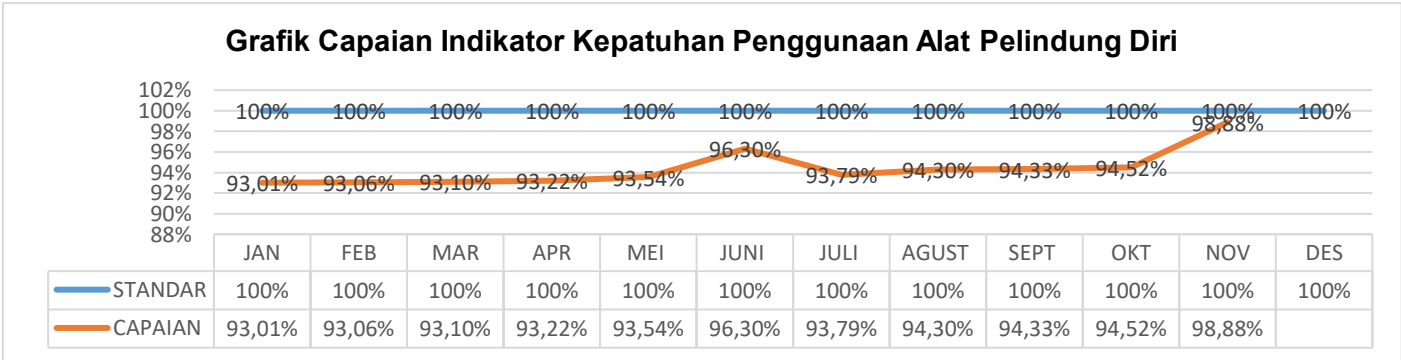
3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%	85,58%	85,32%	85,57%		85,36%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,22%	93,54%	96,3%	93,79%	94,3%	94,33%	94,52%	96,88%		94,18%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%	99,94%	99,83%	99,96%	100%		99,34%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16%	89,38%	99,1%	98,21%	97,58%	97,33%	96,23%	96,60%	96,62%	96,88%	96,89%		95,87%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,32%	0%	0%		0,03%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21%	74,93%	74,19%	72,26%	78,28%	66,22%	60,55%	70,4%	62,74%	71,55%		71,20%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		99,47%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%	99,44%	97,65%	99,09%	96,33%	95,04%	93,45%	89,47%	96,68%		96,8%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		99,99%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,89%	99,9%	99,62%		99,52%

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------	---	----------------------------------	--	--	------------

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.7.10 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



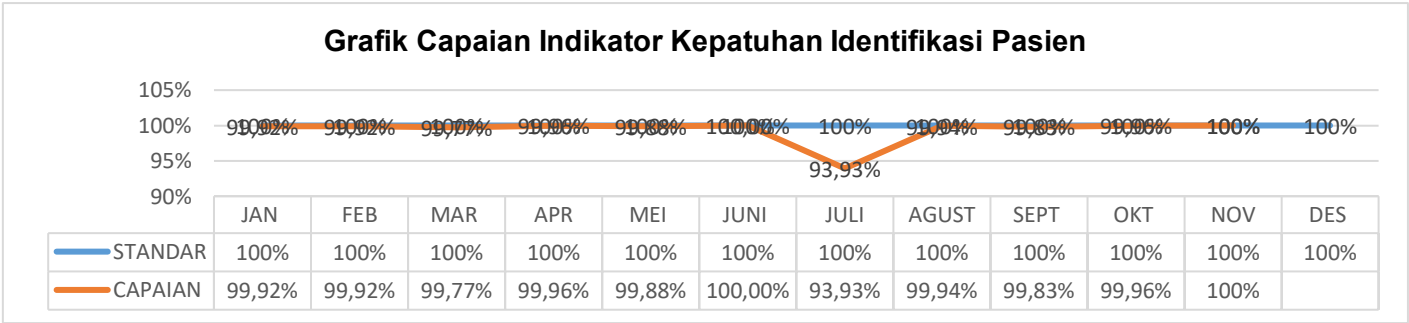
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada bulan Januari hingga November Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.

	6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1%, bulan April 93,22%, bulan Mei 93,54%, bulan Juni 96,3% dan bulan Juli 93,79% serta bulan Agustus sebesar 94,3%, bulan September yaitu 94,33%, bulan Oktober 94,2% dan bulan November 96,88% dengan rata-rata 94,18%. Ketidakpatuhan ini berpotensi meningkatkan risiko penularan infeksi silang antar pasien dan tenaga kesehatan. Berdasarkan temuan, masih ada petugas yang dengan sengaja tetap menggunakan handscoon untuk menulis rekam medis.Selain itu masih ada DPJP yang menggunakan satu APD untuk visit ke seluruh pasien. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran dan disiplin dalam penggunaan APD.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1. pentingnya penggunaan APD kepada seluruh tenaga Kesehatan 2. Melakukan audit harian kepatuhan APD dan memberikan Feedback langsung 3. Memberikan apresiasi (reward) bagi tenaga Kesehatan yang patuh	1. Kepala ruangan dan IPCN 2. Kepala ruangan 3. Kepala Bidang	Satu Bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

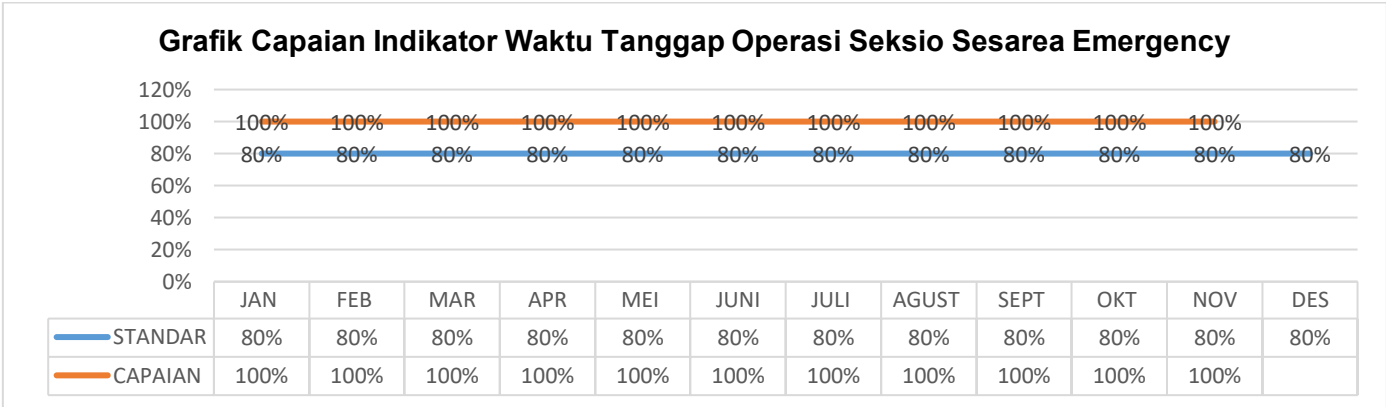
3.7.11 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pas



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juni tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%,namun kembali menurun di bulan Juli yaitu 93,93%, bulan Agustus yaitu 99,94%, bulan September yaitu 99,83% dan bulan Oktober yaitu 99,96%. Pada bulan November ini capaian hingga mencapai standart 100%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan 135lastic135e pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan 135lastic135e dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 %, bulan Februari sebesar 99,92%, bulan Maret sebesar 99,77% capaian di bulan April yaitu 99,96%, capaian di bulan Mei 99,88% dan capaian meningkat di bulan Juni menjadi 100%,namun kembali menurun pada bulan Juli yaitu 93,93% serta bulan Agustus yaitu 99,94%, bulan September yaitu 99,83% dan bulan Oktober yaitu 99,96%. Pada bulan November ini capaian meningkat hingga mencapai standart 100% dengan rata rata capaian bulan Januari hingga November yaitu 99,34%. Dari temuan dilapangan diketahui bahwa DPJP seringkali tidak melakukan identifikasi pasien ketika melakukan visite karena sudah didampingi oleh perawat. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat. 3. Perawat diharapkan bisa membantu melakuakn identiifikasi pasien ulang ketika melakukan visite	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

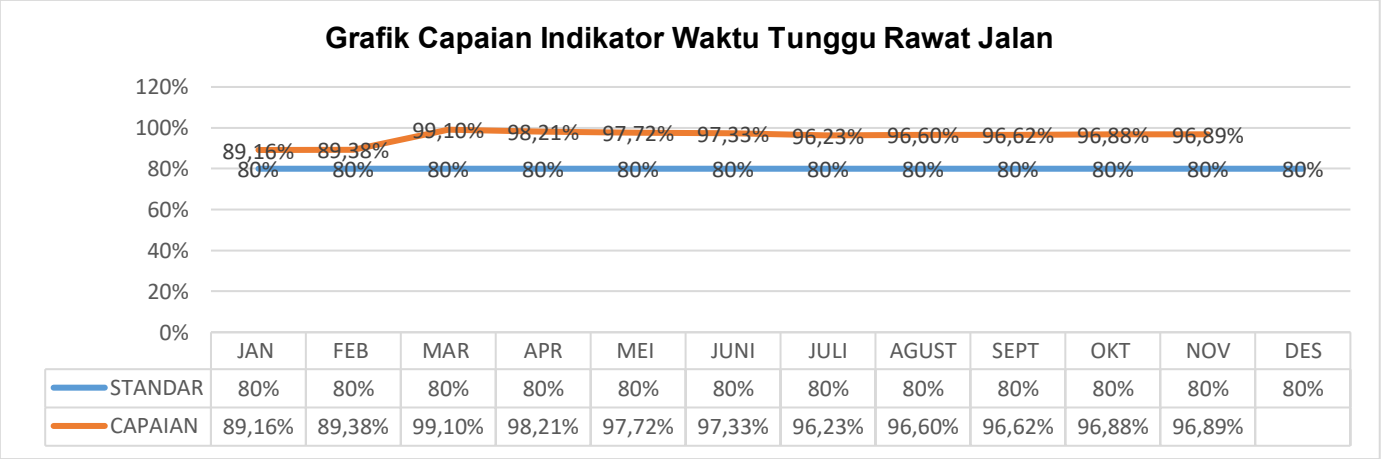
3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 98,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1%, capaian di bulan April 98,22%, capaian di bulan Mei 97,71%, capaian di bulan Juni adalah 97,33% dan capaian di bulan Juli adalah 96,23%, capaian di bulan Agustus yaitu 96,60%, di bulan September yaitu 96,52%, capaian di bulan Oktober yaitu 96,88% dan capaian di bulan November yaitu 96,89% dengan rata-rata 95,87%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Adanya aturan baru bahwa pasien bisa di daftar 1 jam sebelum jadwal praktek dokter juga sangat membuat waktu tunggu rawat jalan menjadi lebih pendek. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya dengan cara Optimalisasi alur pendaftaran dan koordinasi antar unit.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

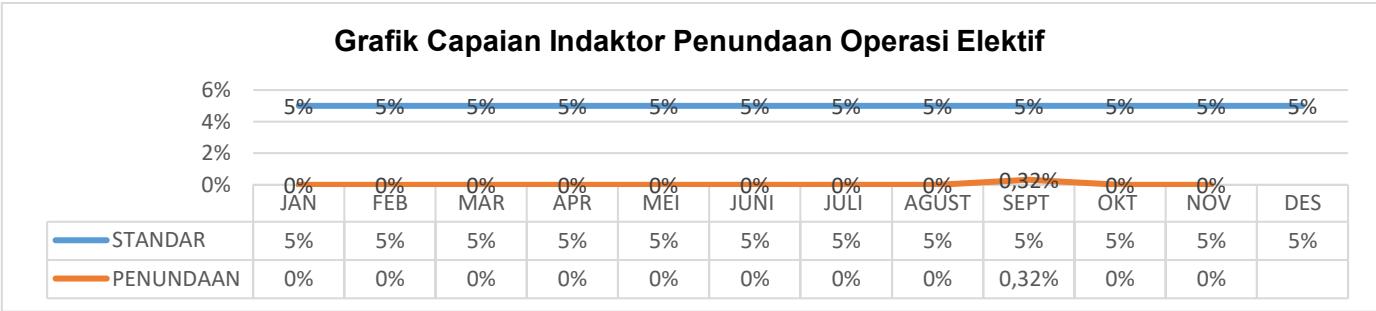
3.7.12 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 98,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1%, capaian di bulan April 98,22%, capaian di bulan Mei 97,71%, capaian di bulan Juni adalah 97,33% dan capaian di bulan Juli adalah 96,23%, capaian di bulan Agustus yaitu 96,60%, di bulan September yaitu 96,52% dan capaian di bulan Oktober yaitu 96,88% dengan rata-rata 95,7%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Adanya aturan baru bahwa pasien bisa di daftar 1 jam sebelum jadwal praktek dokter juga sangat membuat waktu tunggu rawat jalan menjadi lebih pendek. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya dengan cara Optimalisasi alur pendaftaran dan koordinasi antar unit.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.7.13 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

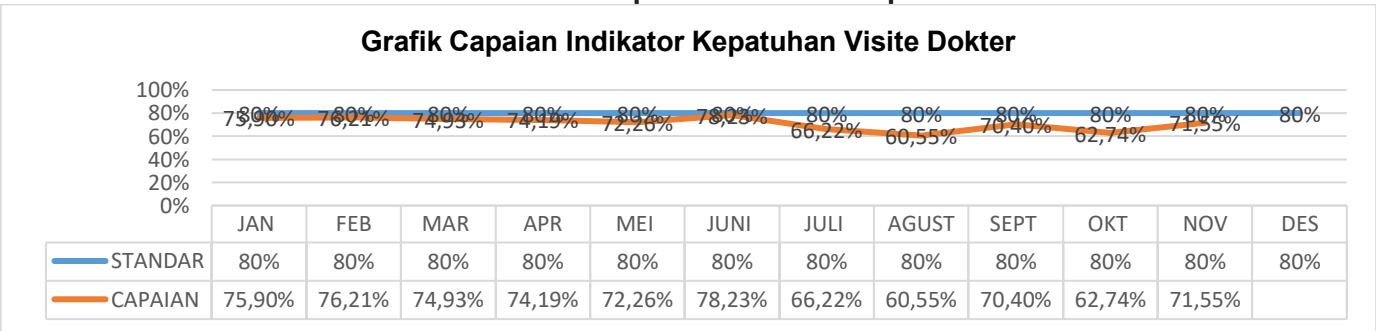


Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga November tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart dengan rata rata 0,03% hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . perencanaan yang matang dari segi SDM, alat dan ruang operasi juga telah dilakukan guna meminimalisir terjadinya penundaan operasi elektif. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya melalui ketersediaan alat dan kesiapan tim.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

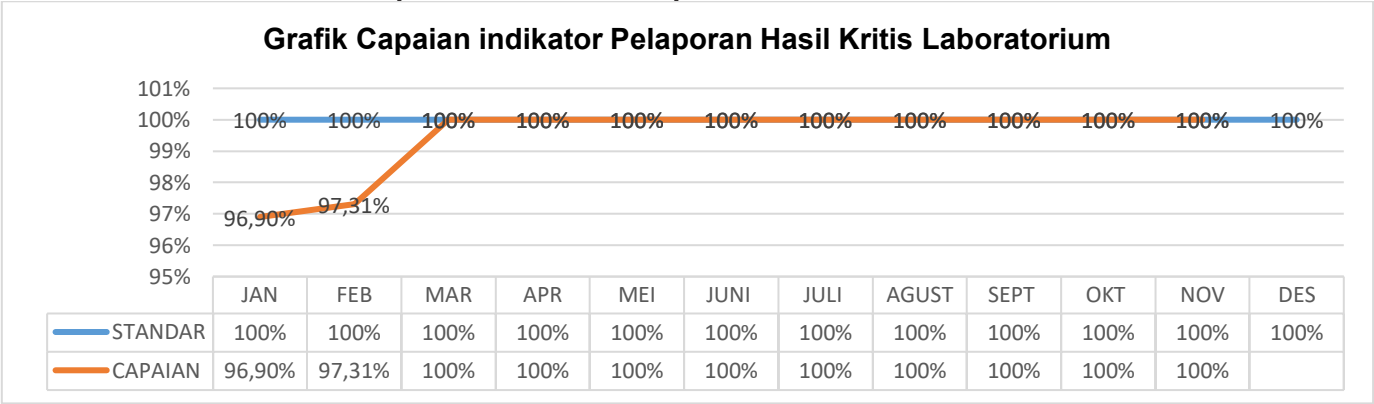


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga November Tahun 2025 belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan februari yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93%, capaian di bulan April yaitu 74,19%, capaian di bulan Mei yaitu 72,26%, capaian di bulan Juni yaitu 78,23%, capaian di bulan Juli yaitu 66,22% dan capaian di bulan Agustus yaitu 60,55%, capaian bulan September yaitu 70,4%, Oktober 62,74% dan November 71,55% dengan rata-rata 71,20%. Dari hasil supervisi didapatkan Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena dokter seringkali memiliki jadwal yang padat termasuk jadwal praktik klinik dan tugas di rumah sakit lain. Selain itu budaya di rumah sakit yang belum sepenuhnya mengutamakan kepatuhan terhadap indikator mutu nasional, diaman visite di anggap fleksibel atau dapat di sesuaikan di luar jam standart.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	1. Kepala ruangan memantau kehadiran dokter pada waktu visite yang dijadwalkan. 2. Data dikumpulkan dan dibandingkan dengan jadwal resmi. 3. Supervisi secara konsisten .	Manajemen RS	Satu Tahun

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Labororium

3.7.14 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

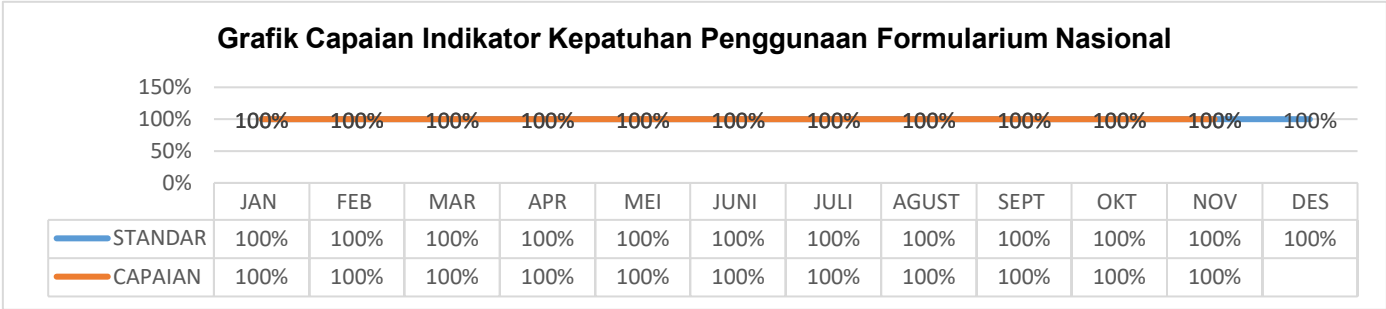


Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 diketahui capaian belum mencapai standart dan capaian meningkat hingga 100% di bulan Maret hingga November

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan 139lastic139e baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga November yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap yang membuat indikator tidak tercapai di bulan Januari dan Februari. Perbaikan telah dilakukan dengan cara menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor, memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap, memberikan pemahaman akan pentingnya melaporkan hasil kritis karena melalui hasil kritis dapat mempercepat mengetahui kondisi yang mengancam jiwa pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap. 3. Memberikan pemahaman akan pentingnya melaporkan hasil kritis karena melalui hasil kritis dapat mempercepat mengetahui kondisi yang mengancam jiwa pasien.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

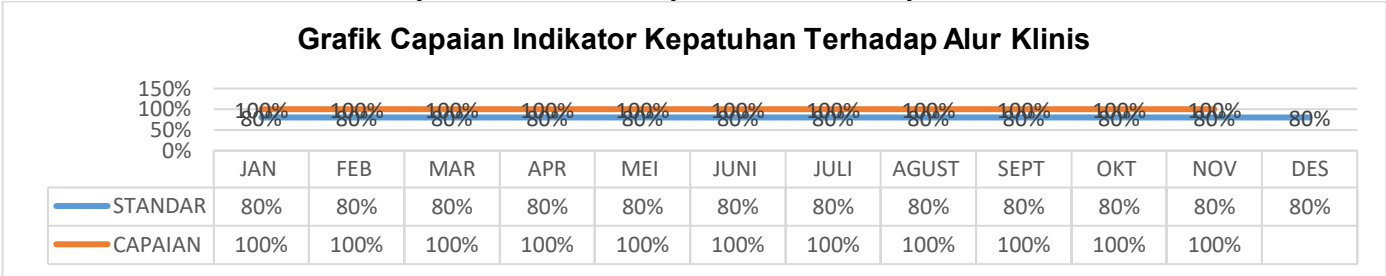
1.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga November tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Adanya payung hukum yang kuat, seperti Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional, memberikan landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan juga menjadi faktor yang membuat rumah sakit wajib mematuhi standart formularium nasional. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.5 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

3.7.15 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



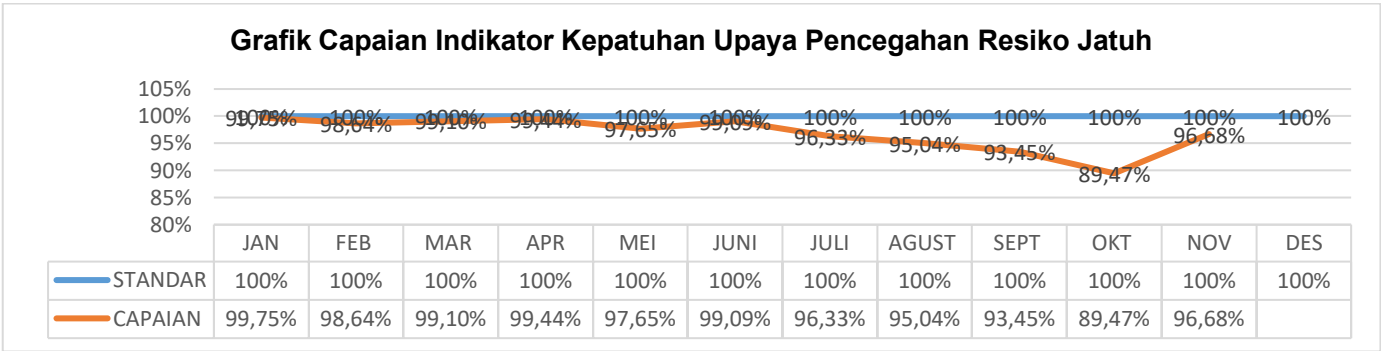
Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga November tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, unit yang patuh dalam pengisian CP daalah unit maternitas dengan diagnosa partus normal dan SC. Alur klinis sendiri sebenarnya membantu menstandarisasi perawatan untuk diagnosis tertentu, memastikan konsistensi dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Daftar Clinical Pathway Bulan November 2025

Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea		65	
Partus Normal		35	
Jumlah		100	

3.6.1.1.6 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.7.16 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



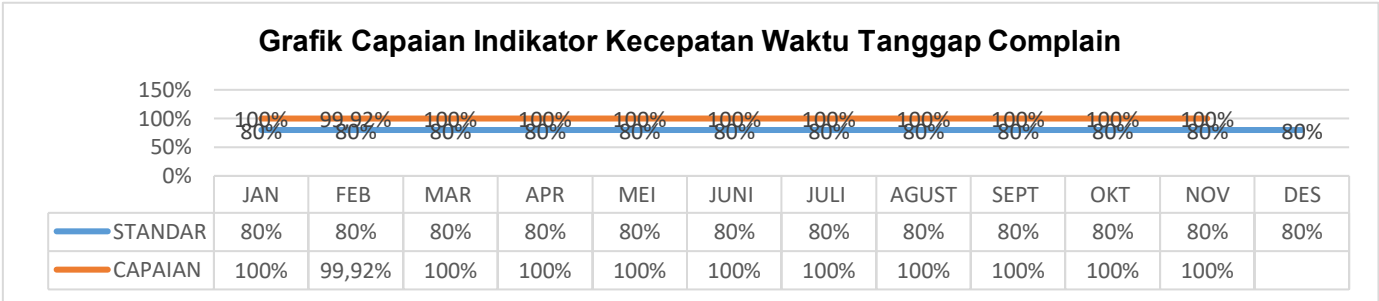
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga November Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1%, capaian di bulan April yaitu 99,44%, capaian di bulan Mei yaitu 97.65%, capaian di bulan Juni adalah 99,09%, capaian di bulan Juli adalah 96,33% dan capaian di bulan Agustus yaitu 95,04%, September 93,45%, Oktober 89,47% dan November yaitu 96,68% dengan rata-rata 96,68%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi. Temuan pada unit IGD yaitu kurangnya kepedualian petugas dalam upaya pencegahan risiko jatuh, hal ini diketahahui dari ditemukannya pasien IGD dengan tempat tidur yang tidak terpasang handrel dan tanda risiko jatuh yang tidak diberikan pada tempat tidur pasien. Hal ini menunjukkan bahwa motinasi petugas yang masih rendah dalam menjalankan prosedur keselamatan pasien secara konsisten.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	1. Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih	Perawat instalasi rawat inap	Satu Bulan

			ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan. 2. Memberikan teguran langsung kepada petugas yang tidak melakukan upaya pencegahan risiko jatuh 3. Meningkatkan pengetahuan perawat mengenai SPO pencegahan risiko jatuh dengan cara melakukan sosialisasi kembali dan pengajuan diklat sasaran keselamatan pasien.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.7 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

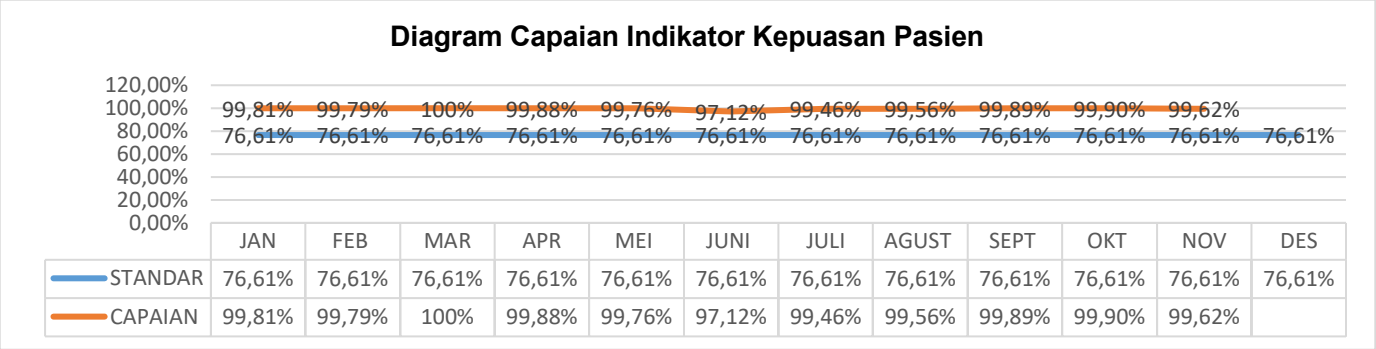
1.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari hingga November tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80% dengan rata-rata 99,99%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Upaya lain yang telah dilakukan adalah mekanisme pelaporan yang mudah bisa langsung melalui PIPP, bisa melalui tlp, WA dan formulir online. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya. Adanya staf yang terlatih khusus dalam manajemen komplain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya indikator kecepatan waktu tanggap complain dapat tercapai.

1.6.1.1.12.2 Kepuasan Pasien

1.6.1.1.12.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 99,52%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk berfokus pada kualitas pelayanan secara keseluruhan. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%	99,94%	99,83%	99,96%	100%		99,34%
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%	99,73%	99,51%	99,33%	99,93%	99,37%	99,41%	99,46%	99,36%	100%		99,6%
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	90,86%	100%	100%	100%	100%	98,62%	99,12%		98,96%
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	91,38%	98,85%	100%	100%	100%	93,22%	100%		99,11%
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspadai / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%

8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%	99,57%	99,77%	90,41%	97,63%	98,22%	98,48%	98,52%	98,62%	98,86%		98,1%
9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%	99,32%	99,63%	98,74%	99,31%	99,48%	98,71%	98,79%	99,93%	100%		99,2%
11.	Kepatuhan 145last pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%	98%	99,44%	97,65%	98,48%	96,33%	95,04%	95,21%	89,47%	96,68%		96,8%
12.	Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%	85,42%	85,32%	85,57%		85,36%

3.6.1.1.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%

3.6.1.1.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,98%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,89%	99,9%	99,62%		99,52%

1.6.1.14 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%	80,39%	81,69%	82,73%	87,5%	89,35%	86,4%	80%	87,5%	87,9%	88,2%	88,64%		86,2%

1.6.1.2.5 Mutu Unit

1.6.1.2.5.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	99,71%	99,7%	97,2%	99,48%	98,79%	98,2%	98,32%	99,9%	99,26%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%	98,37%	98,44%	98,72%	96,03%	95,23%	95,445	95,68%	94,24%	94,41%		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Kepatuhan 146last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%	100%	98,2	98,92%	98,45%	98,92%	98,82%	98,84%	98,9%	98,94%		
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Kepatuhan pelaporan pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%	100%	95,43%	92,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%	2,38%	1,9%	1,67%	5,43%	1,96%	1,72%	1,52%	1,87%	2,02%		

17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	73,21%	73,32%	75,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	c		
22.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.	Kegiatan merujuk pasien (horizontal)	0	1	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0		

Secara keseluruhan, **capaian indikator mutu Unit IGD menunjukkan hasil yang sangat baik dan stabil sepanjang tahun 2025**. Mayoritas indikator berhasil mencapai atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan pelayanan gawat darurat yang sudah berjalan sesuai standar keselamatan pasien dan prosedur operasional.

Beberapa poin penting dari hasil capaian tersebut antara lain:

1. **Indikator pelayanan pasien emergensi dan non-emergensi** (seperti waktu tunggu pasien <5 menit untuk kasus gawat darurat dan <60 menit untuk non-emergensi) menunjukkan capaian **sangat tinggi dan konsisten di kisaran 98–100%**. Hal ini menggambarkan kecepatan serta ketepatan pelayanan tenaga medis IGD dalam menangani pasien.
2. **Indikator keselamatan pasien dan pencegahan infeksi**, seperti **kepatuhan hand hygiene, penggunaan APD, dan identifikasi pasien**, juga mencapai **hasil optimal** dengan capaian di atas standar minimal. Hanya terdapat sedikit fluktuasi pada bulan Maret dan Juni yang kemungkinan disebabkan oleh beban kerja meningkat atau rotasi tenaga baru.

-
3. **Indikator tanpa kejadian**, seperti **pasien jatuh, KTD, dan sentinel event**, menunjukkan **hasil nol (0%)** sepanjang tahun, menandakan pengawasan terhadap risiko keselamatan pasien berjalan sangat baik.
 4. **Kepatuhan terhadap aspek administrasi dan dokumentasi** (misalnya informed consent, form identifikasi, label obat high alert, dan pemasangan gelang pasien) juga tercapai 100% hampir setiap bulan. Ini menunjukkan komitmen tenaga IGD terhadap tata kelola dan tertib dokumentasi pelayanan

Indikator yang masih perlu perhatian antara lain:

1. **Kebersihan lingkungan IGD**, yang memiliki capaian sangat rendah (1–5%). Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kebersihan area kerja dan sistem audit lingkungan.
2. **Ketepatan pelaporan hasil laboratorium ≤ 2 jam**, yang pada awal tahun sempat berada di bawah standar (sekitar 73%) sebelum akhirnya membaik di bulan-bulan berikutnya.
3. **Kejadian gugus insiden horizontal**, masih muncul beberapa kali (hingga 4 kasus) pada awal pertengahan tahun, menunjukkan adanya potensi masalah komunikasi atau tekanan kerja antarstaf.

Secara umum, **kinerja mutu Unit IGD dapat dikategorikan sangat baik** karena hampir seluruh indikator mencapai standar nasional. Namun, peningkatan berkelanjutan tetap diperlukan terutama pada aspek **kebersihan lingkungan, ketepatan pelaporan hasil laboratorium, dan hubungan kerja antarstaf** agar mutu pelayanan tetap optimal dan risiko keselamatan pasien bisa terus ditekan.

1.6.1.2.5.2 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kepatuhan 149last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Kepatuhan penandaan 150lasti operasi sesuai prosedur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.7.17 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%	95,23%	95,31%	97,22%	96,32%	96,88%	95,41%	96,33%		96,42%		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%	94,61%	95,22%	96,34%	97,24%	96,9%	95,26%	95,88%		95,91%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%	92,22%	93,33%	98,85%	94,58%	72,31%	69,88%	70,22%		84,62%		
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7.	Kepatuhan 150last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%	100%	100%	96,03%	100%	100%	100%	100%		100%		

8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%	100%	100%	98,71%	96,93%	100%	100%	100%		100%		
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	96,04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%		
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%		
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	97,93%	100%	100%	100%	97,71%	100%	-	100%		
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	95,48%	100%	100%	100%	95,27%	100%	-	100%		
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	87,25%	100%	100%	100%	100%	-	100%		
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%		
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%		
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	0	-	4,52%	1,81%	-	-	-	-	-		
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	0	-	100%	100%	-	-	-	-	-		
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%		
21.	Kepatuhan penandaan 151lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	95,31%	100%	82,4%	100%	100%	100%	100%	-	100%		
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%		

24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	97,75%	93,79%	100%	100%	100%	100%	-	100%		
-----	---	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------	------	---	------	--	--

Secara umum, capaian indikator mutu di Unit IRNA 3A menunjukkan **kinerja yang baik dan stabil**, dengan sebagian besar indikator berada **di atas atau mendekati standar yang telah ditetapkan**. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Pelayanan dan keselamatan pasien** berjalan dengan baik. Indikator seperti **ketepatan pelaksanaan asesmen awal pasien, kepatuhan penggunaan APD, kebersihan tangan, serta pelaksanaan informed consent** menunjukkan capaian **mendekati atau mencapai 100%** hampir setiap bulan. Hal ini menandakan kesadaran petugas terhadap standar pelayanan dan keselamatan pasien cukup tinggi.
- Kepatuhan kebersihan tangan dan penggunaan APD** secara umum berada di atas standar minimal ($\geq 85\%$), meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa bulan seperti Maret dan Mei, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor beban kerja atau kurangnya pengawasan pada shift tertentu.
- Indikator Clinical Pathway dan kelengkapan dokumentasi** (lembar asesmen, form transfer pasien, dan SSAR) tercapai baik di sebagian besar bulan, menunjukkan ketertiban administrasi dan kelengkapan rekam medis pasien terjaga.
- Beberapa indikator menunjukkan fluktuasi atau penurunan capaian**, seperti:
 - Kepatuhan wawancara awal pasien dan kelengkapan form asesmen awal**, yang sempat menurun di bulan Mei–Juli.
 - Kepatuhan pengisian form transfer pasien antar ruang**, sempat menurun pada bulan April–Mei.
 - Kejadian insiden horizontal** (komunikasi antarstaf), masih muncul meskipun rendah (1–2 kasus pada awal tahun).
- Indikator tanpa kejadian** seperti **KTD dan sentinel event** menunjukkan hasil **0%**, yang berarti tidak ada insiden keselamatan pasien serius selama periode pemantauan.

3.7.18 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25		
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%	100%	100%	90,32%	100%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	$\geq 85\%$	96,72%	96,88%	97,12%	97,22%	98,21%	98,24%	97,22%	95,31%	96,42%	95,22%	95,42%		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%	96,7%	97,8%	98,88%	97,32%	96,34%	95,22%	96,41%	96,21%	96,27%		

4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,86%	100%	100%	95,71%	100%		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	88,98%	95,17%	96,38%	99,46%	98,3%	92,93%	95,52%	89,30%	89,22%	95%	87,02%		
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kepatuhan 153last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%	89,11%	89,19%	97,62%	100%	67,38%	100%	100%	98,22%	98,34%		
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%	100%	95,15%	97,79%	100%	90,27%	100%	1005	100%	100%		
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,55%	100%	100%	82,73%	87,83%		
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	89,8%	41,67%	100%	100%	100%	88,272%	100%		
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	95,38%	100%	100%	100%	97,93%	100%	100%	100%		
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	90,75%	96,52%	100%	100%	95,48%	100%	78,23%	88,34%		
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	82,41%	100%	41,84%	100%	100%	88,1%	88,03%		
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,73%	100%		
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,32%	100%	100%	100%	97,03%	-		
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	2,1%	2,3%	-	-	-	-	-		
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%		

20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	98,7%	59,7%	100%	100%	100%	100%			
21.	Kepatuhan penandaan 154lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	98,06%	84,21%	92,14%	58,82%	82,4%	100%	100%	100%			
22.	Kejadian merujuk pasien (Hirizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	96,32%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator mutu di Unit IRNA 4A selama periode pemantauan, secara umum dapat disimpulkan bahwa **kinerja mutu layanan berada dalam kategori baik**. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator yang menunjukkan capaian stabil mendekati atau mencapai angka **100%**, terutama pada indikator yang berkaitan dengan **keselamatan pasien dan kepatuhan terhadap SOP**, seperti kepatuhan hand hygiene, kepatuhan penggunaan APD, ketepatan identifikasi pasien, pelaksanaan komunikasi SBAR, serta kelengkapan penyerahan pasien antar shift dan antar ruangan. Konsistensi capaian tersebut menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien telah berjalan baik dan menjadi kebiasaan kerja di lingkungan IRNA 4A. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan **fluktuasi capaian**, meskipun tidak terlalu signifikan, namun tetap perlu dilakukan perbaikan. Indikator-indikator tersebut antara lain pada **ketepatan waktu pemberian obat, kepatuhan pengisian dokumentasi, serta kelengkapan pelaporan saat transfer pasien**. Turunnya capaian pada indikator tersebut kemungkinan disebabkan oleh **beban kerja yang tinggi pada jam-jam tertentu, pergantian shift, serta variasi kedisiplinan pelaksanaan dokumentasi di lapangan**. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian berupa penguatan sistem monitoring harian dan peningkatan kepatuhan petugas.

Sementara itu, indikator **kepuasan pasien** menunjukkan hasil yang masih berada dalam batas standar, namun cenderung fluktuatif. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas interaksi antara petugas dan pasien, waktu tunggu pelayanan tertentu, serta kenyamanan lingkungan perawatan. Upaya peningkatan komunikasi terapeutik dan pendekatan pelayanan yang lebih humanis perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan pasien secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan beberapa **rencana tindak lanjut** untuk meningkatkan konsistensi mutu pelayanan, antara lain: pelaksanaan audit dan monitoring dokumentasi secara berkala, penguatan briefing antar shift untuk memastikan kelengkapan informasi dan koordinasi, optimalisasi alur distribusi obat, serta peningkatan kualitas hubungan interpersonal antara

tenaga kesehatan dan pasien. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan capaian mutu IRNA 4A dapat terus meningkat, lebih stabil, dan mendukung tercapainya pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

3.7.19 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	96,55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%	99,2%	99,31%	99,44%	98,79%	97,88%	97,92%	99,36%	98,81%	99,84%		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%	97,8%	98,2%	88,24%	91,23%	93,52%	93,88%	98,8%	99,12%	99,32%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	82,47%	80,15%	78,62%	80,95%	74,42%	72,22%	80,15%	79,49%	88,1%		
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kepatuhan 155last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	94,07%	94,92%	89,05%	86,09%	96,15%	96,42%	94,92%	100%	100%		
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	100%	100%	97,78%	97,14%	100%	100%	100%	100%	100%		
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	97,73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,65%	100%	100%	100%	100%	100%		

14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	93,75%	100%	53,85%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,5%	100%	100%	100%	100%	100%		
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	75%	100%	100%	100%	100%	100%		
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21.	Kepatuhan penandaan 156lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	45,45%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	97,79%	70,83%	90,48%	100%	100%	100%	100%		

Berdasarkan hasil pemantauan capaian indikator mutu di Unit IRNA 2C selama periode Januari hingga Oktober, secara umum diperoleh hasil bahwa sebagian besar indikator mutu **telah mencapai standar yang ditetapkan**. Hal ini terlihat pada indikator-indikator terkait **keselamatan pasien**, seperti kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, ketepatan identifikasi pasien, serta kepatuhan komunikasi SBAR yang menunjukkan capaian stabil mendekati atau mencapai **100%**. Capaian tersebut mencerminkan bahwa penerapan budaya keselamatan pasien **sudah berjalan baik dan konsisten** di lingkungan unit. Selain itu, pelaksanaan dokumentasi keperawatan, kelengkapan lembar observasi, serta pelaksanaan edukasi pasien dan keluarga juga menunjukkan hasil yang baik dan relatif stabil. Hal ini menandakan bahwa petugas telah melaksanakan asuhan keperawatan sesuai prosedur serta mampu mempertahankan mutu pelayanan dalam proses perawatan pasien.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan **fluktuasi capaian** dan pada beberapa bulan masih berada **di bawah standar**, seperti indikator angka kejadian dekubitus, kelengkapan pengisian form transfer pasien, serta kelengkapan dokumentasi asesmen nyeri. Penurunan capaian pada indikator tersebut berpotensi disebabkan oleh **beban kerja perawat yang tinggi**, pergantian shift, serta **kurangnya konsistensi monitoring dokumentasi** di waktu sibuk. Selain itu, adanya variasi tingkat kedisiplinan antar petugas juga dapat memengaruhi konsistensi hasil. Secara keseluruhan, mutu pelayanan IRNA 2C sudah berada dalam kategori **baik**, namun untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan stabil, perlu dilakukan beberapa tindak lanjut berupa: penguatan supervisi dan audit dokumentasi secara berkala, pendampingan kepada perawat dalam penerapan prosedur klinis, optimalisasi briefing antar shift, serta peningkatan kesadaran petugas mengenai pentingnya konsistensi pelaksanaan SOP dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien. Dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan capaian indikator mutu di IRNA 2C dapat terus meningkat dan memberikan pelayanan yang semakin aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien.

3.7.20 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,15%	100%	100%	100%	100%	97,35%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%	97,54%	97,57%	97,22%	97,81%	96,22%	96,82%	96,98%	96,42%	96,51%		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%	96,19%	96,34%	96,1%	97,8%	98,24%	98,60%	98,84%	97,4%	97,67%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-		
7.	Kepatuhan 157last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	97,86%	97,92%%		
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0,43%	1,53%	1,53%	-	100%	-	-	-		
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%		
21.	Kepatuhan penandaan 158lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, capaian indikator mutu di Unit IRNA 3C Anak menunjukkan **kinerja yang sangat baik dan konsisten**, dengan sebagian besar indikator mencapai **100%** setiap bulannya. Hal ini menandakan pelaksanaan standar pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan adanya komitmen yang kuat terhadap mutu pelayanan pasien. Beberapa indikator utama seperti **ketepatan waktu pemberian obat, kepatuhan pengisian rekam medis, pelaksanaan asuhan keperawatan (APD), dan penerapan Clinical Pathway** menunjukkan capaian **stabil di atas 97% hingga 100%** sepanjang tahun. Hasil ini menggambarkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan yang tinggi terhadap prosedur pelayanan. Indikator lain seperti **kelengkapan lembar asuhan, lembar persetujuan tindakan (informed consent), dan serah terima pasien (SBAR)** juga menunjukkan capaian **100% secara konsisten**, menandakan koordinasi antarpetugas yang baik dan dokumentasi yang tertib.

3.7.21 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	92,11%	98,95%	98,78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%	99,7%	99,78%	99,72%	98,92%	97,44%	97,47%	99,92%	99,73%	99,8%		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%	99,5%	99,62%	99,66%	99,71%	99,62%	99,80%	99,68%	99,46%	99,62%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,61%	94,65%	97,96%	99,4%	99,54%	95,65%	100%	100%		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	80,68%	81,44%	75%	68,75%	90,71%	72,22%	85,20%	76,98%	88,57%		
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kepatuhan 159last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	100%	100%	84,15%	69,57%	96,43%	96,52%	84,78%	100%	93,41%		
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	97,27%	99,51%	97,9%	91,67%	97,73%	97,6%	97,8%	100%	100%		
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	98,71%	92,24%	96,88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	88,24%	100%	100%	100%	91,3%	100%	100%	94,74%	100%		
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%		
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	97,47%	97,47%	80,77%	100%	100%	97,57%	100%	100%		
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	75%	95,12%	100%	56,25%	100%	100%	100%	100%	100%		
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	92,64%	98,88%	100%	100%	99,12%	99,72%	100%	100%	100%		
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,47%		
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%	0,43%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	-	0%	-	-	-	-	-	-		
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	99,01%	99,48%	100%	100%	84,62%		
21.	Kepatuhan penandaan 160lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0		
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu Unit IRNA 5C menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten pada sebagian besar indikator. Mayoritas indikator telah mencapai atau melebihi standar yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian untuk mencapai konsistensi 100% atau memenuhi target standar. Unit IRNA 5C telah berhasil menerapkan banyak praktik keselamatan pasien dan dokumentasi medis dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, terbukti dari banyaknya indikator yang mencapai 100% secara konsisten.

3.7.22 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,78%	100%	100%	100%	100%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%	93,3%	93,7%	95,6%	95,92%	99,72%	97,44%	99,72%	98,7%	98,8%		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%	97,1%	97,31%	98,5%	98,88%	99,66%	99,62%	99,66%	98,9%	92,72%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,65%	99,4%	94,65%	100%	100%		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%	82,02%	68,31%	63,64%	65,94%	75%	90,71%	80,60%	64,8%	69,92%		
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kepatuhan 161last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,13%	84,15%	96,43%	97,82%	100%	100%		
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,9%	97,73%	97,9%	100%	100%		
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%	100%	100%	100%	100%		
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,3%	100%	100%	100%		
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%	100%	96,48%		
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,47%	100%	100%	100%	100%		
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,66%	100%	100%	100%	100%	100%		

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,12%	100%	100%	100%		
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%	0,32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,01%	100%	100%	100%		
21.	Kepatuhan penandaan 162lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IRNA 6A menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.23 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%	96,12%	96,16%	97,22%	98,27%	96,62%	98,92%	98,80%	99,22%	99,32%		

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%	92,33%	92,41%	94,62%	96,71%	97,66%	97,21%	97,60%	98,78%	98,84%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,1%	88,42%	98,68%	97,92%	98,21%	100%	100%		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%	63,95%	67,13%	53,89%	69,44%	68,1%	52,88%	66,72%	70,21%	76,06%		
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kepatuhan 163last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	95,69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	87,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	81,18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%	0,64%	0%	0%	1,32%	-	0%	0%	0%	1,2%		

19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%		
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,67%	100%		
21.	Kepatuhan penandaan 164lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IRNA 7A menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun. Capaian indikator kelengkapan edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang mengalami penurunan di bulan Oktober, hal ini disebabkan karena tenaga Kesehatan terkadang kurang teliti atau disiplin dalam mengisi setiap item yang tersedia pada lembar edukasi pasien atau ringkasan pulang, seringkali terburu-buru. Secara keseluruhan, untuk mencapai standar indikator mutu ini, diperlukan intervensi yang komprehensif mulai dari perbaikan sistem alur kerja, peningkatan disiplin dan kompetensi SDM, serta penguatan pengawasan dan penerapan sanksi.

3.7.24 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agt'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%	99,62%	99,64%	98,92%	99,02%	97,2%	98,93%	98.70%	97,2%	97,33%		

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%	95,71%	95,82%	97,21%	98,34%	97,22%	97,22%	97,54%	97,4%	97,57%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%	99,01%	100%	97,93%	98,29%	100%	100%		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%	82,52%	73,6%	52,88%	66,67%	68,1%	52,90%	68,90%	85,5%	85,72%		
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kepatuhan 165last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	92,86%	100%%	100%	92,88%	100%	100%	100%		
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%		

19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21.	Kepatuhan penandaan 166lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IRNA 7A menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.25 ICU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89.9%	95,5%	97,7%	97,8%	98,22%	99,51%	97,22%	98,24%	98,86%	97,68%	97,71%		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%	99,6%	99,8%	99,88%	99,72%	98,2%	99,89%	99,84%	98,92%	98,97%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%	100%	100%	92,14%	94,32%	74,66%	70,21%	72,28%	100%	98,31%%		

6.	Kepatuhan 167last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%	88,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,2%	98,44%		
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,25%	98,29%		
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%	97,9%		
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%		
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,11%	100%		
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,56%	100%		
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	1,4%	-	-	-	-	-	-		
17,	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-		
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	93,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	92,37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,21%	100%		
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu di ruang ICU menunjukkan hasil yang **sangat baik** dengan sebagian besar indikator mencapai atau mendekati **100%** sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja dan penerapan standar pelayanan yang tinggi di unit ICU. **Rata-rata capaian mutu ruang ICU sangat tinggi (di atas 95%)**, menunjukkan pelayanan yang aman, efektif, dan sesuai standar. **Beberapa indikator teknis (pelabelan obat, hand hygiene tertentu)** masih perlu ditingkatkan melalui **penguatan supervisi, edukasi berulang, dan audit mutu internal**. Indikator yang belum berjalan perlu **diperjelas statusnya** agar tidak menurunkan nilai keseluruhan mutu unit.

3.7.26 HCU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%	97,61%	98,17%	99,24%	98,22%	85,22%	99,52%	98,54%	98,2%	98,34%		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%	99,36%	99,42%	99,56%	98,91%	99,2%	99,57%	99,8%	98,72%	98,81%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%	95,32%	100%	94,8%	97,3%	74,66%	70,22%	70,21%	100%	97,8%		
6.	Kepatuhan 168last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%	82,18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,66%	100%		
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%		
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-		
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %		

22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di HCU menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.27 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	S	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%	99,02%	99,32%	98,72%	96,32%	95,62%	96,22%	96,62%	96,4%	97,3%		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%	99,24%	99,44%	98,94%	97,44%	96,8%	96,92%	97,1%	96,2%	96,8%		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	89,3%	99,11%	99,02%	98,72%	97,33%	96,23%	96,66%	96,62%	96,88%	96,89%		
6.	Kepatuhan 170last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%	72,59%	79,58%	79,64%	81,86%	78,6%	82,44%	85,4%%	85,19%	85,55%		
12.	Kejadian merujuk pasien	0	0	0	48		15	17	21	34	41	45			
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu di Instalasi Rawat Jalan (IRJA) pada periode **Januari – Oktober 2025** menunjukkan hasil yang **sangat baik dan stabil**. Mayoritas indikator mencapai nilai **≥95%**, yang menandakan bahwa pelayanan di IRJA telah berjalan sesuai standar mutu rumah sakit dan pedoman Kemenkes.

3.7.27 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%	34,51%	39,04%	39,06%	43,75%	62,22%	64,43%	72,22%	63,25%	30,61%		
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Kepatuhan 172last pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8.	Kejadian keterlambatan operasi 172lastic caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	57,14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2	5	4	2	0	0	3	4	1	2		
11.	Kejadian partus macet	0	0	0	13	8	12	15	11	13	26	17	9		
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2	4	4	1	3	1	1	4	2	1		
14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0		
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%	17,2%	13,6%	7,52%	16,42%		
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%	16,5%	12%	7,52%	16,42%		
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77	86	102	72	90	98	96	123	123	56		
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
27.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
28.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
29.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
30.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
31.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
33.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Secara keseluruhan, indikator mutu ruang maternitas menunjukkan kinerja yang baik dan stabil pada sebagian besar aspek pelayanan. Sebagian besar indikator berada pada angka capaian 100%, menandakan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan, terutama pada aspek identifikasi pasien, penggunaan Clinical Pathway, dan pelaksanaan informed consent.

Indikator dengan Capaian Konsisten Baik (100%)

Beberapa indikator menunjukkan capaian sempurna (100%) sepanjang periode:

- 1. Kepatuhan Identifikasi Pasien
- 2. Kepatuhan Tindakan Sesuai SPO
- 3. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
- 4. Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan
- 5. Angka Kepatuhan Penggunaan APD
- 6. Kepatuhan Pelaksanaan Informed Consent
- 7. Kepatuhan Hand Hygiene & APD di Proses Persalinan

Hal ini mencerminkan bahwa budaya keselamatan pasien dan kepatuhan prosedur sudah berjalan baik di ruang maternitas.

3.7.28 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1	2	0	1	1	3	0	2	0	0		
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%	99,45%	99,57%	99,88%	99,98%	99,8%	99,88%	100%	100%	100%		
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%	99,71%	99,74%	99,81%	99,84%	99,67%	99,86%	100%	98,3%%	98,66%		
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%	81,18%	84,09%	78,13%	87,3%	76,2%	62,34%	100%	79,75%	76,84%		
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	95,51%	98,86%	100%	95,54%	100%	100%	100%		

10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,88%	98,88%	100%	100%	100%	100%		
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	88,46%	94,92%	96,8%	88,47%	89%	89%	89%		
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,92%	100%	100%	100%	100%	100%		
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%		
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%		
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (175lastic175)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-----	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Secara umum, pencapaian indikator mutu di NICU menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

1.6.1.2.6.16 PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%	99,44%	99,61%	99,88%	98,74%	98,8%	98,92%	99,20%	99,15%	99,27%		
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%	98,79%	98,82%	98,92%	98,73%	98,78%	99,21%	99,46%	98,34%	98,59%		
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
16.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di PICU menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.29 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,32%	0%	0%		
4.	Kepatuhan 178last pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	95,61%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan 178lasti operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Kejadian Ketidakpatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0	0	0	81,98%	19,84%	21,05%	42,31%	32,6%	100%	100%	100%	100%		
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%	100%	98,37%	92,98%	98,22%	100%	100%	100%	100%	100%		
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anastesi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IKO menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.30 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0		
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%	100%	100%	98,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1005	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit Laboratorium menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.7.31 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%	3,54	5,5%	6,99%	7,4%	6,22%	5,2%	4,8%	6,59%	6,69%	6,68%		
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	99,49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit Radiologi menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka

≥95%. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun. Terdapat satu indikator yang belum mencapai standart yaitu angka kelengkapan permintaan form radiologi yang disebabkan karena kurangnya kedisiplinan petugas dalam mengisi formulir secara lengkap dan tepat waktu. Untuk mengatasi masalah ini, perbaikan perlu dilakukan secara komprehensif pada semua faktor penyebab tersebut, misalnya dengan merevisi SOP, memberikan pelatihan berkesinambungan, meningkatkan pengawasan.

3.7.32 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,76%	100%		
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	11	0		
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dan lanjut)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%	99,21&	99,42%	99,82%	98,92%	99,28%	99,40%	99,48%	98,46%	98,71%		
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%	98,92%	99,22%	99,54%	99,31%	999,42%	99,53%	99,60%	99,6%	99,89%		

Berdasarkan data capaian indikator mutu pada unit Gizi periode **Januari hingga Oktober 2025**, secara umum dapat disimpulkan bahwa **pelaksanaan mutu pelayanan di unit Gizi berjalan dengan baik dan stabil**, dengan sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang sangat baik serta memenuhi standar yang ditetapkan. Indikator **kejadian keadaan membahayakan diri** menunjukkan adanya **sedikit peningkatan pada Oktober (11 kasus)** setelah beberapa bulan sebelumnya nihil. Hal ini menunjukkan perlunya **evaluasi terhadap faktor risiko atau kondisi pasien** yang mungkin berkontribusi terhadap timbulnya potensi bahaya, serta peningkatan pengawasan dan pelaporan insiden agar bisa segera dilakukan tindakan pencegahan.

Capaian kepatuhan identifikasi pasien menunjukkan hasil yang **sangat tinggi dan konsisten**, yaitu **100%** pada seluruh bulan, dengan sedikit penurunan pada bulan

Oktober menjadi **98,67%**. Hal ini menunjukkan bahwa petugas secara umum **telah menerapkan prosedur identifikasi pasien dengan baik**, meskipun tetap diperlukan **monitoring berkala dan umpan balik langsung** untuk memastikan tidak terjadi kelalaian kecil di lapangan.

3.7.33 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketersediaan obat obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0	1	0	1	0	4	4	4/6	7	1		
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%	74,45%	75,13%	69,23%	55,10%	48,88%	47,72%	43,08%	19,25%			
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%	59,59%	60,78%	53,23%	31,35%	24,03%	19,97%	15,70%	8,27%			
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	1	0		
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0		
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	1		
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	20	13	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0	29	22	42	32	0	0	0	0	0		
15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektifitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

16.	Kepatuhan penyimpanan obat obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	84,29%	89,92%	100%	87,72%	87,72%	86,11%	86,11%		
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	93,10%	97,66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single dose vial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit Farmasi menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun. Indikator mutu waktu tunggu obat tidak mencapai standar karena beberapa faktor seperti jam sibuk yang menyebabkan penumpukan resep, kendala administrasi seperti resep tidak lengkap atau data pasien yang tidak sesuai, masalah stok obat yang tidak cocok antara sistem dan stok fisik, serta proses penyiapan obat racikan yang lebih rumit dan memakan waktu. Keterbatasan sumber daya manusia atau petugas farmasi juga sangat mempengaruhi waktu tunggu.

3.7.34 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%	0,42%	0,24%	0,35%	0,45%	0,26%	0,17%	0,18%	0%	0,17%		
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Berdasarkan data capaian indikator mutu unit pengadaan farmasi dari bulan Januari hingga November 2025, terdapat dua indikator utama yang dievaluasi, yaitu:

Ketepatan stok farmasi : Capaian ketepatan stok farmasi menunjukkan fluktuasi capaian dari bulan ke bulan. Pada awal tahun (Januari–Februari 2025), capaian masih 0%, yang menunjukkan belum adanya pencapaian terhadap target indikator. Mulai Maret hingga Juli 2025, capaian mulai meningkat bertahap dari 0,24% **hingga 0,28%**, dan kemudian sedikit menurun pada Agustus (0,17%) hingga mencapai **0% kembali pada Oktober 2025**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian stok farmasi belum berjalan optimal dan masih memerlukan perbaikan dalam hal perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, serta distribusi agar ketepatan stok dapat terjaga sepanjang tahun. **Angka ketersediaan kebutuhan obat berdasarkan stok** : Indikator kedua menunjukkan hasil yang **konsisten dan optimal**, dengan capaian **100% dari Januari hingga November 2025**.

3.7.35 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%	0,27%	0,23%	0,49%	0,51%	0,25%	0,25%		
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰		
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰		
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰		
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,5%	0,61%	0,73%	0,78%	0,42%	0,77%	0,2%		
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,32%	85,25%	85,38%	85,58%	85,32%	85,57%		
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%	93,59%	93,74%	93,79%	94,3%	94,33%	95,1%	96,88%		
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%	93,51%	93,74%	93,77%	94,35%	94,35%	95,24%	97,28%		
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		

3.7.36 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	1005	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,56%	99,91%	99,62%		
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%	16,09%%	16,89%	18,12%	16,32%	14,22%	19,16%	19,16%	16,21%	19,97%		
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89	100%	100%	99,98%	100%	100%	99,52%	99,52%	100%	100%		
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pasien (PIPP) dari bulan Januari hingga Oktober 2025, secara umum terlihat bahwa kinerja unit menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian mendekati atau mencapai target pada sebagian besar indikator. **Angka Terupdate-nya Display TT dengan Mobile JKN** : Capaian indikator ini menunjukkan konsistensi **100% setiap bulan** dari Januari hingga Oktober 2025. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembaruan data tempat tidur melalui sistem Mobile JKN berjalan optimal dan terpantau secara berkala. **Angka Terupdate-nya Data Operasional dengan Mobile JKN** : Sama halnya dengan indikator pertama, capaian indikator kedua juga **stabil di angka 100%** sepanjang tahun. Hal ini menggambarkan keandalan sistem dan kedisiplinan petugas dalam melakukan pembaruan data operasional secara real time. **Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dalam 24 jam** : Capaian indikator ini **konsisten di angka 100%** pada seluruh periode, menunjukkan respon cepat dan efektif dalam menangani setiap keluhan atau komplain yang masuk dari pasien maupun keluarga pasien **Angka Kepuasan Pasien BPJS** : Capaian indikator ini stabil dengan rata-rata di atas **99% setiap bulan**, menunjukkan bahwa pelayanan bagi pasien BPJS telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. **Angka Capaian Discharge Planning** : Capaian indikator discharge planning tercatat **100% secara konsisten** sepanjang periode pengamatan. Ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pulang pasien telah dilakukan dengan baik sesuai prosedur dan memastikan kesinambungan pelayanan. Indikator Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan masih menunjukkan nilai yang relatif rendah dan perlu menjadi **prioritas perbaikan**. Diperlukan peningkatan motivasi dan kedisiplinan petugas untuk melakukan komunikasi pada pasien agar berkenan untuk mengisi kuisisioner.

3.7.37 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%	98,69%	98,79%	98,69%	98,66%	99,03%	98,96%	98,54%	98,31%	97,9%		
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%	1,91%	2,31%	1,48%	2,03%	2,41%	2,23%	1,99%	2,19%	1,04%		
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu SDM tahun 2025 menunjukkan kinerja **sangat baik**. Seluruh indikator administrasi dan tata kelola SDM mencapai **100%**, menandakan pelaksanaan fungsi manajerial SDM berjalan optimal. Namun demikian, indikator **kehadiran SDM berdasarkan finger print** masih menunjukkan sedikit fluktuasi pada awal tahun, sehingga perlu dilakukan **analisis penyebab ketidakhadiran** dan **strategi peningkatan kedisiplinan** secara berkelanjutan. Selain itu, upaya menjaga konsistensi pencapaian administrasi kepegawaian perlu terus dilakukan agar mutu pelayanan SDM tetap terjaga di seluruh unit.

3.7.38 Rekam Medis															
No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	29,3%	35,83%	51,74%	50,36%	36,06%	80,93%	78,88%	93,95%	84,41%	71,89%		
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%	0,35%	0,47%	0,32%	0,23%	0,49%	0,27%	0,19%	0,28%	0,27%		
3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8%%	98,04%	1,57%	7%	6,67%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%	90,25%	88,2%	10,23%	2,05%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%	9,56%	15,3%	12,21%	10,47%	7,54%	7,6%	12%	5,39%	5,33%		
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%	98,17%	95,87%	95,88%	96,2%	95,94%	100%	100%	100%	100%		

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu rekam medis menunjukkan **kinerja yang cukup baik** dengan beberapa indikator sudah mencapai target 100% secara konsisten, terutama terkait **pengelolaan data di SIMRS dan kelengkapan rekam medis IGD**. Namun, masih terdapat **tantangan signifikan** pada aspek **kelengkapan rekam medis pasien rawat jalan dan ketepatan penyelesaian DRM rawat inap**, yang perlu mendapat perhatian khusus melalui peningkatan supervisi, pelatihan, dan koordinasi antartugas rekam medis dan tenaga kesehatan.

3.7.39 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit K3RS menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

3.7.40 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%	3,23%	3,23%	1,62%	1,19	1,12%	1,32%	1,24%	4,08%	9,3%		
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%	2,22%	2,18%	2,05%	1,31	1,42%	1,21%	1,32%	1,93%	1,65%		
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%	99,26%	98,89%	98,9%	98,8%	99,22%	99,425	99,82%	99,1%	98,98%		
5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Berdasarkan data capaian indikator mutu Asuransi Center periode **Januari sampai November 2025**, secara umum pelaksanaan kegiatan mutu berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan sebagian besar indikator menunjukkan tren yang stabil dan mendekati target yang ditetapkan.

- Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim** : Selama periode Januari hingga Oktober 2025 tidak ditemukan kejadian dokumen rawat jalan yang tidak layak klaim (0 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan kelengkapan administrasi sudah berjalan baik, serta petugas telah memahami standar kelengkapan berkas klaim.
- Angka pending klaim BPJS** : Capaian indikator ini berfluktuasi setiap bulan dengan kisaran antara 1,46% – 4,08%, dimana nilai tertinggi terjadi pada bulan November 2025. Meskipun masih relatif kecil, adanya peningkatan pada bulan Oktober menunjukkan perlunya evaluasi terkait keterlambatan atau kekurangan dokumen pendukung klaim. Penguatan koordinasi antara petugas asuransi, verifikator, dan unit pelayanan menjadi hal penting untuk menekan angka pending klaim.-

3. **Presentase readokasi pasien rawat inap** : Nilai capaian indikator ini relatif stabil antara 0,91% – 2,36% selama periode pengamatan. Angka yang rendah menunjukkan proses administrasi pasien dan penyesuaian data jaminan berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sedikit kasus yang memerlukan readokasi. Perlu dilakukan monitoring terhadap penyebab readokasi untuk mencegah pengulangan.
4. **Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS** : Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan nilai konsisten tinggi di atas 98% hingga 99% setiap bulannya. Hal ini menandakan kedisiplinan dan ketelitian petugas dalam melengkapi berkas klaim sudah optimal, serta sistem penginputan di SIMRS berjalan efektif.
5. **Kejadian pasien tidak di-SEP** : Tidak ditemukan kejadian pasien yang tidak dibuatkan SEP selama periode Januari hingga Oktober 2025 (0 kasus). Ini menunjukkan kepatuhan petugas dalam melakukan registrasi dan pembuatan SEP sesuai ketentuan BPJS telah berjalan dengan sangat baik.

3.7.41 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%	78%	61%	68%	78%	80%	95%	95%	50%	40%		
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%	94%	95%	95%	97%	95%	95%	95%	45%	35%		

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu IPSRS dari bulan Januari hingga November 2025, secara umum terlihat bahwa kinerja IPSRS menunjukkan **pola peningkatan yang cukup baik di awal hingga pertengahan tahun**, meskipun terdapat **penurunan signifikan pada bulan November 2025. Angka ketepatan waktu penanganan perbaikan kerusakan oleh unit terkait ≤ 24 jam (Target: 100%)** Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan dari Januari (46%) hingga mencapai nilai tertinggi pada bulan September (95%). Namun, terjadi penurunan tajam pada bulan November menjadi 40%. Secara umum, capaian rata-rata menunjukkan bahwa **pelaksanaan perbaikan kerusakan dalam waktu 24 jam sudah berjalan cukup baik pada sebagian besar bulan**, terutama pada pertengahan tahun. Penurunan di bulan Oktober dan November kemungkinan disebabkan oleh **peningkatan volume pekerjaan, keterbatasan sumber daya, atau kendala teknis** yang menghambat kecepatan penanganan. **Angka ketepatan waktu respon dan penanganan kerusakan oleh unit terkait ≤ 24 jam (dalam kondisi darurat)** Indikator ini menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan capaian tertinggi mencapai 97% pada bulan Juni, namun juga mengalami penurunan pada bulan Oktober dan November hingga 45%.

Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan bahwa **respon terhadap kondisi darurat umumnya cepat dan tepat waktu** pada sebagian besar bulan, meskipun masih perlu ditingkatkan konsistensinya agar dapat mempertahankan capaian tinggi sepanjang tahun.

3.7.42 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8	7	2	4	2	2	3	2	1	2		
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8	2	2	4	3	7	3	7	3	0		

Berdasarkan data capaian indikator mutu Gudang Umum dari bulan Januari hingga November 2025, secara keseluruhan menunjukkan bahwa kegiatan penerimaan dan distribusi barang telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat **fluktuasi jumlah keterlambatan** pada beberapa bulan tertentu. **Keterlambatan barang datang di gudang (target: 0 keterlambatan)**, selama periode Januari hingga Oktober 2025, tercatat adanya keterlambatan barang dengan jumlah bervariasi antara 1 hingga 8 kejadian per bulan. Jumlah keterlambatan tertinggi terjadi pada bulan Februari dan Maret (masing-masing 8 dan 7 kejadian), sedangkan capaian terbaik terjadi pada bulan Oktober (1 kejadian) dan November (2 kejadian). Secara umum, terdapat **tren penurunan keterlambatan sejak pertengahan tahun**, yang menunjukkan adanya **peningkatan koordinasi dengan pihak penyedia atau vendor** serta efisiensi dalam proses penerimaan barang. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan agar target “0 keterlambatan” dapat tercapai secara konsisten.

Keterlambatan pendistribusian barang oleh unit (target: 0 keterlambatan), ini juga menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan jumlah keterlambatan berkisar antara 2 hingga 10 kejadian per bulan. Keterlambatan tertinggi tercatat pada bulan Februari (10 kejadian), sedangkan capaian terbaik terjadi pada bulan April (2 kejadian). Meskipun masih terjadi keterlambatan pada beberapa bulan, data menunjukkan adanya **perbaikan dalam kecepatan pendistribusian barang**, terutama pada semester kedua tahun berjalan. Hal ini dapat mencerminkan adanya **perbaikan dalam manajemen stok, jadwal pengiriman, serta koordinasi antarunit** di lingkungan rumah sakit.

3.7.43 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%	23,53%	45%	85,22%	35,4%	28,88%	22,35%	20,44%	0%	0%		
2.	Kejadian 192lastic192 Kebersihan Kamar Mandi	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%		
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%	92,47	94,21%	96,62%	97,88%	98,21%	98,40%	98,80%	97,92%	98,1%		
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%	94,28	96,82%	98,24%	99,02%	99,37%	99,55%	99,58%	99,23%	99,54%		

Berdasarkan analisa di atas dapat diketahui capaian indikator angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit masih belum stabil tetapi cenderung semakin membaik di bulan Juni hingga November. Faktor yang membuat petugas patuh dalam menggunakan spillkit antara lain : Memberikan pelatihan dan edukasi yang efektif kepada pengguna tentang pentingnya penggunaan spill kit yang benar dan dampaknya terhadap keselamatan dan lingkungan. Serta Memastikan spill kit tersedia di lokasi-lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pengguna.

3.7.44 KESEKRETARIATAN

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%	56,52%	50%	22,5%	47,62%	26,19%	23,8%	28,57%	35,71%	35,71%		
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%	31,82%	27,78%	38,1%	9,09%	18,18%	34,5%	40%	12,5%	16,67%		
3	Angka tindakan lanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%	34,88%	34,78%	31,25%	20%	13,51%	46,7%	20%	40%	18,52%		

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu kesekretariatan RS sepanjang tahun 2025 menunjukkan **fluktuasi kinerja yang cukup tinggi** dengan kecenderungan penurunan pada pertengahan tahun (Mei–Juli) dan perbaikan kembali pada triwulan ketiga (Agustus–November). Faktor yang mungkin memengaruhi antara lain:

- 1. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kegiatan rutin (rapat dan pelaporan).
- 2. Kendala koordinasi antarunit dan keterlambatan proses administrasi.
- 3. Periode beban kerja tinggi pada pertengahan tahun yang memengaruhi capaian indikator.

Untuk meningkatkan capaian, disarankan:

- 1. Membuat **jadwal tetap dan sistem pengingat otomatis** untuk kegiatan rutin seperti meeting dan pelaporan.
- 2. Meningkatkan **monitoring berkala** terhadap proses pemesanan barang agar waktu pemenuhan lebih cepat.
- 3. Mengadakan **evaluasi bulanan** untuk mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan.

3.7.45 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%	1,78%	2,23%	1,32%	2,06%	2,5%	1,15%	1,22%	1,28%	2,11%	0,8%		
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0		
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	98,82%	99,32%	99,04%	99,22%	99,85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	97,23%	96,22%	96,48%	96,92%	98,72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu laundry di atas, dapat diketahui bahwa masih terjadi keterlambatan penyediaan linen di unit unit karena keterlambatan pengiriman karena petugas pengiriman hanya 1 orang tiap pengiriminya, tindak lanjut yang telah dilakukan Adalah mengirim terlebih dahulu unit unit yang stok unitnya tinggal sedikit sehingga tidak sampai kehabisan.

3.7.46 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%	97,88%	98,22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Berdasarkan tabel capaian di atas, dapat diketahui bahwa masih ditemukan kejadian instrument hilang dan instrument kurang di ruang CSSD. Faktor yang menyebabkan masih terjadi instrumen hilang dan tidak lengkap di ruang CSSD antara lain: Kurangnya Sistem Pelacakan, kurangnya sistem pelacakan yang efektif membuat sulit untuk memantau lokasi instrumen. Selain itu Adalah kesalahan manusia, kesalahan manusia seperti lupa mengembalikan instrumen, salah penempatan, atau tidak mencatat instrumen yang dipinjam dapat menyebabkan instrumen hilang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan pengelolaan instrumen dan mengurangi kehilangan instrument :

1. Implementasi Sistem Pelacakan: Implementasikan sistem pelacakan yang efektif untuk memantau lokasi dan status instrumen.
2. Pelatihan Staf: Berikan pelatihan yang komprehensif kepada staf CSSD tentang prosedur pengelolaan instrumen, termasuk pengumpulan, pembersihan, sterilisasi, dan penyimpanan.
3. Pengembangan Prosedur Operasional Standar (SOP): Kembangkan SOP yang jelas dan efektif untuk pengelolaan instrumen, termasuk prosedur pengumpulan, pembersihan, sterilisasi, dan penyimpanan.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Lakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap pengelolaan instrumen untuk mengidentifikasi area perbaikan.

3.7.47 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%	99,86%	79,78%	84,44%	86,73%	89,32%	94,52%	99,32%	99,02%	99,11%		
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%	93,82%	79,81%	86,21%	88,21%	91,7%	91,88%	87,16%	88,91%	86,97%		
3.	Angka kunjungan pasien rencana operasi 15 pasien perhari	100%	92,34%	91,22%	92,46%	76,14%	79,22%	81,44%	75%	78%	74,3%	74,47%	73,31%		
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%	100%	98,82%	97,92%	72,67%	70,22%	76,22%	100%	92,75%	100%	100%	100%		

1.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0		
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit IT menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

1.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pencatatan pada buku register	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Kelengkapan APD pada ruang jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit kamar Jenazah menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

3.7.48 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%	68,38%	78,88%	82,44%	92,34%	82,75%	86,45%	84,75%	88,90%	97,9%	75%		

1.6.1.2.6.38 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Resptime Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%	99,68%	99,88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Resptime Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%	99,92%	99,82%	98,88%	98,64%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit driver menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

1.6.1.2.6.39 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya merokok, 196lastic rokok di lingkungan RS	0	6	11	7	14	21	13	18	19	16	21	21		

	(mutu prioritas unit)														
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
3	Kejadian potensial barang hilang	0	7	9	13	9	8	9	7	4	5	7	5		
4	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu security dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang menunjukkan jumlah kejadian yang signifikan dan fluktuatif yaitu :

- 1. Kejadian ditemukannya merokok/puntung rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit):
 - a) Indikator ini menunjukkan tingkat kejadian yang paling tinggi di antara semua kategori, mencerminkan adanya tantangan serius dalam menegakkan kebijakan larangan merokok di lingkungan rumah sakit.
 - b) Jumlah kejadian bervariasi dari 6 di Januari hingga puncaknya di Mei (21 kejadian), dan tetap tinggi di bulan-bulan berikutnya (18-21 kejadian)
 - c) Meskipun sedikit menurun di bulan-bulan tertentu, trennya menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penindakan perlu ditingkatkan secara konsisten untuk mencapai lingkungan rumah sakit yang bebas asap rokok.
- 2. Kejadian potensial barang hilang:
 - a) Jumlah kejadian ini juga cukup tinggi dan menunjukkan fluktuasi bulanan yang cukup besar (antara 4 hingga 13 kejadian).
 - b) Puncaknya terjadi pada Maret (13 kejadian).
 - c) Angka ini mencerminkan tingginya risiko atau potensi terjadinya kehilangan barang, yang mungkin memerlukan peningkatan pengawasan, edukasi kepada pengunjung/pasien, dan pengamanan aset di area-area rentan. Dua indikator lainnya menunjukkan hasil yang sangat baik, menandakan bahwa area ini terkendali dengan efektif :
 - 1) Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit :
 - a) Tercatat hanya dua kejadian sepanjang periode (Juni dan Juli).
 - b) Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi barang hilang (poin 3) cukup tinggi, kejadian kehilangan yang benar-benar terjadi dan dilaporkan sangat rendah, mencerminkan efektivitas langkah-langkah pencegahan kerugian dan penanganan insiden.

2) Kejadian Kekerasan di lingkungan RS :

- a) Tidak ada satu pun kejadian yang tercatat dari Januari hingga November 2025 (0 di setiap bulan)
- b) Ini adalah capaian mutu yang sangat baik dan menunjukkan bahwa lingkungan rumah sakit relatif aman dari insiden kekerasan.

1.6.2 Komite PPI

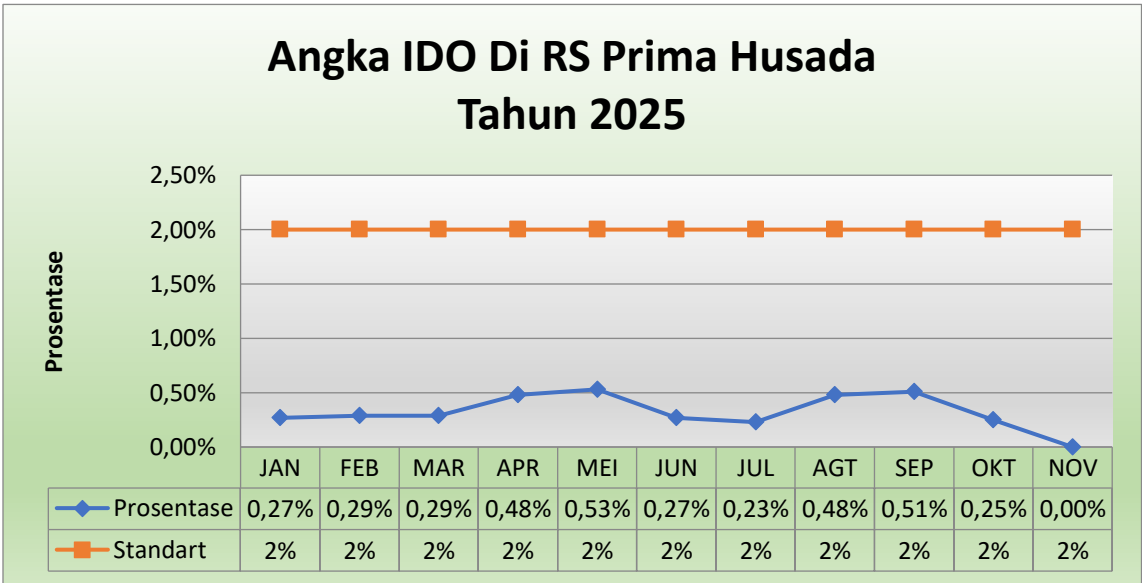
1.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI (November 2025)		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	80	0%
Seksio Sesaria	0	70	0%
Apendiktomi	0	3	0%
Herniotomi	0	14	0%
Katarak	0	54	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	11	0%
Semua Operasi	0	425	0%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	tidak terjadi kejadian IDO pada bulan ini pada keseluruhan jumlah operasi sebanyak 425 operasi.				
Masalah saat ini	tidak terjadi kejadian IDO.				
Permasalahan sebelumnya	• Faktor Manusia (Risiko kontaminasi udara meningkat karena crowding; tidak adanya kultur membuat terapi antibiotik empiris, berpotensi tidak sesuai). • Faktor Pasien (Nutrisi tidak adekuat menyebabkan daya tahan tubuh rendah memperlambat penyembuhan luka.). • Faktor Lingkungan (Jumlah staf yang memang terlalu banyak di dalam OK dan turn over OK yang terlalu cepat sehingga desinfeksi ruangan tidak maksimal). • Faktor metode (Peningkatan flora kulit akibat tidak mandi; pencukuran dengan silet menimbulkan luka mikro; kontrol terlambat menyebabkan infeksi teridentifikasi lambat; beban operasi tinggi menurunkan kualitas sterilisasi ruang). • Faktor material (Sudah sesuai standar, namun efektivitas antiseptik tergantung durasi kontak dan teknik aplikasi.).				
Tindakan yang dilakukan	• Pertahankan monitoring prosedur klinis dengan baik (monitoring perawatan luka pasien post operasi, kontrol proses pencukuran dan perawatan/desinfeksi alat cukur dan penggunaan pisau cukur disposable). • Melakukan monitoring kepatuhan aseptik di ruang-ruang perawatan. • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk persiapan-proses dan pasca operasi.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	• Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. • Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) • Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi risiko infeksi. • Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCEN	• Satu bulan
• Pertahankan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	Pasien post operasi.	• Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. • Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan	• Perawat /Bidan • Karu • IPCLN/IPCEN	• Satu bulan

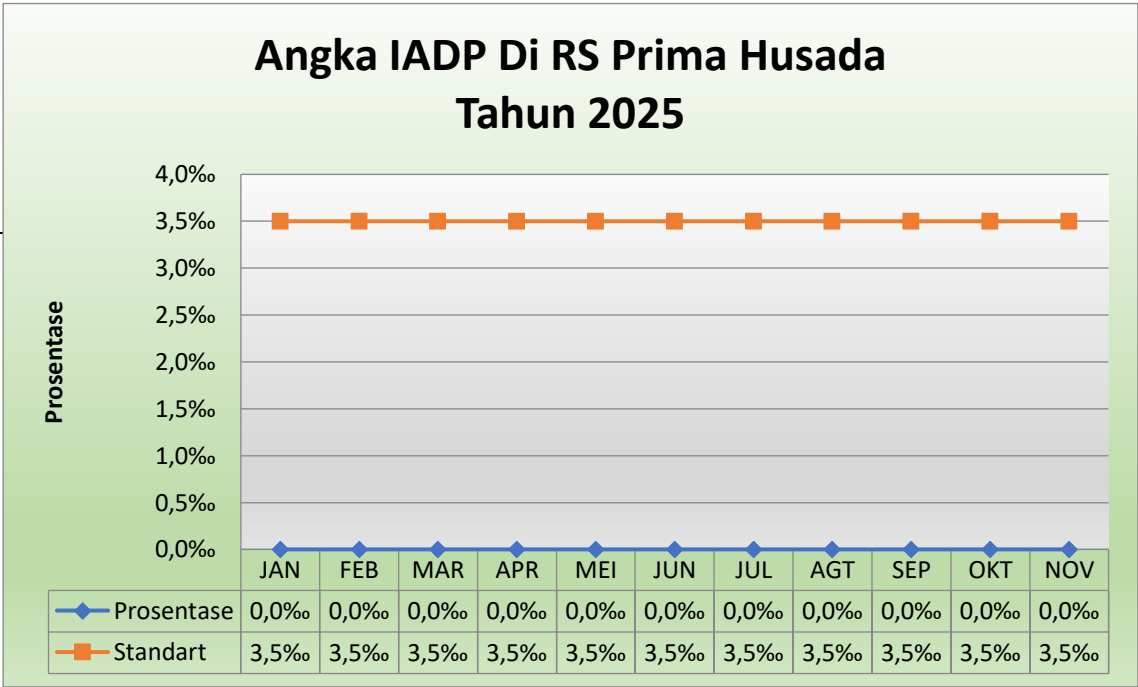
pasien pasca operasi			komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-pesan-media-feed back) • Berikan edukasi terutama terkait pemberian diit tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka. • Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. • Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.		
----------------------	--	--	--	--	--

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes

Ruang	IADP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	20	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.7.49 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP karena tidak ada tindakan pemasangan CVC.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. • Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. • Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. • Melakukan monitoring • perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	• Pasien dengan pemakaian CVC.	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. • Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

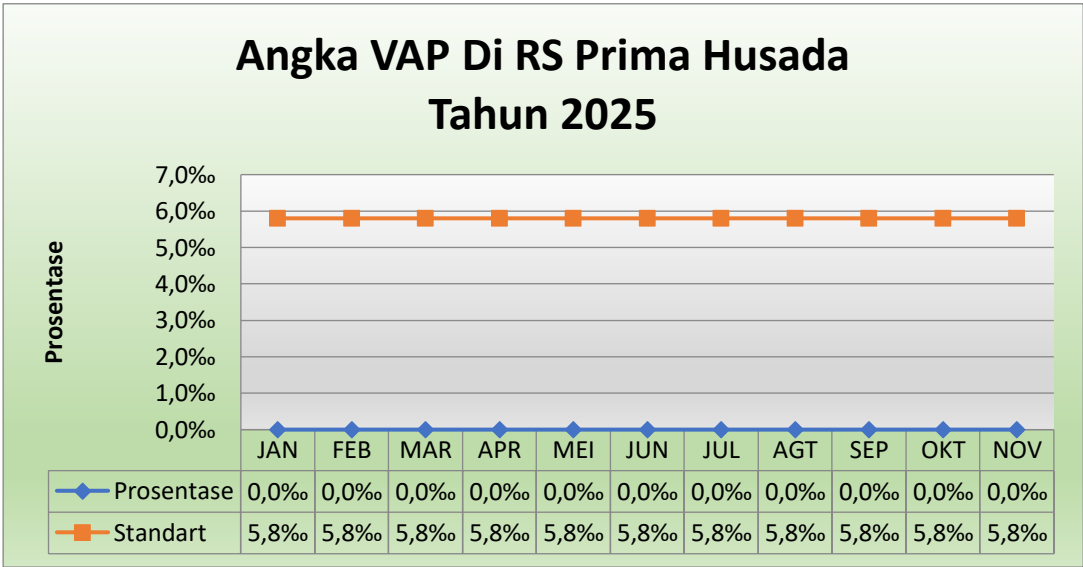
			area penusukan dan lokasi yang tepat. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.		
--	--	--	---	--	--

1.6.1.1.3 VAP

1.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	28	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	1	0‰

1.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 28 hari total lama pemasangan ventilator pada		
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP		
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP		
Tindakan yang dilakukan	- Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. - Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. - Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventila - Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. - Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan or - mendokumentasikan di CPPT/Askep.		
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian pemasangan ventilator. - Monitoring evaluasi posisi tepat pasien hea

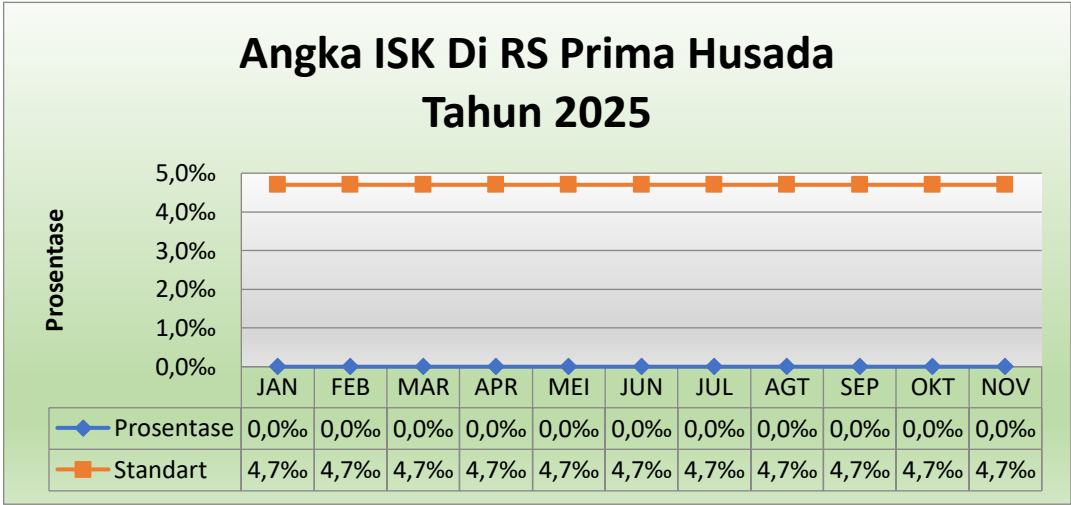
pelaksanaan oral hygiene.			- Monitoring evaluasi tindakan pemasangan - Monitoring kegiatan oral hygiene dan pend - Pemberian tindakan oral hygiene mewajib pada keluarga pasien, agar keluarga ik petugas untuk melakukan tindakan tersebu
---------------------------	--	--	---

1.6.1.1.4 ISK

1.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR ((Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	134	0‰
HCU	0	42	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	7	0‰

3.7.50 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)

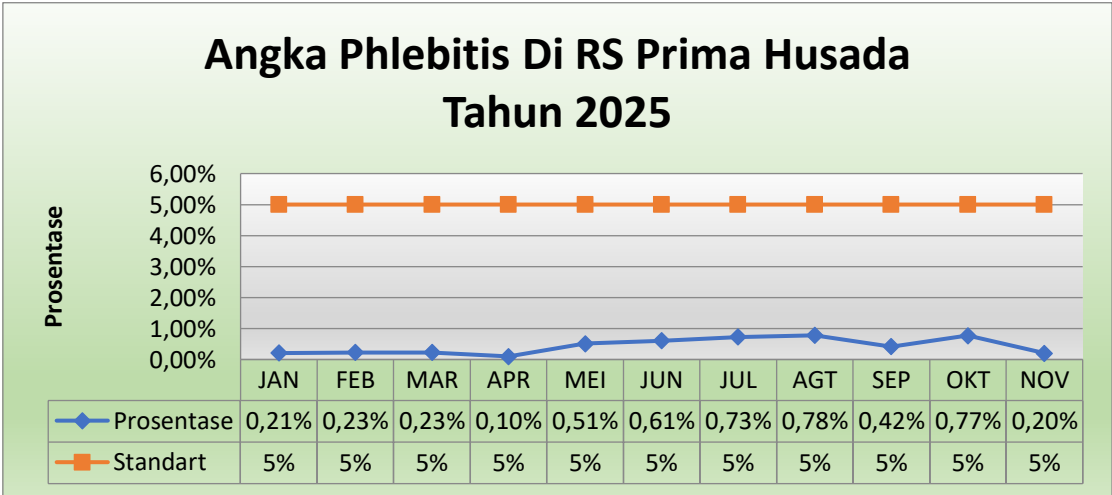


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1014 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	- Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. - Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. - Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. - Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

			Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.		
--	--	--	---	--	--

1.6.1.1.6 Phlebitis

3.7.51 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

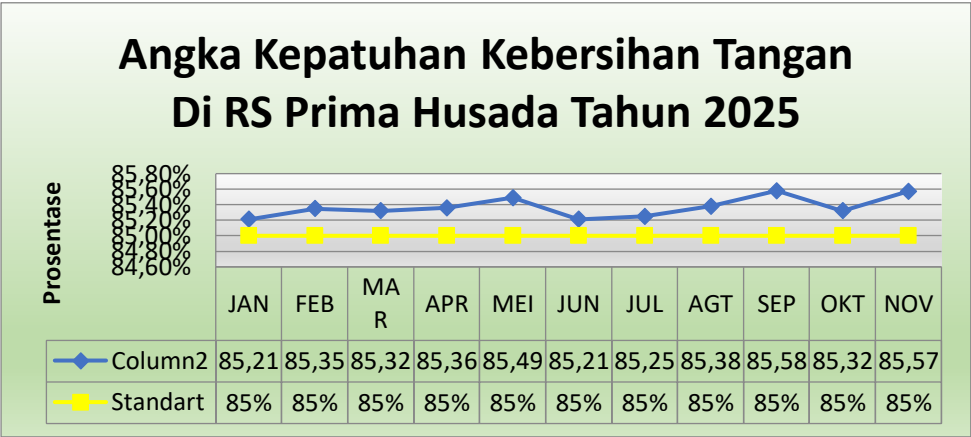


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 3062 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,2%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh terdapat 6 pasien yang mengalami phlebitis. Faktor penyebab kemungkinan besar: Obat pekat/iritatif tanpa pengenceran optimal, pemilihan lokasi pemasangan kurang tepat, teknik pemasangan tidak seragam antar petugas, fiksasi dan perawatan infus kurang optimal, kurangnya dokumentasi pemasang (kasus "NO NAME"), beban kerja tinggi di beberapa unit sehingga monitoring infus kurang. Dari 10 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).					
Masalah saat ini	• Pengenceran obat kurang optimal dan kurang terkontrol di ruangan. • Teknik pemasangan infus yang tidak seragam, serta perawatan yang kurang optimal.					
Permasalahan sebelumnya	• Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. • Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.					
Tindakan yang dilakukan	• Mengkoordinasikan dengan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. • Menganjurkan pada perawat pemasangan infus benar-benar harus menentukan posisi vena yang tepat dan memberikan edukasi setelah melakukan pemasangan infus terutama pada pasien beresiko tinggi. • Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. • Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. • Menganjurkan perawat untuk memberikan edukasi tambahan terkait perawatan saat terpasang infus.					
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU

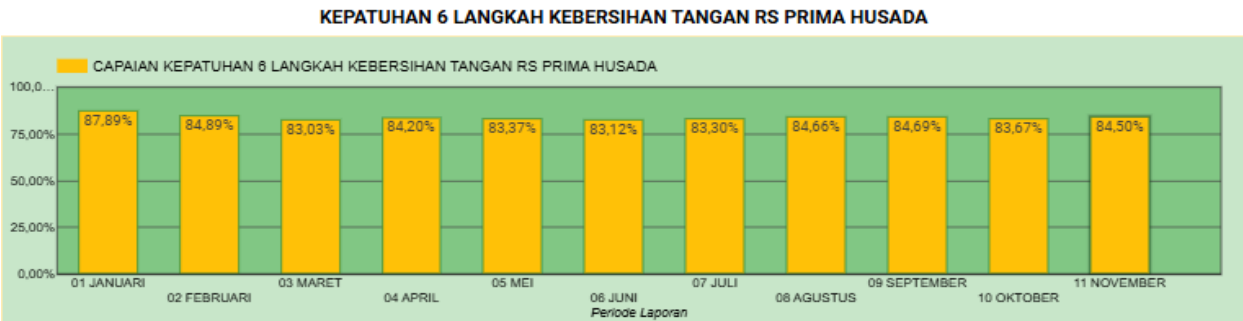
• Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	• Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	• Pasien yang terpasang infus	• Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. • Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. • Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. • Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. • Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. • Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. • Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. • Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan
• Perbaikan Proses Pemasangan & Perawatan Infus	• Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	• Perawat/bidan	• Re-education SOP pemasangan infus (vena besar, hindari area fleksi). • Pelatihan ulang teknik aseptik untuk perawat IGD dan IRNA 8A. • Audit kepatuhan perawatan VAP & manajemen infus setiap bulan. • Checklist harian pemeriksaan lokasi infus oleh perawat jaga.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Tiga bulan
• Pengendalian Penggunaan Obat Iritatif.	• Mengurangi resiko phlebitis karena pemberian obat pekat/iritan.	• Perawat/bidan • Apoteker	• Mewajibkan pengenceran adekuat sesuai standar farmasi. • Laju infus dikontrol untuk antibiotik dan obat pekat. • Koordinasi dengan Instalasi Farmasi untuk memberikan label “Obat Iritatif – Perlu Pengenceran”.	• Perawat /Bidan • Apoteker • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

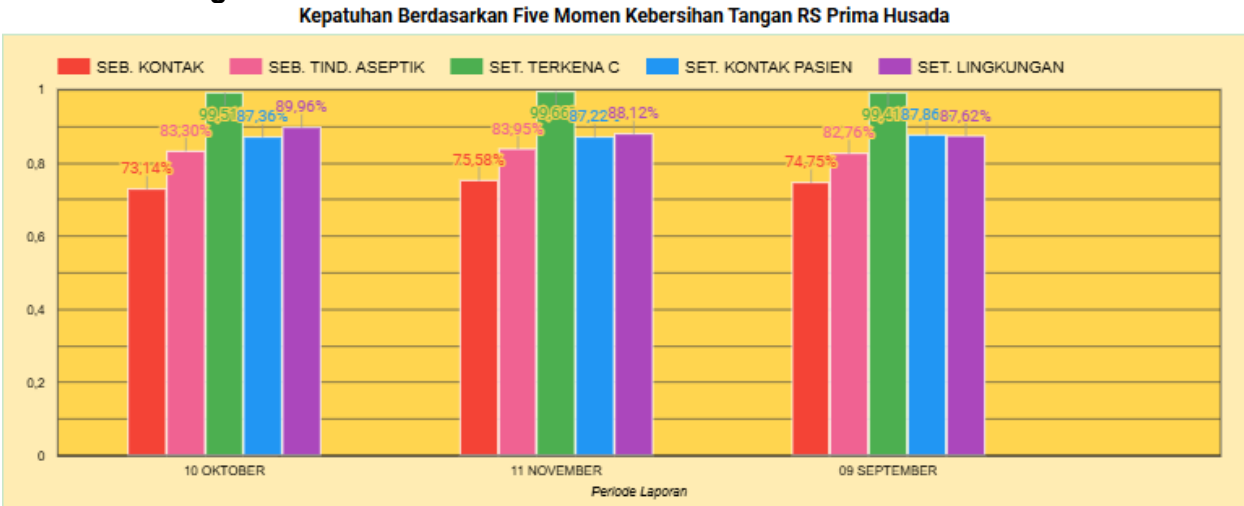
3.7.52 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

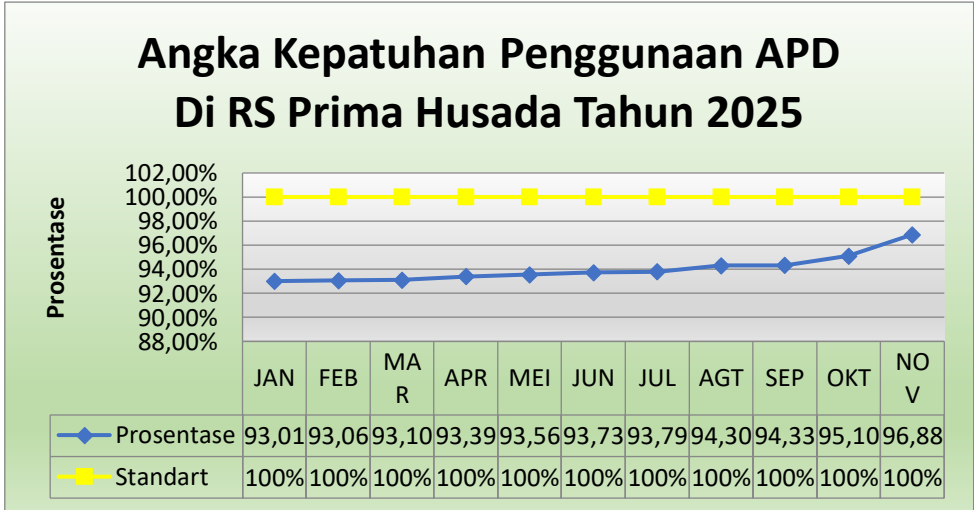


Analisa	Nilai kepatuhan hand hygiene bulan November 2025 berada sedikit di atas standar (selisih +0,57%). Meskipun masih memenuhi standar, terjadi peningkatan dibanding bulan Oktober (85,32%), yang berarti ada sedikit peningkatan kedisiplinan atau konsistensi dalam penerapan cuci tangan. Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan motivasi ulang kepada tenaga kesehatan agar tingkat kepatuhan terus meningkat. Nilai kepatuhan terhadap 6 langkah cuci tangan pada bulan November: 84,50%. Nilai ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya (Oktober: 83,67%). Artinya, meskipun tenaga kesehatan mencuci tangan, kemungkinan masih belum melakukan seluruh 6 langkah dengan benar. Peningkatan ini bisa mencerminkan peningkatan perhatian terhadap teknik yang benar dan peningkatan proses audit cuci tangan karena kebanyakan dari staf akan melakukan sesuai standar saat diamati, bukan hanya peningkatan frekuensi mencuci tangan saja. Pelaksanaan 5 momen cuci tangan di bulan November sudah cukup baik, namun perlu fokus peningkatan pada momen sebelum kontak pasien dan sebelum tindakan aseptik melalui edukasi dan reminder visual di area perawatan.
---------	--

Masalah saat ini	• Ketidakonsistenan dalam melakukan 5 momen cuci tangan. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal. • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata.				
Permasalahan sebelumnya	• Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dibiasakan dalam melakukan tindakan sehari-hari.				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. • Memberikan contoh cara cuci tangan yang benar saat mengisi diklat KE. • Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Meningkatkan kebersihan tangan.	• Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. • Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. • Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. • Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan
• Lanjutkan audit kepatuhan secara acak dan supervisi pengamatan rutin.	• Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	• Petugas kesehatan	• Melakukan audit mendadak (spot check) agar kebiasaan cuci tangan terpantau tanpa pengaruh pengawasan langsung. • Kepala ruangan dan IPCN melakukan pemantauan harian terutama pada shift pagi & sore. • Memberikan feedback cepat ketika ditemukan ketidaksesuaian.	• Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

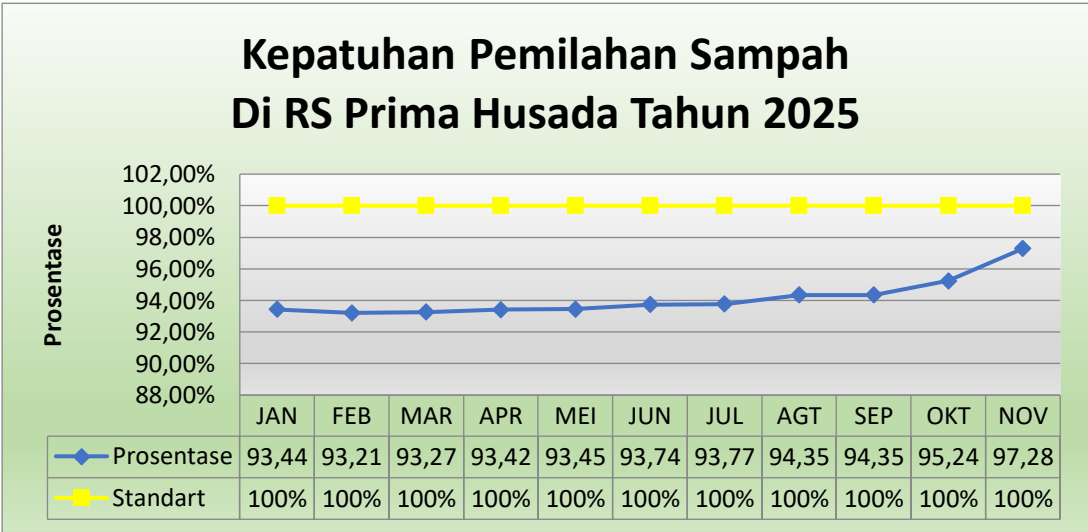


Analisa	Kepatuhan penggunaan APD masih berada di bawah standar 100%, dengan rentang 93,01% – 96,88%. Artinya, meskipun staf menggunakan APD, masih terdapat petugas yang tidak lengkap atau tidak sesuai indikasi. Terjadi peningkatan signifikan pada bulan November (96,88%), menunjukkan adanya: perbaikan perilaku penggunaan APD, meningkatnya kesadaran staf, atau pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Meskipun meningkat, nilai tetap belum mencapai standar 100%, sehingga masih ada: ketidakpatuhan dalam penggunaan APD lengkap dan berlebihan menggunakan APD. Tren umum menunjukkan kenaikan yang lambat (flat meningkat), menandakan bahwa: perubahan perilaku belum konsisten penggunaan APD masih dipengaruhi faktor situasional, bukan kebiasaan yang terbentuk secara kuat.				
Masalah saat ini	• Ketidakkonsistenan penggunaan APD antar shift dan antar unit. • Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.				
Permasalahan sebelumnya	• Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain.				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. • Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. • Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. • Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	• Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. • Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. • Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. • Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. • Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. • Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing	• Seluruh petugas pelayanan di RS.	• Satu bulan

			petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. - Audit kepatuhan harian per shift, IPCN/kepala ruangan/IPCLN/PJ Shift melakukan audit: pagi, sore, malam, minimal 3–5 observasi per shift. Catat petugas dengan angka kepatuhan rendah untuk ditindaklanjuti pada evaluasi kinerja. - Penguatan budaya keselamatan dengan melakukan briefing harian dengan pesan wajib: “APD lengkap sebelum kontak dengan pasien atau cairan tubuh.”		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



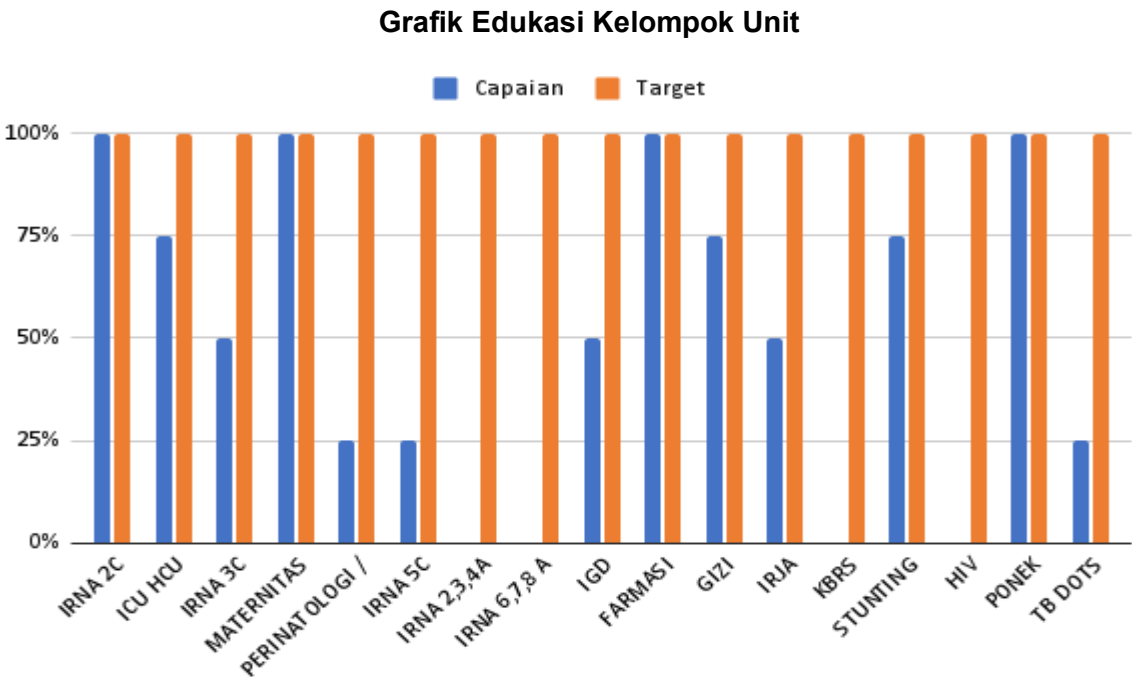
Analisa	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 97,28%. Dari hasil monitoring dan supervise, kepatuhan terdapat peningkatan karena adanya supervise dan monitoring baik dari IPCN/IPCLN maupun dari kepala ruangnya sendiri. Selain itu, petugas juga akhirnya mengingat saat diingatkan langsung bahwa pemilahan sampah yang benar seperti apa.
Masalah saat ini	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius (terutama bungkus alkes).
Permasalahan sebelumnya	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius (terutama bungkus alkes).
Tindakan yang dilakukan	- Menganjurkan menyiapkan kresek hitam dan kresek kuning pada saat akan melakukan tindakan yang sekiranya akan menghasilkan banyak sampah - Memberikan proses pembelajaran langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar. - Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. - Melakukan supervisi pada tempat sampah yang ada di unit-unit.

Pertahankan proses penyuntikan yang aman dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar kejadian. 0	Seluruh petugas pelayanan pasien	- Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. - Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. - Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. - Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan
---	---	--	---	--	--

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

Unit	Target	Sep	Okt	Nov	%	MANDOK	Keterangan
IRNA 2C	4x/Bulan	50%	100%	100%	Tercapai	Meningkat	Lampiran B
ICU\HCU	4x/Bulan	100%	100%	75%	Tidak Tercapai	Tercapai	Lampiran B
IRNA 3C	4x/Bulan	100%	100%	50%	Tidak Tercapai	Meningkat	Lampiran B
MATERNITAS	4x/Bulan	75%	100%	100%	Tercapai	Tercapai	Lampiran B
PERINATOLOGI	4x/Bulan	100%	100%	25%	Tercapai	Tercapai	Lampiran B
IRNA 5C	4x/Bulan	100%	100%	25%	Tidak Tercapai	Meningkat	Lampiran B
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	0%	100%	0%	Meningkat	Meningkat	Lampiran B
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	100%	100%	0%	Meningkat	Tercapai	Lampiran B
IGD	4x/Bulan	100%	100%	50%	Tidak Tercapai	Meningkat	Lampiran B
FARMASI	4x/Bulan	75%	100%	100%	Meningkat	Meningkat	Lampiran B
GIZI	4x/Bulan	75%	75%	75%	Menurun	Menurun	Lampiran B
IRJA	4x/Bulan	75%	100%	50%	Menurun	Tercapai	Lampiran B



ANALISIS

: Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan November Petugas PKRS tiap unit Tidak Mencapai Target Edukasi Penyuluhan, dan beberapa UNIT banyak mengalami penurunan seperti UNIT IRNA 3C, ICU, MTS, PERIN, 5C,

IRNA 2,3,4A, 6,7,8A, IGD, GIZI, IRJA

RTL : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar keteringgalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan April.

3.6.3.1 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.2 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

UNIT	TARGET	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	%	BUKTI DI FORM EDUKASI TERINTEGRASI ATAU KOLABORASI	KET
PONEK	4X/Bulan	100%	75%	100%	Tidak Tercapai	√	terlaksana
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	25%	75%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	25%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana

ANALISIS : Bulan November PROGNAS belum tercapai.
RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

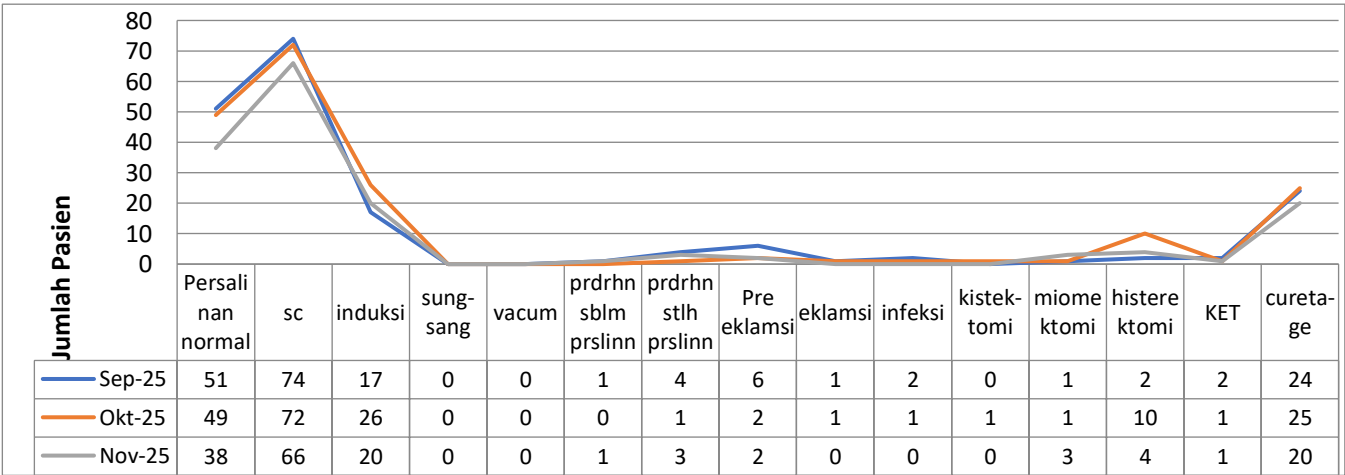
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek November 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1				
	a. Persalinan Normal	51	49	38
	b. <i>SectioCaesaria</i>	74	72	66
2				
	a. Induksi / Drip	17	26	20
	b. Sungsang	0	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	1	0	1
	b. Perdarahan setelah Persalinan	4	1	3
	c. Pre Eklamsi	6	2	2
	d. Eklamsi	1	1	0
	e. Infeksi	2	1	0
4				
	a. Curretage	24	25	20
	b. Kistektomi	0	1	0
	c. Miomektomi	1	1	3
	d. Histerectomy	2	10	4
	e. KET	2	1	1

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan November 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan November 2025 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 66 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan November 2025 juga sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 38 persalinan. Untuk

persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu. Jumlah persalinan secara SC dan Persalinan normal pada bulan November sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah pasien INC di maternitas juga sedikit menurun pada bulan November 2025.

2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Tidak ada persalinan sungsang pada bulan November 2025 dan 2 bulan sebelumnya. Dan juga tidak ada persalinan dengan vacuum pada bulan November 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
4. Induksi Persalinan pada bulan November mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 20 pasien
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan November 2025 sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan November 2025.
6. Jenis pelayanan curretage di bulan November 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 20 pasien. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynecology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

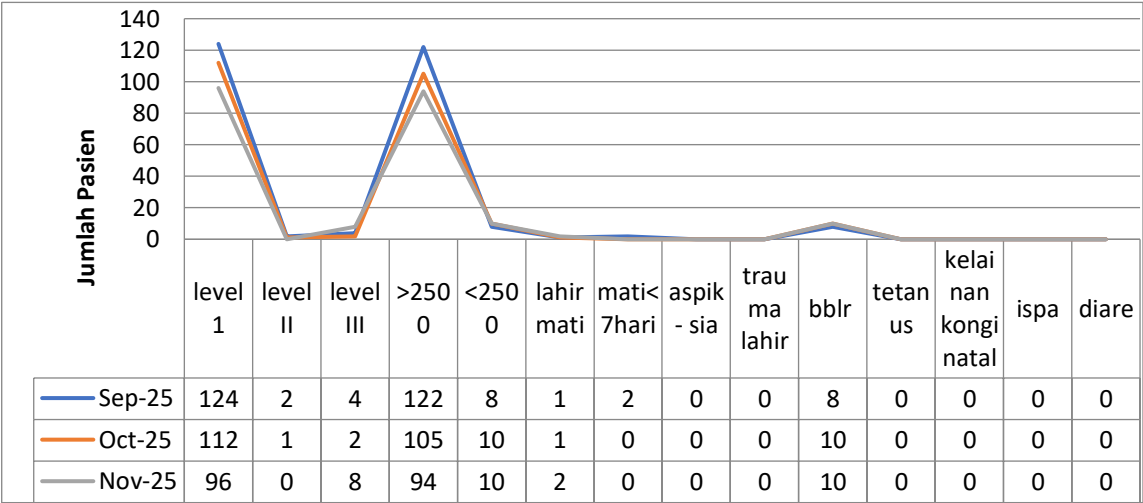
3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponек November 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025	Bulan November 2025
1				
	a. Level 1	124	112	96
	b. Level II	2	1	0
	c. Level III	4	2	8
2				
	a. ≥ 2500 gram	122	105	94
	b. ≤ 2500 gram	8	10	10
3				
	a. Kelahiran Mati	1	1	2
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	1	0	0
4				
	a. Asphyxia	0	0	0

	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	8	10	10
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada November 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan November 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 96 bayi. Dan untuk pelayanan level 2 pada bulan November tidak ada, sedangkan pada level 3 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 8 bayi. Jumlah bayi bulan November 2025 menurun seiring dengan jumlah persalinan pada bulan November 2025
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan November 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 94 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan November 2025 sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan November 2025 sama dengan bulan sebelumnya yaitu 10 bayi.
5. Ada 2 kasus kelahiran mati pada bulan November 2025, sedangkan pada bulan September dan Oktober sama, yaitu 1 kasus.
6. Tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan November dan Oktober, sedangkan pada bulan September ada 2 kasus,

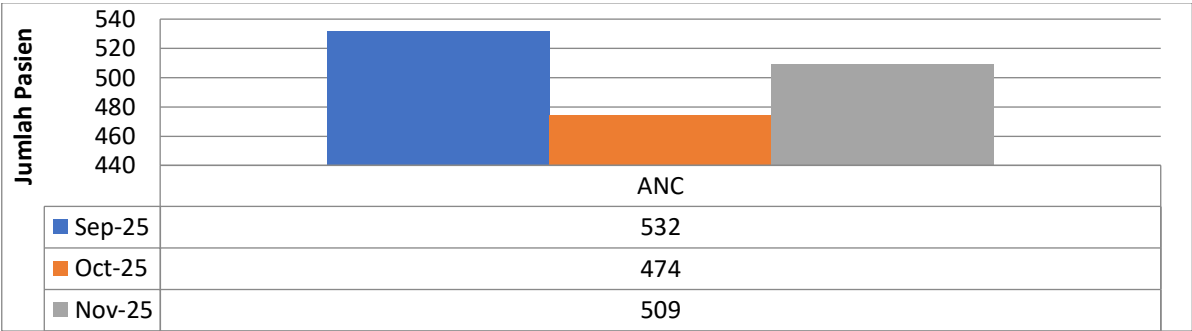
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.7.53 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek November 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	ANC	532	474	509

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada November 2025



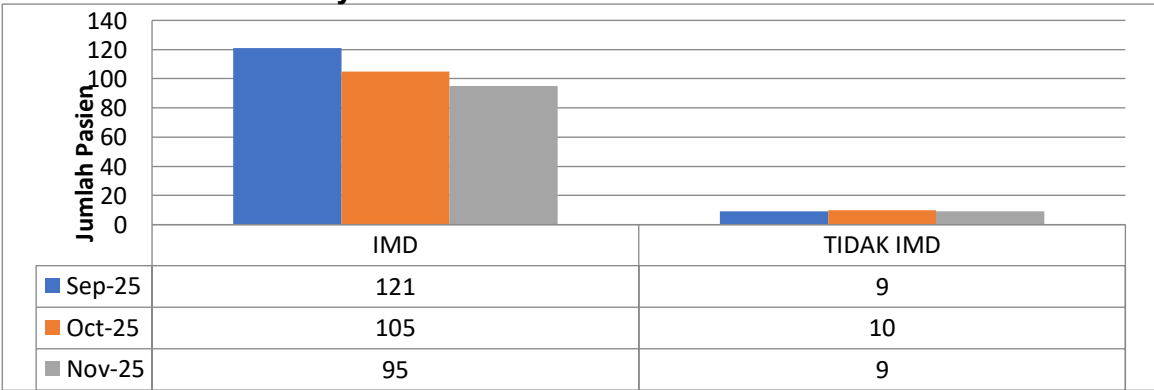
Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan November 2025 mengalami peningkatan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 509 kunjungan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.7.54 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) November 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	IMD	121	105	95
2	Tidak IMD	9	10	9

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan November 2025



Analisis :
1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan November 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 95 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.

2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan november sama dengan bulan September yaitu 9 bayi, Sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 10 bayi.
3. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan November 2025

NO	NAMA BAYI	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	By Ny Ita rokhmawati	NCB + BBLR	Cuvis
2	By Ny Yanastri Dwi	NKB + BBLR + RDS	CPEP + Inkubator
3	By Ny Fanessa	NKB + BBLR + RDS	CPEP + Inkubator
4	By Ny Chusnul P 1	NKB + BBLR + gemelli	Cuvis
5	By Ny Chusnul P 2	NKB + BBLR+ gemelli	Cuvis
6	By Ny Firda Ayu	BBLSR, neonatal seizure, pneumonia, NEC	CPEP + Inkubator
7	By Ny Ellys Fransiska	NCB + BBLR	Cuvis
8	By Ny Maslikatul Zurroh	NCB + BBLR + RDS	CPEP + Inkubator
9	By Ny Vanny F	NCB + BBLR	Cuvis

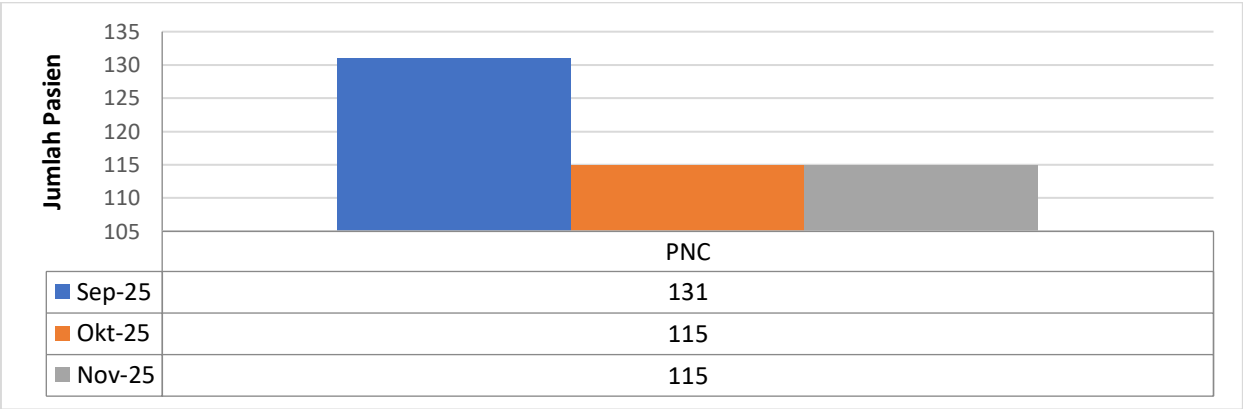
Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

3.7.55 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponек November 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	PNC	131	115	115

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan November 2025



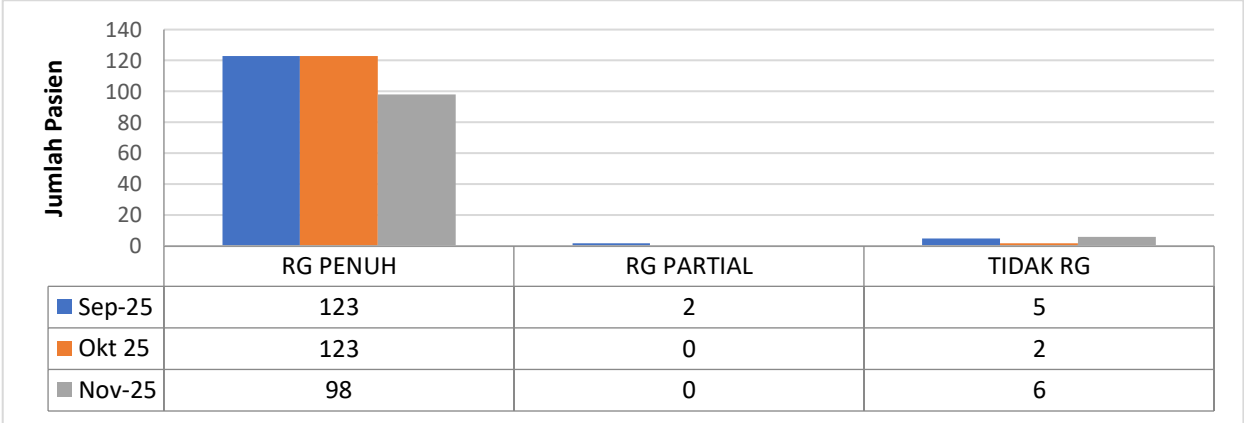
Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan November dan Oktober 2025 sama yaitu 115 kunjungan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponpek November 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	Rawat gabung penuh	123	123	98
2	Rawat gabung partial	2	0	0
3	Tidak Rawat gabung	5	2	6

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2025



Analisis :

- Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan November 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu sebanyak 98 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan November 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 6 bayi.
- Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

NO	NAMA	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	By Ny Firda Ayu	BBLSR, neonatal seizure, pneumonia, NEC	CPEP + Inkubator
2	By Ny Maslikatul Zurroh	NCB + BBLR + RDS	CPEP + Inkubator
3	By Ny Yanastri Dwi	NKB + BBLR + RDS	CPEP + Inkubator
4	By Ny Fanessa	NKB + BBLR + RDS	CPEP + Inkubator
5	By Ny Farida	NCB, RDS	CPEP + Inkubator
6	By Ny Khusnul W	NCB, RDS	CPEP + Inkubator

Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

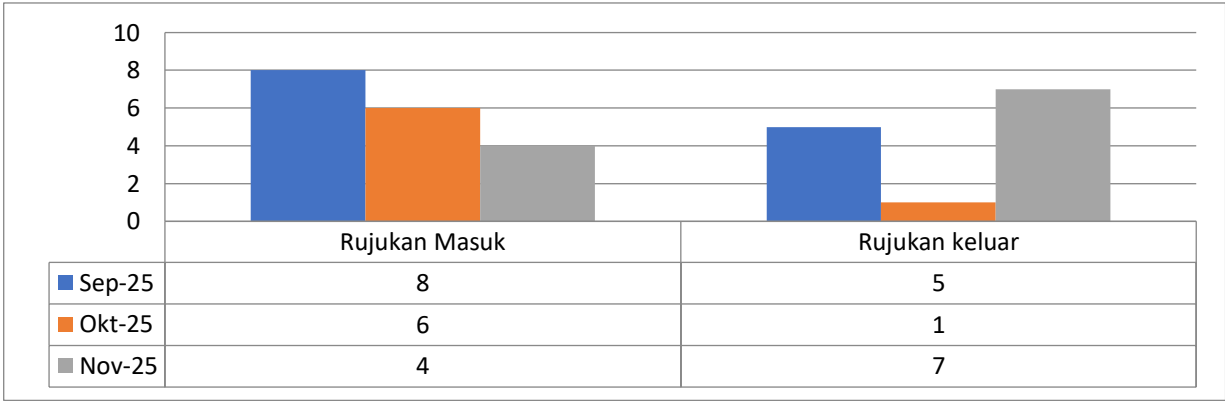
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponpek November 2025

NO	RUJUKAN	BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	Rujukan Masuk	8	6	4
2	Rujukan keluar	5	1	7

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan November 2025

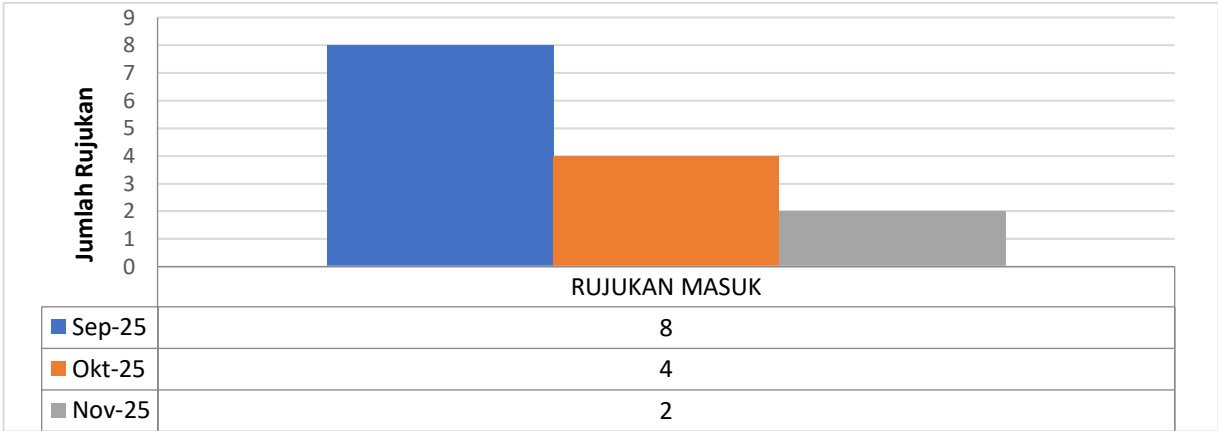


3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek November 2025

Bulan September 2025			
1	By Ny Sri bawon 1	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	RS Sumber Santosa
2	By Ny Sri bawon 2	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	RS Sumber Santosa
3	By By Erwin	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	PKM Singosari
4	By Rayyan Maulana	PNEUMONIA, NEC, BBLSR	RS Sahabat
5	Ny Erwin	P2103 Ab000 dengan post partum + HPP ec sisa plasenta	PKM Singosari
6	Ny Meila	G3 P0010 Ab100 UK 36-37 mgg dg HT+ DM+BOH	PMB Titik Sunaryati
7	Ny Nur Halimatus	G1 P0000 Ab000 UK 39-40 mgg dg KPD	PMB Titik Sunaryati
8	Ny Cholis Ambiyah	G2 P1001 Ab000 UK 40-41 mgg dengan PEB +KPD	PKM Singosari
Bulan Oktober 2025			
1	Ny Riska Rismawati	G2 P1001 Ab000 UK 32-34 minggu dengan hemoroid	RS Graha Medika
2	Ny mAuludiya	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan kala 2 lama	PMB Indah M
3	Ny Rosa Dwi	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
4	Ny Tuminah	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 minggu dengan prolong KIFA +HT+KPD	RKM Ardimulyo
5	APRILIA DWI LESTARI	G1P0000Ab000 UK 39-40 MGG DG OLIGOHIDRAMNION	TPMB TITIK SUNARYATI, S.Tr.Keb.,Bd
6	SITI NUR KHOTIMAH	G1 P0 A0 38-39 mg dengan KPD + Prolonged fase laten	PMB Lilik Agustina Lawang

Bulan November 2025			
1	Ny Ipatul M	G3 P2002 Ab000 UK 32-34 minggu dengan PPI, Febris Hari ke 2	PKM Lawang
2	RISKA RISMAWANTI	G2 P1001 AB000 UK 32-34 MINGGU DNEGAN HEMOROID GRADE 4	RS GRAHA SEHAT MEDIKA
3	MAULIDIA AGUSTINA	G1P0000AB000 38-39 MG DG KALA 2 LAMA	BPM INDAH MAHARANI
4	By Ny Nurul F	BBLR, RDS	BPM Munawaroh

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan November 2025



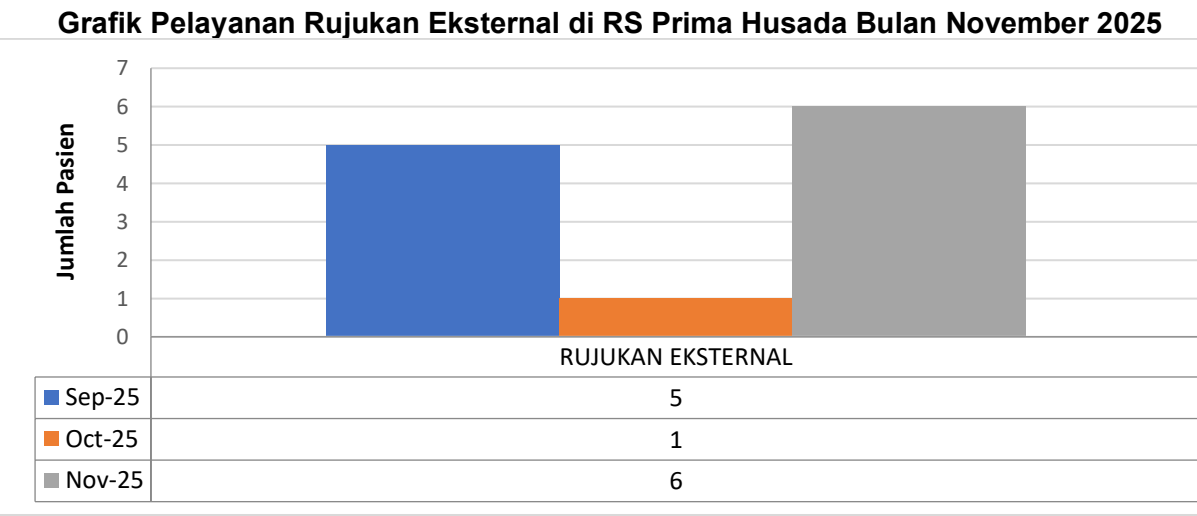
Analisis :
 Jumlah rujukan masuk pada bulan November menurun yaitu hanya 2 rujukan, sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 4 rujukan dan September sebanyak 8 rujukan masuk

Rencana dan Tindak Lanjut
 Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
 Tabel Rujukan Keluar Ponek November 2025

NO	NAMA	USIA	UNIT	DIAGNOSA	ALASAN RUJUKAN	TUJUAN RUJUKAN
Bulan September 2025						
1	By Ny Apsah	3 hr	NICU	Bronchopneumonia + Hipoglikemia refrakter	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
2	By Ny Lia	3 hari	NICU	NP-Spt + BBLASR + obs. dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
3	By Ny Erwin	1 hari	NICU	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Soepraoen
4	By Ny Sri bawon 2	1 hari	NICU	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	Ny Lilis	38 th	PONEK	G2 P0000 AB100 UK 30-32 mgg dengan Eklamsi + HT emergency + nprimi tua sprimer + riwayat infertile +HSVB	Penanganan lebih lanjut	RS Saiful Anwar

Bulan Oktober 2025						
1	Nilam larasati	28 th	PONEK	G2 p1001 ab0 uk 26-28 minggu dg pprom, hiperbilirubin	Penanganan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
Bulan November 2025						
1	By Jerrel Gabrieal	18 hari	NICU	BBLASR,Apnew of prematurity, bronchopulmonary dysplasia, neonatal difficultybfeeding on breast, NEC, Congenital pneuminia	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Lavalette
2	By Jerrel Gabrian	20 hari	NICU	BBLASR,bronchopulmonary dysplasia, neonatal difficultybfeeding on breast, NEC, Congenital pneuminia	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Pantl Nirmala
3	By Ny Firda Ayu	6 hari	NICU	BBLSR, Neonatal Zeizure, pneumonia, NEC	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Lavalette
4	By. Ny khusnul W	1 hari	NICU	NCB, RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Pantl Nirmala
5	By Ny Ira S	2 hari	NICU	RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
6	By Ny Farida	1 hari	NICU	RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Lavalette



Analisis :

Jumlah rujukan keluar pada bulan November meningkat yaitu 6 rujukan, sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 1, dan bulan September sebanyak 5 rujukan.

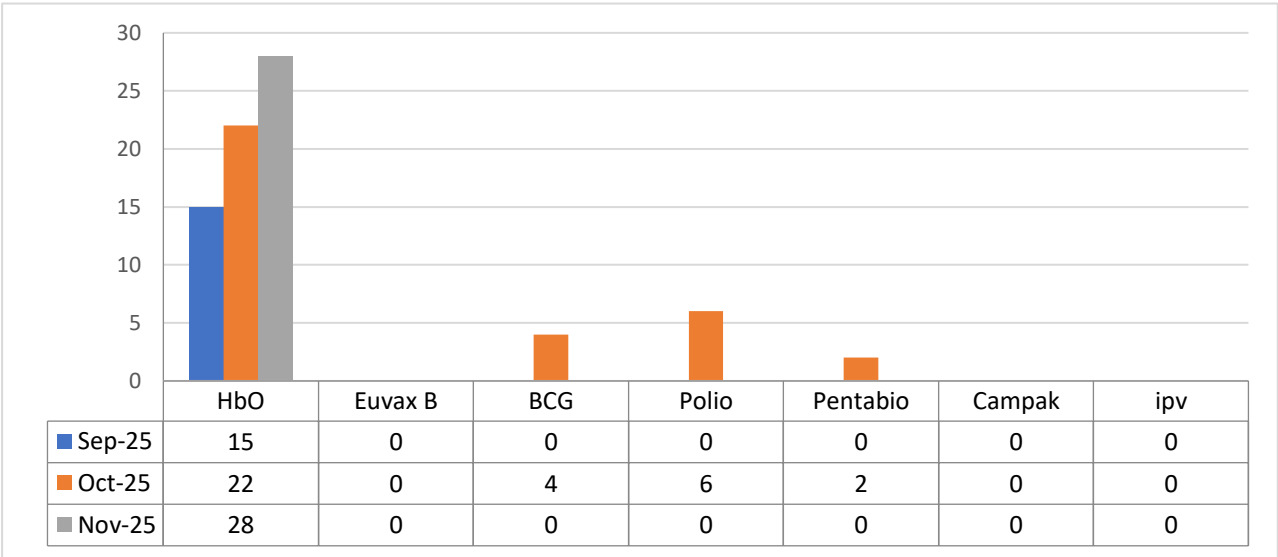
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponpek November 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	HbO	15	22	28
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	0	4	0
3	Polio	0	6	0
4	Pentabio	0	2	0
5	Campak	0	0	0
6	IPV	0	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2025



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode November 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan November sebanyak 28 bayi, sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 22 bayi, dan September Sebanyak 15 bayi. Hal ini dikarenakan minimnya ketidakterseidanya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan November dan 2 bulan sebelumnya.
4. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan November dan 2 bulan sebelumnya
5. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Campak bulan November dan 2 bulan sebelumnya
6. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan November dan September, sedangkan bulan Oktober sebanyak 6 bayi
7. Tidan ada bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan November dan September, sedangkan pada bulan Oktober ada 2 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

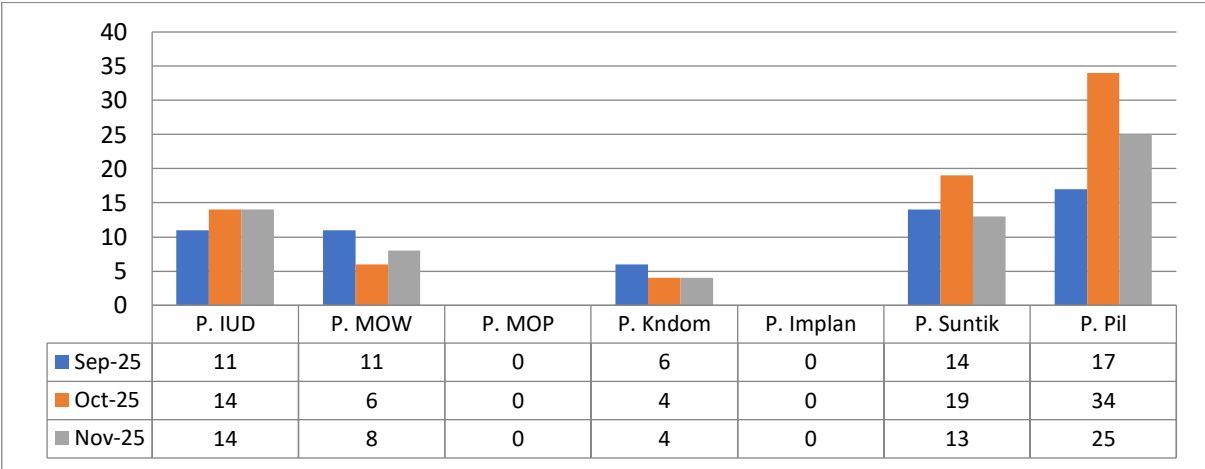
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek November 2025

NO	JENIS	JUMLAH PASANG		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	IUD	11	14	14
2	MOW	11	6	8
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	6	4	4
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	14	19	13
7	Pil	17	34	25

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2025



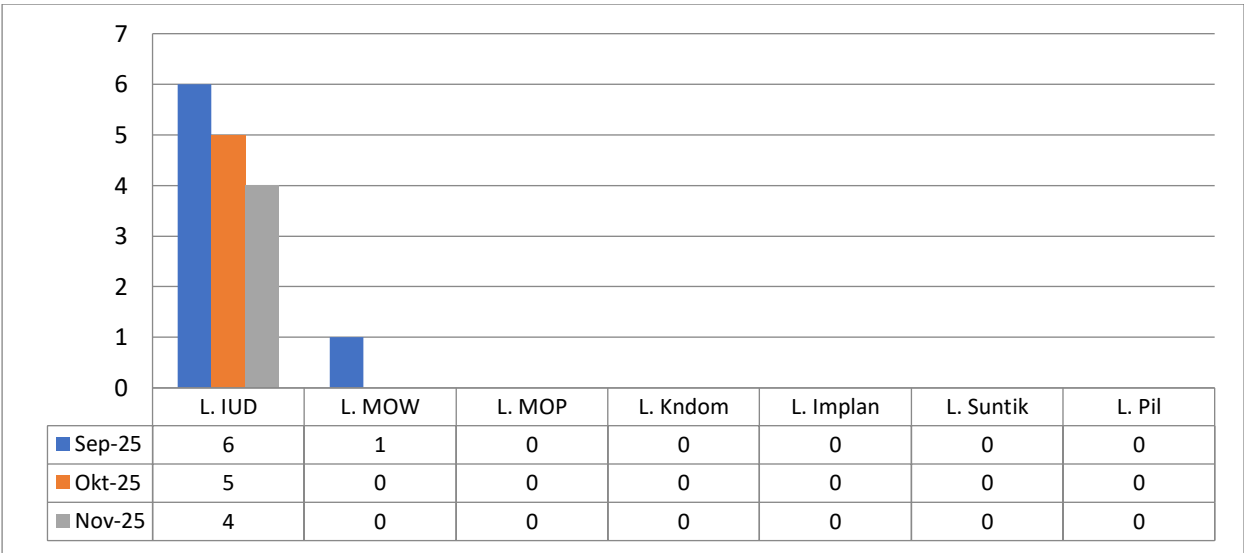
Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan November dan Oktober 2025 sama, yaitu sebanyak 14 akseptor yang terdiri dari 11 akseptor IUD Nova T dan 3 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan November 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 8 pasien, sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 6 orang dan bulan September sebanyak 11 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan November dan Oktober sama yaitu 4, sedangkan pada bulan September sebanyak 6 pengguna.
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan november menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 25 pengguna, sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 34 pengguna, dan bulan September sebanyak 17 pengguna.
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan November sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 13 pengguna, sedangkan bulan September sebanyak 14 pengguna.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

Pelayanan Pelepasan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2025

NO	JENIS	JUMLAH LEPAS		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	IUD	6	5	4
2	MOW	1	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0



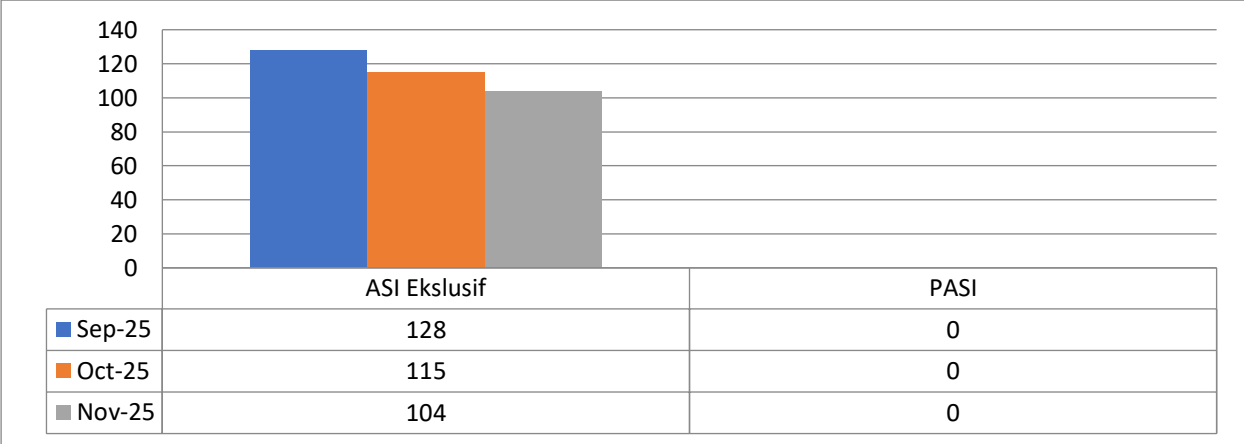
- Analisis :**
1. Pelepasan KB IUD pada bulan November menurun yaitu 4 Akseptor, sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 5 akseptor, dan bulan 10September 6 Akseptor.
 2. Pelepasan KB Implan pada bulan Oktober dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif November 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	Asi eksklusif	128	115	104
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan November 2025



Analisis :

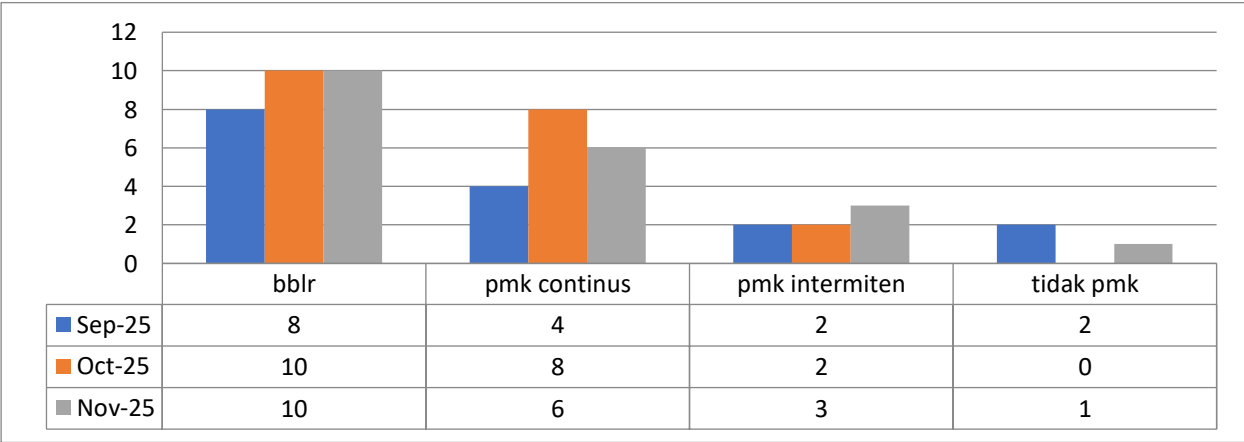
- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan November menurun yaitu 104 bayi, sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 115 bayi, dan September sebanyak 128 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2. Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan Oktober dan 2 bulan sebelumnya. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Oktober 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	Bayi BBLR	8	10	10
2	PMK continuos	4	8	6
3	PMK Intermiten	2	2	3
4	Tidak PMK	2	0	1



Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada
November 2025

Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Ada 3 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan November, sedangkan pada bulan Oktober dan September ada 2. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan November sebanyak 6 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil, sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 8 bayi, dan September sebanyak 4 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada.
- 4. Ada 1 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan November, sedangkan pada bulan Oktober tidak ada dan bulan September sebanyak 2 bayi.

Rencana dan Tindak Lanjut

Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN			KET
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1.	Pemberian Masker pada Pasien Suspek TB/ Non TB	0	0		
2	Pemberian Masker pada Keluarga TB+	2	0		
3	Pemberian masker Pasien TB+ yang lupa membawa Masker/Perilaku tidak berubah	2	0		

Evaluasi :

- 1. Pada bulan Oktober 2025 terdapat 4 pasien yang diberikan masker
- 2. Pada bulan November 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 3. Pada bulan Desember 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker

Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Bulan November 2025

NO	PELAKSANAAN	USIA	PX MANTOUX	TCM BACTERIOLOGIS	FOTO X RAY	HASIL PA
1.	06/11/2025	66th	-	Negatif	Positif	-
2	10/11/2025	1th	Positif	-	Positif	-
3	11/11/2025	20th	-	Negatif	Negatif	Positif
4	12/11/2025	2th	Positif	-	Positif	-
5	14/11/2025	60th	-	Negatif	Negatif	Positif
6	14/11/2025	26th	-	Negatif	Negatif	Positif
7	20/11/2025	73th	-	Positif	Positif	-

8	20/11/2025	6th	Positif	-	Positif	-
9	22/11/2025	28th	-	Negatif	Negatif Kontak erat pasien TB + HIV +	-
10	26/11/2025	29th	-	Positif	Positif	-
11	27/11/2025	29th	-	Negatif	Positif	-
	Total		3	2	7	3

Analisis :

1. Pada bulan Oktober 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 40 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 12 pasien dan pasien negatif sejumlah 28 pasien
2. Pada bulan November 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 43 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 11 pasien dan pasien negative 32 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	UNIT	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Poli Paru	8		
2	Poli Bedah		2	
3	Poli Saraf		1	
4	Poli Anak		3	
5	Irna 2C			
6	ICU	1		
7	IGD			
8	Irna 2A			
9	Irna 3C anak			
10	Irna 3A			
11	Irna 4A			
12	Maternitas 4C			
13	Irna 5C	3	5	
14	Irna 6A			
15	Irna 7A			
16	Irna 8A			
	Total			

Analisis :

1. Pada bulan Oktober 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 40 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 12 pasien dan pasien negatif sejumlah 28 pasien
2. Pada bulan November 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 43 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 11 pasien dan pasien negative 32 pasien
3. Pada bulan Desember 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN			JUMLAH TOTAL PASIEN TB
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	42	47		
2	Pasien RFC (OAT Protolan)	5	3		
3	Pasien RFT	12	11		

Analisis:

1. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC di bulan Oktober mencapai 42 pasien, di bulan November 47 pasien, dan di bulan Desember 0 pasien.
2. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFC di bulan Oktober 5 pasien, di bulan November 0 pasien dan di bulan Desember 0 pasien.
3. Jumlah keseluruhan kunjungandi poli pasien RFT di bulan Oktober 12 pasien, di bulan November 0 pasien dan di bulan Desember 0 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	12	11	

Analisis :

Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pemberian imunisasi BCG	4	0	0

Evakuasi :

1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 4 pasien yang diimunisasi pada bulan Oktober
2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan November

- Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan
Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Desember

Rencana dan Tindak Lanjut :

- Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan November 2025

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Tn. S	V		
		Ny. W	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Tn. B	V		
		Ny. N	V		
		Ny. V	V		
		Tn. H	V		
		Tn. C	V		
3	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed	An. Z	V		
		An. A	V		
		An. T	V		
4	dr. Akhmad Syahrir.Sp.S	Tn. M	V		

Analisis :

Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		Oktober	November	Desember
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker N95	100%	100%	
2	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker bedah	100%	100%	
3	Kepatuhan Staf menggunakan APD Gaun/Skort	100%	100%	

Analisis:

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

No	Penempatan Paien TB	Jumlah Pasien		
		Oktober	November	Desember
1.	Penempatan pasien TB IGD	100%	100%	
2	Penempatan pasien TB Poli Paru	100%	100%	
3	Penempatan pasien TB di IRNA 5c	100%	100%	

Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang IGD isolasi untuk di ruang IGD, di Poli TB untuk pasien TB dan Ruang Isolasi 5c untuk Pasien irna isolasi. hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan November 2025

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Okto	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Ny. M	V	-	1	PKM Ardmulyo	pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						
4	Poli Anak	An. A	V	-	1	PKM Singosari	pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A	Tn. M	V	-	1	PKM Pakis	pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total	3					

Analisis :

1. Pada bulan Oktober 2025 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
2. Pada bulan November 2025 terdapat 6 pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit karena pasien dengan

3. Pada bulan Desember 2025 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP karena.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			ED
		Oktober	November	Desember	
1.	OAT Anak	5	4		12/26
2.	OAT Harian Dewasa	15	12		10/26
3.	Ethambutol 250 mg	448	224		02/26
4.	Ethambutol 400 mg	308	308		05/26
5.	Pirazinamid 500 mg	756	756		05/27
6.	Isoniazid 300 mg	1190	1190		02/26
7.	Rimfapicin 450 mg	1470	1370		03/28
8.	Rimfapicin 300 mg	0	0		0

Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

No	Unit	Jenis TB	Jumlah Pasien					
			Oktober		November		Desember	
			Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
1.		Pasien paru	2	10	3	5		
2.		Pasien Ekstra paru	2	0	0	3		

Evaluasi :
1. Pada bulan Oktober 2025 terdapat 2 pasien ekstra paru dan 12 pasien paru
2. Pada bulan November 2025 terdapat 3 pasien ekstra paru dan 8 pasien paru
3. Pada bulan Desember 2025 terdapat 0 pasien ekstra paru dan 0 pasien paru

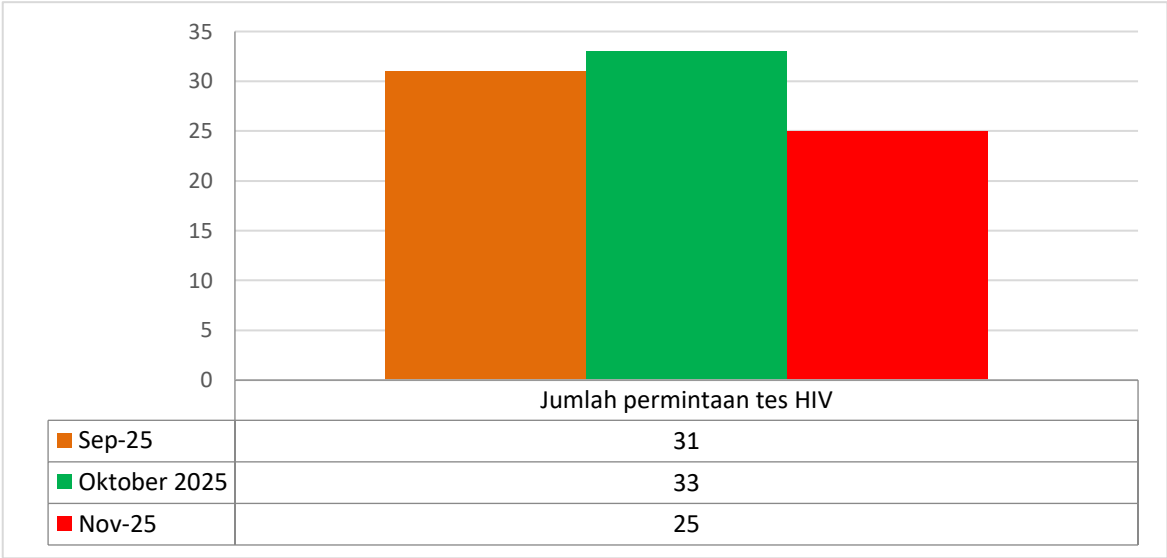
Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	Permintaan Test HIV	31	33	25

**Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan November 2025**



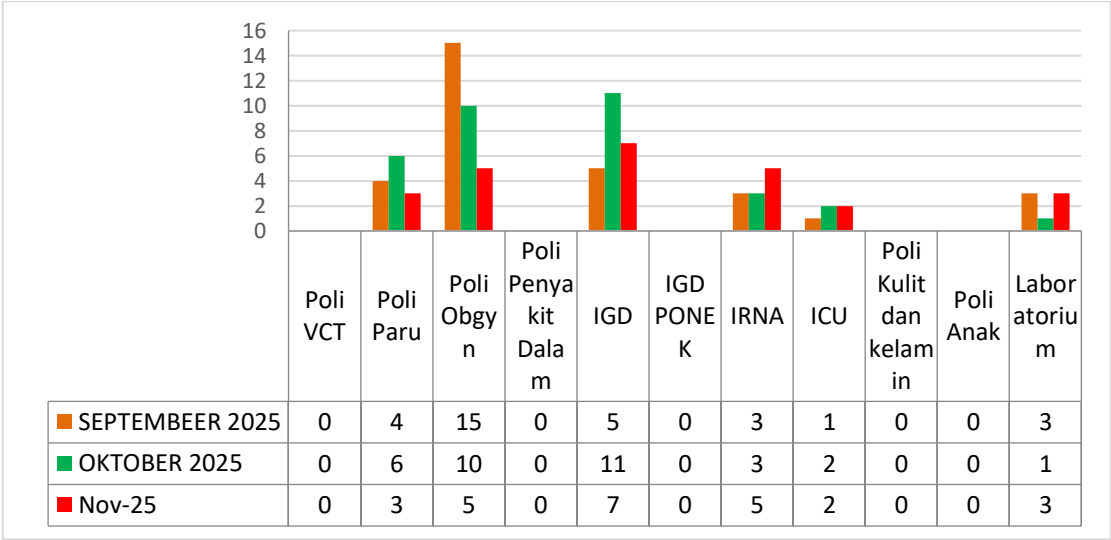
Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan September 2025 sebanyak 31 pasien. pada bulan Oktober 2025 sebanyak 33 pasien Sedangkan pada bulan November 2025 sebanyak 25 pasien
 Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
 Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.56 Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	4	6	3
3	Poli Obgyn	15	10	5
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	5	11	7
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	3	3	5
8	ICU	1	2	2
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	3	1	3

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan November 2025



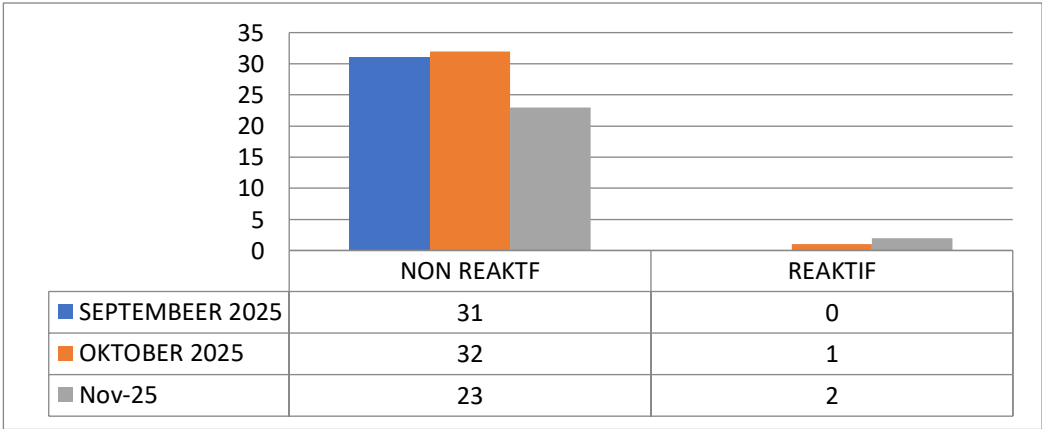
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan Agustus 2025 sebanyak 15 pasien pada bulan September 2025 sebanyak 15 pasien. Sedangkan pada bulan Oktober 2025 sebanyak 10 pasien.
Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	Non Reaktif	31	32	23
2	Reaktif	0	1	2

Grafik Status HIV November 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan September 2025 tidak terdapat pasien dengan HIV reaktif pada bulan Oktober 2025 sebanyak 1 pasien Sedangkan pada bulan November 2025 sebanyak 2 pasien dari IGD dan rawat inap

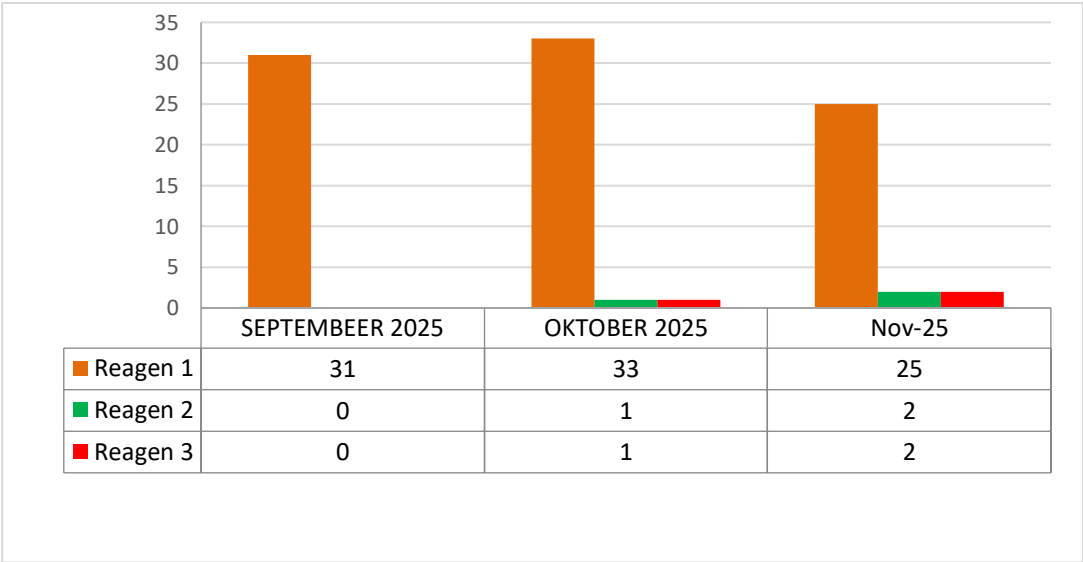
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.57 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	Reagen 1	31	33	25
2	Reagen 2	0	1	2
3	Reagen 3	0	1	2

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen November 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Agustus 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 2 pasien. pada bulan September 2025 hanya memakai reagen 1 dengan jumlah 31 pasien Sedangkan Pada bulan Oktober 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien

Rencana Tindak Lanjut :

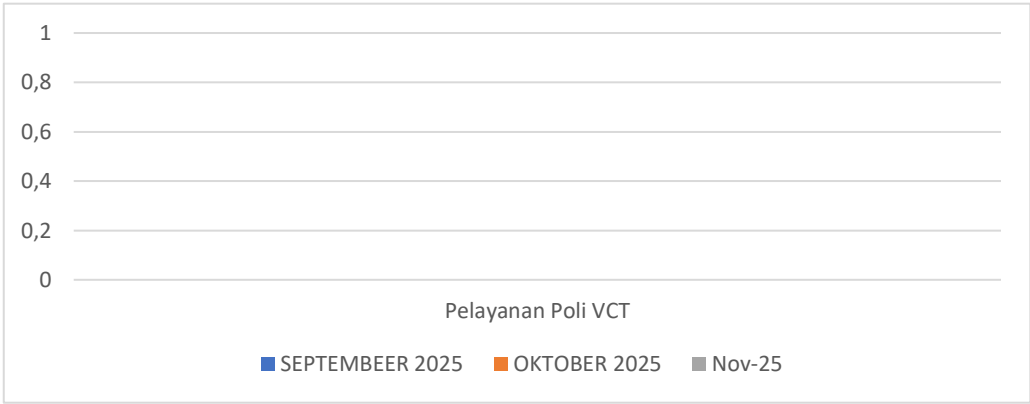
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.

Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.7.58 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT November 2025



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

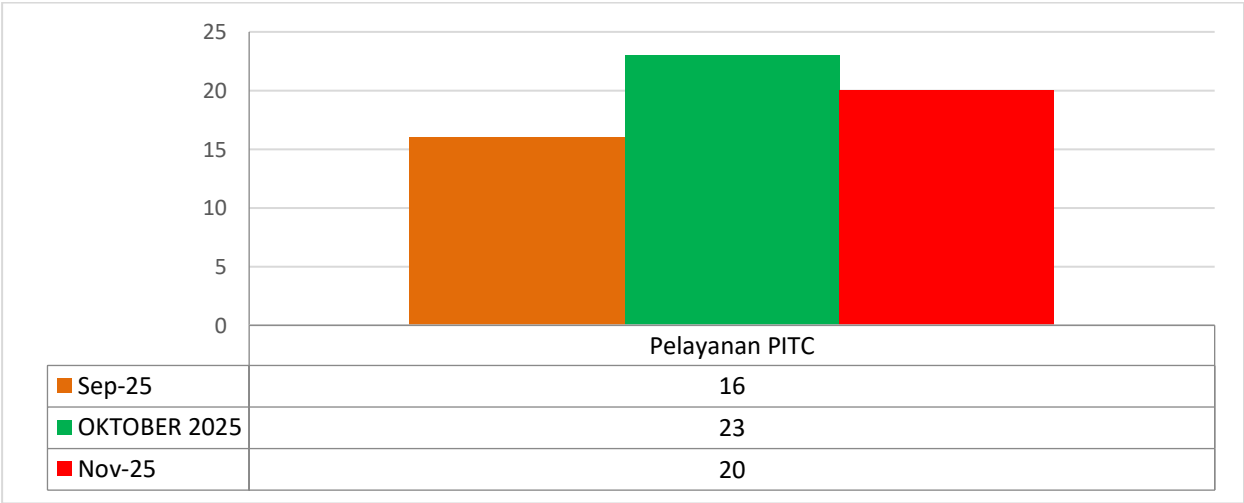
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.7.59 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	Pelayanan PITC	16	23	20

Grafik Pelayanan PITC November 2025



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan pada bulan September 2025

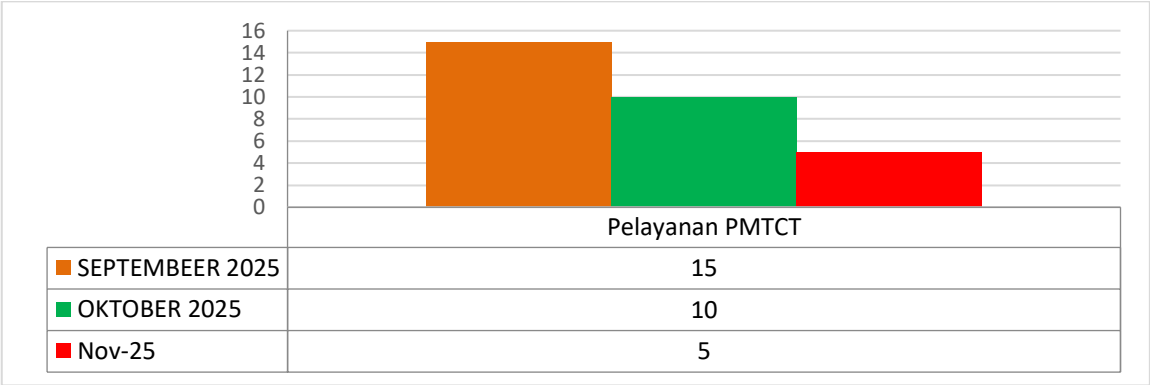
sebanyak 16 pasien pada bulan oktober 2025 sebanyak 23 pasien Sedangkan pada bulan November 2025 sebanyak 20 pasien
Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukkan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.7.60 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	Pelayanan PMTCT	15	10	5

Grafik Pelayanan PMTCT November 2025



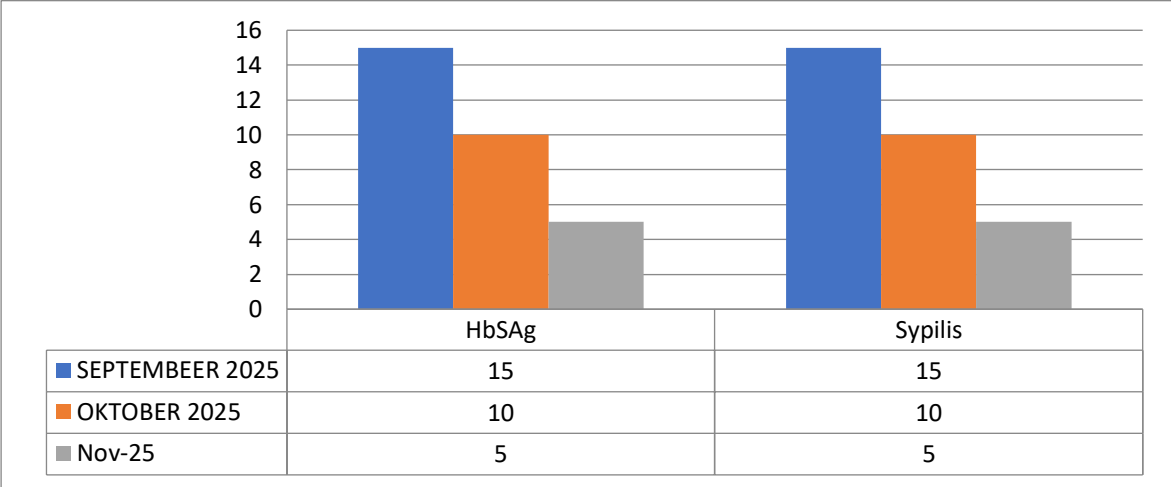
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan September 2025 sebanyak 15 pasien. pada bulan Oktober 2025 sebanyak 10 pasien Sedangkan pada bulan November sebanyak 5 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut :
Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.7.61 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	HbSAg	15	10	5
2	Sypilis	15	10	5

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
November 2025



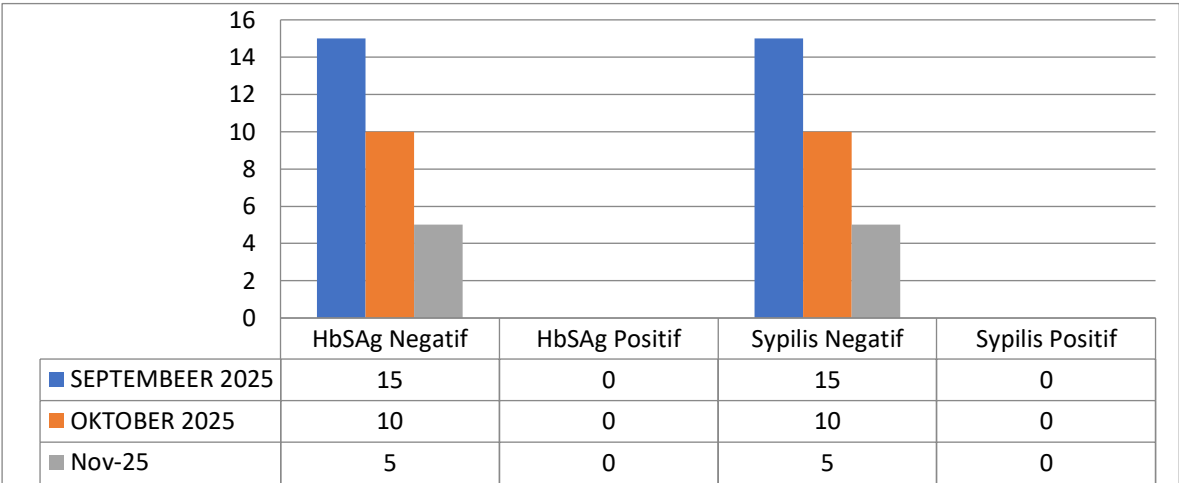
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan pada bulan September 2025 sebanyak 15 pasien. pada bulan Oktober 2025 sebanyak 10 pasien Sedangkan Pada bulan November sebanyak 5 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.62 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	HbSAg			
	Negatif	15	10	5
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	15	10	5
	Positif	0	0	0

**Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
November 2025**



Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan September, Oktober dan November 2025 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif.

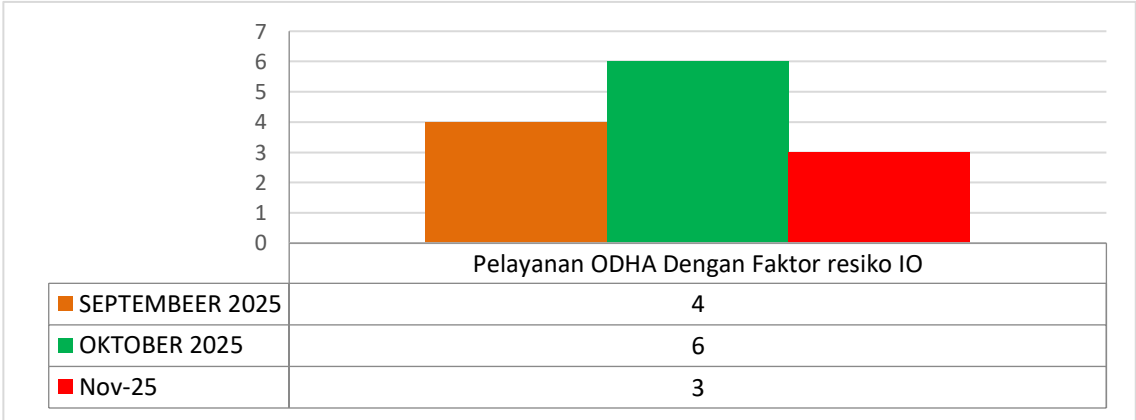
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
 Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Sypilis
 Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.7.63 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	4	6	3

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO November 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. pada bulan September 2025 sebanyak 4 pasien. pada bulan Oktober 2025 sebanyak 6 pasien. Sedangkan Pada bulan November 2025 sebanyak 3 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

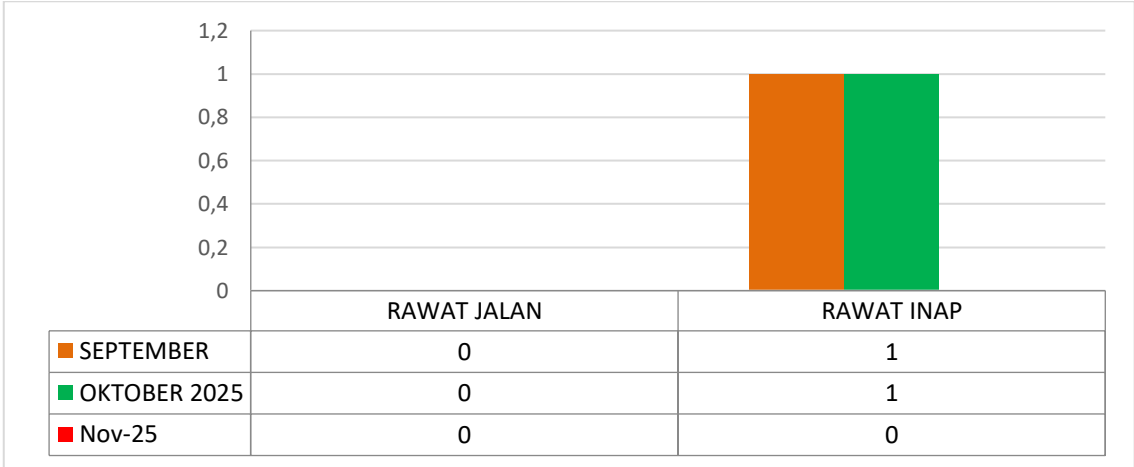
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.7.64 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
1	Rawat Jalan	0	0	0
2	Rawat Inap	1	1	0

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS November 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan September 2025 sebanyak 1 pasien yang dirujuk dari rawat inap pada bulan oktober 2025 sebanyak 1 pasien yang dirujuk dari rawat inap Sedangkan pada bulan November 2025 tidak ada pasien yang dilakukan rujuk baik dari rawat inap maupun rawat jalan. Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

1.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting November 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita	IRNA Anak	IRJA	1	1	1

	2. Pembagian PMBA					
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

	mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia					
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

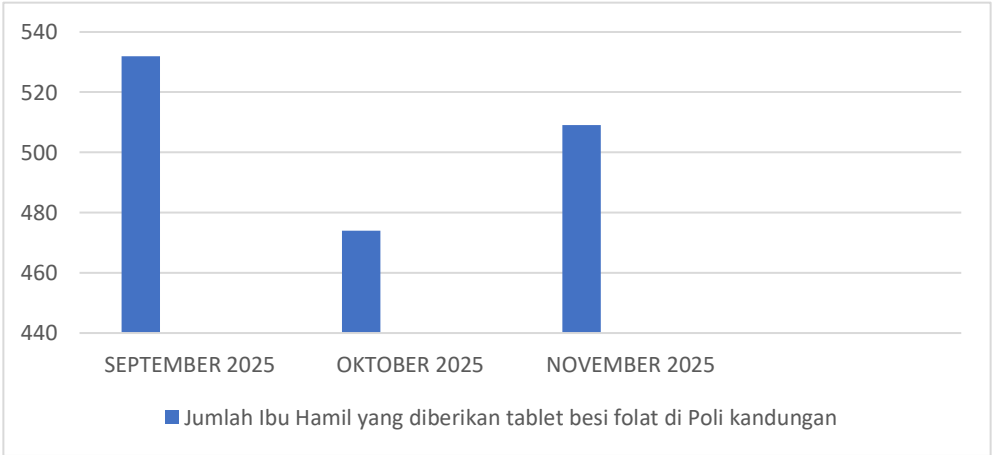
Analisis :
Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	532	474	509

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil November 2025



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat naik dari sebelumnya 474 di bulan Oktober menjadi 509 pada bulan November yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

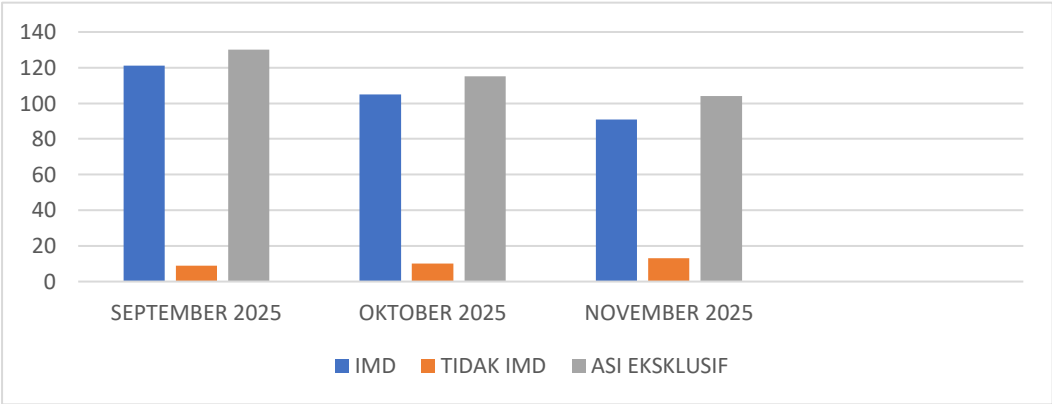
- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	IMD	121	105	91
2	Tidak IMD	9	10	13
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	130	115	104

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif November 2025



- Analisis :**
1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan November sebanyak 91 bayi.
 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan November 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 13 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif menurun pada bulan November 2025 yaitu sebanyak 104 pasien.

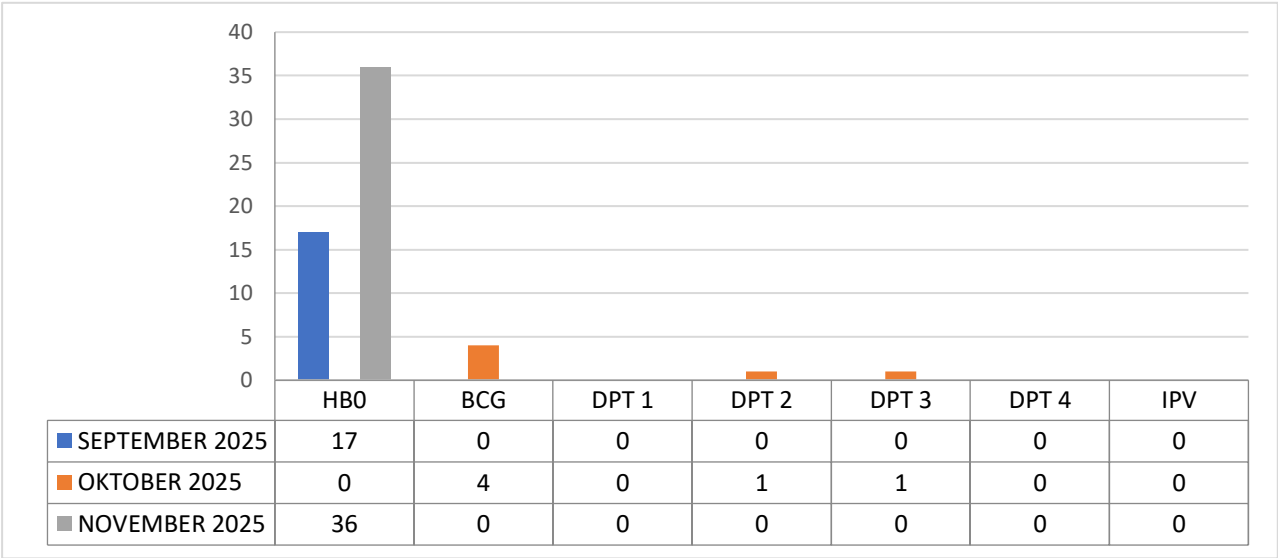
Rencana Tindak Lanjut:
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	BCG	17	0	36
2	DPT 1	0	4	0
3	DPT 2	0	0	0
4	DPT 3	0	1	0
5	DPT 4	0	1	0
5	IPV	0	0	0
6	Campak	0	0	0
7	Polio Oral	0	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada November 2025



Analisis:

Imunisasi pemerintah pada bulan November di Prima Husada Malang hanya HB0 sebanyak 36 bayi

Rencana Tindak Lanjut :

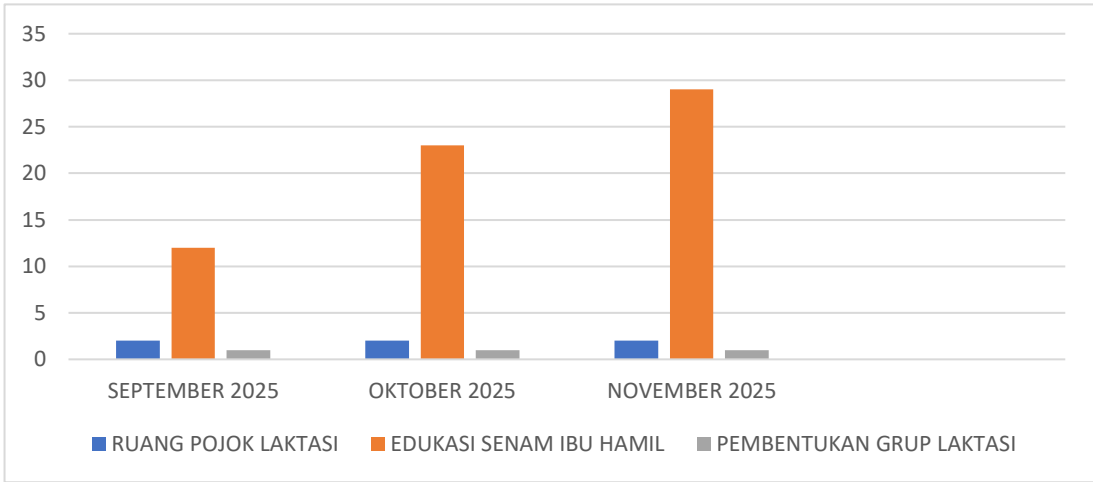
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	12	23	29
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada November 2025



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan November edukasi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan Gizi Seimbang sebanyak 13 peserta penyuluhan dilakukan di poli obgyn. Dan 16 peserta penyuluhan dilakukan di senam ibu hamil

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Rujukan Masuk				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Rujukan Keluar				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan November 2025



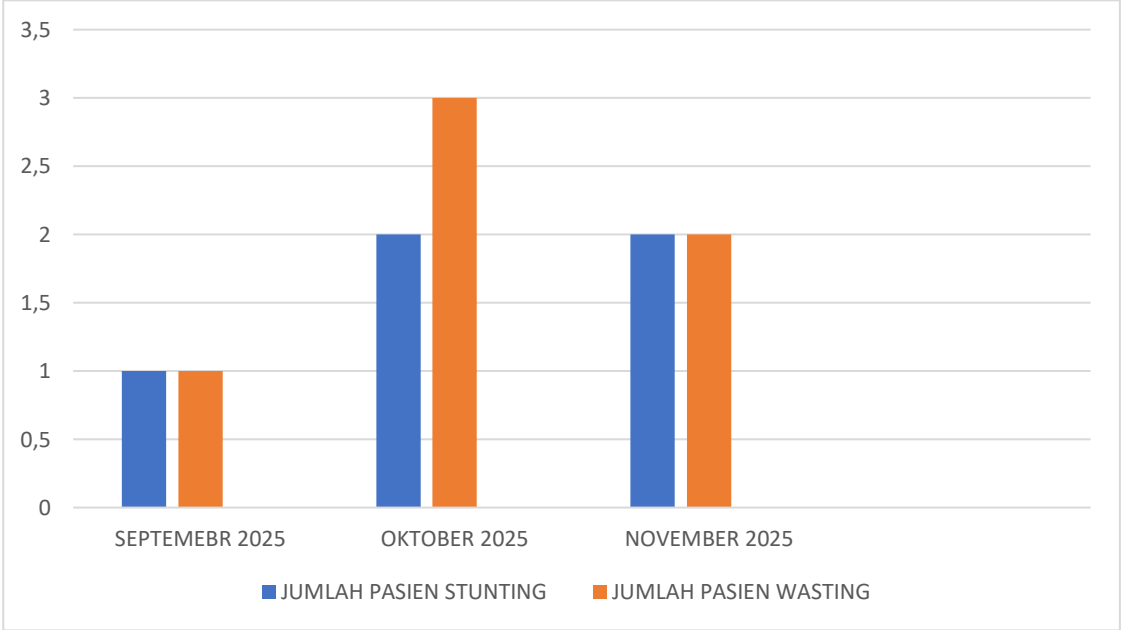
Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS pada bulan November

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting .

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan
Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	SEPTEMBER 2025	OKTOBER 2025	NOVEMBER 2025
Jumlah Pasien Stunting	1	2	2
Jumlah Pasien Wasting	1	3	2

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Pada bulan November 2025 ditemukan 2 pasien berat badan dan tinggi badan tidak sesuai umur

1. Balita atas nama Kinasih Tita Tasbiha, BB: 10,4 kg TB: 91,5 cm (balita BB sangat kurang, pendek dan gizi kurang). Balita memiliki riwayat penyakit TB. Kebiasaan makan pasien masih sulit. Karena terdapat faktor riwayat sakit TB, maka keluarga harus mengejar berat badan pasien dengan pemberian makanan bergizi dan tinggi protein.
2. Balita atas nama Ahmad Hafi Badali, BB: 8.7 kg TB: 79 cm (BB sangat kurang, sangat pendek, dan gizi kurang). Kebiasaan makan pasien 3 kali sehari namun hanya beberapa sendok tidak sampai habis, pasien suka makan cemilan namun tidak suka makan nasi. Sebaiknya pemberian cemilan setelah makan, sehingga balita tidak kekenyangan saat makan utama.

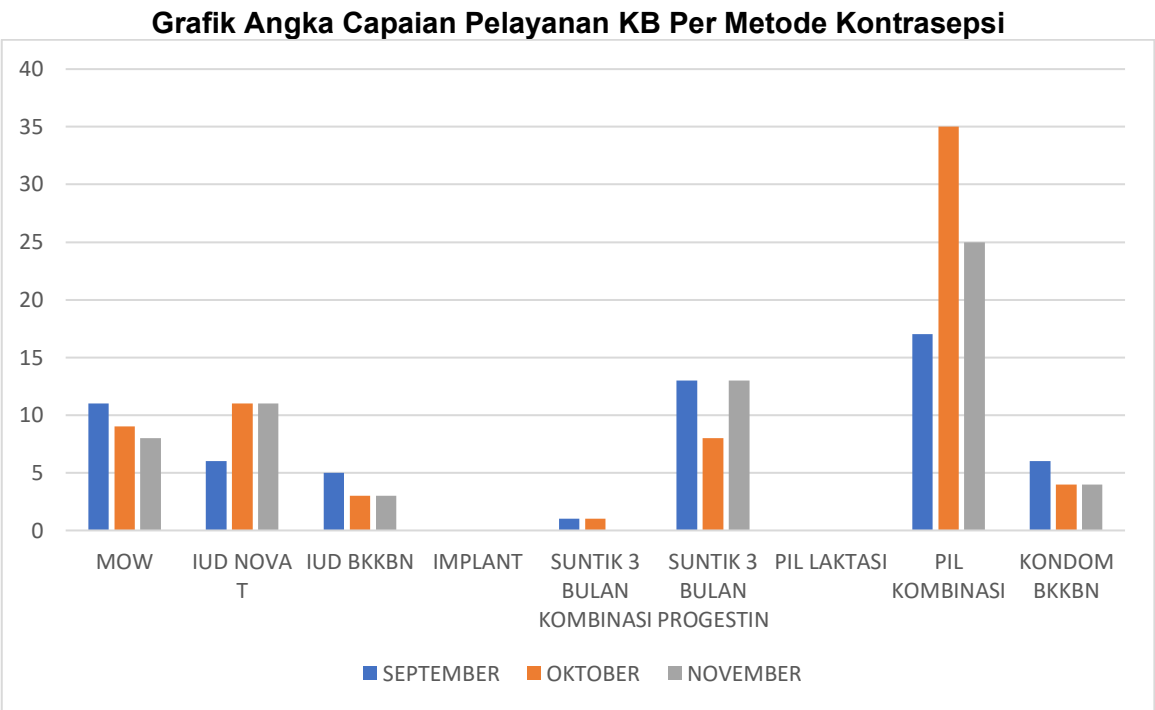
Rencana Tindak Lanjut :

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada lebih gencar dalam melakukan pengukuran dan pelaporan pasien anak baik di rawat inap maupun rawat jalan

3.1.2.5 KBRS

3.7.65 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	MOW	11	9	8
2	IUD Nova T	6	11	11
3	IUD BKKBN	5	3	3
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	1	1	0
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	13	18	13
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	17	35	25
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	6	4	4



- Evaluasi :**
1. Peserta MOW pada bulan September (11) dan turun pada Oktober (9) pada November turun (8)
 2. Peserta IUD Nova T pada bulan September turun (6) Oktober naik (11) pada November tatap 11
 3. Peserta IUD BKKBN pada bulan September naik (5) Oktober turun (3) November tetap (3)
 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan September (1) dan Oktober tetap (1) November turun (0)
 5. Peserta KB suntik progestin pada bulan September turun (13) dan Oktober naik (18) November turun (13)
 6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan September turun (17) Oktober naik (35) November turun (25) karena stok habis
 7. Peserta KB Kondom pada bulan September naik (6) Oktober turun (4) November tetap (4)

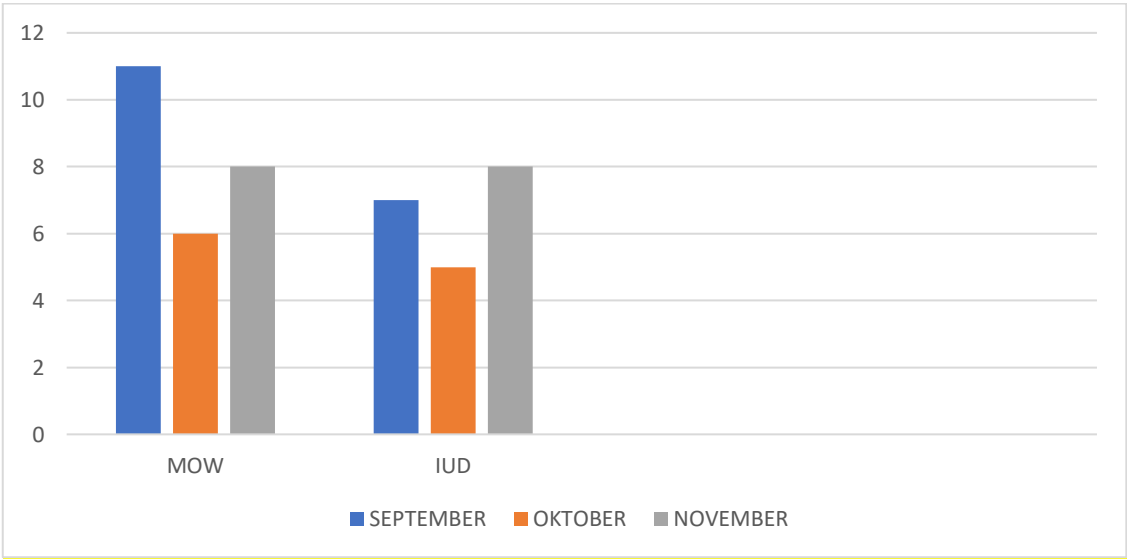
- Analisis :**
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

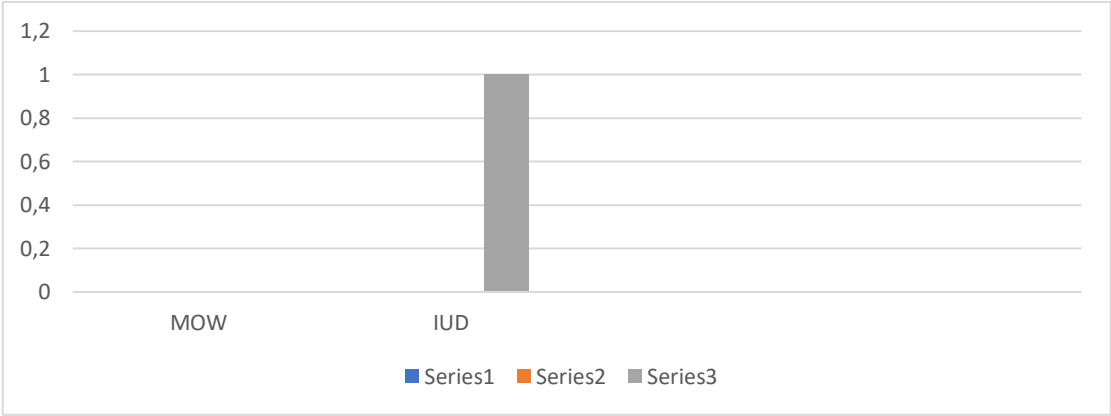
Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran				
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	MOW	11	6	8
2	IUD	7	5	8

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2025	BULAN OKTOBER 2025	BULAN NOVEMBER 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	1

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan September-Oktober-November meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan September-Oktober-November menetap.

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2025

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan September 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Choirul Anam	L/84	dr. Edi, Sp. U	236329	BPH	01/09/2025	03/09/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
2	Samsul Arifin	L/55	dr. Ardhan, Sp. Pd	221994	DM + CKD	01/09/2025	04/09/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	2	0,3	6,67
3	Alifah	P/41	dr. Heri, Sp.Pd	200272	DM 2 + ISK	04/09/2025	09/09/2025	6	Asam Pipemidat	2	2x0,4	2,4	0,8	3
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
4	Ani Andarwati	P/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	144918	TF	08/09/2025	10/09/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
5	Nimas Noviantika	P/25	dr. Humaira, Sp. OG	182763	Abortus	09/09/2025	10/09/2025	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicilin		3x0,5	1,5	1,5	1
6	Siti Meilina Dwi	P/24	dr. Humaira, Sp. OG	232752	Oligohidramnion	12/09/2025	14/09/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Hermanto	L/37	dr. Zaki, Sp.B	237018	Peritonitis akut	14/09/2025	16/09/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
8	Didi Supriadi	L/82	dr. Andy, Sp. P	237027	Pneumoni PSI	14/09/2025	17/09/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
9	Irina Kusuma P	P/24	dr. Humaira, Sp. OG	010721	KPD	16/09/2025	18/09/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
10	Hafidah	P/68	dr. Aji, Sp. Pd	237124	Cholelithiasis	16/09/2025	21/09/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Cefotaxime		3x1	10	4	2,5
11	Heru Suryo	L/56	dr. Pradana, Sp. U	123508	Hydrouretronefrosis is osis	17/09/2025	19/09/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5

12	Amalia Iffah	P/38	dr. Anton, Sp.B	204588	Appendisitis akut	17/09/2025	20/09/2025	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
13	Bheny Murtopo	L/54	dr. Yoga, Sp.JP	237325	ADHF + Sepsis	20/09/2025	25/08/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Levofloxacin inf		1x0,5	1,5	0,3	5
14	Tatik Suprihatin	P/56	dr. Andy, Sp. P	090921	Pneumoni	21/09/2025	23/09/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
15	Rasit	L/61	dr. Heri, Sp.Pd	237275	Abses Hepar	22/09/2025	25/09/2025	4	Ceftraixone	2	2x1	5	2	2,5
									Metronidazol e inf		2x0,5	2,5	1,5	1,67
16	Melati Mandasari	P/39	dr. Ardhi, Sp.Pd	237445	ISK	23/09/2025	27/09/2025	4	Asam Pipemidat	2	2x0,4	1,6	0,8	2
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
17	Puput Pratiwi	P/18	dr. Aji, Sp. Pd	061672	Colic abdomen	23/09/2025	27/09/2025	5	Goforan (Cefotaxime)	1	2x1	8	4	2
18	Wahyundari	P/47	dr. Zaki, Sp.B	099504	Hernia Umbilical	23/09/2025	25/09/2025	3	Cefoperazon e	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
19	Zainul Bahri	L/53	dr. Anton, Sp.B	156453	Gangrene Necrotic Diabeticum	26/09/2025	28/09/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1/5
									Metronidazol e po		3x0,25	1,5	2	7,5
20	Pudji Rahaju	P/72	dr. Oka, Sp.OT	236404	CF Distal	26/09/2025	28/09/2025	3	Cefoperazon e	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Oktober 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Asri Putri Dwi	P/27	dr. Aida, Sp.OG	068706	KPD	30/09/2025	02/10/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
2	Rizky Emiliyatus S	P/30	dr. Humaira, Sp.OG	227436	SC Eracs	02/10/2025	04/10/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Rofiatun Nabila	P/21	dr. Humaira, Sp.OG	238031	Blighted ovum	06/10/2025	07/10/2025		Ceftrizxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicilin		3x0,5	1,5	1,5	1
4	Mila Dwi Pratiwi	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	225267	Post Partum + Granuloma Vagina	07/10/2025	09/10/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
5	Apriliani F	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	234430	Oligohidramnion	08/10/2025	11/10/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
6	Rosa Faradianti	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	236389	KPD	10/10/2025	13/10/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
7	Ismi Tri Utari	P/60	dr. Humaira, Sp.OG	151336	Mioma Uteri	15/10/2025	18/10/2025	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
8	Nani Suhartati	P/50	dr. Aida, Sp.OG	237867	Multiple Miomi Uteri	20/10/2025	23/10/2025	4	Cefazoline	3	1x2	2	2	1
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
									Metronidazole po		3x0,5	1,5	2	7,5
9	Inayah Kurniati	P/37	dr. Humaira, Sp.OG	84320	Abortion	22/10/2025	23/10/2025	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1,5	1,5	1

10	Anis Karunia	P/25	dr. Aida, Sp.OG	95738	SC + MOW	25/10/2025	27/10/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
11	Imam Hanafi	L/55	dr. Anton, Sp.B	238456	Selulitis dd Necrotizing Fascitis Cruris	12/10/2025	14/10/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
12	Sulastri	P/66	dr. Edi, Sp.B	237272	Retensio urine dd cystitis	13/10/2025	15/10/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftizoxime		2x1	3	4	0,75
13	Nur Jamil	L/55	dr. Oka, Sp.OT	238642	Osteomyeltis pedis	15/10/2025	17/10/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
14	Mujiono	L/62	dr. Zaki, Sp.B	238637	Hernia Scrotalis	15/10/2025	17/10/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Sanali	L/78	dr. Edi, Sp. U	206687	BPH	20/10/2025	22/10/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Supeno Hadi	L/64	dr. Anton, Sp.B	156453	Gangrene Necrotic Diabeticum Manus D	19/10/2025	21/10/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,25	2	0,625
17	Fitroir Arif	L/25	dr. Anton, Sp.B	238909	Hydrocel testis	24/10/2025	26/10/2025	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
18	Warni	P/73	dr. Zaki, Sp.B	237911	Appendicitis akut	02/10/2025	05/10/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
19	Widji Asrini	P/68	dr. Andi, Sp.B	237911	Ulkus decubitus	09/10/2025	12/10/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
20	Sumirah	P/91	dr.Oka, Sp.OT	238408	CF distal radius S	11/10/2025	13/10/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
21	Djuma'ijah	P/90	dr. Andy, Sp. P	224262	COPD + Pneumoni	05/10/2025	07/10/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1			
22	Hendrik Prasetiawan	L/48	dr. Elvi, Sp.P	238132	Pneumonia, Bronkitis Kronis	06/10/2025	09/10/2025	2	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Cefoperazone		2x1	3	4	2,5

23	Winarso	L/60	dr. Andy, Sp. P	137124	COPD Ae + Pneumoni Psi	06/10/2025	09/10/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
24	Devan Tri Angga	L/18	Dr. Aji, Sp. Pd	238444	OF, Susp TF	11/10/2025	13/10/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
25	Sumisni	P/59	dr. Zora, Sp. Pd	238597	OF Susp DF + GEA	14/10/2025	16/10/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
26	Kiky Dwi Ratnasari	P/33	Dr. Aji, Sp. Pd	139241	Ruq pain dt cholelelitis	13/10/2025	18/10/2025	6	Ceftizoxime	1	2x1	7	2	3,5
27	Utami	P/66	Dr. Ardhi, Sp. Pd	238607	GEA + Diarrhoea	18/10/2025	19/10/2025	2	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
28	Hery Sampurno	L/73	dr. Zora, Sp. Pd	062693	ISK Colic Abdomen	19/10/2025	22/10/2025	4	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
29	Ruba'inah	P/65	dr. Ardhan, Sp. Pd	238794	DM Hiperkalemi + Edema Paru+ Pneumonia	19/10/2025	22/10/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	2	0,3	6,67
30	Agus Handoyo	L/50	Dr. Yoga, Sp. Jp	131012	ADHF	21/10/2025	24/10/2025	4	Ceftrizone	1	2x1	6	2	3

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan November 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Nabillah Hany	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	069410	Post SC dg BSC	02/11/2025	05/11/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
2	Siti Maslikah	P/48	dr. Aida, Sp.OG	239380	Post Histerektomi A/I Adenomyosis	02/11/2025	05/11/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Wulan Safitri M	P/31	dr. Humaira, Sp. OG	228851	Post partum	03/11/2025	04/11/2025	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
4	Jumrotul M	P/32	dr. Humaira, Sp.OG	238186	KPD	05/11/2025	07/11/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
5	Dita Dwi Lestari	P/26	dr. Humaira, Sp.OG	143986	Post Op Curet A/I Menometroragia	06/11/2025	07/11/2025	2	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Amoxicillin		3x0,5	1	2	0,5

6	Rina Widya R	P/32	dr. Humaira, Sp.OG	166082	Post Op Myomektomi	13/11/2025	16/11/2025	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
7	Intan Asih W	P/21	dr. Humaira, Sp.OG	239778	Post SC A/I Oligohidramnion	15/11/2025	17/11/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
8	Wiwik Handayani	P/41	dr. Humaira, Sp.OG	239954	Post Histerektomi A/I Adenomyosis	17/11/2025	20/11/2025	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
9	Fami Wijayanti	P/40	dr. Humaira, Sp.OG	221212	SC Eracs + Riwayat PE	20/11/2025	22/11/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
10	Diana Roosita Sari	P/30	dr. Aida, Sp.OG	239572	KPD	25/11/2025	28/11/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
11	Umi Kulsum	P/48	dr. Zaki, Sp.B	239289	CA Mamae Dextra Post Open Biopsi	04/11/2025	05/11/2025	2	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
12	Tan Yusuf Tanzil	L/74	dr. Edi, Sp. U	235014	BPH	08/11/2025	10/11/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
13	Taseman	L/71	dr. Andi, Sp.B	196464	Necrotizing abses colli	11/11/2025	13/11/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
14	Choyrul Anam	L/23	dr.Oka, Sp.OT	240016	CF digiti V Manus Dextra	12/11/2025	14/11/2025	3	Cefazoline	2	1x1	1	3	0,33
									Cefazoline		2x1	3	3	1
15	Sibai	L/63	dr. Pradana, Sp. U	123251	URS Sinitra	13/11/2025	15/11/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Siti Zulaikah	P/47	dr. Anton, Sp.B	185011	Necrotizing Fascitis Pedis + Anemia + AKI dd CKD	15/11/2025	17/11/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1	2	0,5
17	Hariyati	P/54	dr. Zaki, Sp.B	218898	Hemorrhoid gr 4	16/11/2025	18/11/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
18	Mudriyah	P/40	dr. Anton, Sp.B	239919	TU Mamae Post Biopsi	19/11/2025	21/11/2025	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	6	6	1
	I Made Maha I	L/44	dr. Zaki, Sp.B	240462		23/11/2025	25/11/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5

19					Abses intraperitoneum post repair				Ceftriaxone		2x1	2	2	1
20	Rokhmatul M	P/24	dr. Sigit, Sp.BP	240585	CKR 456 + Vulnus Appertum Frontalis S	23/11/2025	25/11/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
21	Windyana	P/23	dr. Zora, Sp. Pd	138015	GEA + Vomiting	14/11/2025	16/11/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
22	Arif Mujiono	P/48	dr. Ardhi, Sp. Pd	086651	GEA	14/11/2025	16/11/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
23	Khoirul Anam	L/50	dr. Farid, Sp. N	222428	CVA Infrak + HT Emergency + Reytensi Sputum	14/11/2025	21/11/2025	8	Ceftriaxone	1	2x1	14	2	7
24	Tuty Khusniah	P/51	dr. Andy, Sp. P	109948	Pneumoni Psi + Asma ae	15/11/2025	18/11/2025	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
25	Chusnah	P/32	dr. Aji, Sp. Pd	188107	Cholelitisias + ISK	15/11/2025	20/11/2025	6	Cefotaxime	1	2x1	10	2	5
26	M Fadlil MZ	L/71	dr. Andy, Sp. P	142289	COPD AE susp Efusi Pleura	17/11/2025	19/11/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
27	Siti Mutmainah	P/60	dr. Aji, Sp.Pd	240505	Bacterial infection + ISK	21/11/2025	23/11/2025	3	Asam Pipemidat	2	2x0,4	2	0,8	2,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
28	Imam Syafii	L/60	dr. Ardhanay, Sp. Pd	216279	Colic abdomen + Cholelitisias	23/11/2025	25/11/2025	3	Cefixime	1	2x0,2	1,2	0,4	3
29	Misnan	L/59	dr. Elvi, Sp. P	178238	COPD + Pneumonia	24/11/2025	26/11/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
30	Ignatius Loyola R	L/78	Dr. Elvi, Sp. P	240708	Pneumoni PSI + ARDS + Efusi Pleura + Sepsis	25/11/2025	26/11/2025	2	Meropenem	1	2x1	2	3	0,67

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan November Tahun 2025

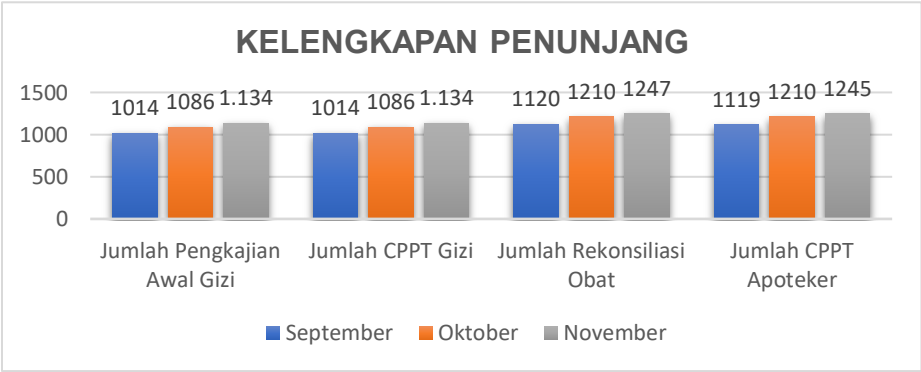
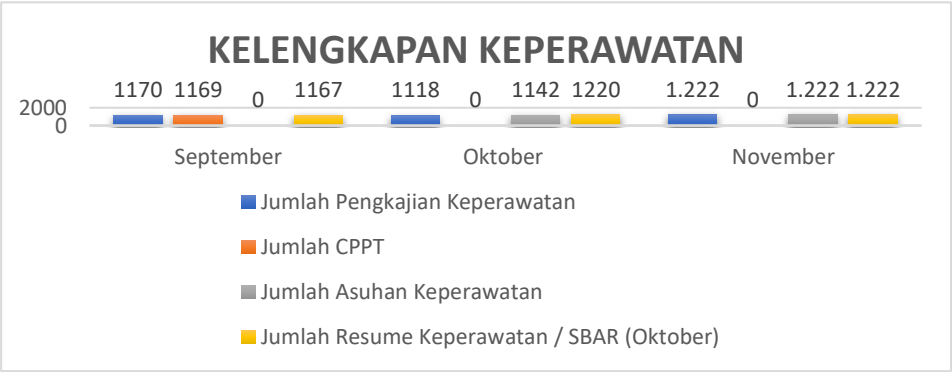
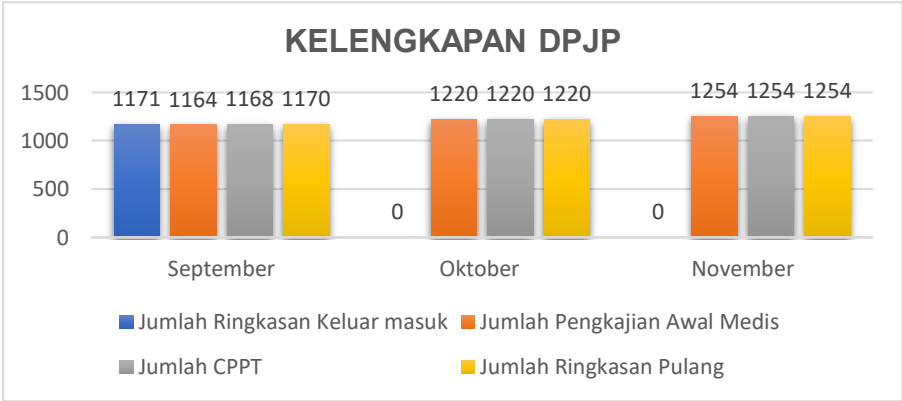
KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28
Juli	1281	99,89	3	0,10	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11
Agustus	1247	97	4	3	1241	99	10	1	1250	100	1	0	1250	100	1	0
September	1171	100	0	0	1164	98,14	7	1,86	1168	99,73	4	0,33	1170	99,84	1	0,16
Oktober	-	-	-	-	1219	99,91	1	0,09	1220	100	0	0	1220	100	0	0
November	-	-	-	-	1241	98,96	13	1,04	1229	98,01	25	1,99	1253	99,92	1	0,08

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR (Oktober)			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20
Juli	1289	100	0	0	1289	100	0	0	-	-	-	-	1289	100	0	0
Agustus	1289	100	0	0	1287	100	0	0	-	-	-	-	1287	100	0	0
September	1170	99,52	1	0,48	1169	99,33	2	0,67	-	-	-	-	1170	99,52	1	0,48
Oktober	1118	92	112	8	-	-	-	-	1142	94	78	6	1220	100	0	0
November	1201	98.28	21	1.72	-	-	-	-	1210	99.02	12	0.98	1222	100	0	0

KELENGKAPAN															
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2
Juli	666	58	563	48	1124	99.65	5	0.35	1269	96.67	1	3.33	1272	96.67	1	3.33
Agustus	1150	100	0	0	1150	100	0	0	1277	100	0	0	1274	100	0	0
September	1014	100	0	0	1014	100	0	0	1120	100	0	0	1119	99.96	1	0.4
Oktober	975	90	111	10	1076	99	10	1	1210	100	0	0	1100	91	110	9
November	918	81	216	19	1132	99.82	2	0.18	1246	99.92	1	0.08	1208	96.87	37	2.97

3.1.1.7 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan November 2025



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi 19% , sebanyak 216 dokumen
- 2. Kelengkapan pengkajian keperawatan 98,28% pada Bulan November 2025.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan November 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.66 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Bor Bedah Plastik Rusak	P	Lakukan identifikasi penyebab kerusakan dikarenakan left time, karena penggunaan dari tahun 2017
		D	Lakukan koordinasi penyebab alat bor tidak bisa karena ada part yang sudah aus dan rusak di sambungan kabelnya sehingga di solatip
		S	Lakukan eksekusi terkait penyebab kerusakan alat, sehingga alat bisa dipakai dengan peminjaman ke PHS sebagai back up
		A	Sudah ada form kerusakan dari IPSRS, pengajuan alat bor plastik (+), follow up pembelian sampai ketersediaan alat ready di IKO
2	Ada dokter anestesi baru dr Denny, SpA di PHM	P	1. Jumat, 14 nov 2025 shift sore (dr denny operasi yang pertama di PHM), TURP, operator dr Pradana, SpU. Pasien sudah di bius SAB, pasien masih gerak dan belum rilex, sehingga di lanjut bius lagi meng. GA. Untuk perdarahannya yang biasanya sedikit, untuk operasi yg ini perdarahannya masif sehingga operator agak kesulitan 2. Jumat, 21 nov 2025, untuk pembiusan memang lebih lama dari dr heru, SpAn, tetapi operasi berjalan lancar dan belum ada yg sampai komplain dari operator
		D	Monitoring dan evaluasi kembali untuk pelayanan dokter anestesi baru
		S	Koordinasi dengan unit IKO dan Kains IKO dr heru, SpAn
		A	Setelah evaluasi 1 bulan, masih belum ada kejadian gagal bius berulang yang menyebabkan operator komplain

3.7.67 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Hand over yang kurang optimal sehingga berpotensi menimbulkan IKP	P	Pasien dr. Fachriy, SpBS harusnya di ruangan pasien posisi head up (kepala diangkat). Tetapi saat operan dari IGD tidak disampaikan ke ruangan sehingga saat di visite, pasien tetap berbaring seperti biasa.
		D	Telusur ke IGD, jika perawat shift sebelumnya terlewat pesan tersebut sehingga tidak dioperkan ke perawat ruangan sehingga advice tidak dilaksanakan
		S	Sosialisasi dan mengingatkan perawat agar lebih teliti dalam menulis lembar transfer, dan melihat kembali advice dpjp by WA untuk memastikan advice sudah dilaksanakan
		A	Monitoring dan evaluasi saat pelaksanaan hand over tiap shift
2	Persiapan USG Abdomen dari IGD kurang maksimal	P	Ada DPJP komplain karena ada pasien susp cholelithiasis hasil USG normal. Kemungkinan saat USG awal, karena persiapannya kurang, bisa jadi empedu nya akan kempes, dan ada yang sampai tertutup makanan atau gas yang ada di gaster sampai usus 12 jari sehingga interpretasinya bisa jadi kesannya normal
		D	Saat di visite dan dilakukan USG ulang oleh dpjp, hasilnya terlihat ada batu empedu
		S	Sudah disampaikan ke Karu IGD untuk review kembali SPO pelaksanaan USG , pasien harus puasa minimal 6-8 jam agar hasil USG lebih optimal
		A	Monitoring dan evaluasi jika ada pasien yang akan diperiksa USG agar persiapannya diperhatikan
3	Masih ditemukan penggunaan resep manual untuk pasien triase hijau	P	Dengan adanya kebijakan pasien IGD bisa didaftar dengan penjamin UMUM, sambil menunggu penjamin fix. Memudahkan perawat untuk input resep agar meminimalisir penggunaan resep manual
		D	Pasien yang menggunakan resep manual adalah pasien yang datang sendiri, pasien KLL rujukan dari ambulance luar, pasien yang tidak membawa kartu identitas sehingga tidak bisa didaftar cepat oleh PDF
		S	Review kembali dan ingatkan perawat agar sesuai SPO
		A	Monitoring dan evaluasi jika ada kejadian penginputan resep yang tidak sesuai
5	Penginputan permintaan radiologi untuk anamnesis kurang sesuai	P	Identifikasi penyebab anamnesis kurang sesuai
		D	Ada 2 kemungkinan, ada kendala atau bug dari program sehingga yang seharusnya anamnese default dan link dengan pengkajian awal, di

			pasien tsb tidak muncul. Kemungkinan kedua adalah human error, karena tidak link, sehingga teman perawat mengetik manual anamnesa dan ada yang kurang sesuai (ketikan yang harusnya untuk chat WA ke dpjp / konsul)
		S	Koordinasi dengan programmer dan memastikan fitur link berjalan
		A	Mengingatkan kembali terkait penulisan dan pengetikan manual disesuaikan dengan kolom yang sesuai

3.7.68 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Orientasi ruangan belum berjalan secara konsisten di unit beserta dokumentasi di ERM	P	Setiap pasien MRS di rawat inap harus dilakukan orientasi ruangan
		D	Setelah orientasi ruangan, di ERM harus didokumentasikan dilengkapi dengan TTD pasien atau keluarga pasien
		S	Impementasi di lapangan kurang konsisten, karena ada 2 kondisi yaitu sudah dilakukan, tetapi tidak terdokumentasi, tidak dilakukan dan tidak terdokumentasi
		A	Kerjasama dengan karu rawat inap untuk mendisiplinkan staf nya dalam pendokumentasian orientasi ruangan rawat inap di ERM
2.	Pendokumentasian pasien meninggal di rawat inap (jam belum sesuai karena sebelumnya tidak ada menu edit)	P	Ditemukan kendala di rawat inap untuk pasien meninggal jam nya tidak sesuai, karena di sistem pencatatan di CPPT real time, sehingga yang terbaca adalah pasien di lakukan tindakan setelah pasien meninggal
		D	Koordinasi dengan programmer untuk menu edit bisa di akses di rawat inap, karena untuk pasien gawat atau penurunan kondisi, perawat ruangan melakukan tindakan dulu, baru melakukan penginputan di billing simrs
		S	Sosialisasi di rawat inap untuk cara penginputan dan edit waktu
		A	Evaluasi dan monitoring pendokumentasian pasien meninggal secara berkala
3.	Pendokumentasian di CPPT belum seragam (terutama untuk pasien nyeri dan observasi)	P	Ditemukan DRM pasien ada keluhan nyeri, di CPPT tidak ada penjabaran PQRST, dan ada pasien observasi di CPPT tidak ada dokumentasi tindakan observasi yang terbaca yang jelas dan rinci.
		D	Sosialisasi kembali untuk penulisan PQRST dan penulisan CPPT untuk pasien observasi
		S	Ada progress setelah ada sosialisasi dengan irna, yaitu lantai 6,7,8 A sudah ada perbaikan penulisan di CPPT, karena beberapa kali juga sudah terpapar lapsus yang diadakan komite keperawatan
		A	Sosialisasi dan monitoring kembali pada ruangan

			rawat inap yang lain yang masih belum sesuai untuk pendokumentasian di CPPT
--	--	--	---

3.7.69 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Pasien rawat jalan poli anak komplain karena dr. Ratih, SpA terlambat praktek	P	Identifikasi penyebab dokter terlambat, karena perjalanan dari PHS (praktek dan visite)
		D	Menghubungi pasien dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya
		S	Menawarkan ke pasien untuk dialihkan ke SpA yang lain agar tetap terlayani
		A	Memberikan surat teguran pada dr. Ratih, SpA dan melakukan penyesuaian HFIS sesuai jam datang
2	Pengisian indikasi medis di lembar surat kontrol masih perlu adaptasi	P	Pengisian indikasi medis untuk setiap pasien kontrol rawat jalan
		D	Akan muncul noted dan warning jika pasien akut dikunjungi kurang dari 8 hari
		S	Sosialisasi pada perawat dan dokter agar pengisian berjalan lancar
		A	Monitoring dan evaluasi selama satu bulan kedepan
3	Kuota pasien poli gigi anak bpjs terbatas, sehingga ada yang membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapatkan nomor antrian	P	Koordinasi dengan programmer untuk penguncian reservasi di M-JKN agar pasien tidak kecewa karena harus dibatalkan untuk di reschedule jika kuota melebihi 8 orang
		D	Koordinasi dengan perawat dan dokter gigi untuk penambahan kuota atau HFIS gigi. Dan penambahan kuota pasien umum maupun asuransi yang jadwal nya lebih Panjang dari sebelumnya
		S	Koordinasi dengan pendaftaran dan CSO, jika ada pasien baru poli gigi anak, yang tidak mendapat kuota, wajib di CC kn ke asisten gigi untuk di skrining dan masuk waiting list
		A	drg ajeng menambah 1 jam setelah praktek untuk pasien umum maupun asuransi. dengan jadwal sbb : - Senin dan rabu 07.30-09.00, pasien umum 09.00-10.00 - Selasa dan kamis 14.00-15.30, pasien umum 15.30-17.00 - jumat 09.00- 11.00, pasien umum 11.00-12.00 jika ada pasien umum, arahkan pada jam tersebut agar tidak jadi satu dengan bpjs
4	Kuota pasien terapi wicara full sampai ada waiting list	P	Identifikasi pasien baru waiting list terapi wicara diurutkan berdasarkan yang paling lama menunggu
		D	Identifikasi pasien lama dengan terapi yang bisa di kurangi dari 2x menjadi 1x / minggu
		S	Masukkan slot dari waiting list untuk bisa masuk 1/minggu dulu
		A	1. Minta nomor HP dan edukasi apabila sewaktu-waktu mendapat kuota karena salah satu pasien ada yang tidak bisa isi slot, maka pasien bisa masuk kuota

			2. Evaluasi kembali pasien lama yang masih memungkinkan terapi dalam 1x / minggu 3. Identifikasi kembali dan disiplinkan terkait kehadiran pasien selama mengikuti jadwal terapi yang sudah diadvicedkan oleh dokternya.
--	--	--	--

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	40	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	11	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	22	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		7	6	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	8	8	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0

		D3 Kebidanan		0	0	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Teknik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	28	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	13	2	0
		D4 Keperawatan Gigi		2	1	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	7	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	17	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		10	6	4	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	13	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	11	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		3	3	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	1
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	1
30	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	15	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0

		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	1	1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	40	14	8	6	0
		SMA		21	17	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			429	429	284	145	2

Keterangan :

Pada bulan November terdapat 2 staf resign (Staf Neonatologi dan Laboratorium).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Desember 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada November 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 08 Desember 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS/RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/II/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025